



โรงพยาบาลมหาสารคาม
MAHASARAKHAM HOSPITAL

รายละเอียดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (Strategic Plan)

โรงพยาบาลมหาสารคาม พ.ศ. 2570-2572



กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

คำนำ

ด้วยโรงพยาบาลมหาสารคามได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมหาสารคามขึ้นเป็นแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2570-2579 เพื่อให้ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาองค์กร การบริหารการแพทย์ในระดับตติยภูมิ รวมถึงการแก้ปัญหาภัยสุขภาพในพื้นที่ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ มีการวิเคราะห์ศักยภาพและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เทียบเคียงกับสถานบริการในระดับเดียวกัน พร้อมทั้งบูรณาการนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ

วิสัยทัศน์ : “ศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศระดับสากลที่ประชาชนไว้วางใจ” ประกอบด้วย 6 พันธกิจ 5 ยุทธศาสตร์ 13 Roadmap ตัวชี้วัด KPI 128 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัด OKR 297 ตัวชี้วัด การพัฒนากลยุทธ์ให้บรรลุผลสำเร็จได้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพทุกสาขา ทุกระดับในองค์กร โดยเฉพาะทีมผู้บริหารมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนแผนงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการเชื่อมโยงตัวชี้วัดสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบรวมทั้งติดตาม ประเมินผล ทบทวน พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของโรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ และชื่นชมทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์นี้ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนพันธกิจของหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

งานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

สารบัญ

หน้า

คำนำ.....	ก
สารบัญ.....	ข
KPI 1 อัตราการ Refer ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 จาก รพช. ภายใน 60 นาที	1
OKR 1.1 อัตราผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ได้รับการ Resuscitation ที่เหมาะสม จาก รพช.	2
KPI 2 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง.....	3
OKR 2.1 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง (อำเภอเมือง).....	4
OKR 2.2 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5 ชั่วโมง จาก รพช. Refer ภายใน 30 นาที.....	5
KPI 3 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis ที่ส่งต่อรักษาจาก รพช.....	6
OKR 3.1 ร้อยละการวินิจฉัยผิดพลาด/คลาดเคลื่อน	9
OKR 3.2 ร้อยละการให้การรักษาเบื้องต้นเหมาะสม	10
KPI 4 อัตราผู้ป่วย UGIB ที่ส่งต่อจากรพช. มีอาการทรุดลง ขณะนำส่ง.....	11
OKR 4.1 ร้อยละการรักษาเบื้องต้นเหมาะสมจากรพช.....	13
KPI 5 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยปลอดภัยในผู้ป่วย PPH with Shock ระดับ 3 - 4.....	14
OKR 5.1 อัตราการส่งต่อในผู้ป่วยกลุ่มมารดาหลังคลอดด้วยภาวะ PPH with Shock ระดับ 3- 4 ลดลง.....	15
OKR 5.2 ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระหว่างการส่งต่อในผู้ป่วยกลุ่มมารดาหลังคลอดด้วยภาวะ PPH with Shock ระดับ 3-4 ลดลง	16
KPI 6 อุบัติการณ์ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป ใน รพช.....	17
KPI 7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN.....	18
OKR 7.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax ลดลง.....	20
OKR 7.2 อัตราการได้รับยา Proper vasodilator ภายใน 30 นาที.....	21
KPI 8 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ลดลง.....	22
OKR 8.1 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม.....	23
OKR 8.2 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000-1,499 กรัม.....	24
KPI 9 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI.....	25
OKR 9.1 อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที	26
OKR 9.2 ผู้ป่วย STEMI ได้รับ Reperfusion.....	27
KPI 10 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke เสียชีวิตในโรงพยาบาล.....	28
OKR 10.1 อัตราผู้ป่วย Stroke ได้รับยา thrombolysis ทันภายใน 60 นาที.....	29

OKR 10.2 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน stroke unit.....	30
OKRs 10.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่ต้องส่งต่อ mechanical thrombectomy ทันภายใน 60 นาที	31
OKR 10.4 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เสียบบลิ้นที่มีความจำเป็นต้องเจาะคอ ได้รับการ Early tracheotomy....	32
KPI 11 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Sepsis.....	33
OKR 11.1 กลุ่มเสี่ยง Sepsis ที่มีอาการสงสัยติดเชื้อ ได้รับการประเมินด้วย S-NEWs และ SIRS	34
OKR 11.2 อัตราการเกิด septic shock ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดไม่รุนแรง (community-acquired sepsis).....	36
KPI 12. อัตราผู้ป่วย TB เสียชีวิต	38
OKR 12.1 อุบัติการณ์วินิจฉัย TB ลำช้าและคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป.....	39
OKR 12.2 อัตราผู้ป่วยวัณโรคปอดได้รับการกำกับและติดตามการกินยา (DOTs/VOTs) และโภชนาการ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.....	40
KPI 13 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบและมี Injury severity score (ISS) > 15	41
OKR 13.1 อัตราผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ได้รับการ Resuscitation ที่เหมาะสม	43
OKR 13.2 อัตราผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด ภายใน 60 นาที.....	44
KPI 14 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe TBI ภายใน 24 ชั่วโมง.....	46
OKR 14.1 อัตราผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 นาที	47
OKRs 14.2 อัตราผู้ป่วย Severe TBI ที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการรายงานแพทย์ตาม Early warning signs	48
KPI 15 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Massive UGIB	49
OKR 15.1 อัตราผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการ Resuscitation ตามเกณฑ์คุณภาพ.....	50
OKR 15.2 อัตราผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการส่องกล้องภายในระยะเวลา 12-24 ชม	52
OKR 15.3 อัตราการ Re-bleeding ในผู้ป่วย UGIBภายหลังการหยุดเลือดด้วยการส่องกล้องภายใน 72 ชม.	54
OKR 15.4 อัตราการ Re-admit ในผู้ป่วย Massive UGIB ภายใน 28 วัน	56
KPI 16 ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม Stage 1-3 ภายใน 5 ปี.....	57
OKR 16.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์	58
> ร้อยละ 82	58
OKR 16.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์	60
OKR 16.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์.....	62
KPI 17 ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3 ภายในระยะเวลา 5 ปี	64
OKR 17.1 ร้อยละของผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy	65
OKR 17.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์.....	67
OKR 17.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์	69

OKR 17.4 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์.....	71
KPI 18 อัตราความสำเร็จของการรักษานิวในทางเดินปัสสาวะ.....	73
OKR 18.1 อัตราการให้บริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายใน 6 สัปดาห์.....	74
OKR 18.2 อัตราการให้บริการผ่าตัดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายใน 12 สัปดาห์.....	75
OKR 18.3 อัตราการเกิด Sepsis ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL).....	77
KPI 19 อัตราผู้บริจาคอวัยวะสมองตายได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (Actual donor) 1:100 Hospital death.....	78
KPI 20 อัตราผู้บริจาคดวงตา ได้รับการจัดเก็บดวงตา (Actual donor) 1:100 Hospital death	79
KPI 21 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งทีมจัดเก็บอวัยวะ (Harvest team) ระดับ 3.....	80
KPI 22 อัตราผู้ป่วย Cerebral Aneurysm ที่เสียชีวิต (ICD 10 : I67.1, I60.0-I60.9).....	81
OKR 22.1 อัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวในผู้ป่วย Cerebral Aneurysm.....	82
OKR 22.2 ลดอัตราการแตกซ้ำของหลอดเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Rebleeding)	83
KPI 23 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe Cholangitis.....	84
OKR 23.2 ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการระบายน้ำดีด้วยวิธี ERCP/PTBD /Surgery ในผู้ป่วย Severe Cholangitis.....	85
KPI 24 อัตราผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี (Well controlled)	87
OKR 24.1 อัตราเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหืด (Potential Asthma) ได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคหืด	88
OKR 24.2 อุบัติการณ์การวินิจฉัยคลาดเคลื่อน ระดับ E ขึ้นไป ในผู้ป่วยเด็กโรคหืด	89
OKR 24.3 อัตราผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ได้รับการประเมินโรคภูมิแพ้ร่วมอย่างถูกต้อง.....	90
OKR 24.4 อัตราผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (FEV1/FVC > 80% หรือ PEER > 80% predicted)	91
KPI 25 อัตราเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ารอบด้านคงอยู่ในระบบการศึกษาได้น้อย 1 ปี.....	92
OKR 25.1 อัตราเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน (Global Developmental delay, GDD) มีพัฒนาการดีขึ้น	93
OKR 25.2 อัตราเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I.....	94
OKR 25.3 อัตราเด็กที่มีพัฒนาการช้ารอบด้าน ได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน	95
KPI 26 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ที่น้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม.....	96
OKR 26.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Severe RDS ลดลง	98
OKR 26.2 อัตราการเกิด Septic shock ลดลง	100
KPI 27 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN	101
OKR 27.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax ลดลง.....	103
OKR 27.2 อัตราการได้รับ Proper vasodilator ภายใน 30 นาที.....	104
KPI 28 อุบัติการณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กโรคไขเลือดออก	105

OKR 28.1	อุบัติการณ์ผู้ป่วยเด็กไขเลือดออกที่ได้รับการแก้ไขภาวะซีดล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง	106
KPI 29	อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง (DM/HT/U/D Med) ได้รับการดูแลจากสูติแพทย์และอายุรแพทย์.....	107
KPI 30	อุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจาก PPH.....	108
OKR 30.1	อุบัติการณ์ EWS ระยะ 24 ชั่วโมงหลังคลอด.....	109
OKR 30.2	อุบัติการณ์การผ่าตัดซ้ำล่าช้า (Delay Re-EL)	110
KPIs 31	อุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจาก PIH	111
OKR 31.1	อุบัติการณ์ EWS ล่าช้าทุกระยะของการคลอด	112
OKR 31.2	อุบัติการณ์รักษาล่าช้า	114
KPI 32	อุบัติการณ์การเกิด Severe BA ในนาทีที่ 5 ใน Preterm labor	115
OKR 32.1	อุบัติการณ์ EWS RD Score ผิดพลาด	116
OKR 32.2	อุบัติการณ์ RRT ล่าช้า.....	117
KPI 33	อุบัติการณ์ Hypovolemic shock ใน Ectopic Pregnancy หลังรับไว้รักษา	118
OKR 33.1	อุบัติการณ์ EWS ล่าช้า.....	119
OKR 33.2	อุบัติการณ์วินิจฉัยผิดพลาด	120
KPI 34	อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage 1-2 ภายใน 5 ปี	121
OKR 34.1	อัตราการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage 1-2 ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับการวินิจฉัย.....	122
OKR 34.2	อัตราของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้รับยาเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์	123
OKR 34.3	อัตราของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้รับรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด.....	124
KPI 35	อัตราผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น.....	125
OKR 35.1	อัตราผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อม	126
OKR 35.2	อัตราผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเสื่อมที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด	127
OKR 35.3	อัตราผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA สามารถงอเข้าได้มากกว่า 90 องศา ก่อนกลับบ้าน	128
OKR 35.4	ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดTKA สามารถเหยียดข้อเข่าไม่สุด (Extension Lag) < 10 องศา ก่อนกลับบ้าน...	129
KPI 36	อัตราการเสียชีวิตจากภาวะ Pulmonary Embolism ของผู้ป่วย Fracture around Hip.....	130
OKR 36.1	อัตราผู้ป่วย Fracture around Hip ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลัง admit	131
OKR 36.2	อัตราผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ได้รับการผ่าตัด มีค่า BI เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ	132
KIP 38	อัตราทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะตาบอดจาก Retinopathy of Prematurity (ROP)	133
OKR 38.1	อัตราทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองภาวะ ROP	134
OKR 38.2	อัตราทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่มีโรค ROP type I ได้รับการรักษาภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัย	135
KPI 39	อุบัติการณ์นักเรียนที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติเกิดภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia)	136

OKR 39.1	นักเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสายตา.....	137
OKR 39.2	นักเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่มีสายตาผิดปกติได้รับแว่นตา	138
KPI 40	ร้อยละระดับสายตาหลังผ่าตัดต่อกระจก 1 เดือน $\geq 20/70$	139
OKR 40.1	อัตราการคัดกรองต่อกระจกในผู้สูงอายุ.....	140
OKR 40.2	ร้อยละผู้ป่วย Blinding cataract ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 1 เดือน.....	141
KPI 41	อุบัติการณ์ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่แก้ไขได้ เกิดปัญหาด้านการพูด	142
OKR 41.1	อัตราทารกแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรองการได้ยิน (Newborn hearing screening)	143
OKR 41.2	อัตราทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติทางการได้ยินได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่องทุกราย	144
KPI 42	อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน	145
OKR 42.1	ร้อยละของผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด	146
OKR 42.2	ร้อยละผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Airway Obstruction) เข้าระบบ fast tract ภายใน 30 นาที.....	147
OKR 42.3	ร้อยละผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Airway Obstruction) ได้รับการแก้ไขเรื่อง Airway	148
KPI 43	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	149
OKR 43.1	ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้รับการคัดกรอง	150
OKR 43.2	ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ.....	151
OKR 43.3	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน	152
KPI 44	อัตราของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้หรือฟันเทียมใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ	154
OKR 44.1	อัตรากลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม ได้รับการวางแผนการรักษาเพื่อใส่ฟันเทียม	155
OKR 44.2	อัตรากลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม ได้รับการเตรียมช่องปาก.....	156
OKR 44.3	อัตรากลุ่มผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟันได้รับการใส่ฟันเทียมทดแทน 4 คู่สบ.....	157
KPI 45	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับ เขตสุขภาพที่ 7	158
OKR 45.1	ด้านการแพทย์.....	160
OKR 45.2	ด้านสาธารณสุข.....	162
OKR 45.3	ด้านบริหารจัดการ	164
KPI 46	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับ ภูมิภาค.....	166
OKR 46.1	ด้านการแพทย์.....	168
OKR 46.2	ด้านสาธารณสุข.....	170

OKR 46.3 ด้านบริหารจัดการ	172
KPI 47 จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับชาติ	174
OKR 47.1 ด้านการแพทย์	176
OKR 47.2 ด้านการสาธารณสุข	178
OKR 47.3 ด้านบริหารจัดการ	180
OKR 47.4 ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา	182
KPI 48 จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ	184
OKR 48.1 ด้านการแพทย์	186
OKR 48.2 ด้านการสาธารณสุข	188
OKR 48.3 ด้านบริหารจัดการ	190
OKR 48.4 ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา	192
KPI 49 จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน	194
OKR 49.1 ด้านการแพทย์	196
OKRs 49.2 ด้านการสาธารณสุข	198
OKR 49.3 การบริหารจัดการ	200
KPI 50 อัตราบัณฑิตแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐาน	202
OKR 50.1 อัตรานักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในศูนย์แพทย์สำเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด	203
OKR 50.2 อัตราบัณฑิตแพทย์ที่คงอยู่ในระบบ	204
KPI 51 อัตราแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สามารถจบหลักสูตรจนได้รับวุฒิบัตร	205
KPI 52 จำนวนหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program) ที่มีการเปิดอบรม	206
OKR 52.1 ระดับความสำเร็จของการผ่านการประเมินหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง	207
OKR 52.2 อัตราพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่มีการเปิดการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลที่เลี้ยง	208
KPI 53 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์ MOPH-4T	209
OKR 53.1 อัตราหน่วยงานภายในโรงพยาบาลน่านโยบายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ร้อยละ	210
KPI 54 ระดับคะแนนการประเมินมาตรฐาน SAP ระดับ P+ บรรลุเป้าหมาย	211
KPI 55 ระดับความสำเร็จในการผ่านการรับรองชั้นก้าวหน้า	212
OKR 55.1 ร้อยละหัวข้อตาม HA Score part I-III (54 บท) ในหมวดหมู่มาตรฐานที่มี HA Score > 4	213

OKR 55.2 อัตรามาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยบรรลุเป้าหมาย	214
KPI 56 บริหารเชิงยุทธศาสตร์: อัตราวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานผ่านเกณฑ์	217
OKR 56.1 อัตราโครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13.....	218
OKR 56.2 อัตราโครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 ได้รับการประเมินผล.....	219
KPI 57 อัตราหน่วยงานในรพ. และเครือข่ายบริการสุขภาพ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบงาน	220
OKR 57.1 อัตราหน่วยงานในรพ. ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ	222
OKR 57.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ	224
KPIs 58 อัตรา Community of Practice (CoPs) ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์.....	226
KPIs 59 อัตราหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ	227
KPI 60 อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง (รพ.ระดับ P to P+) เพียงพอ ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี	228
OKR 60.1 แพทย์เฉพาะทาง	229
OKR 60.2 พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง.....	230
OKRs 60.3 สหสาขาวิชาชีพทางคลินิก	231
KPI 61 อัตราบุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์.....	232
OKR 61.1 แพทย์.....	233
OKR 61.2 พยาบาลวิชาชีพ.....	234
OKR 61.3 สหสาขาวิชาชีพ	235
OKR 61.4 สายสนับสนุน	236
KPI 62 อัตราบุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป.....	237
OKR 62.1 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพงานระดับดีมากขึ้นไป.....	238
OKR 62.2 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน.....	239
OKR 62.3 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านค่านิยมและผู้นำขององค์กรในระดับดีมากขึ้นไป	240
OKR 62.4 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับดีมากขึ้นไป	241
OKR 62.5 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ระดับดีมากขึ้นไป.....	242
OKR 62.6 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน ระดับดีมากขึ้นไป	243
KPI 63 ประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย.....	244
OKR 63.1 ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก ตั้งแต่วันนัดจนถึงรับยากลับบ้าน	245
OKR 63.2 ระยะเวลารอคอย ตั้งแต่วันนัดจนถึงรับยากลับบ้าน.....	246
OKR 63.3 จำนวนวันนอนเฉลี่ย	247

OKR 63.4 อัตราการ refer in ของโรงพยาบาลเครือข่าย.....	248
OKR 63.5 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาบริการใน ER (On ER Time) อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด.....	250
KPI 64 อัตราผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) บรรลุเป้าหมาย	252
OKR 64.1 ด้านการดูแลผู้ป่วยและการสร้างเสริมสุขภาพ	253
OKR 64.2 ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน	254
OKR 64.3 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล	255
OKR 64.4 ด้านการนำ.....	256
OKR 64.5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานที่สำคัญ.....	257
OKR 64.6 ด้านการเงิน	258
KPI 65 อัตราผลลัพธ์ด้านคุณภาพการเทียบเคียง (Benchmark).....	259
KPI 66 อัตราผลลัพธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข บรรลุผลลัพธ์.....	261
KPI 67 อัตราผลลัพธ์ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 7 (4 Excellence) บรรลุเป้าหมาย	262
KPI 68 ได้รับรางวัลระดับชาติเลิศรัฐ, NQA, AHA	263
KPI 69 ประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป	264
OKR 69.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการหนังสือราชการที่สำคัญ (SLA) ภายในเวลา 15 นาที.....	265
OKR 69.2 อัตราบุคลากรใน รพ.และผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาสารคาม ..	266
OKR 69.3 อุบัติการณ์ทรัพย์สินทางราชการ ผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่สูญหายและความรุนแรงในโรงพยาบาล	267
OKR 69.4 อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่รถราชการเป็นฝ่ายผิด.....	268
OKR 69.5 น้ำหนักของมูลฝอยติดเชื้อในหอผู้ป่วยใน เฉลี่ยไม่เกิน 0.75 กิโลกรัมต่อเตียงต่อคนต่อวัน.....	269
OKR 69.6 อัตราบุคลากรในโรงพยาบาลรอบรู้กฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ.....	270
OKR 69.7 อัตราความพึงพอใจต่อการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์.....	272
KPI 70 อัตราบุคลากรได้รับข้อมูลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนทันเวลา	273
KPI 71 อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ระดับ 3 ขึ้นไป	274
OKR 71.1 อุบัติการณ์ไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน ภายใน 10 วินาที	275
OKR 71.2 อุบัติการณ์น้ำประปาไม่ไหล.....	276
OKR 71.3 อุบัติการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล.....	277
OKR 71.4 อุบัติการณ์ลิฟท์ไม่พร้อมใช้	278
OKR 71.5 อุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงไม่เพียงพอ	279
KPI 72 ร้อยละความพึงพอใจภาพรวม ระดับ 4 หรือ 5 ของผู้รับบริการต่อโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล	280
KPI 73 อัตราประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุให้ทันเวลาตามกำหนด	281
KPI 74 อุบัติการณ์เบิกจ่ายเงินผิดพลาดและไม่ทันเวลา	282

OKR 74.1	ปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผลิตและไมทันเวลา	283
OKR 74.2	ปฏิบัติการด้านการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินภายนอกผลิตและไมทันเวลา	284
KPI 75	การบริหารจัดการลูกหนี้ ผ่านเกณฑ์	285
KPI 76	ปฏิบัติการความคลาดเคลื่อนของการรับรู้สินทรัพย์ทางบัญชี	286
OKR 76.1	ปฏิบัติการความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ภายในกลุ่มงานประกัน	288
OKR 76.2	ปฏิบัติการความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ระหว่างกลุ่มงานประกันและบัญชี	290
OKR 76.3	ปฏิบัติการความคลาดเคลื่อนในการกระทบยอดครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระหว่างกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานบัญชี	292
KPI 77	ผ่านการรับรอง Hospital Accreditation of Information Technology (HAIT)	294
OKR 77.1	7 หมดมาตรฐาน HAIT ผ่านระดับ Level 4	296
KPI 78	ผ่านการรับรองโรงพยาบาล Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข	297
OKR 78.1	ร้อยละ 100 ของ 4 หมดโรงพยาบาล Smart Hospital มีคะแนน > ร้อยละ 90	298
KPI 79	อัตราการกลุ่มอายุ 15-25 ปี เข้าถึงบริการซีเอ็มเคร้า	299
OKR 79.1	ร้อยละของการเพิ่มความครอบคลุมการค้นหา คัดกรองภาวะซีเอ็มเคร้า	301
OKR 79.2	ผู้ป่วยโรคซีเอ็มเคร้าในวัยรุ่นที่ขาดยาได้รับการติดตามเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง	302
KPI 80	สัดส่วนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล	303
OKR 80.1	DM	304
OKR 80.2	HT	305
OKR 80.3	CKD	306
OKR 80.4	ผู้สูงอายุ	307
KPI 81	อัตราความสำเร็จของการลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ ในกลุ่มโรค 4 โรค (DM/HT/Stroke/STEMI)	308
OKR 81.1	อัตราความครอบคลุมการค้นหา คัดกรอง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	310
OKR 81.2	อัตรากลุ่มเสี่ยง (DM/HT/Stroke/STEMI) เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล (Individual Lifestyle modification)	311
KPI 82	อัตราผู้ป่วย ESRD รายใหม่ลดลง	313
OKR 82.1	อัตรากลุ่มผู้ป่วย DM สะท้อนการเสื่อมของไต	314
OKR 82.2	อัตรากลุ่มผู้ป่วย HT สะท้อนการเสื่อมของไต	315
OKR 82.3	อัตรากลุ่มผู้ป่วย HT Crisis ได้รับการติดตามเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง	316
OKR 82.4	กลุ่มผู้ป่วย Acute on top CKD ได้รับการวางแผนจำหน่ายและติดตามรักษาน้อย 1 ปี	317
KPI 83	อัตราผู้เสพสารเสพติดที่อยู่ในระบบการรักษา ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน ลดลง	318
OKR 83.1	อัตราผู้เสพสารเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัด	319

OKR 83.2 อัตราผู้สพสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดจนครบ ไม่กลับไปเสพซ้ำ ภายใน 1 ปี.....	320
KPI 84 อุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรค.....	322
OKR 84.1 อัตราความครอบคลุมการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค	323
OKR 84.2 อัตรากลุ่มสงสัยป่วยวัณโรคปอด (CXR ผิดปกติ) ที่ได้รับการตรวจเสมหะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค	324
OKR 84.3 กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อวัณโรค (LTBI) ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง (TB Preventive Treatment, TPT)	325
OKR 84.4 อุบัติการณ์การเป็นโรควัณโรคระบบทางเดินหายใจ จากการทำงานของบุคลากร.....	327
KPI 85 อสม. สามารถจัดการปัญหาสุขภาพในครัวเรือนในคุ่มสุขภาพที่รับผิดชอบ.....	328
OKR 85.1 อสม. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการ 8 โรค.....	329
KPI 86 Care giver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)/พระคิลานุปัฏฐาก/ผู้ช่วยพยาบาล : สามารถดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) และมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ดีขึ้น.....	330
OKR 86.1 ความครอบคลุมของ Care giver ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนด.....	332
OKR 86.2 กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล	333
KPI 87 ระดับความสำเร็จของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพระดับอำเภอประกาศนโยบายพขอ. 8 โรคในชุดนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่.....	334
OKR 87.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนปัญหาสุขภาพ 8 โรคที่สำคัญในชุดนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่.....	337
OKR 87.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่	340
OKR 87.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายมหัศจรรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ.....	342
KPI 88 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 3 ขึ้นไป	344
OKR 88.1 ร้อยละ Risk Register ของความเสี่ยงสำคัญระดับโรงพยาบาลที่ Risk Level ลดลง	346
OKR 88.2 อัตราหน่วยงานที่จัดทำRisk Profile ของความเสี่ยงสำคัญระดับหน่วยงาน	348
OKR 88.3 ร้อยละหน่วยงานในโรงพยาบาลที่ผลลัพธ์มาตรฐานสำคัญจำเป็นบรรลุเป้าหมาย	349
OKR 88.4 อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 4 ขึ้นไปได้รับการจัดทำ RCA/CQI.....	351
KPI 89 อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล ระดับ E ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์	353
OKR 89.1 อัตราหน่วยงานทางการพยาบาลที่มีผลผลิตภาพ (Productivity) ทางพยาบาล เป็นตามมาตรฐาน	355
OKR 89.2 อัตราบุคลากรทางการพยาบาลผ่านการประเมินสมรรถนะความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล	356
OKR 89.3 หน่วยงานทางการพยาบาลมีการนิเทศตามความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาลระดับ E ขึ้นไป.....	357
KPI 90 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป	358
OKR 90.1 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ของ subglottic stenosis	360
OKR 90.2 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ของ Ectopic Pregnancy	362

OKR 90.3	อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน blunt abdomen/blunt chest.....	364
OKR 90.4	อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน STEMI	366
OKR 90.5	อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Pediatric DHF.....	368
OKR 90.6	อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Traumatic Eye injury	370
OKR 90.7	อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Neck shaft femoral fracture.....	372
KPI 91	อัตราการติดเชื้อ HAI < 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน.....	374
OKR 91.1	อัตราการติดเชื้อตำแหน่ง VAP ≤ 6 ต่อ 1,000 vent.Day	375
OKR 91.2	อัตราการติดเชื้อตำแหน่ง CLABSI < 1.5 ต่อ 1,000 line.Day	376
OKR 91.3	อัตราการติดเชื้อตำแหน่ง CAUTI ≤ 1.5 ต่อ 1,000 cath.Day	377
OKR 91.4	อัตราการติดเชื้อฉวย ≤ 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน.....	378
KPI 92	อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาระดับ E ขึ้นไป.....	379
OKR 92.1	อัตรา Prescribing error ผู้ป่วยนอก	381
OKR 92.2	อัตรา Prescribing error ผู้ป่วยใน.....	382
OKR 92.3	อัตรา Dispensing error ผู้ป่วยนอก.....	383
OKR 92.4	อัตรา Dispensing error ผู้ป่วยใน.....	384
OKR 92.5	อัตรา Administration error ผู้ป่วยนอก	385
OKR 92.6	อัตรา Administration error ผู้ป่วยใน.....	386
OKR 92.7	จำนวน Medication error ยา High Alert Drug	387
OKR 92.8	จำนวน Medication error ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์.....	388
OKR 92.9	ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการประสานรายการยาถูกต้อง	389
KPI 94	อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (OPD/IPD).....	390
KPI 95	อุบัติการณ์การแพ้สารทึบรังสีซ้ำ.....	392
OKR 95.1	อัตราผู้ป่วยได้รับการคัดกรองก่อนใช้สารทึบรังสี	393
OKR 95.2	อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างการฉีดสารทึบรังสี (ก่อนและหลังทำ).....	394
OKR 95.3	อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังฉีดสารทึบรังสี 30 นาที ทุกราย	395
KPI 96	อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป.....	396
OKR 96.1	อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไปที่ Lab เคมีคลินิก	397
OKR 96.2	อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไปที่ Lab จุลชีววิทยา.....	398
OKR 96.3	อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไปที่ Lab โลหิตวิทยา.....	399

KPI 97	ปฏิบัติการการรายงานค่าวิกฤติไม่ทันเวลา	400
OKR 97.1	ปฏิบัติการการรายงานค่าวิกฤติไม่ทันเวลาที่ Lab เคมีคลินิก	401
OKR 97.2	ปฏิบัติการการรายงานค่าวิกฤติ ไม่ทันเวลาที่ Lab จุลชีววิทยา.....	402
OKR 97.3	ปฏิบัติการการรายงานค่าวิกฤติ ไม่ทันเวลาที่ Lab โลหิตวิทยา.....	403
KPI 98	ปฏิบัติการจ่ายเลือดผิดคนผิดหมู่ผิดชนิด.....	404
OKR 98.1	ร้อยละการติดสติกเกอร์จากระบบ AI ที่จะรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อรับเลือดถูกต้อง.....	405
KPI 99	อัตราการตรวจทางพยาธิวิทยาภายในภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลา.....	406
OKR 99.1	อัตราการตรวจทางพยาธิวิทยาภายในภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลาในโรคมะเร็งเต้านม	408
OKR 99.2	อัตราการตรวจทางพยาธิวิทยาภายในภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลาในโรคมะเร็งปอด.....	409
OKRs 99.3	อัตราการตรวจทางพยาธิวิทยาภายในภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลาในโรคมะเร็งทางนรีเวช	410
KPI 100	จำนวนปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ ทางนิติเวชวิทยาเคลื่อน ระดับ 3 ขึ้น.....	411
OKR 100.1	ปฏิบัติการระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดพลาด	413
KPI 101	อัตราหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2.....	414
OKR 101.1	อัตราการรายงาน DDS โรคไข้เลือดออกทันเวลา.....	415
OKR 101.2	อัตราหมู่บ้านที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI/CI) ผ่านเกณฑ์	416
KPI 102	ปฏิบัติการ Cardiac arrest ขณะให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน.....	417
OKR 102.1	ความพร้อมในการเตรียมให้ยาระงับความรู้สึก	418
OKR 102.2	ปฏิบัติการการประเมินและแก้ไขตาม Early Warning Sign (EWS) ไม่เหมาะสมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก	419
KPI 103	ปฏิบัติการการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดชนิด.....	420
OKR 103.1	ปฏิบัติการ Mark site ที่ผิวหนังผิดพลาด	422
OKR 103.2	ร้อยละการบันทึก Surgical safety checklist ถูกต้องและครบถ้วน.....	424
OKR 103.3	ปฏิบัติการการทำ Timeout ไม่เหมาะสม.....	426
KPI 104	ปฏิบัติการเครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ค้างในร่างกาย	427
KPI 105	อัตราผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU ที่มีค่า Nutrition Alert Form Score (NAF score) ลดลง.....	429
OKR 105.1	อัตราการคัดกรองภาวะโภชนาการผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU	431
OKR 105.2	อัตราการตอบสนองต่อ Suggestion การให้โภชนาการของนักโภชนาการในผู้ป่วย Stroke	432
KPI 106	อัตราผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICU ที่มีค่า NAF score ลดลง	433
OKR 106.1	อัตราการคัดกรองภาวะโภชนาการผู้ป่วย Sepsis ใน SICU และ TICU	435

OKR 106.2 อัตราการปฏิบัติตาม Suggestion การใช้โภชนาบำบัดของนักโภชนาการ ในผู้ป่วย Sepsis	436
KPI 107 ร้อยละผู้ป่วยระยะท้ายมีภาวะ Good Death	437
OKR 107.1 ร้อยละผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliativecare)	439
OKR 107.2 ร้อยละผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าถึงกระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliativecare) มีภาวะ Good death	441
OKR 107.3 ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน	443
KPI 108 อัตราผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันได้รับการจัดการความปวดอย่างเป็นระบบจนบรรเทาความปวด	444
OKR 108.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน	446
KPI 109 ร้อยละของผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลพหุสภาวะระยะกลาง (Intermediate care, IMC) และมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index, BI) เพิ่มขึ้น 1 คะแนน ภายใน 6 เดือน	448
OKR 109.1 ร้อยละการติดตามผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) 6 ครั้งภายใน 6 เดือน	449
OKR 109.2 ร้อยละผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) สามารถปฏิบัติกรดูแลได้ (ในการเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง)	450
KPI 111 อัตราผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) เข้าถึงระบบการดูแลต่อเนื่องและมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (BI) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน ในผู้ป่วย IMC Ward	453
OKR 111.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการฟื้นฟูอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/วัน โดยสหวิชาชีพ	455
OKR 111.2 อัตราผู้ดูแลสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลพหุสภาวะผู้ป่วยได้ ก่อนจำหน่าย	456
KPI 112 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์แผนไทย	457
OKR 112.1 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการการนวดแผนไทย	459
OKR 112.2 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการทรมือเกือ	460
OKR 112.3 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของการใช้ยาสมุนไพร	461
KPI 113 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์ผสมผสาน	462
OKR 113.1 ผังเข็ม	464
OKR 113.2 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปบริการบ่งต่อด้วยนามหาย	465
KPI 114 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ในบริการ Home base care	466
OKR 114.1 DM อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการ Home base care	467
OKR 114.2 HT อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ใช้บริการ Home base care	469
OKR 114.3 Pressure sore อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยแผลกดทับที่ใช้บริการ Home base care	471
KPI 115 ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score (TPS) ระดับ A	473
OKR 115.1 โรงพยาบาลมีภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 0	475

OKR 115.2 อัตราลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่มีระยะเวลาถ่วงเฉื่อยในการเก็บรักษาลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน.....	478
KPI 116 ประสิทธิภาพในการทำกำไรของโรคที่สำคัญทั้ง 3 กองทุน (กองทุน UC เบิกได้จ่ายตรง ประกันสังคม) เพิ่มขึ้น.....	480
KPI 117 อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้ เพิ่มพิเศษ (Premium).....	481
OKR 117.1 ห้องพิเศษ อัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น	482
OKR 117.2 SMC ผู้ป่วยนอก มีอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น	483
OKR 117.3 อัตรากำไรสุทธิจากบริการ SMC การผ่าตัดเพิ่มขึ้น.....	485
OKR 117.4 การบริการทันตกรรมมีอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น.....	487
OKR 117.5 ตรวจสอบสุขภาพมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น	489
OKR 117.6 การให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนอก มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น.....	490
OKR 117.7 แพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น.....	491
OKR 117.8 ODS & MIS มีอัตราการจ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้น.....	493
OKR 117.9 Skin Clinic มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น.....	494
OKR 117.10 Sleep test มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น	496
KPI 118 ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง 6 มิติ	497
OKR 118.1 มิติด้านการเงิน	499
OKR 118.2 มิติด้านการจัดเก็บรายได้.....	500
OKR 118.4 มิติด้านพัสดุและสินทรัพย์	502
OKR 118.5 มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	503
OKR 118.6 มิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (IT)	504
KPI 119 อัตราการเข้าถึงบริการและความสมบูรณ์การบันทึกค่าบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS)	505
KPI 120 ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังรวม (Inventory Management).....	506
OKR 120.1 คลังวัสดุการแพทย์	507
OKR 120.2 คลังวัสดุมิใช่การแพทย์	508
OKR 120.3 คลังยาเวชภัณฑ์.....	509
KPI 121 ร้อยละหน่วยเบิกบริหารคลังวัสดุการแพทย์ของหน่วยเบิก (Sub stock) ไม่เกิน 3 วัน	510
KPIs 122 หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า.....	511
KPI 123 ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรคลดลง.....	512
OKR 123.1 ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Pneumonia (CAP) ในผู้ป่วยในลดลง	513
OKR 123.2 ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค ESRD ในผู้ป่วยในลดลง.....	515
OKR 123.3 ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Traumatic Brain injury ในผู้ป่วยในลดลง.....	516

OKR 123.4	ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Sepsis ในผู้ป่วยในลดลง.....	517
OKR 123.5	ต้นทุนเฉลี่ยโรค UGIB ในผู้ป่วยในลดลง.....	519
OKR 123.6	ต้นทุนเฉลี่ยโรค Cataract ในผู้ป่วยใน ลดลง	521
OKR 123.7	ต้นทุนเฉลี่ยโรค Postpartum hemorrhage ในผู้ป่วยใน ลดลง	522
OKR 123.8	ต้นทุนเฉลี่ยโรค Fracture around hip ในผู้ป่วยใน ลดลง.....	523
OKR 123.9	ต้นทุนเฉลี่ยโรค DM ลดลง.....	525
OKR 123.10	ต้นทุนเฉลี่ยโรค HT ลดลง.....	527
KPI 124	อัตราผู้รับบริการมีความผูกพัน	529
OKR 124.1	อัตราผู้รับบริการ OPD มีความผูกพัน	530
OKR 124.2	อัตราผู้รับบริการ IPD มีความผูกพัน	531
OKR 124.3	อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก	532
OKR 124.4	อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน รายนาม	533
OKR 124.5	อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER).....	534
OKR 124.6	อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยในชุมชนกลุ่มดูแลต่อเนื่อง	535
OKR 124.7	อัตราความพึงพอใจของกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค	536
OKR 124.8	อัตราความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสุขภาพ.....	537
OKR 124.9	อัตราความพึงพอใจกลุ่มผู้ป่วยที่มีเข้ารับบริการ PMC หรือ SMC	538
KPI 125	อัตราประชาชนมีความผูกพัน.....	539
OKR 125.1	อัตราภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน มีความผูกพัน	540
OKR 125.2	จำนวนคำชมเชย > 1,000ครั้ง/ปี.....	541
KPI 126	อัตราเครือข่ายบริการสุขภาพ มีความผูกพัน	542
OKR 126.1	รพช. มีความผูกพัน	543
OKR 126.2	รพ.สต. มีความผูกพัน.....	544
KPI 127	อัตราปฏิบัติการข้อร้องเรียนรุนแรง (ม.41/ชดเชยเยียวยา/ ฯลฯ)	545
OKR 127.1	อัตราข้อร้องเรียนได้รับการจัดการตามแนวทาง	546
OKR 127.2	อัตราข้อร้องทุกข์ได้รับการจัดการตามแนวทาง	547
OKR 127.3	อัตราทีมใกล้เคียงได้รับการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงตามแผน	548
KPI 128	อัตราตัวชี้วัดประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม	549
OKR 128.1	มูลค่าบริจาค (ทรัพย์สิน/เงิน/ ฯลฯ).....	550
OKR 128.2	จำนวนจิตอาสาและอาสาสมัคร	551
OKR 128.3	จำนวนบริจาคโลหิต	552

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap 1 : Excellent Interfacility		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. Multiple injury : การ Refer ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 จาก รพช. ภายใน 60 นาที		
ตัวชี้วัดที่	KPI 1 อัตราการ Refer ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 จาก รพช. ภายใน 60 นาที		
คำนิยาม	ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 คือ ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บในร่างกายตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพไม่คงที่และมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อน จำเป็นต้องได้รับการประเมินและรักษาแบบเร่งด่วนตามแนวทาง Trauma ภายใน 60 นาที นับระยะเวลาตั้งแต่ Triage ที่ รพช.จนถึงระยะเวลาที่รถ Refer เคลื่อนตัวออกจาก รพช.		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 จาก รพช.		
แหล่งข้อมูล	-ทะเบียนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน -ทะเบียนของหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 -กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย		
รายการข้อมูล	A : จำนวนการ Refer ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 จาก รพช. ภายใน 60 นาที B : จำนวนการ Refer ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 85	2572 ≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสิรินารถ ประพาศพงษ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap 1 : Excellent Interfacility			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. Multiple injury : การ Refer ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 จาก รพช. ภายใน 60 นาที 1.1 ผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ได้รับการ Resuscitation ที่เหมาะสม จาก รพช. เพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 1.1 อัตราผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ได้รับการ Resuscitation ที่เหมาะสม จาก รพช.			
คำนิยาม	ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 คือ ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บในร่างกายตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพไม่คงที่และมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อน จำเป็นต้องได้รับการประเมินและรักษาแบบเร่งด่วนตามแนวทาง Trauma การ Resuscitation ที่เหมาะสมหมายถึง การ Resuscitation ตาม CPG Trauma ดังเอกสารที่...			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่เข้าสู่ระบบการดูแลจากโรงพยาบาลชุมชน และมีการส่งต่อมายังโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	-ทะเบียนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน -ทะเบียนของหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 -กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่ได้รับการ Resuscitation จาก รพช. ตามเกณฑ์คุณภาพ B : จำนวนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่ได้รับการส่งต่อทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสิรินารถ ประพาศพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ไชยวัฒน์ พาณิษฐ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ภายในเวลา 4.5 ชม.เพิ่มขึ้น			
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
ตัวชี้วัด	KPI 2 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง			
คำนิยาม	- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) ที่มาทันเวลาภายใน 4.5 ชม. -ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) เสียบบลัน ภายใน 72 ชั่วโมง			
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มการเข้าถึง เป็นร้อยละ 50			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม / ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข			
รายการข้อมูล	A = ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke : I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) ที่มาทันเวลาภายใน 4.5 ชม.จากทุกหอผู้ป่วย B = ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด (Ischemic Stroke : I63 และ Hemorrhagic Stroke :I60-I62) เสียบบลัน ภายใน 72 ชั่วโมง			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 38	ร้อยละ 44	ร้อยละ 50	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สุพิศชา อีรศาวัต			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ภายในเวลา 4.5 ชม.เพิ่มขึ้น			
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
ตัวชี้วัด	OKR 2.1 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ภายในเวลา 4.5 ชั่วโมง (อำเภอเมือง)			
คำนิยาม	- ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) ที่มาทันเวลาภายใน 4.5 ชม. -ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) เสียบบล้น ภายใน 72 ชั่วโมง			
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มการเข้าถึง เป็นร้อยละ 50			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม / ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข			
รายการข้อมูล	A = ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) ที่มาทันเวลาภายใน 4.5 ชม.จากทุกหอผู้ป่วย B = ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) เสียบบล้น ภายใน 72 ชั่วโมง			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	38	44	50	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สุพิศชา อีระศาสตร์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเข้าถึงบริการทางการแพทย์ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาล ภายในเวลา 4.5 ชม.เพิ่มขึ้น			
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
ตัวชี้วัด	OKR 2.2 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายใน 4.5 ชั่วโมง จาก รพช. Refer ภายใน 30 นาที			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) ที่มีอาการภายใน 4.5 ชั่วโมง			
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มการส่งต่อภายในเวลา 30 นาที เป็นร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่ถูก refer มารักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A = ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาลชุมชนภายใน 4.5 ชั่วโมง ที่ถูกส่งต่อภายใน 30 นาที B = ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic Stroke :I60-I62 และ Ischemic Stroke : I63) ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนถึงโรงพยาบาลชุมชนภายใน 4.5 ชั่วโมง ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สุพิศชา อีระศาวัต			

นียมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	1. SEPSIS : อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ตัวชี้วัด	KPI 3 อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis ที่ส่งต่อรักษาจาก รพช.
คำนิยาม	1. ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัยภาวะ severe sepsis หรือ septic shock 1.1 ผู้ป่วย severe sepsis หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไปที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction โดยที่อาจจะมีหรือไม่มีภาวะ hypotension ก็ได้ หรือมีอาการแสดงตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป, SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป และ Modified Early Warning Score (MEWS) หรือ NEWS 2 ตั้งแต่ 5 ข้อ ขึ้นไป 1.2 ผู้ป่วย septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไปที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥ 65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 2. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดยต้องไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis อัตราตายจากติดเชื้อในกระแสเลือด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. อัตราตายจาก community-acquired sepsis 2. อัตราตายจาก hospital-acquired sepsis (รอกแก้ไข) 3. กลุ่มเป้าหมาย ในปีงบประมาณ 2570 จะมุ่งเน้นที่กลุ่ม community – acquired sepsis เพื่อพัฒนาให้ มีระบบข้อมูลพื้นฐานให้เหมือนกัน ทั้งประเทศ แล้วจึงขยายไปยัง hospital-acquired sepsis ในปีถัดไป 4. การคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรง หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยทั่วไปที่อาจจะเกิดภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงต่อไปซึ่งเครื่องมือที่ใช้ (sepsis screening tools) ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 4.1 ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อในร่างกาย ร่วมกับมี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไปที่เกิดภาวะ tissue hypoperfusion หรือ organ dysfunction (ตารางที่ 2) หรือ มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥ 65 mm Hg และ มี ค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 4.2 qSOFA ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป 4.3 SOS score (search out severity) ตั้งแต่ 4 ข้อ ขึ้นไป 4.4 Modified Early Warning Score (MEWS) หรือ NEWS 2 ตั้งแต่ 5 ข้อ ขึ้นไป

	5. ฐานข้อมูลของโรงพยาบาล หมายถึง ข้อมูลจาก ICD 10 และ/หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ของแต่ละโรงพยาบาลภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงเป็นภาวะวิกฤตที่มีความสำคัญพบว่าอัตราอุบัติการณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นและอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่รับยากดภูมิคุ้มกันนอกจากนี้ยังพบว่าแนวโน้มของเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น ส่งผลให้การรักษาผู้ป่วยไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ยังพบว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ ทำงานผิดปกติส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้แก่ ภาวะช็อก, ไตวาย การทำงานอวัยวะต่าง ๆ ล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด 6. ส่งต่อรักษาจาก รพช. หมายถึง กระบวนการรับส่งต่อผู้ป่วย Sepsis จากสถานพยาบาลต้นทาง (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) ด้วยเหตุผลในการรับส่งต่อ เช่น เกินศักยภาพ เพื่อการวินิจฉัย/รักษา ขาดเครื่องมือ ทางกายภาพ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ส่งต่อตามสิทธิการรักษา หรือเป็นความประสงค์ของผู้ป่วย/ญาติ เป็นต้น 7. เสียชีวิตใน 48 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Sepsis/Septic shock ที่ส่งต่อจากสถานพยาบาลต้นทาง (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) มายังโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่เสียชีวิตภายใน 48 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลมหาสารคาม 8. เสียชีวิตหลัง 48 ชม. หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย Sepsis/Septic shock ที่ส่งต่อจากสถานพยาบาลต้นทาง (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) มายังโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่เสียชีวิตภายหลัง 48 ชั่วโมงหลังเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลมหาสารคาม
ค่าเป้าหมาย	≤ ร้อยละ 34
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อรักษาจากโรงพยาบาลชุมชนที่เสียชีวิต (dead) จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ภายใน 48 ชั่วโมงแรก ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน complication และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) B = จำนวนผู้ป่วยที่รับส่งต่อรักษาจากโรงพยาบาลชุมชนที่ไม่สมัครใจรักษา จากภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired หลัง 48 ชั่วโมงแรก ที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน complication และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) D = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired ทั้งหมดที่ลง ICD 10 รหัส R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis และ

	Comorbidity ไม่นับรวมที่ลงใน complication และไม่นับรวมผู้ป่วย palliative (รหัส Z 51.5) (รอแก้ไข ให้อยู่ใน 1 หน้ากระดาษ)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A+B) / D * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 38	ร้อยละ 36	ร้อยละ 34	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ศุภธิดา เทินสระเกษ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1		3. SEPSIS: อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis		
เป้าประสงค์ที่ 1		เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัดค่า		OKR 3.1 ร้อยละการวินิจฉัยผิดพลาด/คลาดเคลื่อน		
คำนิยาม		1. การวินิจฉัยผิดพลาด/คลาดเคลื่อน หมายถึง แพทย์ให้การวินิจฉัยโรคหรือภาวะของผู้ป่วยไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่ทันเวลา ส่งผลให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลหรือการรักษาที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่แย่ลง หรือเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย การวินิจฉัยผิดพลาดสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท 1.1 Missed diagnosis – ไม่สามารถวินิจฉัยได้ ทั้งที่มีข้อมูลเพียงพอ 1.2 Delayed diagnosis – วินิจฉัยล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น 2. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของการอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด หรือพบว่าการติดเชื้อที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย 3. การส่งต่อรักษาจาก รพช. หมายถึง กระบวนการรับส่งต่อผู้ป่วย Sepsis จากสถานพยาบาลต้นทาง (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) 4. แนวปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง แนวปฏิบัติในการวินิจฉัย และให้การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด		
ค่าเป้าหมาย		ร้อยละการวินิจฉัยผิดพลาด/คลาดเคลื่อน น้อยกว่าร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย		ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่ส่งตัวรักษาต่อจาก รพช. ทั้งหมด		
แหล่งข้อมูล		ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียง		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด		$(A/B) \times 100$		
ข้อมูลที่ต้องการ	ตัวตั้ง	A = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมดที่ส่งตัวรักษาจากโรงพยาบาลชุมชนที่การวินิจฉัยผิดพลาด/คลาดเคลื่อน		
	ตัวหาร	B = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมดที่ส่งตัวรักษาจากโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด		
รหัสโรคที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง/ ตัวหาร	รหัส A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis หรือ Comorbidity เท่านั้น		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้องรายงาน)		** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี		2570	2571	2572
		ร้อยละ 14	ร้อยละ 12	ร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด		พว.สุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		พญ.ศุภจิตา เทินสระเกษ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1		3. SEPSIS: อัตราเสียชีวิตของผู้ป่วย Sepsis		
เป้าประสงค์ที่ 1		เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัด		OKR 3.2 ร้อยละการให้การรักษ่าเบื้องต้นเหมาะสม		
คำนิยาม		1. การรักษ่าเบื้องต้น หมายถึง การรักษ่าตาม 1 hours bundle ตาม sepsis protocol 2. ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของการอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด หรือพบว่ามีเม็ดเลือดขาวที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย 3. การส่งต่อรักษ่าจาก รพช. หมายถึง กระบวนการรับส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด จากสถานพยาบาลต้นทาง (โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง) 4. แนวปฏิบัติการรักษ่าผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง แนวปฏิบัติในการวินิจฉัย และให้การรักษ่าผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ตาม 1 hours bundle ตาม sepsis protocol		
ค่าเป้าหมาย		ร้อยละการให้การรักษ่าเบื้องต้น เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย		ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดที่ส่งตัวรักษ่าต่อจาก รพช. ทั้งหมด		
แหล่งข้อมูล		ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียง		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด		$(A/B) \times 100$		
ข้อมูลที่ ต้องการ	ตัวตั้ง	A = จำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดปฏิบัติตาม 1 hours bundle ตาม sepsis protocol ครบถ้วน		
	ตัวหาร	B = จำนวนผู้ป่วยที่ส่งตัวรักษ่าจากโรงพยาบาลชุมชนที่การวินิจฉัยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมด		
รหัสโรคที่ เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง/ ตัวหาร	รหัส A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R 65.1 และ R57.2 ใน Principle Diagnosis หรือ Comorbidity เท่านั้น		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน		** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี		2570	2571	2572
		≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 90	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด		พว.สุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด		พญ.ศุภธิดา เพินสระเกษ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	4. UGIB : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย UGIB
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ตัวชี้วัด	KPI 4 อัตราผู้ป่วย UGIB ที่ส่งต่อจากรพ. มีอาการทรุดลง ขณะนำส่ง
คำนิยาม	Upper Gastrointestinal Bleeding หมายถึง ผู้ป่วยที่ส่งต่อจากรพ.และได้รับการวินิจฉัยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น การแบ่งความรุนแรงของการเสียเลือด 1) การเสียเลือดระดับ I (Class I Hemorrhage) ผู้ป่วยมีการเสียเลือดตั้งแต่ 10 - 15% ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย หรือประมาณ 750 มล. การเสียเลือดในระดับนี้ร่างกายผู้ป่วยจะไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงความผิดปกติ 2) การเสียเลือดระดับ II (Class II hemorrhage) ผู้ป่วยมีการเสียเลือดปานกลาง ตั้งแต่ 15-30% ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย หรือประมาณ 750-1,500 มล. ทำให้เกิดอาการกระสับกระส่าย หัวใจเต้นเร็ว 100-120 ครั้ง/นาที หายใจปกติ Capillary refill นานเกิน 3 วินาที และความดันโลหิตปกติ แต่ Pulse pressure แคบเล็กน้อย 3) การเสียเลือดระดับ III (Class III hemorrhage) เป็นการเสียเลือดรุนแรงที่เกิดอย่างรวดเร็ว ในปริมาณตั้งแต่ 30-40 % ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย หรือ 1,500-2,000 มล. ความดันโลหิตต่ำลงมาก Pulse pressure แคบ อัตราการเต้นของหัวใจมากกว่า 120 ครั้ง/นาที หายใจเร็ว 30 -40 ครั้ง/นาที ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน กระสับกระส่าย ปัสสาวะออกน้อย 5-15 มล./ชม. Capillary refill นานเกิน 3 วินาที 4) การเสียเลือดระดับ IV (Class IV hemorrhage) ผู้ป่วยที่เสียเลือดในระดับนี้ มัก มี อาการรุนแรงและใกล้เสียชีวิต ในระดับนี้จะมีการเสียเลือดมากกว่า 40% ของปริมาณเลือดทั้งหมดในร่างกาย ความดันโลหิตต่ำ Pulse pressure แคบกว่า 25 mmHg หัวใจเต้นเร็วกว่า 140 ครั้ง/นาที Capillary refill นาน เกิน 3 วินาที จำเป็นต้องให้ resuscitation อย่างรวดเร็ว การอาการทรุดลง หมายถึง อาการของผู้ป่วย UGIB แย่ลงอย่างชัดเจนระหว่างการส่งต่อ เช่น มีภาวะช็อกที่เพิ่มระดับขึ้น ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ความดันโลหิตต่ำลง อย่างมีนัยสำคัญ หรือเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลมหาสารคาม
คำเป้าหมาย	น้อยกว่า ร้อยละ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย UGIB ที่ส่งตัวมาจาก รพช. เพื่อมารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A = จำนวนครั้งของผู้ป่วย UGIB ที่ส่งตัวมาจาก รพช.และมีอาการทรุดลงระหว่างนำส่ง B = จำนวนผู้ป่วย UGIB ที่ส่งตัวมาจาก รพช. ทุกราย
	A = (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K25.6, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2)

	B = (Upper gastrointestinal bleeding : K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้องรายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	<5	<5	<5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐวิวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	4. UGIB : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย UGIB		
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัด	OKR 4.1 ร้อยละการรักษาเบื้องต้นเหมาะสมจาก รพช.		
คำนิยาม	การรักษาเบื้องต้น หมายถึง การประเมินและการรักษาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาความดันโลหิต ปริมาณเลือดและการทำงานของอวัยวะที่สำคัญให้อยู่ในภาวะคงที่ตามแนวปฏิบัติ		
ค่าเป้าหมาย	มากกว่า ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย UGIB ที่ได้รับการส่งต่อจาก รพช. เพื่อมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วย UGIB ที่มีการรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมจาก รพช. ก่อนส่งต่อมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาสารคาม B = จำนวนผู้ป่วย UGIB ทั้งหมดที่ได้รับการส่งต่อจาก รพช. เพื่อมารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
	A = (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) จากทุกหอผู้ป่วย B = (Upper gastrointestinal bleeding : K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) * 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐวิวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	5. Postpartum hemorrhage with Shock (PPH) ระดับ 3- 4 : การส่งต่อปลอดภัยในผู้ป่วย PPH with Shock ระดับ 3- 4			
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคมะเร็งที่สำคัญ			
ตัวชี้วัด	KPI 5 อัตราการส่งต่อผู้ป่วยปลอดภัยในผู้ป่วย PPH with Shock ระดับ 3 - 4			
คำนิยาม	1. การส่งต่อ หมายถึง การส่งมารดาหลังคลอดจากโรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. Postpartum hemorrhage grade 3-4 หมายถึง ภาวะตกเลือดที่มีความรุนแรงสูงมาก ดังนี้ • Class 1 เพิ่ม • ระดับ 2 เพิ่ม • ระดับ 3 หรือ Severe PPH: เป็นภาวะตกเลือดรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายอย่างชัดเจน โดยอาจมีการเสียเลือดมากกว่า 2,000 มิลลิลิตร หรือมีอาการและอาการแสดงที่บ่งชี้ถึงภาวะช็อกได้ เช่น ความดันโลหิตต่ำลงอย่างมาก อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มสูงขึ้น หายใจเร็ว ตัวเย็น เหงื่อออก และอาจมีปัสสาวะน้อยลง • ระดับ 4 หรือ Massive PPH: เป็นภาวะตกเลือดที่รุนแรงที่สุดและเป็นอันตรายถึงชีวิต โดยมีการเสียเลือดในปริมาณมากถึง 3,000 มิลลิลิตรขึ้นไป หรือมีอาการช็อกที่รุนแรงมากจนไม่ตอบสนองต่อการรักษาเบื้องต้น และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ตามมา เช่น ภาวะลิ่มเลือด หรือภาวะเลือดไม่แข็งตัว			
ค่าเป้าหมาย	มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	มารดาหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย และมีการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	สถิติการคลอด กลุ่มงานสูติรีเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม รายงาน ก.2 จังหวัดมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A = มารดาหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย ที่ไม่มีความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป มีการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม B = มารดาหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย และมีการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) * 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 95	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สุภาพร สุภาพวิวัฒน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สุขใจ บุณยะบุญญิต			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	5. PPH with Shock ระดับ 3- 4 : การส่งต่อปลอดภัยในผู้ป่วย PPH with Shock ระดับ 3- 4		
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัด	OKR 5.1 อัตราการส่งต่อในผู้ป่วยกลุ่มมารดาหลังคลอดด้วยภาวะ PPH with Shock ระดับ 3- 4 ลดลง		
คำนิยาม	1.การส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อมารดาหลังคลอดจากโรงพยาบาลในเครือข่าย มายังโรงพยาบาลมหาสารคาม 2.PPH with Shock ระดับ 3-4 หมายถึง มารดาหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย มีการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม		
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มมารดาหลังคลอดด้วยภาวะ PPH with Shock ระดับ 3- 4 ที่ได้รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่าย มาโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	สถิติคลอด กลุ่มงานสูติรีเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม รายงาน ก.2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A=มารดาหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย มีการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม B=ผู้ป่วยกลุ่มมารดาหลังคลอด ที่รับการส่งต่อจากโรงพยาบาลเครือข่าย มาโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สุภาพร สุภาพวิวัฒน์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สุขใจ บุณยะบุญญ์ติ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	5. PPH with Shock ระดับ 3- 4 : การส่งต่อปลอดภัยในผู้ป่วย PPH with Shock ระดับ 3- 4		
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัด	OKR 5.2 ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระหว่างการส่งต่อในผู้ป่วยกลุ่มมารดาหลังคลอดด้วยภาวะ PPH with Shock ระดับ 3-4 ลดลง		
คำนิยาม	1.การส่งต่อ หมายถึง การส่งต่อมารดาหลังคลอดจากโรงพยาบาลในเครือข่าย มายังโรงพยาบาลมหาสารคาม 2.PPH with Shock ระดับ 3-4 หมายถึง มารดาหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย มีการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม		
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	มารดาหลังคลอดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะ PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย มีการส่งต่อมาโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ระบบรายงานอุบัติการณ์ (Incident Report System) สถิติคลอด กลุ่มงานสูติรีเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม รายงาน ก.2 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A=ความเสี่ยงระหว่างการส่งต่อในผู้ป่วยกลุ่มมารดาหลังคลอดด้วยภาวะ PPH with Shock ระดับ 3-4 B=มารดาหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPH with Shock ระดับ 3-4 ที่โรงพยาบาลในเครือข่าย มีการส่งต่อมายังโรงพยาบาลมหาสารคาม ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B*100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สุภาพร สุภาพวิวัฒน์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สุใจ บุณยะบุญญ์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	6. Dengue Hemorrhagic Fever 6.1 ไม่พบอุบัติการณ์วินิจฉัยโรค ไข้เลือดออกผิดพลาดในรพช.เครือข่าย		
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัด	KPI 6 อุตการณ์ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป ใน รพช.		
คำนิยาม	ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก หมายถึง การวินิจฉัยโรคไข้เลือดออกคลาดเคลื่อน หมายถึง... ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้ Intervention เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) หมายถึง ผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคหลัก เป็นไข้เลือดออก ICD-10 = ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอายุ < 15 ปี		
คำเป้าหมาย	ร้อยละของการเกิดภาวะ shock (เกณฑ์ 0)		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มาจาก รพช.		
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูลไข้เลือดออกในเด็ก โรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก ได้รับการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป ใน รพช.		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนันทิชา หาโกสีย์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	อจ.ชมพู่		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	1.PPHN : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
ตัวชี้วัด	KPI 7 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN
คำนิยาม	PPHN ย่อมาจาก Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn หรือ ภาวะความดันโลหิตสูงในปอดของทารกแรกเกิด เป็นภาวะที่ทารกแรกเกิดมีแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงกว่าปกติหลังคลอด ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่ปอดเพื่อรับออกซิเจนได้เพียงพอ แต่ไหลผ่านทางลัด (shunt) เช่น ductus arteriosus หรือ foramen ovale กลับเข้าสู่การไหลเวียนใหญ่ ส่งผลให้เกิดการขาดออกซิเจนเรื้อรังและรุนแรง แม้ว่า ปอดจะไม่เสียหายโดยตรงก็ตาม และปอดของทารกจะทำงานได้ตามปกติ แต่การแลกเปลี่ยนก๊าซไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเลือดส่วนใหญ่ไหลผ่านทางลัด (shunt) กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนใหญ่โดยไม่ผ่านปอด ลักษณะสำคัญ 1. พบได้ในทารกครบกำหนดหรือเกือบครบกำหนด 2. มักสัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนในครรภ์, การสำลักขี้เทา (meconium aspiration), ภาวะปอดบวม, หรือความผิดปกติของการพัฒนาปอด 3. อาการหลัก: เฝียว (cyanosis) รุนแรง, หายใจลำบาก, ค่าออกซิเจนต่ำแม้ให้ออกซิเจนสูง ความสำคัญ PPHN ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางทารกแรกเกิด ต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที เช่น การช่วยหายใจ, การใช้ยาขยายหลอดเลือดปอด (เช่น inhaled nitric oxide), และบางรายอาจต้องใช้ ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN หมายถึง สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) แล้วเสียชีวิต ต่อจำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด คูณด้วย 100
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 50
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะ PPHN ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile Tracer PPHN : กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาลและอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต
รายการข้อมูล	อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN = $(A/B) * 100$ ● A = จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และเสียชีวิต (นับเฉพาะรายที่เสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาล หรือตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) ● B = จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (ทุกรายที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่ประเมิน ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือรอดชีวิต)

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	<50	<50	<50	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปวีณา วนารมย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	1.PPHN : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN		
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัด	OKR 7.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax ลดลง		
คำนิยาม	Pneumothorax หรือ ภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอด หมายถึง ภาวะที่มี อากาศรั่วเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural cavity) ระหว่างเยื่อหุ้มปอดด้านใน (visceral pleura) และเยื่อหุ้มปอดด้านนอก (parietal pleura) ทำให้ปอดถูกกดและแฟบลงบางส่วนหรือทั้งหมด ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงและผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax จากภาวะ PPHN คือ สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และเกิดภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax) ต่อจำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด		
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 10 ($\leq$ ร้อยละ 10)		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) และเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาล โดยมีภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax เกิดขึ้นระหว่างการรักษารักษา		
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile Tracer PPHN : กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาลและอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต		
รายการข้อมูล	อัตราการเกิด Pneumothorax ใน PPHN = $(A/B) * 100$ - A = จำนวนทารกที่มี PPHN และเกิดภาวะ Pneumothorax - B = จำนวนทารกทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ด้วย 100		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) * 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปิรพล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปิยฉวี วนารมย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	1. PPHN : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN			
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
ตัวชี้วัด	OKR 7.2 อัตราการได้รับยา Proper vasodilator ภายใน 30 นาที			
คำนิยาม	Proper vasodilator ใน PPHN หมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงในการลดความต้านทานของหลอดเลือดปอด เช่น Inhaled Nitric Oxide, Sildenafil, Milrinone เพื่อให้การไหลเวียนเลือดผ่านปอดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของทารกดีขึ้น และบรรเทาภาวะพร่องออกซิเจนในทารกที่มี PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) อัตราการได้รับยา Proper vasodilator ใน PPHN หมายถึง สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และได้รับยาขยายหลอดเลือดปอดที่เหมาะสม (เช่น iNO, Sildenafil, Milrinone) ต่อจำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด คูณด้วย 100			
ค่าเป้าหมาย	มากกว่าร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) และเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล โดยได้รับยา Proper vasodilator ระหว่างการรักษา			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile Tracer PPHN : กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาลและอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต			
รายการข้อมูล	อัตราการได้รับยา Proper vasodilator ใน PPHN = (A/B) * 100 A = จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และได้รับยา Proper vasodilator B = จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	มากกว่าร้อยละ 80	มากกว่าร้อยละ 80	มากกว่าร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปิวิศา วนารมย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	1. Preterm : ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด		
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
ตัวชี้วัด	KPI 8 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ลดลง		
คำนิยาม	Newborn หรือ ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุครบ 28 วัน (0-28 วันหลังคลอด) ไม่ว่าจะคลอดครบกำหนด (term) หรือคลอดก่อนกำหนด (preterm) อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด (Neonatal Mortality Rate: NMR) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนทารกแรกเกิดที่มีชีวิตซึ่งเสียชีวิตภายในอายุ 0-28 วันแรกหลังคลอด ต่อจำนวนการเกิดมีชีพ (Live births) ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน คูณด้วย 1,000		
ค่าเป้าหมาย	ลดลง 10%		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดที่มีชีวิต (Live births) ทุกคนในช่วงเวลาที่ประเมิน โดยติดตามการเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 28 วัน		
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile : กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาล และอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต		
รายการข้อมูล	อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด (Neonatal Mortality Rate: NMR) = $(A/B) * 1,000$ หรือ (จำนวนทารกแรกเกิดที่เสียชีวิตอายุน้อยกว่า 28 วัน / จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด) $\times 1,000$ • A = จำนวนทารกที่เสียชีวิตก่อนอายุครบ 28 วัน (รวมตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงวันที่ 28) • B = จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน • ผลลัพธ์ แสดงเป็น “ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 ราย”		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) * 1,000$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปรีพล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปิวิภา วรณมย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	1. Preterm : ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด			
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
ตัวชี้วัด	OKR 8.1 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม			
คำนิยาม	ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม หมายถึง ทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิด < 1,000 กรัม จัดเป็นกลุ่ม Extremely Low Birth Weight (ELBW) มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตสูง ต้องการการดูแลแบบเข้มข้นใน NICU อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม หมายถึง สัดส่วน (ร้อยละ หรือ ต่อ 1,000 ราย) ของทารกแรกเกิดมีชีวิตที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม (Extremely Low Birth Weight; ELBW) แล้วเสียชีวิตภายในช่วงอายุ 0–28 วันแรก หลังคลอด ต่อจำนวนทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัมทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน			
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 10			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดมีชีวิต (Live births) ที่มีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม (Extremely Low Birth Weight; ELBW) ที่เกิดและเข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาล/พื้นที่ที่กำหนด ในช่วงเวลาที่ประเมิน			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile : กุมภาพันธ์กรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาลและอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต			
รายการข้อมูล	อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม <1,000 กรัม = (A/B) * 100 A = จำนวนทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม และเสียชีวิตภายในอายุ 0–28 วัน B = จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1,000 กรัม (Live births <1,000 g) คูณ 100 (หน่วยเป็นร้อยละ) หรือบางรายงานอาจแสดงเป็น ต่อ 1,000 live births <1,000 g			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ บริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปวีณา วรารมย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	1. Preterm : ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด			
เป้าประสงค์ที่ 1	เพิ่มคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
ตัวชี้วัด	OKR 8.2 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000-1,499 กรัม			
คำนิยาม	ทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000–1,499 กรัม หมายถึง ทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดอยู่ในช่วง Very Low Birth Weight (VLBW) มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อนและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดใน NICU อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000–1,499 กรัม หมายถึง สัดส่วน (ร้อยละ หรือ ต่อ 1,000 ราย) ของทารกแรกเกิดมีชีวิตที่มีน้ำหนักแรกเกิดระหว่าง 1,000–1,499 กรัม (Very Low Birth Weight; VLBW) แล้วเสียชีวิตภายในอายุ 0–28 วันแรก หลังคลอด ต่อจำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดที่มีน้ำหนัก 1,000–1,499 กรัม ในช่วงเวลาเดียวกัน			
ค่าเป้าหมาย	ลดลง 10%			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดมีชีวิต (Live births) ที่มีน้ำหนักแรกเกิดอยู่ระหว่าง 1,000–1,499 กรัม (Very Low Birth Weight; VLBW) ที่เกิดและเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล/พื้นที่ที่กำหนด ในช่วงเวลาที่ประเมิน			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile : กุมภาพันธ์กรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาล และอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต			
รายการข้อมูล	อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 1,000–1,499 กรัม = (A/B) * 100 A = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีวิตน้ำหนักแรกเกิด 1,000–1,499 กรัม ที่เสียชีวิตภายในอายุ 0–28 วัน B = จำนวนทารกแรกเกิดมีชีวิตทั้งหมดที่มีน้ำหนักแรกเกิด 1,000–1,499 กรัม หน่วยวัด = ร้อยละ (%) หรืออาจแสดงเป็น “ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 รายในกลุ่มนี้”			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปิวิภา วารมย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (อายุรกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. STEMI : ลดอัตราการเสียชีวิต			
ตัวชี้วัด	KPI 9 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI			
คำนิยาม	โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI หมายถึง กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดการตายของกล้ามเนื้อ และมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติชนิดเอสทียก (ST-Elevated Myocardial Infarction) อัตราตายในผู้ป่วย STEMI 1.ผู้ป่วย STEMI หมายถึง ผู้ป่วย STEMI ที่เป็นผู้ป่วยใน หรือผู้ป่วยมาตรวจที่ แผนกฉุกเฉินและมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า (โดยนับการเจ็บป่วยในครั้งนั้นเป็น 1 visit) 2.การตายของผู้ป่วย STEMI หมายถึง การตายจากสาเหตุโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	น้อยกว่าร้อยละ 8			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้แก่ - ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด - ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก Thai ACS Registry, HDC หรือเวชระเบียน			
รหัสเหตุการณ์/รหัสโรค **เฉพาะทางคลินิก**	A = ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลทั้งหมด B = ผู้ป่วยใน รหัส ICD10- WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B)×100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	น้อยกว่าร้อยละ 4.5	น้อยกว่าร้อยละ 4.5	น้อยกว่าร้อยละ 4.5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปาริชาติ ศรีหนู			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิธร ดวงพรหม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (อายุรกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. STEMI : ลดอัตราการเสียชีวิต 1.1 ผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาทีทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 9.1 อัตราผู้ป่วย STEMI ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที			
คำนิยาม	ผู้ป่วย STEMI หมายถึง ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที โดยเริ่มจาก.....ถึง.....			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้แก่ ผู้ป่วยใน รหัส ICD10-WHO I21.0-I21.3 ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก Thai ACS Registry, HDC หรือเวชระเบียน			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดภายใน 30 นาที B : จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปาริชาติ ศรีหนู			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิธร ดวงพรหม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (อายุรกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. STEMI : ลดอัตราการเสียชีวิต 1.2 ผู้ป่วย STEMI ได้รับ Reperfusion ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 9.2 ผู้ป่วย STEMI ได้รับ Reperfusion			
คำนิยาม	ผู้ป่วย STEMI หมายถึง ... ผู้ป่วย STEMI ได้รับ Reperfusion หมายถึง...			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ได้แก่ ผู้ป่วยใน รหัส ICD10-WHO I21.0-I21.3 ทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก Thai ACS Registry, HDC หรือเวชระเบียน			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับ Reperfusion B : จำนวนผู้ป่วย STEMI ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปาริชาติ ศรีหนู			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิธร ดวงพรหม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง			
ตัวชี้วัด	KPI 10 อัตราผู้ป่วย Ischemic Stroke เสียชีวิตในโรงพยาบาล			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63) เสียชีวิตในโรงพยาบาล			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 3			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63)ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล B= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63)เียบพลันภายใน 72 ชั่วโมงที่รักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเติม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 5	ร้อยละ 4	ร้อยละ 3	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุพิชชา อีรศาสด์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง			
ตัวชี้วัด	OKR 10.1 อัตราผู้ป่วย Stroke ได้รับยา thrombolysis ทันภายใน 60 นาที			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน Ischemic stroke I63 ได้รับยาละลายลิ่มเลือด thrombolysis			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน Ischemic stroke I63 ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน Ischemic stroke I63 ได้รับยาละลายลิ่มเลือด thrombolysis ภายใน 60 นาที B= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน Ischemic stroke I63 ได้รับยาละลายลิ่มเลือด thrombolysis ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเติม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	ร้อยละ100	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุพิศชา อีรศาสด์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง			
ตัวชี้วัด	OKR 10.2 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตึบที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รับการรักษาใน stroke unit			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Ischemic stroke I63) Stroke unit หมายถึง stroke unit/			
คำเป้าหมาย	เพิ่มการเข้าถึง stroke unit หรือ stroke conner ลดอัตราการเสียชีวิต			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63)ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง ได้รักษาใน stroke unit/ stroke Conner B= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมด (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63)ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมง			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเติม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	100	100	100	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุพิศชา อิศาศาวัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง			
ตัวชี้วัด	OKRs 10.3 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน ที่ต้องส่งต่อ mechanical thrombectomy ทันภายใน 60 นาที			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน Ischemic stroke I63 **เพิ่มระยะเวลาของแต่ละข้อที่มีระยะเวลากำกับ			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Ischemic stroke I63 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน Ischemic stroke I63 ที่ต้องส่งต่อ mechanical thrombectomy ทันภายใน 60 นาที B= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน Ischemic stroke I63 ที่ต้องส่งต่อ mechanical thrombectomy ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเติม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	ร้อยละ 80	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุพิศชา อิศาศาสตร์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Stroke : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง			
ตัวชี้วัด	OKR 10.4 อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง เฉียบพลันที่มีความจำเป็นต้องเจาะคอ ได้รับการ Early tracheotomy			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63) เฉียบพลัน(มีอาการภายใน 72 ชั่วโมง) ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่จำเป็นต้องเจาะคอ คือ SET Score ≥ 8 และ ญาติยินยอมเจาะคอ Early tracheotomy ได้รับการเจาะคอภายใน 8 วัน นับจากการ consult ลดอัตราการเสียชีวิต			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63)เฉียบพลัน ที่Early tracheotomy B= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Hemorrhagic stroke I60-I62 และ Ischemic stroke I63)เฉียบพลันที่ทำ tracheotomy ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเติม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นางเบญจพร เองวานิช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุพิชชา อิศาศวัต			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (อายุรกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. Sepsis : ลดอัตราการเสียชีวิต			
ตัวชี้วัดที่	KPI 11 อัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Sepsis			
คำนิยาม	1.การเสียชีวิตของผู้ป่วยใน หมายถึง การเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะที่เข้ารับการรักษาก่อนเป็นผู้ป่วยใน โดยมีระยะเวลาการนอนพักรักษานานตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป 2.ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของการอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด หรือพบว่ามีการติดเชื้อที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย (reference : surviving sepsis campaign 2012) ซึ่งมี Pdx หรือ Sdx หรือมีอาการแสดงตามรหัสโรค ICD-10 TM ที่กำหนด ***นับผู้ป่วย sepsis ในรพ.หรือไม่?? ** นับ palliative หรือ against advice ??			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 11			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน			
รายการข้อมูล	ตัวตั้ง A คือจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาลที่เสียชีวิต ตัวหาร B คือ จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาล			
รหัสโรค/เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง	ตัวตั้ง Pdx = A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ Sdx = A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1 และเสียชีวิตด้วยสาเหตุ sepsis ตัวหาร A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	15	13	11	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ service plan อายุรกรรม (sepsis) ขอชื่อผู้เก็บ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นส.สุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (อายุรกรรมชั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. Sepsis : ลดอัตราการเสียชีวิต 3.1 กลุ่มเสี่ยง Sepsis (1. อายุ > 60 ปี , 2. กลุ่ม Disease Poor control (DM,ESRD) 3.ผู้ป่วยติดเชื้อ) ที่มีอาการสงสัยติดเชื้อ ได้รับการประเมินด้วย S-NEWS และ SIRS เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 11.1 กลุ่มเสี่ยง Sepsis ที่มีอาการสงสัยติดเชื้อ ได้รับการประเมินด้วย S-NEWS และ SIRS
คำนิยาม	1.การประเมินด้วย S-NEWS และ SIRS หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทุกรายต้องได้รับการประเมินด้วย S-NEWS ทุกวัน และกลุ่มที่มีอาการสงสัยติดเชื้อต้องได้รับการประเมินซ้ำด้วย SIRS 2.ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของการอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับพบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด หรือพบว่ามีเม็ดเลือดขาวที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย (reference: surviving sepsis campaign 2012) ซึ่งมี Pdx หรือ Sdx หรือมีอาการแสดงตามรหัสโรค ICD-10 TM ที่กำหนด 3.กลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือด ได้แก่ 1. อายุ > 60 ปี 2. กลุ่ม Disease Poor control (DM,ESRD) 3.กลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ S-NEWS หมายถึง Systemic inflammatory response syndrome (SIRS) หมายถึง
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล แผนกผู้ป่วยใน
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน
รายการข้อมูล	ตัวตั้ง A คือจำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาลได้รับการประเมินภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ตัวหาร B คือ จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดทั้งหมดที่รับไว้ในโรงพยาบาล
	ตัวตั้ง Pdx = A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1 Sdx = A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1 ตัวหาร A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	90	95	100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ service plan อายุรกรรม (sepsis) ขอชื่อ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นส.สุคนธ์ทิพย์ ปัตติหานัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร	
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)	
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (อายุรกรรมขั้นเลิศ)	
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ	
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. Sepsis : ลดอัตราการเสียชีวิต 3.2 ลดการเกิด septic shock ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดไม่รุนแรง (community-acquired sepsis)	
ตัวชี้วัดที่	OKR 11.2 อัตราการเกิด septic shock ในผู้ป่วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดไม่รุนแรง (community-acquired sepsis)	
คำนิยาม	1.ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด (sepsis) หมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของการอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับการพบเชื้อจากการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด หรือพบว่ามีเม็ดเลือดขาวที่ใดที่หนึ่งในร่างกาย (reference: surviving sepsis campaign 2012) ซึ่งมี Pdx หรือ Sdx หรือมีอาการแสดงตามรหัสโรค ICD-10 TM ที่กำหนด 2. Septic shock หมายถึง ผู้ป่วยที่สงสัยหรือยืนยันว่ามีการติดเชื้อใน ร่างกาย ร่วมกับ มี SIRS ตั้งแต่ 2 ข้อ ขึ้นไป (ตารางที่ 1) ที่มี hypotension ต้องใช้ vasopressors ในการ maintain MAP ≥65 mm Hg และ มีค่า serum lactate level >2 mmol/L (18 mg/dL) แม้ว่าจะได้สารน้ำเพียงพอแล้วก็ตาม 3. Community-acquired sepsis หมายถึง การติดเชื้อมาจากที่บ้านหรือที่ชุมชน โดย ต้อง ไม่อยู่ในกลุ่ม hospital-acquired sepsis	
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 5	
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดไม่รุนแรง (community-acquired sepsis) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกระดับ	
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลของโรงพยาบาลหรือ ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข หรือเก็บผ่านโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกัน	
รายการข้อมูล	ตัวตั้ง	A = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดไม่รุนแรง (community-acquired sepsis) ที่เกิดภาวะ septic shock ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล
	ตัวหาร	B = จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดชนิดไม่รุนแรง (community-acquired sepsis) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x100	
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **	

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	15	10	5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ service plan อายุรกรรม (sepsis) ขอชื่อ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นส.สุคนธ์ทิพย์ ปัตติทานัง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (อายุรกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4.TB : ลดอัตราการเสียชีวิต			
ตัวชี้วัดที่	KPI 12. อัตราผู้ป่วย TB เสียชีวิต			
คำนิยาม	ผู้ป่วยวัณโรคปอด หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวินิจฉัยเป็นโรควัณโรคปอดรายใหม่และไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรควัณโรคปอดดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (MDR-TB, Pre-XDR-TB, XDR-TB) การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่อยู่ระหว่างการรักษาวัณโรค			
ค่าเป้าหมาย	≤ ร้อยละ 5			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม NTIP			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย TB เสียชีวิต B :จำนวนผู้ป่วย TB ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A*B/100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤ ร้อยละ 7	≤ ร้อยละ 6	≤ ร้อยละ 5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรุ่งลาวัลย์ ไลออน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ศิโรตม์ จันทรักษา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร									
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)									
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (อายุรกรรมขั้นเลิศ)									
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ									
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4.TB : ลดอัตราการเสียชีวิต 4.1 ไม่พบอุบัติการณ์วินิจัย TB ล่าช้าและคลาดเคลื่อน									
ตัวชี้วัดที่	OKR 12.1 อับัติการณ์วินิจัย TB ล่าช้าและคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป									
คำนิยาม	การวินิจัย TB ล่าช้า หมายถึง การพบว่าผู้ป่วยมีภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติอยู่เดิมที่เข้าได้กับโรควัณโรคปอด แต่ไม่ได้รับการส่งตรวจเสมหะเพื่อวินิจัยโรควัณโรคปอด การส่งตรวจเสมหะเพื่อวินิจัยโรควัณโรคปอด ได้แก่ Sputum AFB, Sputum Gene X-pert, Sputum C/S TB โดยมีระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (Harm) ตั้งแต่ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้ Intervention เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต									
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0									
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยวัณโรคปอด									
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม NTIP									
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์วินิจัย TB ล่าช้าและคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป									
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A									
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **									
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>เท่ากับ 0</td><td>เท่ากับ 0</td><td>เท่ากับ 0</td></tr></table>	2570	2571	2572	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0			
2570	2571	2572								
เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0								
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรุ่งลาวัลย์ โลออน									
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ศิโรตม์ จันทรักษา									

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (อายุรกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4.TB : ลดอัตราการเสียชีวิต 4.1 ไม่พบอุบัติการณ์วินิจฉัย TB ล่าช้าและคลาดเคลื่อน 4.2 ผู้ป่วย TB ทุกรายได้รับการกำกับและติดตามการกินยาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข			
ตัวชี้วัดที่	OKR 12.2 อัตราผู้ป่วยวัณโรคปอดได้รับการกำกับและติดตามการกินยา (DOTs/VOTs) และโภชนาการ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข			
คำนิยาม	ผู้ป่วยวัณโรคปอด หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ได้รับการขึ้นทะเบียนวินิจฉัยเป็นโรควัณโรคปอด การเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรคปอด หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่อยู่ระหว่างการรักษาวัณโรค การกำกับและติดตามการกินยา (DOTs/VOTs) และโภชนาการ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หมายถึง การที่ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยตรง (Directly-Observed Treatment, DOTs) หรือ การที่ผู้ป่วยกินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผ่านทางระบบวิดีโอคอล (Video-Observed Treatment, VOTs) ร่วมกับการประเมินภาวะโภชนาการผ่านแบบคัดกรอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประกอบไปด้วย พยาบาลชุมชน เจ้าหน้าที่รพ.สต. อสม.			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยวัณโรคปอด			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม NTIP			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ได้รับการกำกับและติดตามการกินยา (DOTs/VOTs) และโภชนาการ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข B :จำนวนผู้ป่วยวัณโรคปอดทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A*B/100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรุ่งลาวัลย์ โลออน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ศิโรตม์ จันทรักษา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. Multiple injury : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบและมี Injury severity score (ISS) > 15
ตัวชี้วัดที่	KPI 13 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบและมี Injury severity score (ISS) > 15
คำนิยาม	Multiple injury คือ ภาวะที่ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บในร่างกายและส่งผลกระทบต่ออวัยวะมากกว่า 2 ระบบขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นในสถานการณ์เดียวกัน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิกฤตสูง และต้องได้รับการประเมิน-ดูแลแบบเร่งด่วนและเป็นระบบ การเสียชีวิต หมายถึง การเสียชีวิตของผู้ป่วย Multiple Injury ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ผู้ป่วยมาถึงห้องฉุกเฉิน Injury severity score (ISS) หมายถึง ค่าคะแนนความรุนแรงของการบาดเจ็บ ซึ่งเป็นระบบการให้คะแนนเพื่อประเมินความรุนแรงโดยรวมของผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหลายแห่ง โดยนำคะแนนความรุนแรงจากการบาดเจ็บในอวัยวะที่รุนแรงที่สุด 3 ส่วน มายกกำลังสองแล้วนำมารวมกัน ช่วงคะแนนของ ISS มีค่าตั้งแต่ 1 – 75 คะแนน โดยมักจะถือว่า ISS > 15 เป็นการบาดเจ็บที่รุนแรง คะแนนนี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับอัตราการเสียชีวิต การเจ็บป่วย และระยะเวลาการรักษาในโรงพยาบาล
ค่าเป้าหมาย	≤ ร้อยละ 12
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Multiple injury และมี Injury severity score (ISS) > 15 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	- ทะเบียนผู้ป่วย Multiple injury งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน - ทะเบียนของหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย Multiple injury - กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม - โปรแกรม PHER PLUS
รายการข้อมูล	A: จำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบและมี Injury severity score (ISS) > 15 ที่เสียชีวิต B: จำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบและมี Injury severity score (ISS) > 15 ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤ ร้อยละ 15	≤ ร้อยละ 12	≤ ร้อยละ 12	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสิรินารถ ประพาศพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. Multiple injury : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (ISS > 15) 1.1 ผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ได้รับการ Resuscitation ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 13.1 อัตราผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ได้รับการ Resuscitation ที่เหมาะสม			
คำนิยาม	ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 คือ ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหลายตำแหน่งในร่างกายตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพไม่คงที่และมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อน จำเป็นต้องได้รับการประเมินและรักษาแบบเร่งด่วนตามแนวทาง Trauma การ Resuscitation ที่เหมาะสม หมายถึง การ Resuscitation ตาม CPG Trauma ดังเอกสารที่ MKH-FR-SUR-134 แก้ไขครั้งที่ 01 : วันที่บังคับใช้ : 29/พ.ย./65			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	-ทะเบียนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน -ทะเบียนของหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 -กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่ได้รับการ Resuscitation ที่เหมาะสม B : จำนวนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสิรินารถ ประพาตพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. Multiple injury : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 1.2 อัตราผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด ภายใน 60 นาทีเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 13.2 อัตราผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด ภายใน 60 นาที
คำนิยาม	ผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 คือ ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บหลายตำแหน่งในร่างกายตั้งแต่ 2 ระบบขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีสัญญาณชีพไม่คงที่และมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะแทรกซ้อน จำเป็นต้องได้รับการประเมินและรักษาแบบเร่งด่วนตามแนวทาง Trauma ข้อบ่งชี้ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 60 นาที นับจากเวลา Triage จนถึงเวลาลงมีดผ่าตัด มีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ภาวะเลือดออกในช่องท้องหรือช่องอกอย่างรุนแรงร่วมกับสัญญาณชีพไม่คงที่ (Unstable) 2. บาดแผลทะลุบริเวณช่องอกหรือช่องท้องและมีสัญญาณชีพไม่คงที่ หรือเสี่ยงต่อภาวะคุกคามต่อชีวิต 3. การบาดเจ็บต่อเส้นเลือดที่มีภาวะเลือดออกอย่างรุนแรงที่ควบคุมได้ยาก (Active bleeding) หมายเหตุ : ยกเว้นกรณีญาติไม่ยินยอม หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติไม่สามารถทำการผ่าตัดได้
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด ภายใน 60 นาที
แหล่งข้อมูล	-ทะเบียนผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน -ทะเบียนของหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย Multiple Injury Triage Level 1 -กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A: จำนวนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่มีข้อบ่งชี้และได้รับการผ่าตัด ภายใน 60 นาที B: จำนวนผู้ป่วย Multiple injury Triage Level 1 ที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสิรินารถ ประพาศพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ไชยวัฒน์ พาณิชย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. TBI : ลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วย Severe TBI ภายใน 24 ชั่วโมง		
ตัวชี้วัดที่	KPI 14 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe TBI ภายใน 24 ชั่วโมง		
คำนิยาม	ผู้ป่วย Severe Traumatic brain injury (TBI) หมายถึง ผู้ป่วย TBI ที่มี GCS $\leq$ 8 คะแนน ซึ่งอาจมีมาตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลหรือแย่งภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ Triage การเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง หมายถึง ผู้ป่วย Severe traumatic brain injury ตั้งแต่ Triage จนถึงเวลาที่เสียชีวิต (Door to Death) ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิตในห้องฉุกเฉิน		
ค่าเป้าหมาย	$\leq$ ร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	-ทะเบียนผู้ป่วย TBI งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน -ทะเบียนของหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย TBI -กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Severe TBI ที่เสียชีวิต ภายใน 24 ชั่วโมง B : จำนวนผู้ป่วย Severe TBI ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	$\leq$ ร้อยละ 10	$\leq$ ร้อยละ 10	$\leq$ ร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพร อินนอก		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมคริต ศรีพลแทน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราการป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราการตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. TBI : ลดอัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 2.1 ผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 นาทีทุกราย		
ตัวชี้วัดที่	OKR 14.1 อัตราผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 นาที		
คำนิยาม	ผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้าเกณฑ์ หมายถึง ผู้ป่วย Severe TBI ที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ASDH, EDH thickness > 1cm 2. MLS > 0.5cm 3. ICH volume > 30ml 4. Cerebellar ICH 5. Depressed skull fracture > 1 skull thickness ระยะเวลา 240 นาที นับตั้งแต่ Triage จนถึงเวลาในการลงมีดผ่าตัด (Incision time) หมายเหตุ : ยกเว้นกรณีญาติไม่ยินยอม หรือผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการผิดปกติไม่สามารถทำการผ่าตัดได้		
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Severe TBI ที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด		
แหล่งข้อมูล	-ทะเบียนผู้ป่วย TBI งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน -ทะเบียนของหอผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วย TBI -กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้าเกณฑ์และได้รับการผ่าตัดภายใน 240 นาที B : จำนวนผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้าเกณฑ์และได้รับการผ่าตัดทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพร อินนอก		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมคริต ศรีพลแทน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R 2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราการป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. TBI : ลดอัตราการเสียชีวิตภายใน 24 ชั่วโมง 2.2 ผู้ป่วย Severe TBI ที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการรายงานแพทย์ตาม Early warning signs		
ตัวชี้วัดที่	OKRs 14.2 อัตราผู้ป่วย Severe TBI ที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการรายงานแพทย์ตาม Early warning signs		
คำนิยาม	ผู้ป่วย Severe Traumatic brain injury (TBI) หมายถึง ผู้ป่วย TBI ที่มี GCS ≤ 8 คะแนน ซึ่งอาจมีมาตั้งแต่มาถึงโรงพยาบาลหรือแย่งภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ Triage Early warning sign ได้แก่ พบข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ปฏิบัติตามแนวทางการรายงานแพทย์ตาม Early warning signs หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการรายงานแพทย์ตาม Early warning signs ภายใน 5 นาที		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	-ผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้ารับการรักษารักษาในโรงพยาบาลภายใน 24 ชั่วโมง		
แหล่งข้อมูล	-ทะเบียนหอผู้ป่วยที่ดูแลรักษาผู้ป่วย TBI -รายงานการทบทวนอุบัติการณ์		
รายการข้อมูล	A : ผู้ป่วย Severe TBI ที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการรายงานแพทย์ตาม Early warning signs B : ผู้ป่วย Severe TBI ที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 85	2572 ≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพร อินนอก		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมคริต ศรีพลแทน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. UGIB : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย Massive UGIB			
ตัวชี้วัดที่	KPI 15 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Massive UGIB			
คำนิยาม	1.ผู้ป่วยเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นในปริมาณมาก Massive UGIB ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการหรือภาวะต่อไปนี้ ผู้ป่วยช็อค Class 3-4 หรือ ภาวะไหลเวียนล้มเหลว (Hemodynamic instability) SBP < 90 mmHg หรือ MAP < 65 อัตรา HR ≥ 120 bpm มีการเสียชีวิตจากการอาเจียนเลือดสดจำนวนมากและหรือถ่ายดำ/ถ่ายเลือดสดปริมาณ 30-40%ของร่างกาย(1,500-2,000ml) HCT ลดลงจากเดิม ≥ 3 Vol% ภายใน 6 ชม. ต้องให้เลือด ≥ 4-6 unit ภายใน 24 ชม.ไม่สามารถควบคุมการเสียเลือดได้แม้ได้รับยาและ resus แล้ว ยังมี active bleeding 2. การเสียชีวิตของผู้ป่วย เลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นในปริมาณมาก Massive UGIB หมายถึงการเสียชีวิตทุกสาเหตุของผู้ป่วยที่มี Principal diagnosis Massive UGIB 3. การจำหน่ายทุกสถานะหมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจากโรงพยาบาลในทุกสถานะ			
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 5			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นในปริมาณมาก Massive UGIB ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการหรือภาวะตามที่กำหนดในนิยาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตจากภาวะ Massive UGIB (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) จากทุกหอผู้ป่วยในเดือนนั้น B =จำนวนผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ได้รับการจำหน่ายทุกสถานะจากภาวะ Massive UGIB (Upper gastrointestinal bleeding : K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2)จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเดือนเดียวกันนั้น			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) ×100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	< ร้อยละ 20	< ร้อยละ 18	< ร้อยละ 18	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐวิวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. UGIB : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย Massive UGIB 3.1 ผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการ Resuscitation ตามเกณฑ์คุณภาพทุกราย
ตัวชี้วัดที่	OKR 15.1 อัตราผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการ Resuscitation ตามเกณฑ์คุณภาพ
คำนิยาม	1.ผู้ป่วยเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นในปริมาณมาก Massive UGIB ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการหรือภาวะต่อไปนี้ ผู้ป่วยช็อค Class 3-4 หรือภาวะไหลเวียนล้มเหลว (Hemodynamic instability) SBP < 90 mmHg หรือ MAP < 65 อัตราHR > 120 bpm มีการเสียชีวิตจากการอาเจียนเลือดสดจำนวนมากและหรือถ่ายดำ/ถ่ายเลือดสดปริมาณ 30-40%ของร่างกาย(1,500-2,000ml) HCT ลดลงจากเดิม > 3 Vol% ภายใน 6 ชม. ต้องให้เลือด ≥ 4-6 unit ภายใน 24 ชม.ไม่สามารถควบคุมการเสียเลือดได้แม้ได้รับยาและ resus แล้ว ยังมี active bleeding 2.การ Resuscitation ตามเกณฑ์คุณภาพ คือผู้ป่วย Massive UGIB ทั้งที่ส่งต่อมารจาก รพช.ก่อนนำส่งมารักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม หรือจาก ER ได้รับ IV Access NS/LR 1-2 ลิตร เปิด IV 2 เส้น(18-20G) ภายใน 10 นาที, ให้ O2, Monitor V/S ทุก 15 นาที ใน 1 ชม. แรก, On Foley Cath ติดตามปริมาณปัสสาวะ, PPI ใน 1 ชม., Blood Transfusion ตามเกณฑ์, Admit ICU หรือ Cell concept
ค่าเป้าหมาย	มากกว่าหรือเท่ากับ 90%
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Massive UGIB ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A: จำนวนผู้ป่วย Massive UGIB จาก รพช.หรือ ER ได้รับการ Resuscitation ตามเกณฑ์คุณภาพ ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) ทุกหอผู้ป่วยในเดือนนั้น B: จำนวนผู้ป่วย Massive UGIB ที่ได้รับการส่งต่อจาก รพช หรือ ER ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) ทุกหอผู้ป่วยในเดือนเดียวกันนั้น
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B)×100
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐกิจวิวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. UGIB : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย Massive UGIB 3.2 ผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการส่องกล้องภายในเวลา 12-24 เมื่อมาถึงโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 15.2 อัตราผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการส่องกล้องภายในระยะเวลา 12-24 ชม
คำนิยาม	1.ผู้ป่วยเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นในปริมาณมาก Massive UGIB ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการหรือภาวะต่อไปนี้ ผู้ป่วยช็อค Class 3-4 หรือภาวะไหลเวียนล้มเหลว (Hemodynamic instability) SBP < 90 mmHg หรือ MAP < 65 อัตราHR > 120 bpm มีการเสียเลือดจากการอาเจียนเลือดสดจำนวนมาก และหรือถ่ายดำ/ถ่ายเลือดสดปริมาณ 30-40%ของร่างกาย(1,500-2,000ml) HCT ลดลงจากเดิม > 3 Vol% ภายใน 6 ชม. ต้องให้เลือด ≥ 4-6 unit ภายใน 24 ชม.ไม่สามารถควบคุมการเสียเลือดได้แม้ได้รับยาและ resus แล้ว ยังมี active bleeding 2.การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (esophagogastroduodenoscopy) หมายถึงการส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น 3. ภายใน 24 ชม.หมายถึงช่วงเวลาเริ่มนับตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย UGIB และเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน จนถึงเวลาที่ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น
ค่าเป้าหมาย	มากกว่าหรือเท่ากับ 80 %
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Massive UGIB ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A=ผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการส่องกล้อง (EGD)ภายในระยะเวลา 12-24 ชม. เมื่อมาถึงโรงพยาบาล(Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) และวินิจฉัย EGD Code (4516, 4233, 4513, 4443) จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเดือนนั้น B=ผู้ป่วย Massive UGIB ได้รับการส่องกล้อง (EGD) ทั้งหมด (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) และวินิจฉัยEGD Code (4516, 4233, 4513, 4443) เมื่อมาถึงโรงพยาบาลในช่วงเดือนเดียวกันนั้น
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) ×100
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐกิจวิวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. UGIB : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย Massive UGIB 3.3 ลดอัตราการ Re-bleeding จากแผลในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นภายหลังการหยุดเลือดด้วยการส่องกล้องภายใน 72 ชม.
ตัวชี้วัดที่	OKR 15.3 อัตราการ Re-bleeding ในผู้ป่วย UGIBภายหลังการหยุดเลือดด้วยการส่องกล้องภายใน 72 ชม.
คำนิยาม	1.แผลในทางเดินอาหารส่วนต้น (UGIH)หมายถึงแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น 2.การหยุดเลือดด้วยวิธีการส่องกล้อง หมายถึง การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น ร่วมกับ Adrenaline Injection, Heater Probe, Bipolar Electrocautery Probe, Argon Plasma Coagulation (APC), Hemoclippling, Band Ligation และ Histoacryl injection 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกซ้ำหมายถึง 1) ผู้ป่วยที่มีอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดสด หรือ NG lavage พบเลือดหลังการส่องกล้อง 2) ถ่ายดำ/ถ่ายเป็นเลือดสดภายหลังถ่ายเป็นปกติหรือถ่ายดำแล้ว 3) สัญญาณชีพไม่คงที่ (heart rate $\geq$ 110/min หรือ systolic blood pressure $\leq$ 90 mmHgหลังจากสัญญาณชีพคงที่ $\geq$ 1 ชม.โดยไม่มีสาเหตุอื่น) 4) Hemoglobin ลดลง $\geq$ 2 g/dl หลังจาก Hb คงที่ $\geq$ 3 ชม. 5) Tachycardia or Hypotension ไม่ดีขึ้นภายใน 8 ชม.หลังการส่องกล้องทั้งที่ได้ resuscitation ที่เหมาะสมไม่มีเหตุอื่นร่วมกับมีถ่ายดำหรือถ่ายเป็นเลือดอย่างต่อเนื่อง
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย UGIB ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคามและได้รับการส่องกล้อง (EGD)
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A=จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่เกิดภาวะเลือดออกซ้ำจากแผลในระบบทางเดินอาหารส่วนต้นภายหลังได้รับการหยุดเลือดโดยการส่องกล้องสำเร็จ (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K25.6, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) และวินิจฉัย EGD Code (4516, 4233, 4513, 4443) จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเดือนนั้น

	B=จำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่มีแผลในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (UGIB) ได้รับการหยุดเลือดโดยการส่องกล้องสำเร็จทั้งหมด (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K25.6, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) และวินิจฉัยEGD Code (4516, 4233, 4513, 4443) เมื่อมาถึงโรงพยาบาลในช่วงเดือนเดียวกันนั้น		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥5	≥ 5	≥ 5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐวิวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. UGIB : ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย Massive UGIB 3.4 ลดอัตราการ Re-admit ในผู้ป่วย Massive UGIB ภายใน 28 วัน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 15.4 อัตราการ Re-admit ในผู้ป่วย Massive UGIB ภายใน 28 วัน			
คำนิยาม	1.ผู้ป่วยเลือดออกจากทางเดินอาหารส่วนต้นในปริมาณมาก Massive UGIB ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการหรือภาวะต่อไปนี้ ผู้ป่วยช็อค Class 3-4 หรือ ภาวะไหลเวียนล้มเหลว (Hemodynamic instability) SBP < 90 mmHg หรือ MAP < 65 อัตรา HR > 120 bpm มีการเสียเลือดจากการอาเจียนเลือดสดจำนวนมากและหรือถ่ายดำ/ถ่ายเลือดสดปริมาณ 30-40%ของร่างกาย(1,500-2,000ml) HCT ลดลงจากเดิม > 3 Vol% ภายใน 6 ชม. ต้องให้เลือด ≥ 4-6 unit ภายใน 24 ชม.ไม่สามารถควบคุมการเสียเลือดได้แม้ได้รับยาและ resus แล้ว ยังมี active bleeding 2.การกลับเข้ามานอนรักษาในโรงพยาบาล (Re-admit)ในผู้ป่วย Massive UGIB ภายใน 28 วันภายหลังการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลใน 28 วันด้วยสถานการณ่อนุญาตให้กลับบ้านได้ (status=improve) ยกเว้นผู้ป่วย Massive UGIB ที่ปฏิเสธการรักษาไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอื่น			
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 5			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Massive UGIBที่ได้รับการจำหน่ายโดยสถานอนุญาตในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= จำนวนผู้ป่วย Massive UGIB ที่มีการรับเข้ารักษาในโรงพยาบาลภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผนในเดือนนั้น (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2) B=จำนวนผู้ป่วย Massive UGIB การจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้านได้ (status=improve) ในเดือนก่อนหน้านั้น (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
ที่เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤ 5 %	≤ 5 %	≤ 5 %	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐวิวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4 : มะเร็งเต้านม : เพิ่มการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม Stage 1-3 ภายใน 5 ปี (ระดับเขต)			
ตัวชี้วัดที่	KPI 16 ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม Stage 1-3 ภายใน 5 ปี			
คำนิยาม	การรอดชีวิต หมายถึง จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกกลุ่มอายุ Stage 1-3 ที่มีชีวิตรอดจากโรคมะเร็งนับจากวันที่วินิจฉัย ภายในระยะเวลา 5 ปี (ICD-10 รหัส C502-506 , 508-509) หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม Stage 1-3			
แหล่งข้อมูล	1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. โปรแกรม Thai Cancer Base 2025			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกกลุ่มอายุ Stage 1-3 ที่มีชีวิตรอดจากโรคมะเร็งนับจากวันที่วินิจฉัย ภายในระยะเวลา 5 ปี B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทุกกลุ่มอายุ Stage 1-3 ทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางรัชณี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายจิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4 : มะเร็งเต้านม : เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม Stage 1-3 ภายใน 5 ปี (ระดับเขต) 4.1 ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่	OKR 16.1 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
คำนิยาม	ระยะเวลาการรอดคอยรับการรักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้นิยมนวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และนำมาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา - วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, เคมีบำบัด) โดยนับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา - ในกรณีที่ไม่มี การตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น ให้นับตั้งแต่วันที่ทำการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันทำ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นำผลมาตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง เป็นต้น - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงานจังหวัดหรืออำเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด
แหล่งข้อมูล	1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. หอผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องพิเศษ ห้องผ่าตัด และหน่วยงานที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไปรับบริการผ่าตัด
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัดและได้รับการผ่าตัดรักษา ≤ 4 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางนางรัชนี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายฐิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) แต่ละหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4 : มะเร็งเต้านม : เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม Stage 1-3 ภายใน 5 ปี (ระดับเขต) 4.2 ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์			
ตัวชี้วัดที่	OKR 16.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์			
คำนิยาม	ระยะเวลาการรอดคอยรับการรักษาดูแลด้วยเคมีบำบัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และนำมาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดวันแรก - วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดวันแรก (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงานจังหวัดหรืออำเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด			
แหล่งข้อมูล	1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ห้องพิเศษ 60 ปีชั้น 3 One Day Chemotherapy และหน่วยงานที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมไปรับบริการยาเคมีบำบัด			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดและได้รับเคมีบำบัดรักษา ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางนางรัชนี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายฐิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) แต่ละหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4 : มะเร็งเต้านม : เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม Stage 1-3 ภายใน 5 ปี (ระดับเขต) 4.3 ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์			
ตัวชี้วัดที่	OKR 16.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์			
คำนิยาม	ระยะเวลาการรอดคอยรับการรักษารังสีรักษา หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษารังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และนำมาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกของผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา - วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น เคมีบำบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกของผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) - ในกรณีที่ไม่มี การตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มี การรักษาด้วยวิธีอื่นและผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นให้ใช้หลักการเกี่ยวกับการนับระยะเวลาการรอดคอยรับการรักษารังสีรักษา คือ ให้นับตั้งแต่วันที่ทำการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันทำ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นำผลมาตัดสินใจให้การรักษา มะเร็ง เป็นต้น หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา			
แหล่งข้อมูล	1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. โปรแกรม Thai Cancer Base 2025			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับรังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางนางรัชนี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายฐิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) แต่ละหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5 : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง : เพิ่มการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3 ภายในระยะเวลา 5 ปี			
ตัวชี้วัดที่	KPI 17 ร้อยละการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3 ภายในระยะเวลา 5 ปี			
คำนิยาม	การรอดชีวิต หมายถึง จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทุกกลุ่มอายุ Stage 1-3 ที่มีชีวิตรอดจากโรคมะเร็งนับจากวันที่วินิจฉัย ภายในระยะเวลา 5 ปี (ICD-10 รหัส C170-171, 179-180, 182, 184, 186-187, 189-190 และ C20) หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3			
แหล่งข้อมูล	3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 4. โปรแกรม Thai Cancer Base 2025			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทุกกลุ่มอายุ Stage 1-3 ที่มีชีวิตรอดจากโรคมะเร็งนับจากวันที่วินิจฉัย ภายในระยะเวลา 5 ปี B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงทุกกลุ่มอายุ Stage 1-3 ทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ปี			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางรัชณี บะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายจิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5 : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง : การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3 ภายในระยะเวลา 5 ปี เพิ่มขึ้น 5.1 ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 17.1 ร้อยละของผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy
คำนิยาม	1) การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง ที่มีอายุ 50-70 ปี ได้รับการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) ซึ่งเป็นวิธีที่อาศัยปฏิกิริยาทางอิมมูโนที่จำเพาะต่อ ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงที่มีความจำเพาะของคนเท่านั้น โดยตรวจผ่านชุดตรวจที่มีค่า cut-off 100 ng/ml ผู้รับการตรวจไม่จำเป็นต้องควบคุมอาหารก่อนการตรวจ วัตถุประสงค์เพื่อตรวจหาผู้ป่วยในระยะก่อนเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะต้น ซึ่งประชากร กลุ่มเป้าหมายที่คัดกรองแล้วมีผลปกติ/ผลลบ (Negative) จะทำการตรวจคัดกรอง 1 ครั้ง ในรอบ 2 ปีงบประมาณ 2) ผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ หมายถึง ประชากรเพศชายและเพศหญิง อายุ 50-70 ปีที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fecal Immunochemical Test (FIT) เป็นบวก (Positive) คือ ตรวจพบเม็ดเลือดแดงในตัวอย่างอุจจาระ 3) การส่องกล้อง Colonoscopy หมายถึง การวินิจฉัยความผิดปกติภายในลำไส้ใหญ่ด้วยการส่อง กล้องขยายเพื่อการค้นหารอยโรคก่อนการเกิดมะเร็งและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะต้น
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรเพศชายและหญิง ที่มีอายุ 50-70 ปี
แหล่งข้อมูล	1. จากระบบข้อมูล 43 แฟ้ม (HDC) 2. หอผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องพิเศษ ศูนย์ส่องกล้อง และหน่วยงานที่ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงไปรับบริการ
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติ ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy B = จำนวนผู้ที่มีผลการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงผิดปกติทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางรัชณี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายฐิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) แต่ละหอผู้ป่วย ศูนย์ส่องกล้อง โรงพยาบาลมหาสารคาม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5 : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง : การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3 ภายในระยะเวลา 5 ปี เพิ่มขึ้น 5.2 ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่	OKR 17.2 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์
คำนิยาม	ระยะเวลาการรอดคอยรับการรักษารักษาด้วยการผ่าตัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน) โดยนับจาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้นิยมนวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และนำมาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา - วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, เคมีบำบัด) โดยนับถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษา - ในกรณีที่ไม่มีตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น ให้นับตั้งแต่วันที่ทำการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันทำ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นำผลมาตัดสินใจให้การรักษาเป็นต้น - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงานจังหวัดหรืออำเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีผ่าตัด
แหล่งข้อมูล	5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 6. หอผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องพิเศษ ห้องผ่าตัด และหน่วยงานที่ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงไปรับบริการผ่าตัด
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยการผ่าตัด และได้รับการผ่าตัดรักษา ≤ 4 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมด ในปีที่ยรายงาน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางนางรัชนี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายฐิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) แต่ละหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5 : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง : การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3 ภายในระยะเวลา 5 ปี เพิ่มขึ้น 5.3 ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์			
ตัวชี้วัดที่	OKR 17.3 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์			
คำนิยาม	ระยะเวลาการรอคอยรับการรักษาดูแลด้วยเคมีบำบัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาดูแลด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และนำมาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดวันแรก - วันสุดท้ายของการรักษาดูแลด้วยวิธีอื่น (เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด) นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีบำบัดวันแรก (การรักษาค่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงาน จังหวัดหรืออำเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด			
แหล่งข้อมูล	3. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 4. หอผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไป ห้องพิเศษ 60 ปีขึ้นไป และหน่วยงานที่ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงไปรับบริการยาเคมีบำบัด			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่แพทย์วางแผนการรักษาดูแลด้วยยาเคมีบำบัดและได้รับเคมีบำบัดรักษา ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	

ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางนางรัชนี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายฐิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) แต่ละหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5 : มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง : การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง Stage 1-3 ภายในระยะเวลา 5 ปี เพิ่มขึ้น 5.4 ผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่	OKR 17.4 ร้อยละของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์
คำนิยาม	ระยะเวลาการรอดคอยรับการรักษารังสีรักษา หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษารังสีรักษาภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้น้ำย้อมการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และนำมาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกของผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา - วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น เคมีบำบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกของผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) - ในกรณีที่ไม่มี การตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่นและผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่นให้ใช้หลักการเดียวกับการนับระยะเวลาการรอดคอยรับการรักษารังสีรักษาด้วยการผ่าตัด คือ ให้นับตั้งแต่วันที่ทำการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันทำ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นำผลมาตัดสินใจให้การรักษาเป็นต้น หมายเหตุ การรายงานตัวชี้วัดผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทุกโรค ไม่รวมกรณี Metastatic (Unknown primary)
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 82
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา
แหล่งข้อมูล	1. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. โปรแกรม Thai Cancer Base 2025
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่แพทย์วางแผนการรักษารังสีรักษาและได้รับรังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด B = จำนวนผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 81	≥ ร้อยละ 82	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คณะกรรมการ Service plan สาขาโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	1. นางกมลรัตน์ สุปัญญาบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 2. นางนางรัชนี ปะสาริบุตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3. นายฐิตินันท์ จันทะพา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 4. ผู้ประสานงานโรคมะเร็ง (Cancer Nurse Coordinator) แต่ละหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาสารคาม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. Urinary tract calculi: อัตราความสำเร็จของการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ			
ตัวชี้วัดที่	KPI 18 อัตราความสำเร็จของการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ			
คำนิยาม	นิ่วในทางเดินปัสสาวะ คือ ก้อนแข็งที่เกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุและเกลือแร่ภายในปัสสาวะ แล้วไปก่อตัวสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะ รหัส ICD-10 รหัส N200 N201 N210 N211 ความสำเร็จของการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ คือ ผลลัพธ์ตั้งแต่ระดับ 3 ลงมา ระดับ 1 คือ Stone free ระดับ 2 คือ Complete fragmentation with partial pass ระดับ 3 คือ Partial fragmentation with partial pass ระดับ 4 คือ Partial fragmentation with no pass ระดับ 5 คือ No fragmentation (No change)			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HIS ของโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะมีผลการรักษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป			
	B : ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะที่มารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นส.ธันยาภัทร์ ปิยวัชรเวลา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.วิทมน ตียะไพบุลย์สิน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. Urinary tract calculi: อัตราความสำเร็จของการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ 6.1 การให้บริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายใน 6 สัปดาห์			
ตัวชี้วัดที่	OKR 18.1 อัตราการให้บริการสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายใน 6 สัปดาห์			
คำนิยาม	นิ่วในทางเดินปัสสาวะ คือ ก้อนแข็งที่เกิดจากการตกผลึกของแร่ธาตุและเกลือแร่ภายในปัสสาวะ แล้วไปก่อตัวสะสมอยู่ตามส่วนต่างๆ ของระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น ไตท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะ รหัส ICD-10 รหัส N200 N201 N210 N211 การสลายนิ่ว คือ ICD-9รหัสหัตถการ 98.51 1)การสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ หมายถึง การทำให้นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะแตกสลายเป็นชิ้นเล็กๆและหลุดออกมากับน้ำปัสสาวะโดยการใช้คลื่นช็อคเวฟ 2)การนับระยะเวลาให้เริ่มจากวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นนิ่วและศัลแพทย์ยูโรวิทยาที่รักษาได้สั่งการให้เข้ารับการสลายนิ่ว ไปจนถึงวันที่ได้รับการสลายนิ่วโดยนับเฉพาะครั้งแรกที่เข้ารับการสลายนิ่ว(First session)เท่านั้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะที่ได้รับการตัดสินใจให้ทำการรักษาด้วยการสลายนิ่วโดยคลื่นช็อคเวฟ จากศัลแพทย์ยูโรวิทยา			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโปรแกรม HIS ของโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A=จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วภายใน6 สัปดาห์ B= จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการสลายนิ่วทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นส.ธันยาภัทร์ ปิยวัชรเวลา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.วิทมน ตียะไพบุลย์สิน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. Urinary tract calculi: อัตราความสำเร็จของการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ 6.2 การให้บริการผ่าตัดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายใน 12 สัปดาห์
ตัวชี้วัดที่	OKR 18.2 อัตราการให้บริการผ่าตัดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะภายใน 12 สัปดาห์
คำนิยาม	การผ่าตัดนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ หมายถึง การผ่าตัดนิ่วด้วยวิธีการผ่าตัดวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1.การผ่าตัดนิ่วไตแบบแผลเปิด (ANL, Pyelolithotomy) 2.การผ่าตัดนิ่วท่อไตแบบมีแผลเปิด(Ureterolithotomy) 3.การผ่าตัดนิ่วกระเพาะปัสสาวะแบบมีแผลเปิด(Suprapubic cystolithotomy) 4.การผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะแบบมีแผลเปิด(Meatotomy ,Urethrolithotomy) 5.การผ่าตัดนิ่วไตแบบส่องกล้องผ่านผิวหนัง(PCNL) 6.การผ่าตัดนิ่วในไตผ่านกล้องส่องตรวจท่อไตชนิดคดงอได้(RIRS) 7.การผ่าตัดนิ่วในท่อไตผ่านกล้องส่องตรวจท่อไตชนิดกึ่งคดงอ(URSL) 8.การผ่าตัดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะผ่านกล้องส่องตรวจ(TUL) 9.การผ่าตัดนิ่วผ่านทางส่องตรวจช่องท้อง(Laparoscopic surgery) หมายเหตุ : การนับระยะเวลาให้เริ่มนับจากวันที่ศัลยแพทย์ยูโรวิทยาได้สั่งการให้เข้ารับ การผ่าตัดไปจนถึงวันที่ได้รับการผ่าตัดรักษานิ่ว รหัส ICD-9 รหัสหัตถการ คือ 55.01,55.04,55.11,55.4,55.5,56.0,56.2,57.0,57.19,58.0,58.1,59.95
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	ร้อยละ 70
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะที่ได้รับการตัดสินใจให้ทำการรักษาด้วยการรักษานิ่วด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจาก 1-9 จากศัลยแพทย์ยูโรวิทยา
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมHIS ของโรงพยาบาล
รายการข้อมูล	A=จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษานิ่วภายใน 12 สัปดาห์ B= จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษานิ่วทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นส.ธันยาภัทร์ ปิยวัชรเวลา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.วิทมน ตียะไพบุลย์สิน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. Urinary tract calculi: อัตราความสำเร็จของการรักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ 6.3 การเกิด Sepsisในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Percutaneous Nephrolithotomy(PCNL)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 18.3 อัตราการเกิด Sepsis ในผู้ป่วยหลังผ่าตัด Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)			
คำนิยาม	Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL)คือ การผ่าตัดนิ่วไตแบบส่องกล้องผ่านผิวหนัง Sepsis คือภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานผิดปกติ ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องได้รับการรักษาทันที มีเกณฑ์ 2ข้อจาก 4ข้อ ต่อไปนี้ 1.BT> 38 C หรือ < 36 C 2.HR > 90 ครั้ง/นาที 3.RR > 20 ครั้ง/นาที หรือ CO2 Blood gas <32 4.WBC > 12,000 หรือ < 4,000 รหัส ICD-9 รหัสหัตถการ คือ 55.01, 55.04, 55.11, 55.4, 55.5, 56.0, 56.2, 57.0, 57.19, 58.0, 58.1, 59.95			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 2			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะที่ได้รับการผ่าตัด PCNL			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมHIS ของโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A=ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด PCNL แล้วเกิด Sepsis B=ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด PCNL ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 5	ร้อยละ 4	ร้อยละ 2	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นพ.กิตติพงศ์ เชาวรัตน์ นส.ธันยาภัทร์ ปิยวัชรเวลา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.กิตติพงศ์ เชาวรัตน์ นส.ธันยาภัทร์ ปิยวัชรเวลา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 -2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. Transplant : 7.1 ผู้บริจาคอวัยวะได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออกและได้รับการจัดเก็บดวงตา (Actual donor)			
ตัวชี้วัดที่	KPI 19 อัตราผู้บริจาคอวัยวะสมองตายได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (Actual donor) 1:100 Hospital death			
คำนิยาม	ผู้บริจาคอวัยวะสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (Actual Brain - Dead Organ Donor) หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยภาวะสมองตายครบถ้วนตามกระบวนการที่แพทย์ศากำหนด และญาติลงนามยินยอมบริจาคอวัยวะลงในแบบฟอร์มของศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย และได้มีการลงมือผ่าตัดนำอวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง จากร่างผู้บริจาคอวัยวะ จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุใน 1 ปีงบประมาณก่อนการรายงานผลตัวชี้วัด (เช่น รายงานตัวชี้วัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ใช้จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นตัวหาร)			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	1:100 Hospital death			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Severe Brain Injury เข้าเกณฑ์วินิจฉัยสมองตาย			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HIS ของโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้บริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายที่ได้รับการผ่าตัดนำอวัยวะออก (Actual Brain - Dead Organ Donor) ปีงบประมาณปัจจุบัน B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (Hospital Death) ปีงบประมาณก่อนหน้า			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	1:100 Hospital death	1:100 Hospital death	1:100 Hospital death	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ อินทะวัน/นางสัณณญา เดชศิริ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมคริต ศรีพลแทน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. Transplant : 7.2 ผู้บริจาคดวงตาได้รับการจัดเก็บดวงตา (Actual donor)			
ตัวชี้วัดที่	KPI 20 อัตราผู้บริจาคดวงตา ได้รับการจัดเก็บดวงตา (Actual donor) 1:100 Hospital death			
คำนิยาม	ผู้ป่วยที่ได้รับการจัดเก็บดวงตา หมายถึง ผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่เข้าเกณฑ์บริจาคดวงตา และญาติลงนามยินยอมบริจาคดวงตาลงในแบบฟอร์มของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และได้มีการจัดเก็บดวงตา ส่งที่ศูนย์ดวงตา จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล หมายถึง จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุใน 1 ปีงบประมาณก่อนการรายงานผลตัวชี้วัด (เช่น รายงานตัวชี้วัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้ใช้จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นตัวหาร)			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	1:100 Hospital death			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกราย			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HIS ของโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตที่ได้รับการจัดเก็บดวงตา B = จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลจากทุกสาเหตุ (Hospital Death) ปีงบประมาณก่อนหน้า			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	1:100 Hospital death	1:100 Hospital death	1:100 Hospital death	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ อินทะวัน/นางสัณณูญา เดชศิริ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมกริต ศรีพลแทน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. Transplant : 7.3 การจัดตั้งทีมจัดเก็บอวัยวะ (Harvest team)			
ตัวชี้วัดที่	KPI 21 ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งทีมจัดเก็บอวัยวะ (Harvest team) ระดับ 3			
คำนิยาม	ทีมจัดเก็บอวัยวะ (Harvest team) หมายถึง.. ระดับ 1 = ระดับ 2 = ระดับ 3 = สามารถผ่าตัดได้เอง			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	ระดับ 3			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรที่เกี่ยวข้อง			
แหล่งข้อมูล	รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดตั้งทีมจัดเก็บอวัยวะ (Harvest team)			
รายการข้อมูล	A : ระดับความสำเร็จของการจัดตั้งทีมจัดเก็บอวัยวะ (Harvest team)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ อินทะวัน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางสัญญาญญา เดชศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมคิดิต ศรีพลแทน นายแพทย์เชี่ยวชาญ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	Cerebral aneurysm : อัตราผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง			
ตัวชี้วัด	KPI 22 อัตราผู้ป่วย Cerebral Aneurysm ที่เสียชีวิต (ICD 10 : I67.1, I60.0–I60.9)			
คำนิยาม	อัตราผู้ป่วย Cerebral Aneurysm (ICD 10 : I67.1, I60.0–I60.9) ที่เสียชีวิตระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล			
ค่าเป้าหมาย	≤ ร้อยละ 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Cerebral Aneurysm ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโป่งพอง ที่เสียชีวิตในโรงพยาบาล B= ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโป่งพอง ที่รักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเติม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นาง สุชัยญญา เดชศิริ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์ไกรวิน รัตนรักษ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	Cerebral aneurysm : อัตราผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง			
ตัวชี้วัด	OKR 22.1 อัตราการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองหดตัวในผู้ป่วย Cerebral Aneurysm			
คำนิยาม	ผู้ป่วย Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (ICD-10: I60.0–I60.7) ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี Cerebral Vasospasm จากการตรวจ CTA, หรือมีอาการทางระบบประสาทแย่งที่แพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจาก Vasospasm(หลังจากผ่าตัด >72hr) ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล			
ค่าเป้าหมาย	≤ ร้อยละ 30			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= จำนวนผู้ป่วย Cerebral Aneurysm ที่เกิด Cerebral Vasospasm ระหว่างการรักษา B= จำนวนผู้ป่วย Cerebral Aneurysm ทั้งหมดที่รับไว้รักษา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเดิม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≤ ร้อยละ 30	2571 ≤ ร้อยละ 30	2572 ≤ ร้อยละ 30	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นาง สุชัยญญา เดชศิริ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์ไกรวิน รัตนรักษ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1	2. Cerebral aneurysm : อัตราผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเสียชีวิต			
เป้าประสงค์ที่ 1	ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง			
ตัวชี้วัด	OKR 22.2 ลดอัตราการแตกซ้ำของหลอดเลือดโป่งพองในสมอง (Aneurysm Rebleeding)			
คำนิยาม	ผู้ป่วย Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (ICD-10 : I60.0 – I60.7) ที่มีอาการทางระบบประสาททรุดลงเฉียบพลันร่วมกับพบเลือดออกใหม่หรือปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นจากการตรวจ CT Brain หรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเกิด Rebleeding ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล			
ค่าเป้าหมาย	≤ ร้อยละ 5			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (ICD-10 : I60.0 – I60.7) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A= จำนวนผู้ป่วย Cerebral Aneurysm ที่เกิดภาวะเลือดออกซ้ำ (Rebleeding) ระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล B= จำนวนผู้ป่วย Cerebral Aneurysm ทั้งหมดที่รับไว้รักษา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	**ไม่ต้องเดิม**			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≤ ร้อยละ 5	2571 ≤ ร้อยละ 5	2572 ≤ ร้อยละ 5	
ผู้เก็บตัวชี้วัด	นาง สุชัยญญา เดชศิริ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์ไกรวิน รัตนรักษ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	Cholangitis: ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe Cholangitis			
ตัวชี้วัดที่	KPI 23 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe Cholangitis			
คำนิยาม	1. Severe Cholangitis หรือ Acute Severe Cholangitis คือ ภาวะการอักเสบติดเชื้อของท่อน้ำดีที่มีความรุนแรง จนเกิดความผิดปกติของอวัยวะสำคัญอย่างน้อย 1 ระบบ (Organ Dysfunction) ได้แก่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไต ระบบตับ หรือระบบโลหิตวิทยา ตามเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของ Tokyo Guidelines 2. การเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe Cholangitis หมายถึง การเสียชีวิตทุกสาเหตุของผู้ป่วยที่มี Principal diagnosis Severe Cholangitis ที่ระบุไว้ตามรหัส ICD-10 = K83.01 – K83.09 และสถานะการจำหน่ายเป็นเสียชีวิต			
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 15			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Severe Cholangitis ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการหรือภาวะตามที่กำหนดในนิยาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A: จำนวนผู้ป่วย Severe Cholangitis ที่เสียชีวิต B: จำนวนผู้ป่วย Severe Cholangitis ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) ×100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	< ร้อยละ 15	< 10	< 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางชัชดา เชาว์สันเทียะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายนครินทร์ ฤทธิสิงห์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. Cholangitis: ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วย Severe Cholangitis
ตัวชี้วัดที่	OKR 23.2 ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการระบายน้ำดีด้วยวิธี ERCP/PTBD /Surgery ในผู้ป่วย Severe Cholangitis
คำนิยาม	1. Severe Cholangitis หรือ Acute Severe Cholangitis คือ ภาวะการอักเสบติดเชื้อของท่อน้ำดีที่มีความรุนแรง จนเกิดความผิดปกติของอวัยวะสำคัญอย่างน้อย 1 ระบบ (Organ Dysfunction) ได้แก่ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบไต ระบบตับ หรือระบบโลหิตวิทยา ตามเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของ Tokyo Guidelines โรคนี้มักเกิดจากการอุดตันของทางเดินน้ำดี เช่น นิ่วในท่อน้ำดี เนื้องอก หรือการตีบแคบของท่อน้ำดี ทำให้เกิดการคั่งของน้ำดีและการติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินน้ำดี 2. ภาวะแทรกซ้อนหลังการระบายน้ำดี (Post Biliary Drainage Complications) หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นภายหลังการระบายน้ำดีด้วยวิธี ERCP, PTBD หรือการผ่าตัด ในผู้ป่วย Severe Cholangitis ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติม ระยะเวลานอนโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หรือมีผลกระทบต่อการฟื้นตัวของผู้ป่วย โดยเกิดภายใน 30 วันหลังการทำหัตถการ ประกอบด้วย เลือดออก (Bleeding) มีอาการเลือดออกที่สัมพันธ์กับหัตถการ ต้องได้รับเลือดหรือหัตถการห้ามเลือดตับอ่อนอักเสบหลัง ERCP (Post-ERCP Pancreatitis) การทะลุของทางเดินอาหารหรือท่อน้ำดี (Perforation) น้ำดีรั่ว (Bile Leakage) ICD-10 = K 83.01-83.09, R571, D62, K 859 รหัส ICD-9=51.1, 51.11, 51.13, 51.14, 52.13, 52.14, 51.84, 51.85, 51.86, 51.87, 51.88
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มีภาวะการอักเสบติดเชื้อของท่อน้ำดีที่มีความรุนแรง จนเกิดความผิดปกติของอวัยวะสำคัญอย่างน้อย 1 ระบบ (Morgan Dysfunction) ตามเกณฑ์การประเมินความรุนแรงของ Tokyo Guidelines ชายหรือหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีอาการหรือภาวะตามที่กำหนดในนิยาม และได้รับการรักษาโดยการระบายน้ำดีด้วยวิธี ERCP, PTBD หรือการผ่าตัด
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Severe Cholangitis ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังการระบายน้ำดี ด้วยวิธี ERCP/PTBD/Surgery ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

	B: จำนวนผู้ป่วย Severe Cholangitis ที่ได้รับการระบายน้ำดีด้วยวิธี ERCP/PTBD / Surgery ทั้งหมดในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้น			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) ×100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤ร้อยละ 10	≤ 8	≤ 5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางชัชดา เชาวสันเทียะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายนครินทร์ ฤทธิสิงห์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1: ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2: การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. Pediatric Asthma: ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี			
ตัวชี้วัดที่	KPI 24 อัตราผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี (Well controlled)			
คำนิยาม	จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคหืดแบบง่ายในเด็ก (Easy Asthma Clinic: EAC) ซึ่งได้รับการประเมินระดับควบคุมโรคหืดตามเกณฑ์มาตรฐานของ GINA guideline มีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี (Well controlled) ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอายุ < 15 ปี			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคหืดแบบง่ายในเด็ก (EAC) ในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูล Easy Asthma Clinic ระบบข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี (Well controlled) B : จำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคหืดแบบง่ายในเด็ก (EAC) ในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.มานิชา ชัยอาสา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สายพิน ฤทธิโคตร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.Pediatric Asthma : ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี 1.1 คัดกรองและค้นหาผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ เข้าระบบการดูแลรักษา 3P Program และขึ้นทะเบียนใน EAC (Easy Asthma Clinic) เพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 24.1 อัตราเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหืด (Potential Asthma) ได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคหืด		
คำนิยาม	เด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหืด (Potential Asthma) หมายถึง เด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 15 ปี ทำแบบประเมิน Potential Asthma test ได้คะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป เด็กโรคหืดรายใหม่จากการตรวจยืนยัน (Confirm Diagnosis) หมายถึง การตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคหืดในเด็กตามมาตรฐาน GINA และแนวทางการรักษาโรคหืดในเด็กแห่งประเทศไทย โดยกุมารแพทย์ ดังเอกสารหมายเลข		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเสี่ยงต่อโรคหืดได้รับการค้นหา (Potential Asthma)		
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูล Easy Asthma Clinic ระบบข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหืด (Potential Asthma) ที่ได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยโรคหืด B : จำนวนเด็กกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหืด (Potential Asthma) ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.จิระวรรณ บุตรพูล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สายพิน ฤทธิโคตร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.Pediatric Asthma : ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี 1.2 ผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ได้รับการวินิจฉัยโรคหืดอย่างถูกต้อง			
ตัวชี้วัดที่	OKR 24.2 อุบัติการณ์การวินิจฉัยคลาดเคลื่อน ระดับ E ขึ้นไป ในผู้ป่วยเด็กโรคหืด			
คำนิยาม	การวินิจฉัยโรคหืดคลาดเคลื่อน หมายถึง... ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้ Intervention เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ (New Asthma)			
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูล Easy Asthma Clinic ระบบข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนการวินิจฉัยคลาดเคลื่อน ระดับ E ขึ้นไป ในผู้ป่วยเด็กโรคหืด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.ประภัสสร บำพิมาย			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สายพิน ฤทธิโคตร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.Pediatric Asthma : ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี 1.3 ผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ได้รับการประเมินโรครุมแพพร้อมอย่างถูกต้อง เพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 24.3 อัตราผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ได้รับการประเมินโรครุมแพพร้อมอย่างถูกต้อง		
คำนิยาม	ผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ได้รับการประเมินโรครุมแพพร้อมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล GINA guideline และแนวทางการรักษาโรคหืดในเด็กแห่งประเทศไทย		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ (New Asthma)		
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูล Easy Asthma Clinic ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ได้รับการประเมินโรครุมแพพร้อมอย่างถูกต้อง B : จำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคหืดแบบง่ายในเด็ก (EAC) ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 80	2572 ≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.มานิชา ชัยอาสา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สายพิน ฤทธิโคตร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.Pediatric Asthma : ผู้ป่วยเด็กโรคหืดมีระดับการควบคุมโรคหืดได้ดี 1.4 สมรรถภาพปอดของผู้ป่วยเด็กโรคหืดหลังเข้ารับการรักษา 3P program มีระดับดีขึ้น และอยู่ในเกณฑ์ปกติ (FEV1/FVC > 80% หรือ PEER > 80% predicted) เพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 24.4 อัตราผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ (FEV1/FVC > 80% หรือ PEER > 80% predicted)			
คำนิยาม	ผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ หมายถึง ผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีค่าสมรรถภาพปอด ดังนี้ FEV1/FVC > 80% หรือ PEER > 80% predicted			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูล Easy Asthma Clinic ระบบข้อมูลของโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดที่มีสมรรถภาพปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ B : จำนวนผู้ป่วยเด็กโรคหืดรายใหม่ที่ขึ้นทะเบียนในคลินิกโรคหืดแบบง่ายในเด็ก (EAC) ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.มานิชา ชัยอาสา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.สายพิน ฤทธิโคตร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน Global Developmental delay (GDD) : คงอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างน้อย 1 ปี เพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	KPI 25 อัตราเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ารอบด้านคงอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างน้อย 1 ปี		
คำนิยาม	เด็กมีพัฒนาการช้ารอบด้าน หมายถึง เด็กที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เป็นGlobal developmental delay (F83) หรือ R62 อาจมีหรือไม่มีโรคร่วม ที่มีอายุระหว่าง 3 ปี ถึง 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก คงอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างน้อย 1 ปี หมายถึง หลังจากเข้าสู่ระบบการศึกษา เช่น การเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ หรือศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้อย่างน้อย 1ปี โดยไม่ถูกส่งกลับหรือถูกปฏิเสธด้วยปัญหาพัฒนาการหรือพฤติกรรม		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้านที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก		
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียน คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้ารอบด้าน ที่คงอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างน้อย 1 ปี B : จำนวนเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน (GDD) ที่ส่งเข้าระบบการศึกษา		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 60	2571 ≥ ร้อยละ 70	2572 ≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สิทธิพงศ์ ปาปะกัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.นลินี ยมศรีเคน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน Global Developmental delay (GDD) : คงอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างน้อย 1 ปี เพิ่มขึ้น 3.1 เด็กพัฒนาการช้ารอบด้านมีพัฒนาการดีขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 25.1 อัตราเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน (Global Developmental delay, GDD) มีพัฒนาการดีขึ้น			
คำนิยาม	เด็กมีพัฒนาการช้ารอบด้าน หมายถึง เด็กที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เป็นGlobal developmental delay (F83) หรือ R62 อาจมีหรือไม่มีโรคร่วมที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปี 11 เดือน 29วัน ที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก พัฒนาการดีขึ้น หมายถึง พัฒนาการด้านล่าช้าที่ดีขึ้นด้านใดด้านหนึ่งใน 5 ด้าน โดยมีด้านใดลดลงภายใน 6 เดือน หลังการรักษา พัฒนาการ 5 ด้าน หมายถึง 1) ด้านการเคลื่อนไหว (gross motor) 2) ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (fine motor) 3) ด้านการเข้าใจภาษา (receptive language) 4) ด้านการใช้ภาษา (expressive language) 5) ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (personal and social)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้านที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียน คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม รหัสโรคF83/R62			
รายการข้อมูล	A : จำนวนเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน (Global Developmental delay, GDD) มีพัฒนาการดีขึ้น B : จำนวนเด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน (Global Developmental delay, GDD) ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สิทธิพงศ์ ปาปะกัง			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.นลินี ยมศรีเคน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน Global Developmental delay (GDD) : คงอยู่ในระบบการศึกษาได้อย่างน้อย 1 ปี เพิ่มขึ้น 3.2 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I เพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 25.2 อัตราเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I			
คำนิยาม	เด็กมีพัฒนาการช้ารอบด้าน หมายถึง เด็กที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เป็นGlobal developmental delay (F83) หรือ R62 อาจมีหรือไม่มีโรคร่วม ที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปี 11 เดือน 29วัน ที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก กระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หมายถึง ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I หลังจากได้รับการวินิจฉัย โดยพยาบาลหรือผู้เชี่ยวชาญ ในการกระตุ้นพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเคลื่อนไหว (gross motor) 2) ด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญา (fine motor) 3) ด้านการเข้าใจภาษา (receptive language) 4) ด้านการใช้ภาษา (expressive language) 5) ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม (personal and social) ทุก 1 เดือนอย่างน้อย 3 ครั้ง ICD-10 = F83/R62			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้านที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียน คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการช้ารอบด้านที่ได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I B : จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการช้ารอบด้านทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ80	≥ ร้อยละ90	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สิทธิพงศ์ ปาปะกัง			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.นลินี ยมศรีเคน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้าน Global Developmental delay (GDD) : คงอยู่ในระบบการศึกษาได้น้อย 1 ปี เพิ่มขึ้น 3.3 เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน.			
ตัวชี้วัดที่	OKR 25.3 อัตราเด็กที่มีพัฒนาการช้ารอบด้าน ได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน			
คำนิยาม	เด็กมีพัฒนาการช้ารอบด้าน หมายถึง เด็กที่ได้รับวินิจฉัยจากแพทย์เป็นGlobal developmental delay (F83) หรือ R62 อาจมีหรือไม่มีโรคร่วม ที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 5 ปี 11 เดือน 29วัน ที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก การติดตามการรักษาต่อเนื่อง อย่างน้อย 6 เดือน เริ่มนับเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กพัฒนาการช้ารอบด้านที่มารับบริการที่คลินิกพัฒนาการเด็ก			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียน คลินิกพัฒนาการเด็ก รพ.มหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการช้ารอบด้านที่ได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน B : จำนวนเด็กที่มีพัฒนาการช้ารอบด้านทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.สิทธิพงศ์ ปาปะกัง			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.นลินี ยมศรีเคน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. Preterm : ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ที่น้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม - ทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 1,000 กรัม - ทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000-1,499 กรัม
ตัวชี้วัดที่	KPI 26 อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด ที่น้ำหนักน้อยกว่า 1,500 กรัม - ทารกแรกเกิดน้ำหนัก น้อยกว่า 1,000 กรัม ลดลงร้อยละ...10 - ทารกแรกเกิดน้ำหนัก 1,000-1,499 กรัม ลดลงร้อยละ....10 *** ให้ตั้งเป้าเป็นตัวเลขต่อ 1,000 live birth
คำนิยาม	Newborn หรือ ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกตั้งแต่แรกคลอดจนถึงอายุครบ 28 วัน (0-28 วันหลังคลอด) ไม่ว่าจะคลอดครบกำหนด (term) หรือคลอดก่อนกำหนด (preterm) ทารกแรกเกิดมีชีวิต (Live births) ที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,000 กรัม (Extremely Low Birth Weight; ELBW) ที่เกิดและเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล/พื้นที่ที่กำหนด ในช่วงเวลาที่ประเมิน ทารกแรกเกิดมีชีวิต (Live births) ที่น้ำหนักแรกเกิดอยู่ระหว่าง 1,000-1,499 กรัม (Very Low Birth Weight; VLBW) ที่เกิดและเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล/พื้นที่ที่กำหนด ในช่วงเวลาที่ประเมิน อัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด (Neonatal Mortality Rate: NMR) หมายถึง สัดส่วนของจำนวนทารกแรกเกิดที่มีชีวิตซึ่งเสียชีวิตภายในอายุ 0-28 วันแรก หลังคลอด ต่อจำนวนการเกิดมีชีพ (Live births) ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน คูณด้วย 1,000
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ....10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดที่มีชีวิต (Live births) ที่น้ำหนัก < 1,500 กรัม ทุกคนในช่วงเวลาที่ประเมิน โดยติดตามการเสียชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 28 วัน
แหล่งข้อมูล	แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาล และอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดมีชีวิต (Live births) ที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัมที่เสียชีวิตภายใน 28 วัน B : จำนวนทารกแรกเกิดมีชีวิต (Live births) ที่น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 1,500 กรัม ทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ....10	ลดลงร้อยละ....10	ลดลงร้อยละ....10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศุภวรรณ ปาปะชี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. Preterm : ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด 3.1 ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Severe RDS
ตัวชี้วัดที่	OKR 26.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Severe RDS ลดลง
คำนิยาม	RDS ย่อมาจาก respiratory distress syndrome หรือ ภาวะหายใจลำบากในทารกแรกเกิด หมายถึง ภาวะปอดล้มเหลวเฉียบพลันในทารกเกิดก่อนกำหนด เกิดจากการขาดสารลดแรงตึงผิว (Surfactant deficiency) ทำให้ถุงลมปอดแฟบ (alveolar collapse) ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่อง เกิดภาวะพร่องออกซิเจนและหายใจลำบาก มักพบในทารกอายุน้อยกว่า 34 สัปดาห์ โดยเฉพาะ < 28 สัปดาห์ Severe RDS (Severe Respiratory Distress Syndrome) หมายถึง ภาวะหายใจลำบากรุนแรงในทารกแรกเกิด โดยเฉพาะทารกเกิดก่อนกำหนด ที่มีการขาดสารลดแรงตึงผิว (surfactant deficiency) อย่างมาก จนทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซผิดปกติรุนแรง และมีภาวะพร่องออกซิเจน (hypoxemia) อย่างชัดเจน แม้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ภาวะแทรกซ้อนของ Severe RDS หมายถึง ภาวะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ - ภาวะปอดรั่ว (Air leak syndrome: pneumothorax, pulmonary interstitial emphysema) - ภาวะปอดเรื้อรัง (Bronchopulmonary Dysplasia: BPD) - ความดันหลอดเลือดปอดสูง (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn: PPHN) - ภาวะพร่องออกซิเจนรุนแรงและหายใจล้มเหลว (Severe hypoxemia & respiratory failure) - ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ เช่น Ventilator-associated pneumonia (VAP)
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ....10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดที่มีชีวิต (Live births) น้ำหนัก < 1,500 กรัมหรืออายุครรภ์น้อยกว่า 34 สัปดาห์ ที่มีภาวะ Severe RDS ทุกคนในช่วงเวลาที่ประเมิน
แหล่งข้อมูล	แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาล และอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต

รายการข้อมูล	A : ผู้ป่วย Severe RDS ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดก็ได้ ≥ 1 รายการ เช่น ปอดรั่ว (air leak), PPHN, BPD, VAP/ติดเชื้อเกี่ยวกับเครื่องช่วยหายใจ, respiratory failure ต้อง escalation โหมดช่วยหายใจ ฯลฯ B : ผู้ป่วย Severe RDS ที่รับไว้รักษาในช่วงเวลาประเมิน (เช่น ไตรมาส/ปีงบประมาณ) หน่วย: ร้อยละ (%)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) * 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ....10	ลดลงร้อยละ....10	ลดลงร้อยละ....10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศุภวรรณ ปาปะชี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. Preterm : ลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด 3.2 ลดอัตราการเกิด Septic shock		
ตัวชี้วัดที่	OKR 26.2 อัตราการเกิด Septic shock ลดลง		
คำนิยาม	- Neonatal sepsis (ภาวะติดเชื้อในทารกแรกเกิด) หมายถึง ภาวะที่ทารกแรกเกิดมีการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา ภายใน 28 วันหลังคลอด (หรือในทารกคลอดก่อนกำหนดนับตามอายุครรภ์ที่เทียบเท่า) โดยเชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้เกิด อาการ/อาการแสดงของการติดเชื้อระบบ (systemic infection) ซึ่งมีความรุนแรงและอาจนำไปสู่ภาวะช็อกหรือเสียชีวิตได้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที *** ให้เพิ่มเกณฑ์การวินิจฉัย Neonatal sepsis *** - Septic shock (ภาวะช็อกจากการติดเชื้อ) หมายถึง ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่สุดของ sepsis (การติดเชื้อในกระแสเลือดที่มีการตอบสนองอักเสบทั้งร่างกาย) ที่นำไปสู่ ความล้มเหลวของระบบไหลเวียนโลหิตและการเผาผลาญของเซลล์ แม้ได้รับสารน้ำอย่างเพียงพอแล้ว แต่ยังคงมีความดันโลหิตต่ำและมีหลักฐานของ tissue hypoperfusion ทำให้อวัยวะต่าง ๆ ขาดเลือดและขาดออกซิเจน		
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ....10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายหลัก ทารกแรกเกิดที่มีภาวะ Sepsis โดยเฉพาะทารกเกิดก่อนกำหนด หรือน้ำหนักตัวน้อยที่เข้ารับการรักษาใน NICU เป็นผู้ป่วยโดยตรงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลุกลามเป็น Septic shock		
แหล่งข้อมูล	แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาล และอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยที่มี Septic shock รายใหม่ในช่วงเวลาที่ประเมิน B : จำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะ Sepsis ทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน หน่วย: ร้อยละ (%)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ....10	ลดลงร้อยละ....10	ลดลงร้อยละ....10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศุภวรรณ ปาปะชี		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. PPHN : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN
ตัวชี้วัดที่	KPI 27 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN
คำนิยาม	PPHN ย่อมาจาก Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn หรือ ภาวะความดันโลหิตสูงในปอดของทารกแรกเกิด เป็นภาวะที่ทารกแรกเกิดมีแรงดันในหลอดเลือดปอดสูงกว่าปกติหลังคลอด ทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปที่ปอดเพื่อรับออกซิเจนได้เพียงพอ แต่ไหลผ่านทางลัด (shunt) เช่น ductus arteriosus หรือ foramen ovale กลับเข้าสู่การไหลเวียนใหญ่ ส่งผลให้เกิดการ ขาดออกซิเจนเรื้อรังและรุนแรง แม้ว่า ปอดจะไม่เสียหายโดยตรงก็ตาม และปอดของทารกจะทำงานได้ตามปกติ แต่การแลกเปลี่ยนก๊าซไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเลือดส่วนใหญ่ไหลผ่านทางลัด (shunt) กลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนใหญ่โดยไม่ผ่านปอด ลักษณะสำคัญ 1. พบได้ในทารกแรกเกิดหรือเกือบครบกำหนด 2. มักสัมพันธ์กับภาวะขาดออกซิเจนในครรภ์, การสำลักขี้เทา (meconium aspiration), ภาวะปอดบวม, หรือความผิดปกติของการพัฒนาปอด 3. อาการหลัก: เขียว (cyanosis) รุนแรง, หายใจลำบาก, ค่าออกซิเจนต่ำแม้ให้ออกซิเจนสูง ความสำคัญ PPHN ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางทารกแรกเกิด ต้องได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที เช่น การช่วยหายใจ, การใช้ยาขยายหลอดเลือดปอด (เช่น inhaled nitric oxide), และบางรายอาจต้องใช้ ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN หมายถึง สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) แล้วเสียชีวิต ต่อจำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด คูณด้วย 100
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 50 (<50)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่มีภาวะ PPHN ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile Tracer PPHN : กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาลและอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต
รายการข้อมูล	อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN = (A/B) * 100

	A = จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และเสียชีวิต (นับเฉพาะรายที่เสียชีวิตภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น ระหว่างนอนรักษาใน โรงพยาบาล หรือตามเกณฑ์ของหน่วยงาน) B = จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (ทุกรายที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่ประเมิน ไม่ว่าจะเสียชีวิตหรือรอด ชีวิต)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	<50	<50	<50	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปิวิภา วนารมย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. PPHN : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN 4.1 ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax			
ตัวชี้วัดที่	OKR 27.1 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax ลดลง			
คำนิยาม	Pneumothorax หรือ ภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอด หมายถึง ภาวะที่มี อากาศรั่วเข้าสู่ช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural cavity) ระหว่างเยื่อหุ้มปอดด้านใน (visceral pleura) และเยื่อหุ้มปอดด้านนอก (parietal pleura) ทำให้ปอดถูกกดและแฟบลงบางส่วนหรือทั้งหมด ส่งผลให้การแลกเปลี่ยนก๊าซลดลงและผู้ป่วยมีอาการหายใจลำบาก อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax จากภาวะ PPHN คือ สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และเกิดภาวะลมรั่วในโพรงเยื่อหุ้มปอด (Pneumothorax) ต่อจำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด			
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 10			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) และเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล โดยมีภาวะแทรกซ้อน Pneumothorax เกิดขึ้นระหว่างการรักษา			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile Tracer PPHN : กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาลและอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต			
รายการข้อมูล	อัตราการเกิด Pneumothorax ใน PPHN = (A/B) * 100 A = จำนวนทารกที่มี PPHN และเกิดภาวะ Pneumothorax B = จำนวนทารกทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ด้วย 100			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	ลดลงร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปวีณา วนารมย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมขั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. PPHN : ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย PPHN 4.2 อัตราการได้รับ Proper vasodilator ภายใน 30 นาที เพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 27.2 อัตราการได้รับ Proper vasodilator ภายใน 30 นาที		
คำนิยาม	Proper vasodilator ใน PPHN หมายถึง ยาที่ออกฤทธิ์โดยตรงในการลดความต้านทานของหลอดเลือดปอด เช่น Inhaled Nitric Oxide, Sildenafil, Milrinone เพื่อให้การไหลเวียนเลือดผ่านปอดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนของทารกดีขึ้น และบรรเทาภาวะพร่องออกซิเจนในทารกที่มี PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) อัตราการได้รับยา Proper vasodilator ใน PPHN หมายถึง สัดส่วนของทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และได้รับยาขยายหลอดเลือดปอดที่เหมาะสม (เช่น iNO, Sildenafil, Milrinone) ต่อจำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN ทั้งหมด ในช่วงเวลาที่กำหนด คูณด้วย 100		
ค่าเป้าหมาย	มากกว่าร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN (Persistent Pulmonary Hypertension of the Newborn) และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล โดยได้รับยา Proper vasodilator ระหว่างการรักษา		
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจาก CLT Profile Tracer PPHN : กุมารเวชกรรมโรงพยาบาลมหาสารคาม/แบบบันทึกสถิติประจำเดือนข้อมูลแบบบันทึกภาวะแทรกซ้อน แบบบันทึกผลการรักษาพยาบาลและอุบัติการณ์การตาย หอผู้ป่วยทารกวิกฤต		
รายการข้อมูล	อัตราการได้รับยา Proper vasodilator ใน PPHN = $(A/B) \times 100$ A = จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN และได้รับยา Proper vasodilator B = จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น PPHN		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	มากกว่าร้อยละ 80	มากกว่าร้อยละ 80	มากกว่าร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรสสุคนธ์ ปริพล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงปวีณา วรารมย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร								
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)								
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. Dengue Hemorrhagic Fever : ไม่พบอัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กอายุ < 15 ปี								
ตัวชี้วัดที่	KPI 28 อุบัติการณ์การเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก								
คำนิยาม	การเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) หมายถึง ผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคหลัก เป็นไข้เลือดออก และสถานะการจำหน่ายเป็นเสียชีวิต ICD-10 = ผู้ป่วยเด็ก หมายถึง ผู้ป่วยที่มีอายุ < 15 ปี								
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)								
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม								
รายการข้อมูล	A : จำนวนการเสียชีวิตในผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A								
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>เท่ากับ 0</td><td>เท่ากับ 0</td><td>เท่ากับ 0</td></tr></table>	2570	2571	2572	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0		
2570	2571	2572							
เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนันธิชา หาโกสีย์								
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุวรรณ ปาปะชี								

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (กุมารเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. Dengue Hemorrhagic Fever : ไม่พบอัตราป่วยตายโรคไข้เลือดออกในกลุ่มเด็กอายุ < 15 ปี 5.1 ไม่พบอุบัติการณ์แก้ไขภาวะช็อคล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง			
ตัวชี้วัดที่	OKR 28.1 อับัติการณ์ผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่ได้รับการแก้ไขภาวะช็อคล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง			
คำนิยาม	ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) หมายถึง ผู้ป่วยที่วินิจฉัยโรคหลัก เป็นไข้เลือดออก ICD-10 = การแก้ไขภาวะช็อคล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง หมายถึง การที่ไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยพ้นภาวะช็อคได้ภายใน 2 ชั่วโมง นับเวลาตั้งแต่วินิจฉัยภาวะช็อคจากโรคไข้เลือดออกจนถึงผู้ป่วยพ้นภาวะช็อค ภาวะช็อค หมายถึง			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเด็กโรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever)			
แหล่งข้อมูล	ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยเด็กไข้เลือดออกที่ได้รับการแก้ไขภาวะช็อคล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนันทิชา หาโกสีย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศุภวรรณ ปาปะชี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. High risk Pregnancy : หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง (DM/HT/U/D Med) ได้รับการดูแลจากสูติแพทย์และอายุรแพทย์ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	KPI 29 อัตราหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง (DM/HT/U/D Med) ได้รับการดูแลจากสูติแพทย์และอายุรแพทย์			
คำนิยาม	หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง (High-risk Pregnancy): หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้การตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปลอดภัย ได้แก่เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคประจำตัวทางอายุรกรรมอื่นๆ			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มารับบริการฝากครรภ์ และคลอดที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (OPD), ผู้ป่วยใน (IPD) และข้อมูลการคลอดของโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A=จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูงที่ได้รับการดูแลจากสูติแพทย์และอายุรแพทย์ B=จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่มีภาวะเสี่ยงสูง			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A*B/100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเดิม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางมยุรี ศรีภูโรจน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงกนกพร บุตรमारศรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. PPH : ไม่พบอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากPPH			
ตัวชี้วัดที่	KPI 30 อุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจาก PPH			
คำนิยาม	1.Postpartum hemorrhage หมายถึง ภาวะที่มีเลือดออกปริมาณตั้งแต่ 1,000 มิลลิตรขึ้นไป หรือมีเลือดออกร่วมกับมีอาการหรืออาการแสดงของภาวะ hypovolemia ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด รวมการเสียเลือดช่วงที่เจ็บครรภ์คลอด 2.มารดาเสียชีวิต หมายถึง มารดาที่เสียชีวิตในระหว่างการตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือ ภายใน 42 วันหลังการคลอด โดยสาเหตุการเสียชีวิตต้องเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร ไม่นับรวมสาเหตุจากอุบัติเหตุหรือการฆาตกรรม			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือหลังการคลอดภายใน 42 วันที่มีภาวะ Postpartum hemorrhage			
แหล่งข้อมูล	1. สถิติการคลอด กลุ่มงานสูตินรีเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. รายงาน ก.2 จังหวัดมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือหลังการคลอดภายใน 42 วันที่มีภาวะ Postpartum hemorrhage เสียชีวิต			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.ชุดิมา อันเนตร์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร บุตรมาศรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. PPH : ไม่พบอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากPPH 2.1 ไม่พบอุบัติการณ์ EWS ค่าชาระยะ24 ชั่วโมงหลังคลอด			
ตัวชี้วัดที่	OKR 30.1 อุตการณ์ EWS ระยะ24 ชั่วโมงหลังคลอด			
คำนิยาม	1.Early warning signs (EWS) หมายถึง สัญญาณหรืออาการผิดปกติที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มที่ผู้ป่วยจะมีการทรุดลงหรือเข้าสู่ภาวะวิกฤตอย่างเฉียบพลัน			
	2. Early warning signs in PPH ได้แก่			
	2.1 PR > 100 ครั้ง/นาที	2.2 Active bleeding		
	2.3 Pulse pressure < 30 mmHg	2.4 Uterine atony		
	2.5 เวียนศีรษะ หน้ามืด/เป็นลม/เหงื่อออก ตัวเย็น	2.6 Pain > 7 คะแนน หลังให้ยาแก้ปวด		
	2.7 รอบท้องเพิ่ม > 3 cms (C/S)	2.8 Hct drop > 3 %		
ค่าเป้าหมาย	อุบัติการณ์ EWS ระยะ 24 ชั่วโมงหลังคลอดเท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือหลังการคลอดภายใน 24 ชั่วโมงที่มีภาวะ Postpartum hemorrhage			
แหล่งข้อมูล	1. สถิติการคลอด กลุ่มงานสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. รายงาน ก.2 จังหวัดมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือหลังการคลอดภายใน 24 ชั่วโมงที่มีภาวะ Postpartum hemorrhage ได้รับการประเมิน EWS ค่าซ้ำ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.ชุติมา อันเนตร์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร บุตรमारศรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. PPH : ไม่พบอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากPPH 2.2 ไม่พบอุบัติการณ์การผ่าตัดซ้ำล่าช้า (Delay Re-EL)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 30.2 อุตการณ์การผ่าตัดซ้ำล่าช้า (Delay Re-EL)			
คำนิยาม	การผ่าตัดซ้ำล่าช้า (Delay Re-EL)หมายถึง ผู้ป่วยผ่าตัดที่ทำกับผู้ป่วยอีกครั้ง หลังจากเคยได้รับการผ่าตัดในครั้งแรกไปแล้วหรือผู้ป่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงผลลัพธ์จากการผ่าตัดครั้งแรกที่ไม่ได้ผลตามที่ต้องการ หรือแก้ไขความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดครั้งแรก โดยส่งผู้ป่วยถึงห้องผ่าตัดล่าช้ากว่า 30 นาที นับจากแพทย์ Order (Order to OR)			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือหลังการคลอดภายใน 24 ชั่วโมงที่มีภาวะ Postpartum hemorrhage แพทย์มี Order set OR for Exploratory laparotomy			
แหล่งข้อมูล	1. สถิติการคลอด กลุ่มงานสูติเวช โรงพยาบาลมหาสารคาม 2. รายงาน ก.2 จังหวัดมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหญิงตั้งครรภ์ คลอดบุตร หรือหลังการคลอดภายใน 24 ชั่วโมงที่มีภาวะ Postpartum hemorrhage แพทย์มี Order set OR for Exploratory laparotomy			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.ชุติมา อันเนตร์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร บุตรमारศรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. PIH : ไม่พบอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากPIH			
ตัวชี้วัดที่	KPIs 31 อับัติการณ์มารดาเสียชีวิตจาก PIH			
คำนิยาม	มารดาเสียชีวิตจาก PIH (Maternal Death from PIH):หมายถึง การเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงหลังคลอดที่มีสาเหตุหลักหรือสาเหตุร่วมมาจากภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Pregnancy-induced Hypertension - PIH)			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงหลังคลอดที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH) ทุกคนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD), ทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต และรายงานการทบทวนการเสียชีวิตของมารดา (Maternal Death Review)			
รายการข้อมูล	A : จำนวนมารดาที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเสียชีวิตจากภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Pregnancy-induced Hypertension - PIH)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางณิรชา ชินรัตน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงวกุล ลัญจกรสิริพันธุ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. PIH : ไม่พบอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากPIH 3.1 ไม่พบอุบัติการณ์EWS ล่าช้าทุกระยะของการคลอด			
ตัวชี้วัดที่	OKR 31.1 อุตการณ์ EWS ล่าช้าทุกระยะของการคลอด			
คำนิยาม	Early warning signs PIH มีดังนี้ 1.Early Warning Sign (EWS) Preeclampsia 2.Early Warning Sign (EWS) Eclampsia 3.Early Warning Sign HELLP syndrome			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH) ทุกคนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD), ทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต และรายงานการทบทวนการเสียชีวิตของมารดา (Maternal Death Review)			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงหลังคลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (PIH) ทุกคนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการประเมินและประเมินซ้ำจากพยาบาล และแพทย์ โดยใช้ EWS เพื่อเฝ้าระวังอันตรายที่อาจส่งผลให้มารดาเสียชีวิตจากPIH จำนวนครั้งของอุบัติการณ์ EWS ล่าช้าทุกระยะของการคลอดที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด				
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางณิรชา ชินรัตน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงวกุล ลัญจกรสิริพันธุ์			

⁽¹⁾Early warning signs PIH มีดังนี้

Early Warning Sign (EWS) Preeclampsia

1. SBP ≥ 140 หรือ DBP ≥ 90 mmHg ตัวใดตัวหนึ่งสูงพัก 10-15 นาทีวัดซ้ำยังสูง
2. Urine Albumin $\geq + 2$
3. Proteinuria : > 300 mg/day หรือ UPCI > 0.3 mg/dl (urine protein creatinine index)
4. ค่าเกล็ดเลือด: จำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 ต่อไมโครลิตร
5. ค่าเอนไซม์ตับ: ค่าเอนไซม์ตับ (AST และ/หรือ ALT) สูงกว่าปกติอย่างน้อยสองเท่า
6. ค่าไต: ค่าcreatinine ในเลือดสูงกว่า 1.1 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรหรือสูงขึ้นเป็นสองเท่าจากค่าเดิม

Early Warning Sign (EWS) Eclampsia

1. SBP ≥ 160 หรือ DBP ≥ 110 mmHg ตัวใดตัวหนึ่งสูงพัก 5 นาทีวัดซ้ำยังสูง
2. ปวดศีรษะบริเวณหน้าผากหรือท้ายทอย
3. ตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัด
4. จุกแน่นใต้ลิ้นปี่
5. เจ็บชายโครงขวา
6. อาการทางปอด: มีภาวะน้ำท่วมปอดทำให้หายใจหอบเหนื่อยหรือหายใจลำบาก

Early Warning Sign Pulmonary edema

1. O₂sat < 95 % in room air
2. PR ≥ 120 bpm ร่วมกับ RR > 20 bpm
3. Respiratory rate > 24 ครั้ง/นาที
4. Urine output < 30 cc/hr
5. I/O Positive
6. บวมที่ใบหน้ามือหรือเท้า
7. เหนื่อยหายใจไม่อิ่มบ่อย

Early Warning Sign HELLP syndrome

1. เจ็บชายโครงขวา
2. ตาพร่ามัวมองเห็นไม่ชัด
3. ปวดศีรษะ
3. คลื่นไส้และอาเจียน
4. ภาวะตัวเหลืองหรือตาเหลือง
5. ปัสสาวะจะออกเป็นสีแดงหรือน้ำตาล (สีโค้ก)
6. ภาวะเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis): ค่าLDH ≥ 600 U/L
7. ค่าเกล็ดเลือด: จำนวนเกล็ดเลือดต่ำกว่า 100,000 ต่อไมโครลิตร

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. PIH : ไม่พบอุบัติการณ์มารดาเสียชีวิตจากPIH 3.2 ไม่พบอุบัติการณ์รักษาล่าช้า			
ตัวชี้วัดที่	OKR 31.2 อุตบัติการณ์รักษาล่าช้า			
คำนิยาม	การรักษาPIH ล่าช้าหมายถึง การที่หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (Pregnancy-induced Hypertension - PIH) หรือมีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดภายในระยะเวลาที่เหมาะสมระยะเวลาที่เหมาะสม:โดยทั่วไปหมายถึงภายใน 30-60 นาทีหลังจากวินิจฉัยภาวะรุนแรง เช่น Pre-eclampsia with severefeature หรือ Eclampsia การรักษาที่สำคัญ:ได้แก่ การให้ยาป้องกันอาการชัก (Magnesium sulfate), การให้ยาลดความดันโลหิต,หรือการตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วยไปยังห้องผ่าตัดฉุกเฉิน 1.เวลาที่แพทย์วินิจฉัยภาวะ Severe PIH 2. เวลาที่เริ่มให้การรักษา (เช่น เวลาที่เริ่มให้ Magnesium sulfate หรือยาลดความดันโลหิต) 3.การคำนวณระยะเวลาที่ใช้ในการเริ่มการรักษา 4.จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมดที่เข้าเกณฑ์การวินิจฉัย Pre-eclampsia with severefeature			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรง (Pre-eclampsia with severefeature)ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD):โดยเฉพาะส่วนที่บันทึกคำสั่งการรักษาและเวลาที่ให้การรักษา บันทึกที่ห้องคลอด/ห้องฉุกเฉิน:เพื่อดูเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงและเวลาที่เริ่มต้นการรักษา			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งของอุบัติการณ์การรักษา PIH ล่าช้าตามแนวทางปฏิบัติ ตามช่วงเวลาที่กำหนด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางณิรชา ชินรัตน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงวสุกุล ลัญจกรสิริพันธ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. Preterm Labor : ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดSevere BA ในนาทีที่ 5 แรกคลอด			
ตัวชี้วัดที่	KPI 32 อุบัติการณ์การเกิด Severe BA ในนาทีที่ 5 ใน Preterm labor			
คำนิยาม	Severe BA (Severe Birth Asphyxia) ในนาทีที่ 5 แรกคลอด ใน Preterm labor หมายถึง ภาวะที่ทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดมีคะแนน Apgar score ที่ 5 นาที เท่ากับ 0-3			
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่า 1 รายต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดทุกคนที่คลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) และข้อมูลการคลอดของโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดมีภาวะ Severe BA (Apgar score 0-3) ในนาทีที่ 5			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	อุบัติการณ์การเกิด Severe BA ในนาทีที่ 5 = จำนวนทารกแรกเกิดที่ที่คลอดก่อนกำหนดมี Apgar score 0-3 ในนาทีที่ 5			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	น้อยกว่า 3 รายต่อปี	น้อยกว่า 2 รายต่อปี	น้อยกว่า 1 รายต่อปี	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุภาพร สุภาพวีวัฒน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์ศราวุธ มิตะลา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. Preterm Labor : ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดSevere BA ในนาที่ที่ 5 แรกคลอด 4.1 ไม่พบอุบัติการณ์ EWS RD Score ผิดพลาด			
ตัวชี้วัดที่	OKR 32.1 อุบัติการณ์ EWS RD Score ผิดพลาด			
คำนิยาม	EWS RD Score ผิดพลาด หมายถึง ความคลาดเคลื่อนหรือความผิดพลาดในการใช้ การคำนวณ หรือการแปลผลคะแนน Early Warning Score (EWS) ที่ใช้ในการประเมินภาวะหายใจลำบาก (Respiratory Distress Syndrome: RDS) ในทารกแรกเกิด ได้แก่ Cyanosis, Retraction, Grunting, Air entry และ Respiratory ซึ่งอาจนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาที่ไม่เหมาะสม			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดทุกคนที่คลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) และข้อมูลการคลอดของโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดที่คลอดก่อนกำหนดมีภาวะ Severe BA (Apgar score 0-3) ในนาที่ที่ 5			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุภาพร สุภาพวีวัฒน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์ศราวุธ มิทะลา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. Preterm Labor : ไม่พบอุบัติการณ์การเกิด Severe BA ในนาทีที่ 5 แรกตลอด 4.2 ไม่พบอุบัติการณ์ RRT ล่าช้า			
ตัวชี้วัดที่	OKR 32.2 อุตการณ์RRT ล่าช้า			
คำนิยาม	RRT (Rapid Response Team): หมายถึง ทีมแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อตอบสนองต่อผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤตอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอาการทรุดลงหรือเสียชีวิต RRT ล่าช้า : หมายถึง การที่ทีม RRT ไม่สามารถมาถึงผู้ป่วยและเริ่มต้นการประเมินหรือให้การรักษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับการแจ้งเตือน ระยะเวลาที่กำหนด: ไม่เกิน 5 นาทีหลังจากได้รับการแจ้งเหตุฉุกเฉินจากบุคลากรในหน่วยงาน 1. เวลาที่แพทย์วินิจฉัยภาวะ Severe BA 2. เวลาที่RRTมาถึงผู้ป่วยและเริ่มต้นการประเมินหรือให้การรักษาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากได้รับการแจ้งเตือน			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารก Preterm ที่เกิดภาวะ Severe BA ในนาทีที่ 5 แรกตลอดในโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่ได้รับการเรียกทีมRRTเพื่อช่วยเหลือ			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) และข้อมูลการคลอดของโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งที่ทีม RRT เข้าถึงผู้ป่วยล่าช้า			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุภาพร สุภาพวีวัฒน์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์ศราวุธ มิทะลา			

ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1:ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย นิยามและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. Ectopic Pregnancy : ไม่พบอุบัติการณ์ Hypovolemic shock หลังรับไว้รักษา			
ตัวชี้วัดที่	KPI 33 อับัติการณ์ Hypovolemic shock ใน Ectopic Pregnancy หลังรับไว้รักษา			
คำนิยาม	อุบัติการณ์ Hypovolemic shock ที่มาจากสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูก หลังรับไว้รักษา อับัติการณ์(Incident) หมายถึง จำนวนมารดาที่มีภาวะ Hypovolemic shock หลังรับไว้รักษา ที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งครรภ์นอกมดลูกทุกคนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน			
รายการข้อมูล	A : จำนวนสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งครรภ์นอกมดลูกและมีภาวะ Hypovolemic shock หลังรับไว้รักษา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี		2570	2571	2572
		เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางองค์ออน ภาภูตานนท์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.เบญจรัตน์ ตริวิริยานุภาพ			

(1) EWS Ectopic Pregnancy

1. EWS score in Ectopic ≥ 5
2. EWS Hypovolemic shock
 - 2.1 เวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม
 - 2.2 V/S : PR > 100 bpm, Pulse pressure < 30 mmHg
 - 2.3 pain score หลังให้ยาแก้ปวด
 - 2.4 Hct drop $\geq 3\%$
 - 2.5 Abdominal signs: ท้องอืดร่วมกับ Guarding ร่วมกับกดเจ็บ/ rebound tenderness

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. Ectopic Pregnancy : ไม่พบอุบัติการณ์ Hypovolemic shock ในผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูก 5.1 ไม่พบอุบัติการณ์ EWS ลำไส้		
ตัวชี้วัดที่	OKR 33.1 อุตการณ์ EWS ลำไส้		
คำนิยาม	EWS ลำไส้ หมายถึง การประเมินไม่ครอบคลุมตามแนวทางการประเมินผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามเกณฑ์ EWS score Ectopic pregnancy		
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งครรภ์นอกมดลูกทุกคนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยที่ได้รับการประเมิน EWS score ตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกตามเวลาที่กำหนด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นาง อังคอรณ ภาณุตานนท์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.เบญจรัตน์ ตรีวิริยานุภาพ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. Ectopic Pregnancy : ไม่พบอุบัติการณ์ Hypovolemic shock 5.2 ไม่พบอุบัติการณ์วินิจฉัยผิดพลาด			
ตัวชี้วัดที่	OKR 33.2 อับัติการณ์วินิจัยผิดพลาด			
คำนิยาม	การวินิจฉัย Ectopic ผิดพลาดหมายถึง สตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าตั้งครรภ์นอกมดลูกและไม่ได้รับการรักษาตามแนวปฏิบัติที่กำหนด			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	สตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยตั้งครรภ์นอกมดลูกทุกคนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกที่เข้ารับการรักษในโรงพยาบาลมหาสารคาม และจำนวนสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ได้รับการวินิจฉัยผิดพลาด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นาง องค์ออน ภาฏตานนท์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.เบญจรัตน์ ตรีวิริยานุภาพ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. CA Cervix : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกStage 1-2 ภายใน 5 ปีเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPI 34 อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage 1-2 ภายใน 5 ปี			
คำนิยาม	ความหมาย : สตรีที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นรายใหม่ในปี (ปีงบประมาณ) ระยะที่ 1 : เซลล์มะเร็งอยู่ที่ปากมดลูก และเริ่มมีการลุกลาม ระยะที่ 2 : เซลล์มะเร็งลุกลามเข้าไปในช่องคลอด แต่ยังไม่ถึง 1/3 ของช่องคลอด หรืออาจลุกลามเข้าไปที่เนื้อเยื่อข้างปากมดลูก แต่ยังไม่ถึงผนังของเชิงกราน			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage 1-2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD), ทะเบียนผู้ป่วยเสียชีวิต และรายงานการทบทวนการเสียชีวิตของผู้ป่วย			
รายการข้อมูล	A=ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage 1-2 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่รอดชีวิตภายใน 5 ปี B=ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ทุกระยะ (ระยะ 1-4) ในช่วงเวลาที่กำหนด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสมพร รักษาภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิวิมล ราตรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคมะเร็งในโรคมะเร็งที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. CA Cervix : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกStage 1-2 ภายใน 5 ปีเพิ่มขึ้น 6.1 ได้รับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage1-2 ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับการวินิจฉัยทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 34.1 อัตราการผ่าตัด ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage 1-2 ภายใน 4 สัปดาห์หลังจากได้รับการวินิจฉัย			
คำนิยาม	การผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage1-2 ภายใน 4 สัปดาห์ หลังจากได้รับการวินิจฉัย ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสม การผ่าตัดรักษา จะใช้ในการรักษามะเร็งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ขึ้นต้น คือช่วงที่เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นบริเวณปากมดลูกและช่องคลอด เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังอวัยวะอื่น			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกStage1-2 ที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนผู้ป่วยนอกทางนรีเวช (OPD) และ เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD)			
รายการข้อมูล	A=ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage 1-2 ที่เข้ารับการผ่าตัดภายใน 4 สัปดาห์ B=ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก ทุกระยะ (ระยะ 1-4) ในช่วงเวลาที่กำหนด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสมพร รักษาภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิวิมล ราตรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. CA Cervix : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกStage 1-2 ภายใน 5 ปีเพิ่มขึ้น 6.2 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้รับยาเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 34.2 อัตราของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้รับยาเคมีบำบัดภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์			
คำนิยาม	การรักษาด้วยเคมีบำบัด หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึงบริการ (Access to Care) การรักษาด้วยเคมีบำบัดภายใน 6 สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับ จาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ยืนยันการวินิจฉัยเป็นมะเร็งและนำมาสู่การรักษามะเร็ง นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับ ยาเคมีวันแรก -วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น รังสีรักษา, ผ่าตัด นับถึงวันที่ผู้ป่วยได้รับยาเคมีวันแรก (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกรายงานจังหวัดหรืออำเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ การผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage1-2 ได้รับยาเคมีบำบัด ภายใน 6 สัปดาห์ หลังจากได้รับการวินิจฉัย ในเป็นเวลาที่เหมาะสม การผ่าตัดรักษา จะใช้ในการรักษามะเร็งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ขึ้นต้น คือช่วงที่เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นบริเวณปากมดลูกและช่องคลอด เพื่อป้องกันการลุกลามไปยังอวัยวะอื่น			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัด			
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนผู้ป่วยนอกทางนรีเวช (OPD) และ เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD)			
รายการข้อมูล	A=ผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูก Stage1-2 ได้รับยาเคมีบำบัด ภายใน 6 สัปดาห์ B=จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด เพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสมพร รักษาภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิวิมล ราตรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (สูติ-นรีเวชกรรมขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราการป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. CA Cervix : อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกStage 1-2 ภายใน 5 ปีเพิ่มขึ้น 6.3 ผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้รับรังสีรักษาภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังผ่าตัดทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 34.3 อัตราของผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกได้รับรังสีรักษา ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์หลังผ่าตัด			
คำนิยาม	การรักษาด้วยรังสีรักษา หมายถึง การกำหนดระยะเวลาในการเข้าถึง บริการ (Access to Care)การรักษาด้วยรังสีรักษาภายใน 6สัปดาห์ (42 วัน) โดยนับจาก - วันที่ตัดชิ้นเนื้อ/เซลล์ ส่งตรวจ (เป็นชิ้นเนื้อ/เซลล์ในครั้งที่ใช้นิยมนการวินิจฉัยเป็นมะเร็ง และ นำมาสู่การรักษามะเร็ง) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับรังสีรักษา - วันสุดท้ายของการรักษาด้วยวิธีอื่น (เช่น เคมีบำบัด, ผ่าตัด) นับถึงวันแรกที่ผู้ป่วยได้รับ รังสีรักษา (การรักษาผ่าตัด นับจากวันที่ผ่าตัด) - ในกรณีที่ไม่มีการตรวจชิ้นเนื้อหรือไม่มีการรักษาด้วยวิธีอื่น ให้นับตั้งแต่วันที่ทำการตรวจ วินิจฉัยทางรังสีวิทยา เช่น วันทำ CT, MRI, Ultrasound, X-ray โดยนับจากครั้งที่นำผลมา ตัดสินใจให้การรักษามะเร็ง เป็นต้น - กรณีผู้ป่วยส่งต่อจากสถานพยาบาลอื่น ให้นับแบบเดียวกับผู้ป่วยใหม่โดยแยกราชงาน จังหวัดหรืออำเภอที่ส่งต่อเพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องได้รับการรักษามะเร็งด้วยวิธีให้ยาเคมีบำบัด			
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนผู้ป่วยนอกทางนรีเวช (OPD) และ เวชระเบียนผู้ป่วยใน (IPD) หน่วยบริการรังสี ควบคุมคุณภาพ ทะเบียนมะเร็ง			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษาและได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษา ≤ 6 สัปดาห์ นับตามเกณฑ์ที่กำหนด B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาเพื่อรักษามะเร็งทั้งหมดในปีที่รายงาน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/ B) X 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสมพร รักษาภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิวิมล ราตรี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. TKA : ผู้ป่วยหลังผ่าตัด TKA มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับชาติ)			
ตัวชี้วัดที่	KPI 35 อัตราผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น			
คำนิยาม	Total Knee Arthroplasty (TKA) หมายถึง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ โดยแพทย์จะนำผิวข้อกระดูกที่เสื่อมสภาพออก แล้วใส่วัสดุ รถในการใช้ชีวิตประจำวันและความสุขที่ลดลงเนื่องจากอาการปวด ข้อเข่าแข็ง ข้อเข่าผิดรูป และความยากลำบากในการทำกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การเคลื่อนไหวทั่วไป เช่น เดิน ขึ้นลงบันได ไปจนถึงกิจกรรมทางสังคม การทำงาน และสภาพจิตใจ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด TKA มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยประเมินจากคะแนน VOMAC Score ประเมินคะแนนลดลง VOMAC Score หมายถึง... เกณฑ์คะแนน คือ .. รหัส ICD-9 ของ TKA =			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยน TKA			
แหล่งข้อมูล	รายงาน...ประจำปีประจำปีไตรมาส			
รายการข้อมูล	A = ผู้ป่วยหลังผ่าตัด TKA มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยประเมินจากคะแนน VOMAC Score ประเมินคะแนนลดลง B = ผู้ป่วยที่ผ่าตัด TKA ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ร้อยละ 80	2571 ร้อยละ 80	2572 ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นียมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. TKA : ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับชาติ) 1.1 ผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 35.1 อัตราผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อม			
คำนิยาม	ข้อเข่าเสื่อม (Knee Osteoarthritis) หมายถึง ภาวะที่ผิวข้อกระดูกอ่อนบริเวณเข่า ค่อย ๆ เสื่อมสภาพ ทำให้กระดูกเสียดสีกันโดยตรง ส่งผลให้เกิดอาการปวด บวม ข้อฝืด และเคลื่อนไหวลำบาก ผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ Oxford knee Score			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุ > 50 ปี			
แหล่งข้อมูล	รายงานประจำปีประจำปีไตรมาส			
รายการข้อมูล	A = ผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ Oxford knee Score B = ผู้สูงอายุ > 50 ปี ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. TKA : ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับชาติ) 1.2 ผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ Oxford knee Score พบภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดได้รับการผ่าตัด			
ตัวชี้วัดที่	OKR 35.2 อัตราผู้สูงอายุที่ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเสื่อมที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด			
คำนิยาม	ผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเสื่อมโดยใช้ Oxford knee Scoreภาวะข้อเสื่อมที่มีข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด ข้อบ่งชี้ได้รับการผ่าตัด คือ ... การผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม หมายถึง ... ได้รับการผ่าตัดภายในระยะเวลา....เริ่ม....ถึง....			
ค่าเป้าหมาย	มากกว่าร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุ > 50 ปีได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ Oxford knee Score พบภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	รายงานตามไตรมาส			
รายการข้อมูล	A = ผู้สูงอายุ > 50 ปี ได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ Oxford knee Score พบภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดได้รับการผ่าตัด B = ผู้สูงอายุ > 50 ปีได้รับการคัดกรองภาวะข้อเข่าเสื่อมโดยใช้ Oxford knee Score พบภาวะข้อเข่าเสื่อมที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. TKA : ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับชาติ) 1.3 ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA สามารถงอเข้าได้มากกว่า 90 องศาเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 35.3 อัตราผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA สามารถงอเข้าได้มากกว่า 90 องศา ก่อนกลับบ้าน			
คำนิยาม	Total Knee Arthroplasty (TKA) หมายถึง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ โดยแพทย์จะนำผิวข้อกระดูกที่เสื่อมสภาพออก แล้วใส่วัสดุเทียม (prosthesis) แทน เพื่อให้ข้อเข่ากลับมาเคลื่อนไหวได้ดี ลดอาการปวด และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย **วิธีการวัด** องศาการงอเข้า คือ ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA สามารถงอเข้าได้มากกว่า 90 องศา ก่อนกลับบ้าน			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA			
แหล่งข้อมูล	รายงานตามไตรมาส			
รายการข้อมูล	A = ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA สามารถงอเข้าได้มากกว่า 90 องศา ก่อนกลับบ้าน B = ผู้สูงอายุข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. TKA : ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ระดับชาติ) 1.4 ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเสื่อม สามารถเหยียดข้อเข่าไม่สุด (Extension Lag) < 10 องศา เพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 35.4 ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดTKA สามารถเหยียดข้อเข่าไม่สุด (Extension Lag) < 10 องศา ก่อนกลับบ้าน			
คำนิยาม	Total Knee Arthroplasty (TKA) หมายถึง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ โดยแพทย์จะนำผิวข้อกระดูกที่เสื่อมสภาพออก แล้วใส่วัสดุเทียม (prosthesis) แทน เพื่อให้ข้อเข่ากลับมาเคลื่อนไหวได้ดี ลดอาการปวด และเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย **วิธีการวัด** องศาการเหยียดเข่า คือ...			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดTKA			
แหล่งข้อมูล	รายงานตามไตรมาส			
รายการข้อมูล	A = ผู้สูงอายุข้อเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA สามารถเหยียดข้อเข่าไม่สุด (Extension Lag) < 10 องศา ก่อนกลับบ้าน B = ผู้สูงอายุข้อเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัด TKA			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Fracture around Hip in elderly : ลดอัตราการเสียชีวิต			
ตัวชี้วัดที่	KPI 36 อัตราการเสียชีวิตจากภาวะ Pulmonary Embolism ของผู้ป่วย Fracture around Hip			
คำนิยาม	ผู้ป่วย Fracture around Hip หมายถึง... ภาวะ Pulmonary Embolism หมายถึง... รหัส ICD-10 ของ Fracture around Hip คือ รหัส..... รหัส ICD-10 ของ Pulmonary Embolism คือ รหัส.....			
ค่าเป้าหมาย	น้อยกว่าร้อยละ 2			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Fracture around Hip			
แหล่งข้อมูล	รายงานตามไตรมาส			
รายการข้อมูล	A = ผู้ป่วย Fracture around Hip เสียชีวิตจากภาวะ Pulmonary Embolism B = ผู้ป่วย Fracture around Hip			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/Bx100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	< ร้อยละ 2	< ร้อยละ 2	< ร้อยละ 2	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Fracture around Hip in elderly : ลดอัตราการเสียชีวิต 2.1 อัตราผู้ป่วย Fracture around Hip ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงหลัง admit ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 36.1 อัตราผู้ป่วย Fracture around Hip ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมงหลัง admit			
คำนิยาม	ผู้ป่วย Fracture around Hip หมายถึง... ระยะเวลาการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลัง admit นับระยะเวลาจาก....ถึง.... รหัส ICD-10 Fracture around Hip			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Fracture around Hip			
แหล่งข้อมูล	รายงานตามไตรมาส			
รายการข้อมูล	A= ผู้ป่วย Fracture around Hip ได้รับการผ่าตัดภายใน 72 ชั่วโมง หลัง admit B= ผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ admit			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/Bx1000			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Fracture around Hip in elderly : ลดอัตราการเสียชีวิต 2.2 อัตราผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ได้รับการผ่าตัด มีค่า BI เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 36.2 อัตราผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ได้รับการผ่าตัด มีค่า BI เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ			
คำนิยาม	ผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ได้รับการผ่าตัด มีค่า BI เพิ่มขึ้น			
ค่าเป้าหมาย	มากกว่าร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ได้รับการผ่าตัด			
แหล่งข้อมูล	รายงานตามไตรมาส			
รายการข้อมูล	A=ผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ได้รับการผ่าตัดมีค่า BI เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระดับ B= ผู้ป่วย Fracture around Hip ที่ได้รับการผ่าตัด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/Bx100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.รัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร								
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)								
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จักษุชั้นเลิศ)								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. ROP : อัตราทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงไม่มีภาวะตาบอดจากโรค Retinopathy of Prematurity (ROP)								
ตัวชี้วัดที่	KIP 38 อัตราทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะตาบอดจาก Retinopathy of Prematurity (ROP)								
คำนิยาม	ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง คือ 1. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,000 กรัมหรืออายุครรภ์น้อยกว่า 36 สัปดาห์ 2. ทารกแรกเกิดที่อายุครรภ์มากกว่า 36 สัปดาห์ และมีปัญหาโรคทางกายอย่างอื่น ๆ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ Retinopathy of Prematurity (ROP) คือ ภาวะผิดปกติของจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เกิดจากการที่หลอดเลือดในจอประสาทตายังพัฒนาไม่สมบูรณ์ แล้วมีการเจริญเติบโตผิดปกติ อาจทำให้เกิดพังผืด ดึงรั้งจอประสาทตาจนหลุดลอก และนำไปสู่ ภาวะตาบอดถาวร ได้ ภาวะตาบอด หมายถึง ระดับสายตาข้างที่ด้อยที่สุดน้อยกว่า 5/200E รหัส ICD-10 ..								
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เป็น 0								
ประชากรกลุ่มเสี่ยง	-เด็กทารกคลอดก่อนกำหนดมีข้อบ่งชี้การตรวจตาจังหวัดมหาสารคาม								
แหล่งข้อมูล	-ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม / ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข								
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดที่มีภาวะตาบอดจาก ROP B : จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัย ROP ทั้งหมด								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100								
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2570	2571	2572	0	0	0		
2570	2571	2572							
0	0	0							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางจินสุดา ดวงดี								
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.อัจฉริยา แสนมี								

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จักษุชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ROP : อัตราทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดไม่มีตาบอดจากโรค ROP (Unfavorable visual outcome) : อัตราทารกแรกเกิดได้รับการคัดกรองภาวะROP ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 38.1 อัตราทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองภาวะ ROP			
คำนิยาม	ทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง คือ 1. ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,000 กรัมหรืออายุครรภ์ ≤ 32 สัปดาห์ 2. ทารกแรกเกิดที่อายุครรภ์ > 32 สัปดาห์ และมีปัญหาโรคทางกายอย่างอื่น ๆ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ Retinopathy of Prematurity (ROP) คือ ภาวะผิดปกติของจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เกิดจากการที่หลอดเลือดในจอประสาทตายังพัฒนาไม่สมบูรณ์ แล้วมีการเจริญเติบโตผิดปกติ อาจทำให้เกิดพังผืด ดึงรั้งจอประสาทตาจนหลุดลอก และนำไปสู่ ภาวะตาบอดถาวร ได้ รหัส ICD-10 ..			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ100			
ประชากรกลุ่มเสี่ยง	-เด็กทารกคลอดก่อนกำหนดมีข้อบ่งชี้การตรวจตาจังหวัดมหาสารคามและเขตสุขภาพที่7			
แหล่งข้อมูล	-ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม / ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข			
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง B : จำนวนทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางจินสุดา ดวงดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.อัจฉริยา แสนมี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (จักษุขั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ROP : อัตราทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดไม่มีตาบอดจากโรคROP (Unfavorable visual outcome) : อัตราทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีโรค ROP type I ได้รับการรักษาภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัย		
ตัวชี้วัดที่	OKR 38.2 อัตราทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่มีโรค ROP type I ได้รับการรักษาภายในเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัย		
คำนิยาม	Prematurity Type : เป็นภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีความรุนแรงและจำเป็นต้องได้รับการรักษาทันทีเพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็น อาการและลักษณะทางคลินิกของ ROP type 1 อ้างอิงตาม International Classification Of Retinopathy of Prematurity (ICROP) ROP type 1 หมายถึง ● Zone I : มี ROP stage 3 (มีเส้นเลือดผิดปกติพร้อม extraretinal fibrovascular proliferation) โดยมี plus disease ● Zone I : มี ROP ทุก stage ที่มี plusdisease ● Zone II : มี ROP stage 2 หรือ 3 โดยมี plus disease Plus disease หมายถึง หลอดเลือดจอตาขยายและคดงอผิดปกติ ร่วมกับความผิดปกติของม่านตาและน้ำวุ้นตา		
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเสี่ยง	ประชากรเด็กทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง		
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลจากโรงพยาบาลมหาสารคาม / ฐานข้อมูลจากการประเมินข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) กระทรวงสาธารณสุข		
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะ ROP Type 1 ที่ได้รับการรักษาภายใน 72 ชั่วโมง B : จำนวนทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะ ROP Type 1 ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางจินสุตา ดวงดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.อัจฉริยา แสนมี		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (จักษุขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ไม่พบอุบัติการณ์นักเรียนที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติเกิดภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia)			
ตัวชี้วัดที่	KPI 39 อุบัติการณ์นักเรียนที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติเกิดภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia)			
คำนิยาม	นักเรียน คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาวะสายตาสั้นผิดปกติ หมายถึง ระดับสายตาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20/40 ภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia) หมายถึง ภาวะที่สายตาของข้างใดข้างหนึ่ง มีระดับสายตาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20/40 หรือระดับสายตา 2 ข้างต่างกันมากกว่าหรือเท่ากับ 2 แถวของ Snellen chart แม้จะแก้ไขด้วยแว่นหรือคอนแทคเลนส์แล้ว			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในจังหวัดมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	• รายงานการตรวจคัดกรองสายตาในโรงเรียน • ฐานข้อมูลงานเวชระเบียน / OPD • แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน			
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์การเกิดภาวะตาขี้เกียจในเด็กนักเรียนที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติรายใหม่ในแต่ละปีการศึกษา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	1. นางชลดา วงษาไธ 2. นางสาวศิริกัญญา ตั้งอารยทรัพย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์วิวัฒน์ สุทธิสา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จักษุชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ไม่พบอุบัติการณ์นักเรียนที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติเกิดภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia) 2.1 นักเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสายตาททุกคน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 39.1 นักเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ได้รับการคัดกรองสายตา			
คำนิยาม	การคัดกรองสายตา หมายถึง การตรวจวัดสายตาของเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) โดยใช้วิธีการตรวจ Visual Acuity Test โดยบุคลากรทางการแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับการอบรม/คุณครูอนามัยที่ผ่านการอบรม			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในจังหวัดมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	• รายงานการคัดกรองสายตาในโรงเรียน • ฐานข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมสังคม • รายงานจากครูหรือสถานศึกษา			
รายการข้อมูล	A : จำนวนเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ที่ได้รับการคัดกรองสายตา B : จำนวนเด็กนักเรียน ป.1-ป.6 ทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B *100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	1.นางชลดา วงษาไฮ 2.นางสาวศิริกัญญา ตั้งอารยทรัพย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์วิรัตน์ สุทธิสา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูงทันสมัยครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาคระดับชาติและระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จักษุชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วยลดอัตราการพิการลดอัตราตายและเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ไม่พบอุบัติการณ์นักเรียนที่มีภาวะสายตาสั้นผิดปกติเกิดภาวะตาขี้เกียจ (Amblyopia) 2.2 นักเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่มีสายตาสั้นผิดปกติได้รับแว่นตาทุกคน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 39.2 นักเรียนประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ที่มีสายตาสั้นผิดปกติได้รับแว่นตา			
คำนิยาม	ภาวะสายตาสั้นผิดปกติ หมายถึง ระดับสายตาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20/40			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 ที่มีสายตาสั้นผิดปกติในจังหวัดมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	- แบบบันทึกการคัดกรองสายตาศูนย์นักเรียน - รายงานการตรวจและส่งมอบแว่นสายตา - ฐานข้อมูลงานจักษุ / เวชระเบียนโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับการส่งมอบแว่นสายตา B : จำนวนเด็กนักเรียนที่ตรวจพบสายตาสั้นผิดปกติทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	1.นางชลดา วงษาโฮ 2.นางสาวศิริกัญญา ตั้งอารยทรัพย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์วิรัตน์ สุทธิสา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (จักษุขั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	จำนวนผู้ป่วยที่ระดับสายตาหลังการผ่าตัดต้อกระจก $\geq 20/70$ เพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPI 40 ร้อยละระดับสายตาหลังผ่าตัดต้อกระจก 1 เดือน $\geq 20/70$			
คำนิยาม	1.ระดับสายตา $\geq 20/70$ หมายถึง ความสามารถในการมองเห็นในระยะ 20 ฟุต หรือ ระยะ 6 เมตร ได้ชัดเจน เท่ากับที่คนสายตาปกติมองเห็นได้ระยะ 70 ฟุตด้วยการวัด Snellen chart 2. 1 เดือน หลังผ่าตัดต้อกระจก หมายถึง หลังผ่าตัดตา 1 วัน จนถึง 28 วัน เป็นต้นไป			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 85			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยต้อกระจกที่ได้รับการรักษาที่รพ.มหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	● รายงานข้อมูลจากรพ.มหาสารคาม ● ฐานข้อมูลจากโปรแกรม vision2020 Thailand กระทรวงสาธารณสุข			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยที่มีระดับสายตาหลังการผ่าตัดที่ 1 เดือนได้ $\geq 20/70$ B : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 82	ร้อยละ 85	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอัญชลี คุณโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงอติพร สุรวงษ์สิน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จักษุชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เพิ่มจำนวนการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 40.1 อัตราการคัดกรองต้อกระจกในผู้สูงอายุ			
คำนิยาม	การคัดกรองสายตา หมายถึง การตรวจวัดสายตาของผู้ป่วยต้อกระจกโดยใช้วิธีการตรวจนับนิ้วที่ 3 เมตรไม่ได้ โดยอสม. ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ระดับสายตา หมายถึง ค่าสายตาที่มองไม่เห็นนับนิ้ว ที่ 3 เมตรไม่ได้และประเมินค่าโดยบุคลากรปฐมภูมิ			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 75			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	● รายงานข้อมูลจากกรมมหาสารคาม ● ฐานข้อมูลจากโปรแกรม vision2020 Thailand กระทรวงสาธารณสุข			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยที่อายุมากกว่า60 ปี ที่ได้รับการคัดกรองของจังหวัดมหาสารคาม B : จำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดในจังหวัดมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 75	ร้อยละ 75	ร้อยละ 75	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอัญชลี คุณโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงอติพร สุรวงษ์สิน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จักษุชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	เพิ่มจำนวนผู้ป่วย Bliding cataract ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 1 เดือน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 40.2 ร้อยละผู้ป่วย Bliding cataract ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 1 เดือน			
คำนิยาม	Bliding cataract หมายถึง ระดับสายตาที่ได้รับการตรวจด้วย visual Acuity Test มองเห็นที่ระยะ 5/200E ด้วยวิธี Snellen chart 1 เดือน หมายถึง ระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่วินิจฉัยโดยจักษุแพทย์			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 85			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยต้อกระจกที่มีระยะการมองเห็นที่มีระดับ 5/200E ที่มารับบริการรพ.มหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	● รายงานข้อมูลจากรพ.มหาสารคาม ● ฐานข้อมูลจากโปรแกรม vision2020 Thailand กระทรวงสาธารณสุข			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Bliding cataract ที่ได้รับการผ่าตัดภายใน 1 เดือน B : จำนวนผู้ป่วย Bliding cataract ทั้งหมดที่มารับบริการในรพ.มหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอัญชลี คุณโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงอติพร สุรวงษ์สิน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (โสต ศอ นาสิกชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. การได้ยิน: ไม่พบทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่แก้ไขได้ เกิดปัญหาด้านการพูด			
ตัวชี้วัดที่	KPI 41 อุบัติการณ์ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่แก้ไขได้ เกิดปัญหาด้านการพูด			
คำนิยาม	ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีวิตที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่แก้ไขได้ หมายถึง ทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 เดือน เกิดปัญหาด้านการพูด หมายถึง			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดมีชีวิตที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด			
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่แก้ไขได้ เกิดปัญหาด้านการพูด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุมาลี บุญยะเพ็ญ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กิตติยา ศรีชวนชื่นสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (โสต ศอ นาสิกชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. การได้ยิน: ไม่พบทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่แก้ไขได้ เกิดปัญหาด้านการพูด 1.1 การตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (Newborn hearing screening) ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 41.1 อัตราทารกแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรองการได้ยิน (Newborn hearing screening)			
คำนิยาม	ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกอายุตั้งแต่ 4 สัปดาห์หลังคลอด การคัดกรองการได้ยิน หมายถึง การตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกอายุ 0-48 ชั่วโมง ทารกอายุ 1 เดือน ด้วยวิธี Otoacoustic Emission (OAE) และ ทารกอายุ 2 เดือนด้วยวิธี Automated Auditory Brainstem Response (AABR) การได้รับการคัดกรองการได้ยิน ต้องเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ทารกอายุ 0-48 ชั่วโมง ที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธี OAE ได้ผลปกติ 2. ทารกอายุ 0-48 ชั่วโมง ที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธี OAE ได้ผลผิดปกติ แต่ผลตรวจ OAE ที่อายุ 1 เดือนได้ผลปกติ 3. ทารกอายุ 0-48 ชั่วโมงและอายุ 1 เดือน ที่ตรวจคัดกรองด้วยวิธี OAE ได้ผลผิดปกติ และได้รับการตรวจ AABR ที่อายุ 2 เดือน หมายเหตุ : ไม่นับทารกที่เสียชีวิตระหว่างการติดตามการตรวจคัดกรอง			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดมีชีพที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด			
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการคัดกรองการได้ยิน B : จำนวนทารกแรกเกิดทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุมาลี บุญยะเพ็ญ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กิตติยา ศรีชวนชื่นสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (โสต ศอ นาสิกชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. การได้ยิน: ไม่พบทารกแรกเกิดที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินที่แก้ไขได้ เกิดปัญหาด้านการพูด 1.2 ทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติทางการได้ยินได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่อง ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 41.2 อัตราทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติทางการได้ยินได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่องทุกราย			
คำนิยาม	ทารกแรกเกิด หมายถึง ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลมหาสารคาม ความผิดปกติทางการได้ยิน หมายถึง การตรวจ Automated Auditory Brainstem Response (AABR) ไม่ผ่าน การติดตามการรักษาต่อเนื่อง หมายถึง การติดตามการรักษาต่อเนื่องจนถึงอายุ 1 ปี			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทารกแรกเกิดมีชีพในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด			
รายการข้อมูล	A : จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติทางการได้ยินได้รับการติดตามการรักษาต่อเนื่อง B : จำนวนทารกแรกเกิดที่ได้รับการวินิจฉัยความผิดปกติทางการได้ยินทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุมาลี บุญยะเพ็ญ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กิตติยา ศรีชวนชื่นสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	ผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน			
ตัวชี้วัดที่	KPI 42 อัตราตายของผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน			
คำนิยาม	ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในเยื่อหุ้มคอชั้นลึก (Deep neck infection) มีการอักเสบติดเชื้อที่บริเวณคีระและลำคอ มีความรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Airway Obstruction)			
ค่าเป้าหมาย	0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้ป่วย Deep neck infection			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลสถิติจากเวชระเบียน			
รายการข้อมูล				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอเสียชีวิต/ผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอทั้งหมด*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0	0	0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางกิงแก้ว บัวละคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์				
ตัวชี้วัดที่	OKR 42.1 ร้อยละของผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด			
คำนิยาม	ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในเยื่อหุ้มคอชั้นลึก (Deep neck infection) มีการอักเสบติดเชื้อที่บริเวณคีระและลำคอ มีความรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด			
ค่าเป้าหมาย	0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้ป่วย Sepsis in Deep neck infection			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลสถิติจากเวชระเบียน			
รายการข้อมูล				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิต/ผู้ป่วยติดเชื้อชั้นลึกของคอทั้งหมด*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤17	≤15	≤13	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางกิงแก้ว บัวละคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์				
ตัวชี้วัดที่	OKR 42.2 ร้อยละผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Airway Obstruction) เข้าสู่ระบบ fast tract ภายใน 30 นาที			
คำนิยาม	ผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Airway Obstruction) ได้รับการผ่าตัดโดยการใส่ท่อเจาะคอนับตั้งแต่วันที่วินิจฉัยจนได้รับผ่าตัดเจาะคอภายใน 30 นาที			
ค่าเป้าหมาย	0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้ป่วย Deep neck infection			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลสถิติจากเวชระเบียน			
รายการข้อมูล				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนที่เข้าเกณฑ์ระบบ fast tract เข้ารับการผ่าตัดเจาะคอภายใน 30 นาที/ผู้ป่วยมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนที่เข้าเกณฑ์ระบบ fast tract ทั้งหมด*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	100%	100%	100%	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางกิงแก้ว บัวละคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ศัลยกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์				
ตัวชี้วัดที่	OKR 42.3 ร้อยละผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Airway Obstruction) ได้รับการแก้ไขเรื่อง Airway			
คำนิยาม	ผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Airway Obstruction) ได้รับการแก้ไข Airway ตามเกณฑ์การประเมินตามเวลาที่กำหนด			
ค่าเป้าหมาย	0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้ป่วย Deep neck infection			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลสถิติจากเวชระเบียน			
รายการข้อมูล				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนที่มีปัญหา Airway ที่ได้รับการแก้ไขตามเกณฑ์ที่กำหนด/ผู้ป่วยมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมด* 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	100%	100%	100%	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางกิงแก้ว บัวละคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จิตเวชชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราการตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. โรคซึมเศร้า : ลดอัตราการฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตัวเองในผู้ป่วยซึมเศร้า			
ตัวชี้วัดที่	KPI 43 อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ			
คำนิยาม	การฆ่าตัวตายสำเร็จ คือ การกระทำของบุคคลในการปลิดชีวิตของตนเองโดยสมัครใจ และเจตนาที่จะให้ตายจริง เพื่อให้หลุดพ้นจากการบีบคั้น หรือความคับข้องใจที่เกิดขึ้นในชีวิต ซึ่งอาจจะกระทำอย่างตรงไปตรงมา หรือกระทำโดยอ้อม ด้วยวิธีต่าง ๆ จนกระทั่งได้สำเร็จ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≤ 8.0 คนต่อแสนประชากร			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จ ในอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	รายงาน HDC			
รายการข้อมูล	A: จำนวนผู้ป่วยฆ่าตัวตายสำเร็จ B: จำนวนประชากรกลางปีที่ผ่านมา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100,000			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤ 8.0 คนต่อแสนประชากร	≤ 8.0 คนต่อแสนประชากร	≤ 8.0 คนต่อแสนประชากร	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางโชติกา รัตนพลเสน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์สุภฤกษ์ อุดรินทร์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จิตเวชชั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. โรคซึมเศร้า : ลดอัตราการฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตัวเองในผู้ป่วยซึมเศร้า 1.1 เพิ่มการเข้าถึงบริการของกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า		
ตัวชี้วัดที่	OKR 43.1 ร้อยละประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าได้รับการคัดกรอง		
คำนิยาม	ประชากรกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคซึมเศร้า จำนวน 7 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยใช้สารเสพติด ผู้ป่วยโรคทางจิตเวชอื่นๆ ผู้ป่วย HIV ผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังมาเป็นระยะเวลานาน ผู้ป่วยระยะท้าย หญิงตั้งครรภ์ (ใช้สารเสพติด/ไม่พร้อม) วัยรุ่น การคัดกรอง หมายถึง กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการประเมินคัดกรองความเสี่ยงซึมเศร้า ด้วยแบบประเมิน 2Q 8Q 9Q		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่มีปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคซึมเศร้า		
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A: จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ที่ได้รับการคัดกรองประเมิน 2Q 8Q 9Q B: จำนวนผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B)x100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางโชติกา รัตนพลเสน/นส.พจนีย์ ขูลีลัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์สุฤกษ์ อุตรินทร์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)		
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (จิตเวชชั้นเลิศ)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. โรคซึมเศร้า : ลดอัตราการฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตัวเองในผู้ป่วยซึมเศร้า 1.1 เพิ่มการเข้าถึงบริการของกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า		
ตัวชี้วัดที่	OKR 43.2 ร้อยละกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ		
คำนิยาม	กลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชากรกลุ่มเสี่ยงการเกิดโรคซึมเศร้าที่ได้รับการคัดกรอง และมีคะแนนการคัดกรอง $9Q \geq 7$ คะแนนขึ้นไป การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่ประชาชนผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัดและแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสมจากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 85		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า		
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A: จำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าที่เข้าสู่บริการ B: จำนวนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้าทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	$\geq$ ร้อยละ 75	$\geq$ ร้อยละ 80	$\geq$ ร้อยละ 85
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางโชติกา รัตนพลเสน/นส.พจนีย์ ขูลีลัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์สุภฤกษ์ อุดรินทร์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ขั้นเลิศ (จิตเวชขั้นเลิศ)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. โรคซึมเศร้า : ลดอัตราการฆ่าตัวตาย/ทำร้ายตัวเองในผู้ป่วยซึมเศร้า 1.3 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน
ตัวชี้วัดที่	OKR 43.3 ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามีอาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า หมายถึง ประชาชนไทยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x อาการทุเลาในการติดตาม 6 เดือน หมายถึง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (Depressive Disorder) ที่มารับบริการในสถานบริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม ซึ่งได้รับการติดตามโดยวิธีการใดก็ได้ (พบแพทย์/ ปรึกษา/ มารับบริการอื่นๆ เช่น ปรึกษาทางโทรศัพท์ การปรึกษาทางไกล Tele-psychiatry/ โทรศัพท์ติดตาม/ การออกเยี่ยมผู้ป่วย) และได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือ 9Q โดยคะแนน 9Q ครั้งแรก ≥ 7 และต้องมีการประเมินผลการรักษาด้วยเครื่องมือ 9Q จนคะแนน 9Q < 7 ในการติดตามอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเนื่องกัน โดยการติดตามครั้งที่ 1 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 90-120 วัน การติดตามครั้งที่ 2 ถัดไปในช่วงเวลา 121-150 วัน และการติดตามครั้งที่ 3 ถัดไปในช่วงเวลา 151-180 วัน ทั้งนี้ไม่นับกรณีมีการส่งตัว (refer) และเสียชีวิตภายใน 6 เดือน
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM 5 : Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และบันทึกรหัสตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD-10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x ที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วยนอก และ บันทึกติดตามผู้ป่วยในที่จำหน่ายกลับบ้านโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอาการทุเลาภายใน 6 เดือน B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าทั้งหมดที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) * 100$

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางโชติกา รัตนพลเสน/นส.พจนีย์ ขูลีลัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์สุภฤกษ์ อุดรินทร์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ทันตกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. กลุ่มผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้หรือฟันเทียมใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ			
ตัวชี้วัดที่	KPI 44 อัตราของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้หรือฟันเทียมใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ			
คำนิยาม	ฟันแท้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 ซี่ หมายถึง ผู้ที่มีฟันแท้ที่สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้ตั้งแต่ 20 ซี่ขึ้นไป จะไม่นับรวมกรณี เหลือแต่รากฟันที่จำเป็นต้องถอน หรือ ฟันโยกตั้งแต่ 3degree ที่ต้องถอน ฟันหลัง(แท้หรือเทียม) ใช้งานที่เหมาะสม (ไม่น้อยกว่า 4 คู่สบ) หมายถึงผู้ที่มีการสบฟันหลัง (ทั้งที่เป็นฟันแท้หรือฟันเทียม) ตั้งแต่ฟันกรามน้อยและ/หรือฟันกราม ทั้งซ้าย-ขวา รวมกันตั้งแต่ 4 คู่ขึ้นไป			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่ได้รับการตรวจฟันทั้งปาก และ วางแผน			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลในระบบ HIS			
รายการข้อมูล 1 (A)	นับจำนวนประชากร จากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไขคือ PTEETH >= 20 และ PERMANENT_PERMANENT + PERMANENT_PROSTHESIS + PROSTHESIS_PROSTHESIS >= 4			
รายการข้อมูล 2 (B)	จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ.วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก ที่อาศัยอยู่ในเขต ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม Person Type Area (“1”, ”3”) และ Person Discharge = “9”			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 10	ร้อยละ 15	ร้อยละ 20	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ทันตกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. กลุ่มผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้หรือฟันเทียมใช้งานได้น้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 1.1 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม ได้รับการวางแผนการรักษาเพื่อใส่ฟันเทียม ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 44.1 อัตรากลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม ได้รับการวางแผนการรักษาเพื่อใส่ฟันเทียม			
คำนิยาม	ได้รับการวางแผนการรักษาเพื่อใส่ฟันเทียม หมายถึง ผู้ที่ได้รับคำแนะนำ มีการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประเภทต่างๆที่จำเป็น ก่อนการใส่ฟันเทียม			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่ได้รับการตรวจฟันทั้งปาก และ มีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล โปรแกรมทันตกรรม ของโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล 1 (A)	นับจำนวนประชากร จากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไขคือ รหัสเหตุการณ์ 00120			
รายการข้อมูล 2 (B)	จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ.วันที่มารับบริการตรวจช่องปากที่มีความประสงค์ใส่ฟันเทียม ที่อาศัยอยู่ในเขต ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม Person Type Area (“1” , ”3”) และ Person Discharge = “9”			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	90	100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ทันตกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. กลุ่มผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้หรือฟันเทียมใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่ สบ 1.2 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม ได้รับการเตรียมช่องปาก			
ตัวชี้วัดที่	OKR 44.2 อัตรากลุ่มผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม ได้รับการเตรียมช่องปาก			
คำนิยาม	ได้รับการเตรียมช่องปากหมายถึง ผู้ที่ได้รับการบริการทันตกรรม ประเภทต่างๆที่จำเป็น ก่อนการใส่ฟันเทียม			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 30			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่ได้รับการตรวจฟันทั้งปากและมีความประสงค์จะใส่ฟันเทียม และ ได้รับการเตรียมช่องปาก			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล โปรแกรมทันตกรรม ของโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล 1 (A)	นับจำนวนประชากร จากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไขคือ รหัสหัตถการ 00120 และ 058991			
รายการข้อมูล 2 (B)	จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ.วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก มีความประสงค์ใส่ฟันเทียม และอาศัยอยู่ในเขต ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม Person Type Area (“1”, ”3”) และ Person Discharge = “9”			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M1_ยกระดับบริการทางการแพทย์คุณภาพสูง ทันสมัย ครบวงจร			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO1 : ยกระดับการแพทย์เฉพาะทางขั้นสูงมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ (Performance Excellence)			
Roadmap	Roadmap R2 : การแพทย์ชั้นเลิศ (ทันตกรรมชั้นเลิศ)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ลดอัตราป่วย ลดอัตราการพิการ ลดอัตราตาย และเพิ่มคุณภาพชีวิตในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่มีความเป็นเลิศ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. กลุ่มผู้สูงอายุ : ผู้สูงอายุที่มีฟันแท้หรือฟันเทียมใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ หรือ 4 คู่สบ 1.3 กลุ่มผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟันได้รับการใส่ฟันเทียมทดแทน 4 คู่สบ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 44.3 อัตรากลุ่มผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียฟันได้รับการใส่ฟันเทียมทดแทน 4 คู่สบ			
คำนิยาม	ได้รับการใส่ฟันเทียม หมายถึง ผู้ที่ได้รับการใส่ฟันเทียมประเภทต่างๆ			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้สูงอายุในเขตรับผิดชอบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม ที่ได้รับการตรวจฟันทั้งปาก และ ใส่ฟันเทียม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล โปรแกรมทันตกรรม ของโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล 1 (A)	นับจำนวนประชากร จากรายการข้อมูล 2 (B) ที่มีเงื่อนไขคือ รหัสหัตถการ 00120 และ 05100 – 05281-5			
รายการข้อมูล 2 (B)	จำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ.วันที่มารับบริการตรวจช่องปาก มีความประสงค์ใส่ฟันเทียม และอาศัยอยู่ในเขต ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม Person Type Area (“1”, ”3”) และ Person Discharge = “9”			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	20	25	30	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ. กรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น ระดับเขตสุขภาพที่ 7
ตัวชี้วัดที่	KPI 45 จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับ เขตสุขภาพที่ 7
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่าง เป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตาม หลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริง ให้ ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือ กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/ เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ของ หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ ระดับเขตสุขภาพ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการ นำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ ระดับเขตสุขภาพ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาล มหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับเขตสุขภาพที่ 7 อย่าง เป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอใน การประชุม/เวทีของเขตสุขภาพที่ 7 หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับเขต)
ค่าเป้าหมาย 3 ปี	14 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม

	รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับเขตสุขภาพที่ 7 หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	10 เรื่อง	12 เรื่อง	14 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกศิรา รักภักดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จูติพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น ระดับเขตสุขภาพที่ 7
ตัวชี้วัดที่	OKR 45.1 ด้านการแพทย์
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับเขตสุขภาพ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับเขตสุขภาพ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับเขตสุขภาพที่ 7 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีของเขตสุขภาพที่ 7 หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับเขต) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) การให้บริการทางคลินิก (Clinical Services) และ การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์

คำเป้าหมาย	9 เรื่อง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับเขตสุขภาพที่ 7 หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	7 เรื่อง	8 เรื่อง	9 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุภา ศักดิ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิญ จิตพิพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น ระดับเขตสุขภาพที่ 7
ตัวชี้วัดที่	OKR 45.2 ด้านการสาธารณสุข
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับเขตสุขภาพ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับเขตสุขภาพ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับเขตสุขภาพที่ 7 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีของเขตสุขภาพที่ 7 หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับเขต) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสาธารณสุข คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การป้องกันโรค (Disease Prevention) การเฝ้าระวังภัยสุขภาพระดับประชากร ชุมชน หรือในเขตสุขภาพที่ 7

คำเป้าหมาย	9 เรื่อง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับเขตสุขภาพที่ 7 หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	7 เรื่อง	8 เรื่อง	9 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุภา รักรักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิญ จิติพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานเพิ่มขึ้น ระดับเขตสุขภาพที่ 7
ตัวชี้วัดที่	OKR 45.3 ด้านบริหารจัดการ
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับเขตสุขภาพ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับเขตสุขภาพ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับเขตสุขภาพที่ 7 อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีของเขตสุขภาพที่ 7 หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับเขต) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบริหารทรัพยากร การจัดการ

	องค์กร การเงิน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและเขตสุขภาพที่ 7		
คำเป้าหมาย	3 เรื่อง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับเขตสุขภาพที่ 7 หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับเขตสุขภาพที่ 7		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	1 เรื่อง	2 เรื่อง	3 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกิตา รักภักดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จิตีพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับภูมิภาค เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	KPI 46 จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับภูมิภาค
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็น ระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตาม หลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริง ให้ ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะ หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสาร การประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่ เป็นที่ยอมรับ ระดับภูมิภาค เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการ นำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึง การเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ ระดับภูมิภาค 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาล มหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับภูมิภาค อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีของระดับภูมิภาค หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับภูมิภาค)
ค่าเป้าหมาย	7 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับภูมิภาค, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับภูมิภาค		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับภูมิภาค		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	5 เรื่อง	6 เรื่อง	7 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกษา รักภักดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิฐ จิตีพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับภูมิภาค เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 46.1 ด้านการแพทย์
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับภูมิภาค เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับภูมิภาค 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับภูมิภาค อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีของระดับภูมิภาค หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับภูมิภาค) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าการพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) การให้บริการทางคลินิก (Clinical Services) และการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์

คำเป้าหมาย	5 เรื่อง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับภูมิภาค, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับภูมิภาค			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับภูมิภาค			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	3 เรื่อง	4 เรื่อง	5 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุภา รักรักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิฐ จิตีพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับภูมิภาค เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 46.2 ด้านการสาธารณสุข
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับภูมิภาค เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับภูมิภาค 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับภูมิภาค อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีของระดับภูมิภาค หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับภูมิภาค) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสาธารณสุข คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การป้องกันโรค (Disease Prevention) การเฝ้าระวังภัยสุขภาพประชากร ชุมชน และในระดับภูมิภาค

คำเป้าหมาย	5 เรื่อง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับภูมิภาค, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับภูมิภาค			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับภูมิภาค			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	3 เรื่อง	4 เรื่อง	5 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุภา รักรักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิฐ จิตพิรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับภูมิภาค เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 46.3 ด้านบริหารจัดการ
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับภูมิภาค เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับภูมิภาค 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับภูมิภาค อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีของระดับภูมิภาค หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับภูมิภาค) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบริหารทรัพยากร การจัดการ

	องค์กร การเงิน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและในระดับภูมิภาค		
คำเป้าหมาย	1 เรื่อง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับภูมิภาค, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับภูมิภาค		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับภูมิภาค		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	1 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกิตา รักภักดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนนิน จิตพิพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	KPI 47 จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระดับชาติ
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่าง เป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้อง ตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริง ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน และกระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะ หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/ เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของ หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการ ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ ระบบงานใน หน่วยงานระดับชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีระดับชาติหรือการ อ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับชาติ)
ค่าเป้าหมาย	6 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับระดับชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับชาติ						
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับชาติ						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับชาติ						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table border="1"> <tr> <td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr> <tr> <td>4 เรื่อง</td><td>5 เรื่อง</td><td>6 เรื่อง</td></tr> </table>	2570	2571	2572	4 เรื่อง	5 เรื่อง	6 เรื่อง
2570	2571	2572					
4 เรื่อง	5 เรื่อง	6 เรื่อง					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกัศรา รักภักดี						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จิตติพรรณกุล						

นียมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 47.1 ด้านการแพทย์
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย อย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิม เน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ ได้จริง ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน และกระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะ หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/ เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของ หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการ ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีระดับชาติหรือการอ้างอิง ในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การดูแลรักษาผู้ป่วย

	(Patient Care) การให้บริการทางคลินิก (Clinical Services) และการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์		
คำเป้าหมาย	2 เรื่อง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับระดับชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับชาติ		
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับชาติ		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับชาติ		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	1 เรื่อง	1 เรื่อง	2 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกัศรา รักภักดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จิตีพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 47.2 ด้านการสาธารณสุข
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัย อย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิม เน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ ได้จริง ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน และกระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะ หรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/ เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของ หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการ ที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีระดับชาติหรือการอ้างอิงในการ ดำเนินงานของหน่วยงานระดับชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสาธารณสุข คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ

	การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การป้องกันโรค (Disease Prevention) การเฝ้าระวังภัยสุขภาพระดับประชากร ชุมชน หรือในระดับชาติ			
คำเป้าหมาย	2 เรื่อง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับระดับชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับชาติ			
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับชาติ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับชาติ			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	1 เรื่อง	2 เรื่อง	2 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกิตา รักภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จิตีพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระดับชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 47.3 ด้านบริหารจัดการ
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย และบทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน และกระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีระดับชาติหรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ประสิทธิภาพ

	(Efficiency) และ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) ในการบริหารทรัพยากร การจัดการองค์กร การเงิน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ โรงพยาบาลและระดับชาติ			
คำเป้าหมาย	1 เรื่อง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุม วิชาการ/เวทีระดับระดับชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระดับระดับชาติ			
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับชาติ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับชาติ			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	1 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุภา รักรักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิญ จิตติพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระดับชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 47.4 ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย และบทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน และกระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์ : ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ เผยแพร่ : ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีระดับชาติหรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education Research) คือ กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ (Systematic

	investigation) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "กระบวนการผลิตและพัฒนาแพทย์" ในทุกระดับ ตั้งแต่นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ไปจนถึงแพทย์ที่จบไปทำงานแล้ว			
คำเป้าหมาย	1 เรื่อง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคามศึกษา			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับระดับชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับระดับชาติ			
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับชาติ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับชาติ			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	1 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนันทวัน ยอดแก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิฐ จิตพิพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	KPI 48 จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงาน ระดับนานาชาติ
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่าง เป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้อง ตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริง ให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือ กลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/ เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของ หน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการ นำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิง เพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีนานาชาติ หรือการอ้างอิงในการ ดำเนินงานของหน่วยงานระดับนานาชาติ)
ค่าเป้าหมาย	4 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม

แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับนานาชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ						
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับนานาชาติ						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table border="1"> <tr> <td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr> <tr> <td>4 เรื่อง</td><td>4 เรื่อง</td><td>4 เรื่อง</td></tr> </table>	2570	2571	2572	4 เรื่อง	4 เรื่อง	4 เรื่อง
2570	2571	2572					
4 เรื่อง	4 เรื่อง	4 เรื่อง					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกัศรา รักภักดี						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จิติพรรณกุล						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 48.1 ด้านการแพทย์
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีนานาชาติ หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับนานาชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าการพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient Care) การให้บริการทางคลินิก (Clinical Services) และ การพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์

คำเป้าหมาย	1 เรื่อง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับนานาชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ		
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับนานาชาติ		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	1 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุภา ศักดิ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิฐ ฐิติพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 48.2 ด้านการสาธารณสุข
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม เช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือ รวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีนานาชาติ หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับนานาชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการสาธารณสุข คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) การป้องกันโรค

	(Disease Prevention) การเฝ้าระวังภัยสุขภาพระดับประชากร ชุมชน หรือในระดับนานาชาติ		
คำเป้าหมาย	1 เรื่อง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับนานาชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ		
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับนานาชาติ		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	1	1	1
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกัศรา รักภักดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิช จิตติพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 48.3 ด้านบริหารจัดการ
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีนานาชาติ หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับนานาชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านบริหารจัดการ คือ ผลงานวิชาการที่มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า การพัฒนา หรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ ประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบริหารทรัพยากร การ

	จัดการองค์กร การเงิน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและระดับนานาชาติ			
คำเป้าหมาย	จำนวนเรื่องของผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้ตามคํานิยาม (กำหนดเป็นค่าตัวเลขตามแผนปฏิบัติการประจำปี)			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับนานาชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ			
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับนานาชาติ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	1	1	1	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุภิสรา รักภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จิติพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงาน ระดับนานาชาติ เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 48.4 ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา
คำนิยาม	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) คือ ผลลัพธ์จากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยอย่างเป็นระบบมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือสรุปความรู้เดิมเน้นความถูกต้องตามหลักการและทฤษฎี เช่น งานวิจัย,บทความวิชาการ 2. นวัตกรรม (Innovation) คือ การนำสิ่งใหม่ (แนวคิด, วิธีการ, สิ่งประดิษฐ์) มาประยุกต์ใช้มีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่า หรือแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเน้นการนำไปใช้ได้จริงให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเช่น แอปพลิเคชัน, กระบวนการใหม่ๆ 3. ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ คือ ผลงานวิชาการถูกนำเสนอต่อสาธารณะหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นทางการ หลักฐานการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ดังนี้ ตีพิมพ์: ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) หรือหนังสือรวมบทความ/เอกสารการประชุมวิชาการ (Proceeding) ทั้งในรูปแบบรูปเล่มหรือออนไลน์ ของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เผยแพร่: ได้รับการนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) หรือการนำเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) ในเวที/การประชุมวิชาการที่น่าเชื่อถือรวมถึงการเผยแพร่ผ่านช่องทางของหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานในหน่วยงานระดับนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีนานาชาติ หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับนานาชาติ) 5. งานวิจัยและนวัตกรรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (Medical Education Research) คือ กระบวนการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ (Systematic investigation) เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับ "กระบวนการ

	ผลิตและพัฒนาแพทย์" ในทุกระดับ ตั้งแต่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน ไปจนถึงแพทย์ที่จบไปทำงานแล้ว		
ค่าเป้าหมาย	1 เรื่อง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ/เวทีระดับนานาชาติ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ		
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับนานาชาติ		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ที่ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับนานาชาติ		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	1 เรื่อง	1 เรื่อง	1 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนันท์วัน ยอดแก้ว		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิฐ จิตพิพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	KPI 49 จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลที่นำมาใช้ในการพัฒนา คุณภาพระบบงาน
คำนิยาม	1. องค์ความรู้ คือ ความรู้ที่ถูกรวบรวม เรียบเรียง และจัดระบบ เพื่อให้สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในงานหรือองค์กร เช่น ขั้นตอนทำงานที่ดีที่สุด (Best Practice), เทคนิคการแก้ปัญหา, วิธีพัฒนาคุณภาพงาน, งานวิจัย หรือประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญที่แปลงเป็นคู่มือ 2. นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แก้ปัญหา พัฒนางาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน อาจเป็นของใหม่ทั้งหมด หรือเป็น ของเดิมที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ได้ 3. นวัตกรรมระดับสากลที่นำมาพัฒนาคุณภาพระบบงาน หมายถึง นวัตกรรมหรือแนว ปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำ ทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไข ปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับ นานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีสากล หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับสากล)
ค่าเป้าหมาย	จำนวน 10 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุม วิชาการ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสากล

รายการข้อมูล	A : จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	10 เรื่อง	12 เรื่อง	14 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกัศรา รักภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนนิน จิตพิพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 49.1 ด้านการแพทย์
คำนิยาม	1. องค์ความรู้ คือ ความรู้ที่ถูกรวบรวม เรียบเรียง และจัดระบบ เพื่อให้สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในงานหรือองค์กร เช่น ขั้นตอนทำงานที่ดีที่สุด (Best Practice), เทคนิคการแก้ปัญหา, วิธีพัฒนาคุณภาพงาน, งานวิจัย หรือประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญที่แปลงเป็นคู่มือ 2. นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แก้ปัญหา พัฒนางาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน อาจเป็นของใหม่ทั้งหมด หรือเป็น ของเดิมที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ได้ 3. นวัตกรรมระดับสากลที่นำมาพัฒนาคุณภาพระบบงาน หมายถึง นวัตกรรมหรือแนว ปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำ ทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไข ปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับ นานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีสากล หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับสากล)
ค่าเป้าหมาย	6 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุม วิชาการ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสากล
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา

	วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับสากล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	5 เรื่อง	5 เรื่อง	6 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกิตา รักภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนนิน จิตพิพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการ พัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการ บริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKRs 49.2 ด้านการสาธารณสุข
คำนิยาม	1. องค์ความรู้ คือ ความรู้ที่ถูกรวบรวม เรียบเรียง และจัดระบบ เพื่อให้สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในงานหรือองค์กร เช่น ขั้นตอนทำงานที่ดีที่สุด (Best Practice), เทคนิคการแก้ปัญหา, วิธีพัฒนาคุณภาพงาน, งานวิจัย หรือประสบการณ์ จากผู้เชี่ยวชาญที่แปลงเป็นคู่มือ 2. นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แก้ปัญหา พัฒนางาน หรือ เพิ่มประสิทธิภาพ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน อาจเป็นของใหม่ทั้งหมด หรือเป็น ของเดิมที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ได้ 3. นวัตกรรมระดับสากลที่นำมาพัฒนาคุณภาพระบบงาน หมายถึง นวัตกรรมหรือแนว ปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำ ทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมี ประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไข ปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับ นานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีสากล หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงาน ระดับสากล)
ค่าเป้าหมาย	6 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุม วิชาการ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสากล
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา

	วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับสากล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	4 เรื่อง	5 เรื่อง	6 เรื่อง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกิตา รักภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนนิน จิตพิพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ
Roadmap	Roadmap 3 : วิจัยและนวัตกรรม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. ผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ได้รับการเผยแพร่หรือตีพิมพ์และนำมาใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 2. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. นำองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงานเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 49.3 การบริหารจัดการ
คำนิยาม	1. องค์ความรู้ คือ ความรู้ที่ถูกรวบรวม เรียบเรียง และจัดระบบ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในงานหรือองค์กร เช่น ขั้นตอนทำงานที่ดีที่สุด (Best Practice), เทคนิคการแก้ปัญหา, วิธีพัฒนาคุณภาพงาน, งานวิจัย หรือประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญที่แปลงเป็นคู่มือ 2. นวัตกรรม คือ สิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ แก้ปัญหา พัฒนางาน หรือเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจน อาจเป็นของใหม่ทั้งหมด หรือเป็นของเดิมที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ได้ 3. นวัตกรรมระดับสากลที่นำมาพัฒนาคุณภาพระบบงาน หมายถึง นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และมีการใช้อย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การนำไปใช้ คือ การที่ผลงานวิชาการ (วิจัยหรือนวัตกรรม) ของบุคลากร โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้รับการยอมรับ และ ถูกประยุกต์ใช้ หรือ อ้างอิงเพื่อแก้ไขปัญหา พัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน/ระบบงานใน หน่วยงานระดับนานาชาติ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานการนำไปใช้ที่ชัดเจน (เช่น หนังสือราชการ การนำเสนอในการประชุม/เวทีสากล หรือการอ้างอิงในการดำเนินงานของหน่วยงานระดับสากล)
ค่าเป้าหมาย	2 เรื่อง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลมหาสารคาม, รายงานการประชุมวิชาการ, หลักฐานการนำผลงานไปใช้ในการพัฒนาระบบงานระดับสากล
รายการข้อมูล	ชื่อผลงานวิชาการ (วิจัยและนวัตกรรม) ชื่อผู้วิจัย/ผู้พัฒนา

	วันที่เผยแพร่/ตีพิมพ์ หลักฐานการนำไปใช้ระดับสากล		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	จำนวนองค์ความรู้และนวัตกรรมระดับสากลที่นำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบงาน		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	1 เรื่อง	2 เรื่อง	2 เรื่อง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณสุกิตา รักภักดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนนิน จิตีพรรณกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ			
Roadmap	Roadmap 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	บัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. บัณฑิตแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากลเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPI 50 อัตราบัณฑิตแพทย์ สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐาน			
คำนิยาม	บัณฑิตแพทย์ หมายถึง นักศึกษาแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานในพื้นที่ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐาน หมายถึง บัณฑิตแพทย์ได้รับการประเมิน ผ่านตามเกณฑ์แพทย์สภา โดยใช้แบบประเมิน Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) และแบบประเมิน Entrustable Professional Activities (EPA) ในขณะที่ปฏิบัติงานเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะในพื้นที่ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์เพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บัณฑิตแพทย์			
แหล่งข้อมูล	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำรวจและทำฐานข้อมูลรายชื่อแพทย์ CPIRD			
รายการข้อมูล	A : จำนวนบัณฑิตแพทย์ที่สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐาน B : จำนวนบัณฑิตแพทย์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวอนงค์ อรรควาล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวนรรัตน์ อยู่บาง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ		
Roadmap	Roadmap 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	บัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.1 สามารถสอบผ่านการประเมินวิชาชีพตามเกณฑ์แพทยสภาและจบการศึกษาตามเกณฑ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 50.1 อัตรานักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในศูนย์แพทย์สำเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด		
คำนิยาม	นักศึกษาแพทย์ หมายถึง นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคาม การได้รับใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง การสอบผ่าน National License (NL) การสำเร็จการศึกษา หมายถึง การสอบผ่านตามเกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด หมายถึง การใช้เวลาการศึกษาชั้นคลินิกที่ศูนย์แพทยศาสตรโรงพยาบาลมหาสารคาม ภายใน 3 ปี		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	นักศึกษาแพทย์ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต		
แหล่งข้อมูล	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รายงานรายชื่อนักศึกษาและผลการสอบใบประกอบวิชาชีพ		
รายการข้อมูล	A : จำนวนนักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในศูนย์แพทย์สำเร็จการศึกษาและได้รับใบประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาที่กำหนด ในปีการศึกษานั้น B : จำนวนนักศึกษาแพทย์ในปีการศึกษานั้น		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 90	2571 ≥ ร้อยละ 90	2572 ≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวอนงค์ อรรควาล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวนรรัตน์ อยู่บาง		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ			
Roadmap	Roadmap 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	บัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาและหลักสูตร ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.2 คงอยู่ในระบบเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 50.2 อัตราบัณฑิตแพทย์ที่คงอยู่ในระบบ			
คำนิยาม	บัณฑิตแพทย์ หมายถึง นักศึกษาแพทย์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่สำเร็จ การศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และจบการศึกษาไปแล้วเป็นเวลา 3 ปี การคงอยู่ในระบบ หมายถึง บัณฑิตแพทย์ได้รับการบรรจุในตำแหน่งนายแพทย์และ ยังคงปฏิบัติงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครบตามสัญญานักศึกษา แพทย์ (3 ปี)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 95			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บัณฑิตแพทย์			
แหล่งข้อมูล	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกสำรวจและทำฐานข้อมูลรายชื่อแพทย์ CPIRD			
รายการข้อมูล	A : จำนวนบัณฑิตแพทย์ที่คงอยู่ในระบบ B : จำนวนบัณฑิตแพทย์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 90	2571 ≥ ร้อยละ 90	2572 ≥ ร้อยละ 95	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวอนงค์ อรรควาล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวอินทิรา อนันต์พินิจวัฒนา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้ วิจัย ผลิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ คุณภาพสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับ นานาชาติ			
Roadmap	Roadmap 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	บัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาและหลักสูตร ฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. แพทย์เฉพาะทาง : สามารถจบหลักสูตรจนได้รับวุฒิบัตรทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	KPI 51 อัตราแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว สามารถจบหลักสูตรจน ได้รับวุฒิบัตร			
คำนิยาม	แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว หมายถึง แพทย์ที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่โรงพยาบาลมหาสารคาม ครบตามเกณฑ์และเข้า รับการสอบเพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรในสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว การได้รับวุฒิบัตร หมายถึง เอกสารที่ใช้รับรองสำหรับแพทย์ประจำบ้านที่ได้ผ่านการ ฝึกอบรมเฉพาะทางในสาขาที่เลือกจนครบตามหลักสูตรแล้ว จะต้องผ่านการสอบ รับรองความรู้ความชำนาญ ซึ่งเมื่อสอบผ่านแล้วจะได้รับ วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในสาขานั้น ๆ			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว			
แหล่งข้อมูล	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก			
รายการข้อมูล	A : จำนวนแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่สามารถจบหลักสูตรจนได้รับ วุฒิบัตรในปีนั้น B : จำนวนแพทย์แพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในปีนั้นทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ร้อยละ 100	2571 ร้อยละ 100	2572 ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิตติกานต์ เพี้ยโคตรแก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวเบญจวรรณ ธรรมปัญญาวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์บุคลากรทางการแพทย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ		
Roadmap	Roadmap 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	บัณฑิตแพทย์แพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. พยาบาลวิชาชีพ : สามารถเปิดหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program)		
ตัวชี้วัดที่	KPI 52 จำนวนหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program) ที่มีการเปิดอบรม		
คำนิยาม	หลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program) หมายถึง หลักสูตรการอบรมในระดับหลังปริญญาตรี (Post-Graduation) ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา พยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะขั้นสูงใน "สาขาเฉพาะทาง" โดยมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณ์จริงอย่างเข้มข้น หลักสูตรนี้เปรียบเสมือน "ระบบแพทย์ประจำบ้าน (Residency)" ของฝั่งแพทย์ เพื่อเปลี่ยนผ่านพยาบาลทั่วไป (Generalist) ให้กลายเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Specialist) ที่สามารถตัดสินใจทางคลินิกในรายที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน...สาขา รายละเอียดสาขาตามเอกสารแนบที่ ...		
ค่าเป้าหมาย	8 สาขา		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมฐานข้อมูลกลุ่มการพยาบาล		
รายการข้อมูล	A : จำนวนหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program) ที่มีการเปิดอบรมทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	4 สาขา	6 สาขา	8 สาขา
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอังคณา จันคามิ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจุลินทร ศรีโพนทัน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์บุคลากรทางการแพทย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ		
Roadmap	Roadmap 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	บัณฑิตแพทย์แพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. พยาบาลวิชาชีพ : สามารถเปิดหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program) 3.1 การประเมินหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program)		
ตัวชี้วัดที่	OKR 52.1 ระดับความสำเร็จของการผ่านการประเมินหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง		
คำนิยาม	การผ่านการประเมินหลักสูตร หมายถึง การผ่านการประเมินหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program) โดยสภาการพยาบาล ระดับความสำเร็จของการผ่านการประเมิน มีดังนี้ ระดับ 1 คือ จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 1- 2 สาขา ระดับ 2 คือ จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 3-4 สาขา ระดับ 3 คือ จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 5-6 สาขา ระดับ 4 คือ จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน 7-8 สาขา ระดับ 5 คือ จำนวนหลักสูตรที่ผ่านการประเมิน ≥ 9 สาขา		
ค่าเป้าหมาย	ผ่านเกณฑ์ระดับ 5		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมฐานข้อมูลกลุ่มการพยาบาล		
รายการข้อมูล	A : ระดับความสำเร็จของการผ่านการประเมินหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอังคณา จันคามิ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจุลินทร ศรีโพนทัน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M2_ยกระดับองค์กรแห่งการเรียนรู้วิจัยผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์คุณภาพสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	SO2 : ศูนย์ผลิตแพทย์บุคลากรทางการแพทย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมระดับนานาชาติ		
Roadmap	Roadmap 4 : ผลิตและพัฒนาบุคลากร		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	บัณฑิตแพทย์แพทย์เฉพาะทางและสหสาขาวิชาชีพที่จบการศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เต็มสมรรถนะได้มาตรฐานระดับสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. พยาบาลวิชาชีพ : สามารถเปิดหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง (Post Baccalaureate Residency Training Program) 3.2 พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่มีการเปิดการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยง		
ตัวชี้วัดที่	OKR 52.2 อัตราพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่มีการเปิดการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยง		
คำนิยาม	หลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยง (Preceptor Course) หมายถึง หลักสูตรการอบรมระยะสั้นที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนา พยาบาลวิชาชีพ ให้มีทักษะและความสามารถในการทำหน้าที่เป็น "พี่เลี้ยง" (Preceptor) คอยสอนงาน ประคับประคอง และแนะนำพยาบาลจบใหม่ (Nurse New Graduate) หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ย้ายมาใหม่ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านจากพยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ไปสู่การเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อช่วยให้พยาบาลใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรและปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่มีการเปิดการอบรม		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมฐานข้อมูลกลุ่มการพยาบาล		
รายการข้อมูล	A : พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่มีการเปิดการอบรมที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลพี่เลี้ยง B : พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในสาขาที่มีการเปิดการอบรมทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอังคณา จันคามิ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจุลินทร ศรีโพนทัน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.การนำองค์กร : โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นโรงพยาบาลสมรรถนะสูง			
ตัวชี้วัดที่	KPI 53 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามสมรรถนะสูง ตามเกณฑ์ MOPH-4T (เกณฑ์กระทรวง)			
คำนิยาม	การพัฒนาโรงพยาบาลสมรรถนะสูงตามเกณฑ์ MOPH-4T หมายถึง กระบวนการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวคิด MOPH-4T Model ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับองค์กรให้มี สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ทั้งด้าน บริการ การบริหารจัดการ และคุณภาพระบบงานโดยรวม องค์ประกอบ 4T ได้แก่ T1 : Teamwork คือ การทำงานเป็นทีมและความร่วมมือทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร การบูรณาการเครือข่ายบริการสุขภาพ T2 : Target คือ การกำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ชัดเจนและการขับเคลื่อนสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย T3 : Technology คือ การใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และดิจิทัลในการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการ T4 : Transparency คือ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง คือ ต้องได้คะแนน ≥ 80 คะแนน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	MOPH-4T ระดับ 5			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : คะแนนตามเกณฑ์ MOPH-4T			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	MOPH-4T ระดับ 5	MOPH-4T ระดับ 5	MOPH-4T ระดับ 5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานะมาศ มะโนราช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงกนกพร โชคคตวิวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.การนำองค์กร : โรงพยาบาลมหาสารคามเป็นโรงพยาบาลสมรรถนะสูง 1.1 หน่วยงานภายในโรงพยาบาลนํานโยบายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติทุกหน่วยงาน (ธรรมาภิบาล)		
ตัวชี้วัดที่	OKR 53.1 อัตราหน่วยงานภายในโรงพยาบาลนํานโยบายควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงสู่การปฏิบัติ ร้อยละ 100 (ธรรมาภิบาล)		
คำนิยาม	นโยบายควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการ นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำขึ้น เพื่อบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าองค์กรจะบรรลุเป้าหมาย คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามแนวทางมาตรฐานของ COSO การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวางแผน วิเคราะห์ ประเมิน และควบคุมเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่งอาจสร้างความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย เพื่อลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่บุคคลหรือองค์กรยอมรับได้		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาล		
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายใน		
รายการข้อมูล	A : หน่วยงานภายในโรงพยาบาลที่นํานโยบายควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ B : หน่วยงานภายในโรงพยาบาลทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายฉัตรมงคล สิงห์กลาง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายศิวักร แสนยะมาศ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.1 เพิ่มขีดความสามารถโรงพยาบาลมาตรฐาน (SAP) ระดับ P to P+		
ตัวชี้วัดที่	KPI 54 ระดับคะแนนการประเมินมาตรฐาน SAP ระดับ P+ บรรลุเป้าหมาย		
คำนิยาม	โรงพยาบาลมาตรฐาน SAP คือ การปรับระดับการบริการสุขภาพของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าสู่รูปแบบ SAP (S : Standard, S+: Standard Plus, A : Academy, A+: Academy Plus, P : Premium และ P+: Premium Plus) การประเมินมาตรฐาน SAP ได้แก่ การประเมินด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Structure) บริการ (Service) บุคลากรที่สอด้รับการบริการ และประสิทธิภาพการบริการ การได้รับมาตรฐานระดับ P+ คือ คะแนนประเมินระดับ P+ ≥ 80 คะแนน		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	คะแนน ≥ 80 คะแนน		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		
รายการข้อมูล	A : คะแนนประเมินระดับ P+		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ 70 คะแนน	≥ 75 คะแนน	≥ 80 คะแนน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนรินทร์พร สงศรี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงกนกพร โชคคติวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. โรงพยาบาลมหาสารคามมีระดับความสำเร็จในการผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้าเป็นไปตาม Roadmap			
ตัวชี้วัดที่	KPI 55 ระดับความสำเร็จในการผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า			
คำนิยาม	ระดับความสำเร็จในการผ่านการรับรองขั้นก้าวหน้า หมายถึง การบรรลุเป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด			
	ตัวชี้วัด	2570	2571	2572
	ร้อยละหัวข้อตาม HA Score part 1-3 (54บท) ในหมวดหมู่มาตรฐานที่มี HA Score ≥ 4	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60
	ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย	$\geq$ ร้อยละ 80	$\geq$ ร้อยละ 80	$\geq$ ร้อยละ 80
	จำนวน PDSC ที่ผ่านการรับรองหรือต่ออายุ	≥ 2 เรื่อง	≥ 2 เรื่อง	≥ 5 เรื่อง
	ระดับ 1 บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด ระดับ 2 บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ระดับ 3 บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ความสำเร็จระดับ 3			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการเยี่ยมสำรวจ/สรุปผลการประเมิน HA Score ของทีม QMR			
รายการข้อมูล	A : ระดับความสำเร็จ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	1 ครั้ง/ปี			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ระดับ 3	ระดับ 3	ระดับ 3	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณช่อทิพย์ ภาคมฤค			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ปิยะนารถ ด้านพรประเสริฐ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์				
ตัวชี้วัดที่	OKR 55.1 ร้อยละหัวข้อตาม HA Score part I-III (54 บท) ในหมวดหมู่มาตรฐานที่มี HA Score ≥ 4			
คำนิยาม	เอกสารการประเมินกระบวนการปฏิบัติตามมาตรฐาน ตอนที่ I-III จำนวน 54 บท หมายเหตุ*			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	HA Score part I-III (54 บท)			
แหล่งข้อมูล	เอกสารประเมินตนเองตาม HA Score part I-III			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part I-III ที่บรรลุเป้าหมาย HA Score ≥ 4 B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part I-III ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 40	ร้อยละ 50	ร้อยละ 60	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ปิยะนารถ ด้านพรประเสริฐ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน AHA ภายในปี 2569
ตัวชี้วัดที่	OKR 55.2 อัตรามาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยบรรลุเป้าหมาย
คำนิยาม	มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัยประกอบด้วย 1. การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ 2. การติดเชื้อที่สำคัญในสถานพยาบาลตามบริบทขององค์กรในกลุ่ม SSI, VAP, CAUTI, CABS 3. บุคลากรติดเชื้อจากการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งตรงกับมาตรฐาน 4. การเกิด Medication Error และ Adverse Drug Event 5. การให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด 6. การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด 7. ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยโรค 8. การรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ/พยาธิวิทยาคลาดเคลื่อน 9. การคัดแยกที่ห้องฉุกเฉินคลาดเคลื่อน
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	SAR Part I-III
แหล่งข้อมูล	HA Score part I-III ที่เกี่ยวข้องมาตรฐานสำคัญจำเป็น ได้แก่ มาตรฐาน บทที่ III-4.3 การดูแลเฉพาะ ข.การผ่าตัด (4) มาตรฐาน บทที่ II-4.2 การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มจำเพาะ (1) มาตรฐาน บทที่ I-5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร ข. สวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสุขภาวะของบุคลากร (3) (vii) มาตรฐาน บทที่ II-4.2 การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ข. การป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มจำเพาะ (6) มาตรฐาน บทที่ II-6.1 การกำกับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน ก. การกำกับดูแลการจัดการด้านยา (1) (iv) มาตรฐาน บทที่ II-7.3 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต มาตรฐาน บทที่ III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ ค. การเข้ารับบริการ (entry) (5) มาตรฐาน บทที่ III-2 การประเมินผู้ป่วย ค.การวินิจฉัยโรค (5)

	มาตรฐาน บทที่ II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก ข.การให้บริการ (3) มาตรฐาน บทที่ II-7.4 พยาธิวิทยากายวิภาค, เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์และนิติเวชคลินิก มาตรฐาน บทที่ II-7.5 บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ มาตรฐาน บทที่ III-1 การเข้าถึงบริการ (4)		
รายการข้อมูล	A : ตัวชี้วัดมาตรฐานสำคัญจำเ็นต่อความปลอดภัยบรรลุปเป้าหมาย B : ตัวชี้วัดมาตรฐานสำคัญจำเ็นต่อความปลอดภัยทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงจันทร์จิรา วรรณติกุล		

หัวข้อตาม HA Score part 1-3 (54 บท) * ได้แก่

ลำดับ	part 1-3 (54 บท)
1	I-1.1 การนำองค์กรโดยผู้นำระดับสูง
2	I-1.2 การกำกับดูแลองค์กร การจัดบริการสุขภาพเพื่อความยั่งยืน และการทำประโยชน์ให้สังคม
3	I-2.1 การจัดทำกลยุทธ์
4	I-2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ
5	I-3.1 ความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
6	I-3.2 ความผูกพันของผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน
7	I-3.3 สิทธิผู้ป่วย
8	I-4.1 การวัด การวิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินการขององค์กร
9	I-4.2 การจัดการสารสนเทศและการจัดการความรู้
10	I-5.1 สภาพแวดล้อมของบุคลากร
11	I-5.2 ความผูกพันของบุคลากร
12	I-6.1 กระบวนการทำงาน
13	I-6.2 ประสิทธิภาพของการปฏิบัติการ
14	II-1.1 การบริหารงานคุณภาพ
15	II-1.2 การบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย
16	II-2.1 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการพยาบาล
17	II-2.2 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์
18	II-3.1 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย

ลำดับ	part 1-3 (54 บท)
19	II-3.2 เครื่องมือและระบบสาธารณสุขโลก
20	II-3.3 สิ่งแวดล้อมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
21	II-4.1 ระบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
22	II-4.2 การปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ
23	II-5.1 ระบบเวชระเบียน
24	II-5.2 เวชระเบียนผู้ป่วย
25	II-6.1 การกำกับดูแลและสิ่งแวดล้อมสนับสนุน
26	II-6.2 การปฏิบัติในการใช้ยา
27	II-7.1 บริการรังสีวิทยา/ภาพทางการแพทย์
28	II-7.2 บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก
29	II-7.3 ธนาคารเลือดและงานบริการโลหิต
30	II-7.4 พยาธิวิทยากายวิภาค, เซลล์วิทยา, นิติเวชศาสตร์และนิติเวชคลินิก
31	II-7.5 บริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
32	II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
33	II-9.1 การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับชุมชน
34	II-9.2 การเสริมพลังชุมชน
35	II-10 การดูแลผู้ป่วยโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
36	III-1 การเข้าถึงและเข้ารับบริการ
37	III-2 การประเมินผู้ป่วย
38	III-3.1 การวางแผนการดูแล
39	III-3.2 การวางแผนจำหน่าย
40	III-4.1 การดูแลทั่วไป
41	III-4.2 การดูแลผู้ป่วยและการให้บริการที่มีความเสี่ยงสูง
42	III-4.3 ก. การระงับความรู้สึก
43	III-4.3 ข. การผ่าตัด
44	III-4.3 ค. อาหารและโภชนาบำบัด
45	III-4.3 ง. การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
46	III-4.3 จ. การจัดการความปวด
47	III-4.3 ฉ. การฟื้นฟูสภาพและสมรรถภาพ
48	III-4.3 ช. การดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
49	III-4.3 ซ. การแพทย์แผนไทย
50	III-4.3 ฌ. การแพทย์ทางเลือก
51	III-4.3 ญ. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่บ้าน
52	III-4.3 ฎ. การดูแลผู้ป่วยวิกฤติ
53	III-5 การให้ข้อมูลและการเสริมพลังแก่ผู้ป่วย/ครอบครัว
54	III-6 การดูแลต่อเนื่อง

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. บริหารเชิงยุทธศาสตร์ : วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานสูงอย่างต่อเนื่อง			
ตัวชี้วัดที่	KPI 56 บริหารเชิงยุทธศาสตร์: อัตราวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานผ่านเกณฑ์			
คำนิยาม	วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ คือ วัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม (10 ปี) ผลการดำเนินงาน ประเมินจาก KPI ของวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งหมด			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดทั้งหมดของแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล (10 ปี)			
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์			
รายการข้อมูล	A : ตัวชี้วัด (KPIs) ยุทธศาสตร์ที่ผ่านเกณฑ์ B : ตัวชี้วัด (KPIs) ยุทธศาสตร์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานะมาศ มะโนราช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงกนกพร โชคดีวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. บริหารเชิงยุทธศาสตร์ : วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานสูงอย่างต่อเนื่อง 2.1 โครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 จำนวน....โครงการ นำสู่การปฏิบัติทุกโครงการ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 56.1 อัตราโครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13			
คำนิยาม	โครงการและแผนปฏิบัติการ หมายถึง โครงการและแผนปฏิบัติการที่ระบุอยู่ในเล่มแผนยุทธศาสตร์ (10 ปี)			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โครงการทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน			
รายการข้อมูล	A : โครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 ที่นำสู่การปฏิบัติ B : โครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานะมาศ มะโนราช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงกนกพร โชคคติวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. บริหารเชิงยุทธศาสตร์ : วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ มีผลลัพธ์จากการดำเนินงานสูงอย่างต่อเนื่อง 2.2 โครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 นำสู่การปฏิบัติและได้รับการประเมินผลทุกโครงการ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 56.2 อัตราโครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 ได้รับการประเมินผล			
คำนิยาม	โครงการและแผนปฏิบัติการ หมายถึง โครงการและแผนปฏิบัติการที่ระบุอยู่ในเล่มแผนยุทธศาสตร์ (10 ปี) การประเมินผลโครงการ ประเมินจากผลลัพธ์การประเมินโครงการที่ระบุไว้ในเล่มแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โครงการทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน			
รายการข้อมูล	A : โครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 ที่ได้รับการประเมินผล B : โครงการและแผนปฏิบัติการ R1-R13 ที่นำสู่การปฏิบัติทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานะมาศ มะโนราช			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงกนกพร โชคคตวิวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ 4.1 Dashboard for Quick win : หน่วยงานในรพ. และเครือข่ายบริการสุขภาพ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบงานสูงขึ้น
ตัวชี้วัดที่	KPI 57 อัตราหน่วยงานในรพ. และเครือข่ายบริการสุขภาพ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบงาน
คำนิยาม	สารสนเทศทางการแพทย์ การสาธารณสุข ประกอบด้วย ข้อมูลสถานะสุขภาพ, ข้อมูลบริการสุขภาพ, ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข และข้อมูลตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลผู้ป่วยไปจนถึงการวางแผนเชิงนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ - ข้อมูลสถานะสุขภาพ (Health Status) - ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลและกลุ่มประชากร เช่น โรคประจำตัว, พฤติกรรมสุขภาพ, ประวัติการรับบริการ - ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการประเมินสถานการณ์สุขภาพของประชากรและการวางแผนป้องกันโรค - ข้อมูลบริการสุขภาพ (Health Service) - ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ได้รับ เช่น การรักษาพยาบาล, การวินิจฉัย, การส่งต่อ - รวมถึงข้อมูลของระบบบริการสุขภาพ เช่น การให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ - ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (Health Resources) - ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการแพทย์, สถานพยาบาล, อุปกรณ์ทางการแพทย์ - ใช้สำหรับการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ - ข้อมูลตัวชี้วัด (Health Indicator) - ข้อมูลที่ใช้วัดผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน, KPI (Key Performance Indicator) - ใช้เพื่อประเมินและติดตามผลลัพธ์ของนโยบายและโครงการต่างๆ การพัฒนาระบบงาน คือ
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาล

แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการข้อมูล (Information Management)			
รายการข้อมูล	A : หน่วยงานในรพ. และเครือข่ายบริการสุขภาพ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบงาน B : หน่วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ 4.1 Dashboard for Quick win : หน่วยงานในรพ. และเครือข่ายบริการสุขภาพ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น 4.1.1 หน่วยงานในรพ.
ตัวชี้วัดที่	OKR 57.1 อัตราหน่วยงานในรพ. ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
คำนิยาม	สารสนเทศทางการแพทย์ การสาธารณสุข ประกอบด้วย ข้อมูลสถานะสุขภาพ, ข้อมูลบริการสุขภาพ, ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข และข้อมูลตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลผู้ป่วยไปจนถึงการวางแผนเชิงนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ 1. ข้อมูลสถานะสุขภาพ (Health Status) • ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลและกลุ่มประชากร เช่น โรคประจำตัว, พฤติกรรมสุขภาพ, ประวัติการรับบริการ • ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการประเมินสถานการณ์สุขภาพของประชากรและการวางแผนป้องกันโรค 2. ข้อมูลบริการสุขภาพ (Health Service) • ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ได้รับ เช่น การรักษาพยาบาล, การวินิจฉัย, การส่งต่อ • รวมถึงข้อมูลของระบบบริการสุขภาพ เช่น การให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ 3. ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (Health Resources) • ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการแพทย์, สถานพยาบาล, อุปกรณ์ทางการแพทย์ • ใช้สำหรับการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 4. ข้อมูลตัวชี้วัด (Health Indicator) • ข้อมูลที่ใช้วัดผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน, KPI (Key Performance Indicator) • ใช้เพื่อประเมินและติดตามผลลัพธ์ของนโยบายและโครงการต่างๆ
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	

แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล	A : หน่วยงานในรพ. ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ B : หน่วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ 4.1 Dashboard for Quick win : หน่วยงานในรพ. และเครือข่ายบริการสุขภาพ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น 4.1.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ
ตัวชี้วัดที่	OKR 57.2 หน่วยบริการปฐมภูมิ ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ
คำนิยาม	สารสนเทศทางการแพทย์ การสาธารณสุข ประกอบด้วย ข้อมูลสถานะสุขภาพ, ข้อมูลบริการสุขภาพ, ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข และข้อมูลตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการข้อมูลผู้ป่วยไปจนถึงการวางแผนเชิงนโยบายและการจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ - ข้อมูลสถานะสุขภาพ (Health Status) - ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของบุคคลและกลุ่มประชากร เช่น โรคประจำตัว, พฤติกรรมสุขภาพ, ประวัติการรับบริการ - ข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการประเมินสถานการณ์สุขภาพของประชากรและการวางแผนป้องกันโรค - ข้อมูลบริการสุขภาพ (Health Service) - ข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ได้รับ เช่น การรักษาพยาบาล, การวินิจฉัย, การส่งต่อ - รวมถึงข้อมูลของระบบบริการสุขภาพ เช่น การให้บริการในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ - ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข (Health Resources) - ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เช่น บุคลากรทางการแพทย์, สถานพยาบาล, อุปกรณ์ทางการแพทย์ - ใช้สำหรับการบริหารจัดการและวางแผนการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ - ข้อมูลตัวชี้วัด (Health Indicator) - ข้อมูลที่ใช้วัดผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุข เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน, KPI (Key Performance Indicator) - ใช้เพื่อประเมินและติดตามผลลัพธ์ของนโยบายและโครงการต่างๆ หน่วยบริการปฐมภูมิ ประกอบด้วย 1) ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 4 แห่ง 2) รพ.สต.ในอำเภอเมือง จำนวน 17 แห่ง
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน	≥ ร้อยละ 80

ระยะ 3 ปี				
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล	A : หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ใช้สารสนเทศด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการในการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพ B : หน่วยบริการปฐมภูมิทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 80	2572 ≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4.2 จัดการความรู้ : ใช้ CoPs (OKRs ใน R1-R13) ในการปรับปรุง พัฒนาระบบงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPIs 58 อัตรา Community of Practice (CoPs) ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์			
คำนิยาม	Community of Practice (CoP) หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยความสนใจ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะในหัวข้อเดียวกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทั้งในรูปแบบการประชุมจริง (face-to-face) หรือผ่านช่องทางเสมือน (online) CoP เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการความรู้ (KM) ที่ช่วยส่งเสริมการสร้างความรู้ใหม่ ๆ และนำไปสู่การปฏิบัติที่ดีขึ้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	Community of Practice (CoPs) ที่มีในโรงพยาบาล			
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานของ CoPs			
รายการข้อมูล	A : จำนวน Community of Practice (CoPs) ที่มีผลลัพธ์บรรลุเป้าหมาย B : จำนวน CoPs ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	IM+HRD			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4.2 จัดการความรู้ : หน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPIs 59 อัตราหน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ			
คำนิยาม	การพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ หมายถึง กระบวนการสร้างหรือปรับปรุงแนวคิด วิธีการหรือเครื่องมือ หรือกระบวนการทำงาน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ (Systematic change) ภายในองค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อให้ระบบงานโดยรวมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพและความยั่งยืนมากขึ้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาล			
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ/กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ			
รายการข้อมูล	A : หน่วยงานที่มีการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ B : หน่วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน				
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. อัตรากำลัง : อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง (รพ.ระดับ P to P+) เพียงพอตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี			
ตัวชี้วัดที่	KPI 60 อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง (รพ.ระดับ P to P+) เพียงพอตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี			
คำนิยาม	สหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง หมายถึง แพทย์ พยาบาล สหสาขาวิชาชีพทางคลินิกที่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพแต่ละสาขา สหสาขาวิชาชีพทางคลินิก ประกอบด้วย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ นักทัศนมาตร นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ความเพียงพอ หมายถึง มีจำนวนสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง ตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปี (3 ปี) ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน ของปีงบประมาณ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แผนอัตรากำลัง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนกำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูงตามแผนยุทธศาสตร์ที่มี B : จำนวนกำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูงตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวธนาภรณ์ ฝนดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. อัตรากำลัง : อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง (รพ.ระดับ P to P+) เพียงพอ เหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี 5.1 อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพสมรรถนะสูง เพียงพอ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 60.1 แพทย์เฉพาะทาง			
คำนิยาม	แพทย์เฉพาะทาง หมายถึง แพทย์ที่ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากแพทยสภา ความเพียงพอ หมายถึง มีจำนวนแพทย์เฉพาะทางตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปี (3 ปี) ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน ของปีงบประมาณ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	แพทย์โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แผนอัตรากำลัง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนแพทย์เฉพาะทางตามแผนยุทธศาสตร์ที่มี B : จำนวนแพทย์เฉพาะทางตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวธนาภรณ์ ฝนดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. อัตรากำลัง : อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง (รพ.ระดับ P to P+) เพียงพอ เหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี 5.1 อัตรากำลังพยาบาลวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง เพียงพอ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 60.2 พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง			
คำนิยาม	พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง หมายถึง พยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางที่ได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสภาการพยาบาล ความเพียงพอ หมายถึง มีจำนวนพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปี (3 ปี) ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน ของปีงบประมาณ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แผนอัตรากำลัง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางตามแผนยุทธศาสตร์ที่มี B : จำนวนพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวธนาภรณ์ ฝนดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. อัตรากำลัง : อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพที่มีสมรรถนะสูง (รพ.ระดับ P to P+) เพียงพอ เหมาะสมตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี 5.1 อัตรากำลังสหสาขาวิชาชีพทางคลินิกมีสมรรถนะสูง เพียงพอ			
ตัวชี้วัดที่	OKRs 60.3 สหสาขาวิชาชีพทางคลินิก			
คำนิยาม	สหสาขาวิชาชีพทางคลินิก ประกอบด้วย เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ นักรังสีแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักกายอุปกรณ์ นักทัศนมาตร นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ความเพียงพอ หมายถึง มีจำนวนสหสาขาวิชาชีพทางคลินิกตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละปี (3 ปี) ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน ของปีงบประมาณ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	สหสาขาวิชาชีพทางคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แผนอัตรากำลัง โรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนสหสาขาวิชาชีพทางคลินิกตามแผนยุทธศาสตร์ที่มี B : จำนวนสหสาขาวิชาชีพทางคลินิกตามแผนยุทธศาสตร์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวธนาภรณ์ ฝนดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.5. บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์		
ตัวชี้วัดที่	KPI 61 อัตราบุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์		
คำนิยาม	สมรรถนะตามเกณฑ์สายวิชาชีพ (Professional Competency) หมายถึง ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรสายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานขององค์กร สมรรถนะตามเกณฑ์สายสนับสนุน (Support Staff Competency) หมายถึง ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุน เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสนับสนุนอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการให้บริการสุขภาพของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ B : บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวชนัญดา ปิเจริญ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.5. บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์ 5.5.1 แพทย์		
ตัวชี้วัดที่	OKR 61.1 แพทย์		
คำนิยาม	สมรรถนะตามเกณฑ์สายวิชาชีพ (Professional Competency) หมายถึง ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรสายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานขององค์กร		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : บุคลากรวิชาชีพแพทย์ที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ B : บุคลากรวิชาชีพแพทย์ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวชนัญดา ปิเจริญ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.5. บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์ 5.5.2 พยาบาลวิชาชีพ		
ตัวชี้วัดที่	OKR 61.2 พยาบาลวิชาชีพ		
คำนิยาม	สมรรถนะตามเกณฑ์สายวิชาชีพ (Professional Competency) หมายถึง ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรสายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานขององค์กร		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : บุคลากรวิชาชีพพยาบาลที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ B : บุคลากรวิชาชีพพยาบาลทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวชนัญดา ปิเจริญ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.5. บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์ 5.5.3 สหสาขาวิชาชีพ		
ตัวชี้วัดที่	OKR 61.3 สหสาขาวิชาชีพ		
คำนิยาม	สมรรถนะตามเกณฑ์สายวิชาชีพ (Professional Competency) หมายถึง ระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรสายวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ หรือบุคลากรสุขภาพเฉพาะทาง ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ เพื่อให้บริการผู้ป่วยหรือประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานขององค์กร สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง การที่ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาชีพมารวมตัวกัน ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ แนวคิดนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้านทั้งในด้านการแพทย์ จิตใจ และสังคม		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : บุคลากรสหสาขาวิชาชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์ B : บุคลากรสหสาขาวิชาชีพทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวชนัญดา ปิเจริญ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.5. บุคลากรสหสาขาวิชาชีพและสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์ 5.5.4 สายสนับสนุน		
ตัวชี้วัดที่	OKR 61.4 สายสนับสนุน		
คำนิยาม	สายสนับสนุน (Back Office) หมายถึง กลุ่มงาน แผนก หรือบุคลากรในองค์กรที่ไม่ได้ทำหน้าที่เผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรง (Non-facing Customer) และไม่ได้อยู่ในสายกระบวนการผลิตหรือบริการหลัก แต่มีหน้าที่สำคัญในการวางแผน บริหารจัดการดูแลระบบ และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ "สายงานหลัก" (Front Office) สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สายสนับสนุนบริการ (Service Support Line) หมายถึง กลุ่มงาน แผนก หรือบุคลากรในองค์กร (โดยเฉพาะในบริบทสาธารณสุขและโรงพยาบาล) ที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาลหรือวินิจฉัยโรคโดยตรงเหมือนแพทย์หรือพยาบาล แต่มีหน้าที่ "ให้บริการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเชิงเทคนิค กายภาพ และสิ่งแวดล้อม" เพื่อให้การบริการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยเป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน ประกอบด้วย		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสรุปผลการประเมินสมรรถนะบุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : บุคลากรสายสนับสนุนมีสมรรถนะตามเกณฑ์ B : บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวชนัญดา ปีเจริญ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.6 บุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป			
ตัวชี้วัดที่	KPI 62 อัตราบุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป			
คำนิยาม	บุคลากรมีความผูกพัน หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบุคลากรต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วม การทำงานอย่างทุ่มเท และการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญของบุคลากรที่มีความผูกพัน 1. ความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Commitment): รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าขององค์กร 2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction): รู้สึกพอใจต่อบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. ความเต็มใจในการมีส่วนร่วม (Engagement): ทำงานด้วยแรงจูงใจสูง และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 4. ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถามความผูกพันต่อโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป B : บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานันย์ โคตรมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.6 บุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป 5.6.2.1 ด้านความพึงพอใจต่อคุณภาพงาน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 62.1 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพงานระดับดีมากขึ้นไป			
คำนิยาม	บุคลากรมีความผูกพัน หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบุคลากรต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วม การทำงานอย่างทุ่มเท และการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญของบุคลากรที่มีความผูกพัน 1. ความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Commitment): รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าขององค์กร 2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction): รู้สึกพอใจต่อบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. ความเต็มใจในการมีส่วนร่วม (Engagement): ทำงานด้วยแรงจูงใจสูง และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 4. ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถามความผูกพันต่อโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความผูกพัน โดยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพงานระดับดีมากขึ้นไป B : บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานันย์ โคตรมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.6 บุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป 5.6.2 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 62.2 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน			
คำนิยาม	บุคลากรมีความผูกพัน หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบุคลากรต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วม การทำงานอย่างทุ่มเท และการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญของบุคลากรที่มีความผูกพัน 1. ความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Commitment): รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าขององค์กร 2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction): รู้สึกพอใจต่อบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. ความเต็มใจในการมีส่วนร่วม (Engagement): ทำงานด้วยแรงจูงใจสูง และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 4. ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถามความผูกพันต่อโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความผูกพัน โดยมีความพึงพอใจความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน ระดับดีมากขึ้นไป B : บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานันย์ โคตรมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.6 บุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป 5.6.3 ด้านค่านิยมและผู้นำขององค์กร			
ตัวชี้วัดที่	OKR 62.3 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านค่านิยมและผู้นำขององค์กรในระดับดีมากขึ้นไป			
คำนิยาม	บุคลากรมีความผูกพัน หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบุคลากรต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วม การทำงานอย่างทุ่มเท และการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญของบุคลากรที่มีความผูกพัน 1. ความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Commitment): รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าขององค์กร 2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction): รู้สึกพอใจต่อบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. ความเต็มใจในการมีส่วนร่วม (Engagement): ทำงานด้วยแรงจูงใจสูง และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 4. ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถามความผูกพันต่อโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความผูกพัน โดยมีความพึงพอใจด้านค่านิยมและผู้นำขององค์กร ระดับดีมากขึ้นไป B : บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานันท์ โคตรมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.6 บุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป 5.6.4 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 62.4 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับดีมากขึ้นไป			
คำนิยาม	บุคลากรมีความผูกพัน หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบุคลากรต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วม การทำงานอย่างทุ่มเท และการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญของบุคลากรที่มีความผูกพัน 1. ความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Commitment): รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าขององค์กร 2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction): รู้สึกพอใจต่อบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. ความเต็มใจในการมีส่วนร่วม (Engagement): ทำงานด้วยแรงจูงใจสูง และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 4. ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถามความผูกพันต่อโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความผูกพัน โดยมีความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับดีมากขึ้นไป B : บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานันท์ โคตรมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.6 บุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป 5.6.5 ด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 62.5 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ระดับดีมากขึ้นไป			
คำนิยาม	บุคลากรมีความผูกพัน หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบุคลากรต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วม การทำงานอย่างทุ่มเท และการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญของบุคลากรที่มีความผูกพัน 1. ความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Commitment): รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าขององค์กร 2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction): รู้สึกพอใจต่อบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. ความเต็มใจในการมีส่วนร่วม (Engagement): ทำงานด้วยแรงจูงใจสูง และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 4. ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถามความผูกพันต่อโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความผูกพัน โดยมีระดับความพึงพอใจด้านโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน ระดับดีมากขึ้นไป B : บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานันท์ โคตรมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5.6 บุคลากรมีความผูกพัน ระดับดีมากขึ้นไป 5.6.6 ด้านค่าตอบแทน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 62.6 อัตราบุคลากรที่มีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน ระดับดีมากขึ้นไป			
คำนิยาม	บุคลากรมีความผูกพัน หมายถึง ระดับความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบของบุคลากรต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ ซึ่งสะท้อนถึงความเต็มใจในการมีส่วนร่วม การทำงานอย่างทุ่มเท และการรักษาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับองค์กร เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ลักษณะสำคัญของบุคลากรที่มีความผูกพัน 1. ความมุ่งมั่นต่อองค์กร (Commitment): รู้สึกภูมิใจและเห็นคุณค่าขององค์กร 2. ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction): รู้สึกพอใจต่อบทบาท หน้าที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน 3. ความเต็มใจในการมีส่วนร่วม (Engagement): ทำงานด้วยแรงจูงใจสูง และสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร 4. ความภักดีต่อองค์กร (Loyalty): มีแนวโน้มที่จะอยู่กับองค์กรระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 60			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถามความผูกพันต่อโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามว่ามีความผูกพัน โดยมีความพึงพอใจด้านค่าตอบแทน ระดับดีมากขึ้นไป B : บุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 60	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวฐานันย์ โคตรมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. การจัดการกระบวนการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ใน OPD , IPD, ER , ทันตกรรม		
ตัวชี้วัดที่	KPI 63 ประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย		
คำนิยาม	ลดความแออัดและลดระยะเวลารอคอย หมายถึง การปรับปรุงกระบวนการและระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการโดยไม่ต้องรอนานและมีจำนวนคนรอใช้บริการในบริเวณนั้นน้อยลง. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโรงพยาบาล อาจหมายถึงการลดเวลาตั้งแต่การลงทะเบียน, การพบแพทย์, จนถึงการรักษา ลดความแออัด หมายถึง การจัดการให้มีจำนวนคนในพื้นที่บริการน้อยลง เพื่อลดความรู้สึกไม่สะดวกสบายและความแออัด ลดระยะเวลารอคอย หมายถึง การลดเวลาที่ผู้รับบริการต้องใช้ในการรอรับบริการในแต่ละขั้นตอน		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 75		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยนอก, ทันตกรรม, ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, ผู้ป่วยในและศูนย์ส่งต่อ		
รายการข้อมูล	A : จำนวน OKRs ที่บรรลุเป้าหมาย (OKRs 57.1-57.5) B : จำนวน OKRs ทั้งหมด (OKRs 57.1-57.5)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 40	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนรินทร์พร สงศรี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ศิโรตม์ จันทรักษา		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. การจัดการกระบวนการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ใน OPD , IPD, ER , ทันตกรรม 6.1 ลดระยะเวลารอคอย (OPD)		
ตัวชี้วัดที่	OKR 63.1 ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก ตั้งแต่นับบัตรจนถึงรับยากลับบ้าน		
คำนิยาม	ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก (Out patient Waiting Time) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยนอก (OPD - ผู้ป่วยที่มารับการตรวจรักษาแต่ไม่ได้นอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล) ต้องใช้ในการรอคอยเพื่อรับบริการทางการแพทย์ในขั้นตอนต่างๆ โดยปกติจะเริ่มนับตั้งแต่ผู้ป่วยทำบัตรหรือลงทะเบียนที่จุดแรก ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือการชำระเงินและรับยาเสร็จสิ้นเพื่อเดินทางกลับ		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≤ 120 นาที		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาการให้บริการผู้ป่วยนอก		
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก		
รายการข้อมูล	A : ระยะเวลารวมการให้บริการผู้ป่วยนอก B : จำนวนผู้ป่วยนอก(ครั้ง)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≤ 140 นาที	2571 ≤ 130 นาที	2572 ≤ 100 นาที
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. การจัดการกระบวนการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ใน OPD , IPD, ER , ทันตกรรม 6.2 ลดระยะเวลารอคอย (ทันตกรรม)		
ตัวชี้วัดที่	OKR 63.2 ระยะเวลารอคอย ตั้งแต่นับัตรจนถึงรับยากลับบ้าน		
คำนิยาม	ระยะเวลารอคอยบริการทันตกรรม (Dental Waiting Time) หมายถึง ระยะเวลาที่ผู้ป่วยต้องรอคอยเพื่อให้ได้รับการตรวจ วินิจฉัย หรือทำหัตถการรักษาโรคในช่องปากและฟัน		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	> 120 นาที		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาการให้บริการทันตกรรม		
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานทันตกรรม		
รายการข้อมูล	A : ระยะเวลารวมการให้บริการทันตกรรม B : จำนวนผู้ป่วยนอกทันตกรรม (ครั้ง)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≤ 120 นาที	≤ 120 นาที	≤ 120 นาที
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. การจัดการกระบวนการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ใน OPD , IPD, ER , ทันตกรรม 6.3 ลดจำนวนวันนอน (IPD)		
ตัวชี้วัดที่	OKR 63.3 จำนวนวันนอนเฉลี่ย		
คำนิยาม	จำนวนวันนอนเฉลี่ย (Average Length of Stay: ALOS) หมายถึง ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผู้ป่วยใน (Inpatient) แต่ละรายต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยนับตั้งแต่วันที่รับตัวเข้ารับรักษา (Admission) จนถึงวันที่จำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Discharge) ไม่ว่าจะด้วยการอนุญาตให้กลับบ้าน การส่งต่อไปยังสถานพยาบาลอื่น หรือการเสียชีวิตก็ตาม จำนวนวันนอนพักรักษาในโรงพยาบาลของผู้ป่วยใน เฉลี่ยต่อราย		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≤ 5 วัน		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : ผลรวมของจำนวนวันนอนของผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด B : จำนวนผู้ป่วยในที่จำหน่ายทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≤ 5 วัน	≤ 5 วัน	≤ 5 วัน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. การจัดการกระบวนการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ใน OPD , IPD, ER , ทันตกรรม 6.4 ลดการ Refer ของโรงพยาบาลเครือข่าย		
ตัวชี้วัดที่	OKR 63.4 อัตราการ refer in ของโรงพยาบาลเครือข่าย <table><tr><td>57.4.1 ระดับ S+ ถึง A+ ผู้ป่วยที่มี adj RW < 0.8 ลดลงร้อยละ 10</td></tr><tr><td>57.4.2 ระดับ S ผู้ป่วยที่มี adj RW < 0.6 ลดลงร้อยละ 10</td></tr></table>	57.4.1 ระดับ S+ ถึง A+ ผู้ป่วยที่มี adj RW < 0.8 ลดลงร้อยละ 10	57.4.2 ระดับ S ผู้ป่วยที่มี adj RW < 0.6 ลดลงร้อยละ 10
57.4.1 ระดับ S+ ถึง A+ ผู้ป่วยที่มี adj RW < 0.8 ลดลงร้อยละ 10			
57.4.2 ระดับ S ผู้ป่วยที่มี adj RW < 0.6 ลดลงร้อยละ 10			
คำนิยาม	Refer in หมายถึง สถานพยาบาลแห่งหนึ่งรับส่งต่อผู้ป่วย ด้วยเหตุผลในการรับส่งต่อ เช่น สถานพยาบาลต้นทางขาดศักยภาพ ไม่สามารถตรวจวินิจฉัย/รักษา ขาดเครื่องมือทางการแพทย์ ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รับส่งต่อตามสิทธิ์การรักษา หรือเป็นความประสงค์ของผู้ป่วย/ญาติเป็นต้น adj RW < 0.8 หมายถึง คำนวณน้ำหนักสัมพัทธ์ที่ปรับค่าตามวินนอน adj RW < 0.6 หมายถึง โรงพยาบาล ระดับ A ได้แก่ รพ.บรบือ โรงพยาบาล ระดับ S+ ได้แก่ รพ.พยัคภูมิสัย, รพ.โกสุม และรพ.วาปีปทุม โรงพยาบาล ระดับ S ได้แก่ รพ.กันทรวิชัย, รพ.กุตุรง, รพ.แกดำ, รพ.ชื่นชม, รพ.เชียงยืน, รพ.ยางสีสุราช, รพ.นาइन, รพ.นาเชือก		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ลดลงร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S+ ถึง A+ ที่มีค่า Adj RW <0.8 ผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S ที่มีค่า Adj RW < 0.6		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HIS โรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S+ ถึง A+ ที่มีค่า Adj RW <0.8 ในปีก่อนหน้า B : จำนวนผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S+ ถึง A+ ที่มีค่า Adj RW <0.8 ในปีปัจจุบัน E : ร้อยละที่ลดลงของผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S+ ถึง A+ ที่มีค่า Adj RW < 0.8 = (A-B)/A*100 สำหรับ รพ.ระดับ S+ ถึง A+ C : จำนวนผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S ที่มีค่า Adj RW <0.6 ในปีก่อนหน้า D : จำนวนผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S ที่มีค่า Adj RW <0.6 ในปีปัจจุบัน F : ร้อยละที่ลดลงของผู้ป่วยที่ Refer in จากรพช. ระดับ S ที่มีค่า Adj RW < 0.6		

	= (C-D)/C*100 สำหรับ รพ.ระดับ S			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(E+F)/2			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	
	10	10	10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางกนกวรรณ เจริญศิริ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.อนันตเดช วงศรียา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. การจัดการกระบวนการ : เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย ใน OPD , IPD, ER , ทันตกรรม 6.4 ลดระยะเวลาให้บริการที่ ER (ลด Crowding)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 63.5 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด <table><tr><td>57.5.1 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 1 ไม่เกิน 90 นาที ร้อยละ 80</td></tr><tr><td>57.5.2 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 2 ไม่เกิน 120 นาที ร้อยละ 80</td></tr><tr><td>57.5.3 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 3 ไม่เกิน 180 นาที ร้อยละ 80</td></tr></table>	57.5.1 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 1 ไม่เกิน 90 นาที ร้อยละ 80	57.5.2 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 2 ไม่เกิน 120 นาที ร้อยละ 80	57.5.3 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 3 ไม่เกิน 180 นาที ร้อยละ 80
57.5.1 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 1 ไม่เกิน 90 นาที ร้อยละ 80				
57.5.2 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 2 ไม่เกิน 120 นาที ร้อยละ 80				
57.5.3 อัตราผู้ป่วยที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) ในกลุ่ม Triage level 3 ไม่เกิน 180 นาที ร้อยละ 80				
คำนิยาม	ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ Triage จนถึงเวลาที่ผู้ป่วยออกจาก ER Triage level 1 หมายถึง Resuscitation (สีแดง) ผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามต่อชีวิตหากไม่ได้รับช่วยเหลือทันทีอาจเสียชีวิตได้ Triage level 2 หมายถึง Emergency (สีชมพู) ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง มีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์อันตรายต้องให้การดูแลรักษาภายใน 5-15 นาที Triage level 3 หมายถึง Urgent (สีเหลือง) ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินไม่เร่งด่วน ควรได้รับการดูแลรักษาภายใน 30-60 นาที			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Triage level 1-3 ที่มารับบริการที่ ER			
แหล่งข้อมูล	ระบบรายงานข้อมูล HIS ผ่านโปรแกรมคลินิก			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Triage Level 1-3 ที่ระยะเวลาให้บริการใน ER (On ER Time) อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด B : จำนวนผู้ป่วย Triage Level 1-3 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B)*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปรมาภรณ์ คลังพระศรี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.อนันตเดช วงศรียา		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. ผลลัพธ์ : สูงกว่าค่าเฉลี่ยรพ.คู่เทียบเพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านคุณภาพ			
ตัวชี้วัดที่	KPI 64 อัตราผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) บรรลุเป้าหมาย			
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ/การดูแลทางคลินิก การสร้างเสริมสุขภาพ IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น IV-3 ผลด้านบุคลากร IV-4 ผลด้านการนำและการกำกับดูแล IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการ IV-6 ผลด้านการเงิน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV 259 ตัวชี้วัด			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV ที่บรรลุเป้าหมาย B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	85	90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ปิยะนารถ ด่านพรประเสริฐ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. ผลลัพธ์ : สูงกว่าค่าเฉลี่ยรพ.คู่เทียบเพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) - ด้านการดูแลผู้ป่วยและการสร้างเสริมสุขภาพ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 64.1 ด้านการดูแลผู้ป่วยและการสร้างเสริมสุขภาพ			
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ/การดูแลทางคลินิก การสร้างเสริมสุขภาพ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV ตัวชี้วัดที่ 1-185			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-1 ที่บรรลุเป้าหมาย B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-1 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	85	90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ปิยะนารถ ด่านพรประเสริฐ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. ผลลัพธ์ : สูงกว่าค่าเฉลี่ยรพ.คู่เทียบเพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) - ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 64.2 ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน			
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-2 ด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงาน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV ตัวชี้วัดที่ 186-194			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-2 ที่บรรลุเป้าหมาย B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-2 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	85	90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ปิยะนารถ ด่านพรประเสริฐ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. ผลลัพธ์ : สูงกว่าค่าเฉลี่ยรพ.คู่เทียบเพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) - ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล			
ตัวชี้วัดที่	OKR 64.3 ด้านการมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล			
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-3 ด้านบุคลากร			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV ตัวชี้วัดที่ 195-210			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-3 ที่บรรลุเป้าหมาย B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-3 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	85	90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางทัศนีย์ บุตรพรม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงอติพร สุรวงษ์สิน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. ผลลัพธ์ : สูงกว่าค่าเฉลี่ยรพ.คู่เทียบเพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) - ด้านการนำ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 64.4 ด้านการนำ			
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-4 ผลด้านการนำและการกำกับดูแล			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV ตัวชี้วัดที่ 211-219			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-4 ที่บรรลุเป้าหมาย B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-4 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้องรายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	85	90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายแพทย์เฉลิมพล บุญพรหมธีรกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. ผลลัพธ์ : สูงกว่าค่าเฉลี่ยรพ.คู่เทียบเพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) - ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานที่สำคัญ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 64.5 ด้านประสิทธิผลของกระบวนการทำงานที่สำคัญ			
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-5 ประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานที่สำคัญ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV ตัวชี้วัดที่ 220-250			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-5 ที่บรรลุเป้าหมาย B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-5 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	85	90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. ผลลัพธ์ : สูงกว่าค่าเฉลี่ยรพ.คู่เทียบเพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านคุณภาพ 7.1 ผลลัพธ์ด้านคุณภาพ (AHA ตอนที่ 4) - ด้านการเงิน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 64.6 ด้านการเงิน			
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-6 ด้านการเงิน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV ตัวชี้วัดที่ 251-259			
รายการข้อมูล	A: จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-6 ที่บรรลุเป้าหมาย B : จำนวนตัวชี้วัด SAR Part IV-6 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	80	85	90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสิริยุญาพร คงแสนคำ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกัญดา คำพอ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7.4 เพิ่มผลลัพธ์เหนือคู่แข่งจากการเทียบเคียง (Benchmark)
ตัวชี้วัดที่	KPI 65 อัตราผลลัพธ์ด้านคุณภาพการเทียบเคียง (Benchmark) - เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 80 - ภูมิภาค (เขตสุขภาพที่ 7,8,9,10) ร้อยละ 80 - ระดับชาติ ร้อยละ 80 - ระดับนานาชาติ ร้อยละ 80
คำนิยาม	ผลการดำเนินงานที่ดีและการปรับปรุงในประเด็นสำคัญที่โรงพยาบาลกำหนด SAR Part IV ได้แก่ IV-1 ผลด้านการดูแลสุขภาพ/การดูแลทางคลินิก การสร้างเสริมสุขภาพ IV-2 ผลด้านการมุ่งเน้นผู้ป่วยและผู้รับผลงานอื่น IV-3 ผลด้านบุคลากร IV-4 ผลด้านการนำและการกำกับดูแล IV-5 ผลด้านประสิทธิผลของกระบวนการ IV-6 ผลด้านการเงิน ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการเทียบเคียง หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานด้านคุณภาพของหน่วยงานสุขภาพ ซึ่งได้รับการวัดและเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งในระดับองค์กรเดียวกันหรือองค์กรอื่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาประสิทธิภาพ และสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการสุขภาพ 1. มีมาตรฐานอ้างอิง (Benchmark) เช่น เกณฑ์ HA, เกณฑ์ SAP, หรือค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2. วัดผลเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น อัตราการติดเชื้อหลังผ่าตัด, เวลารอคอยผู้ป่วย, ความพึงพอใจผู้รับบริการ 3. ใช้เปรียบเทียบได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อระบุจุดแข็งและช่องว่าง 4. สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Quality Improvement – CQI)
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผลลัพธ์การดำเนินการ SAR Part IV โรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	SAR Part IV
รายการข้อมูล	A : ผลลัพธ์ดีกว่าคู่แข่ง (Benchmark) B : ผลลัพธ์ดีเท่ากับคู่แข่ง (Benchmark) ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงสุภาวดี นวลอ่อน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7.2 เพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข			
ตัวชี้วัดที่	KPI 66 อัตราผลลัพธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข บรรลุผลลัพธ์			
คำนิยาม	ผลลัพธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข หมายถึง ผลลัพธ์หรือผลสำเร็จที่วัดได้จากแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพอย่างยั่งยืน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล	A : นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข บรรลุผลลัพธ์ B : นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7.3 เพิ่มการบรรลุเป้าหมายของผลลัพธ์ตามนโยบายและยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 7			
ตัวชี้วัดที่	KPI 67 อัตราผลลัพธ์ตามนโยบายเขตสุขภาพที่ 7 (4 Excellence) บรรลุเป้าหมาย			
คำนิยาม	ผลลัพธ์ตามนโยบาย เขตสุขภาพที่ 7 หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายเฉพาะของเขตสุขภาพที่ 7 เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล	A : นโยบายเขตสุขภาพที่ 7 (4 Excellence) บรรลุเป้าหมาย B : นโยบายเขตสุขภาพที่ 7 (4 Excellence) ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R5 : High Performance Organization (HPO)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7.5 รางวัลระดับชาติ (เลิศรัฐ) / นานาชาติ ได้รับรางวัลระดับชาติเลิศรัฐ,NQA,AHA			
ตัวชี้วัดที่	KPI 68 ได้รับรางวัลระดับชาติเลิศรัฐ, NQA, AHA			
คำนิยาม	รางวัลระดับชาติเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศและมีความโดดเด่น โดยมีทั้งหมด 3 สาขาหลักคือ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA), สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม, และ สาขาบริการภาครัฐ ซึ่งรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูหน่วยงานที่ดำเนินงานได้ดีเยี่ยม และสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน NQA หมายถึง ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ > 700 คะแนน รางวัล Nursing Quality Assessment Award (NQA Award) รับโล่รางวัล ระยะการรับรอง 5 ปี > 650 – 699 คะแนน รางวัล Nursing Quality Assessment Class Plus (NQA Class Plus) รับโล่รางวัล ระยะการรับรอง 3 ปี การรับรองมาตรฐาน AHA หมายถึง การรับรองว่าโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพมีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีมาตรฐานและมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ตามเกณฑ์ที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลกำหนดไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพและความปลอดภัยในองค์กรสุขภาพอย่างยั่งยืน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ 1 รางวัล			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล	A : ได้รับรางวัลระดับชาติเลิศรัฐ, NQA, AHA อย่างน้อย 1 รางวัล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ 1 รางวัล	≥ 1 รางวัล	≥ 1 รางวัล	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป		
ตัวชี้วัดที่	KPI 69 ประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป		
คำนิยาม	ตัวชี้วัด (OKR) ของกลุ่มงานบริหารทั่วไป ผ่านเกณฑ์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 (5 ตัว จาก 7 ตัว)		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 70		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานภายในกลุ่มงานบริหารทั่วไป		
แหล่งข้อมูล	ตัวชี้วัดของกลุ่มงานบริหารทั่วไป		
รายการข้อมูล	A : ตัวชี้วัด OKR ของกลุ่มงานบริหารทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์ B : ตัวชี้วัด OKR ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายศิวักร แสนยะมาตย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 1.1 งานสารบรรณ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการหนังสือราชการที่สำคัญ (Service Level Agreement : SLA) ภายในเวลา 15 นาที		
ตัวชี้วัดที่	OKR 69.1 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามข้อตกลงการให้บริการหนังสือราชการที่สำคัญ (SLA) ภายในเวลา 15 นาที		
คำนิยาม	- SLA (Service Level Agreement) ของ งานสารบัญ ก็คือ ข้อตกลงเรื่องระดับการให้บริการ ที่กำหนดไว้ชัดเจน ว่างานสารบัญ (งานธุรการกลางที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเข้า-ออก การรับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียน และกระจายเอกสาร) จะต้องทำให้เสร็จภายในเวลา/มาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น - หนังสือราชการที่สำคัญ คือ หนังสือที่ประทับด่วนที่สุด/ด่วนมาก/ลับ/หนังสือที่ใกล้ครบกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามหนังสือภายในเวลา 48 ชั่วโมง - ระยะเวลาในการให้บริการหนังสือราชการ คือ ระยะเวลาที่ลงรับหนังสือถึงเสนอผู้บริหารและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ภายใน 15 นาที		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนลงรับหนังสือราชการ (โปรแกรม E-Saraban)		
รายการข้อมูล	A : จำนวนหนังสือราชการที่สำคัญที่ระยะเวลาในการให้บริการหนังสือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 15 นาที B : จำนวนหนังสือราชการที่สำคัญทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ร้อยละ 80	2571 ร้อยละ 85	2572 ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวธนกร เทศพรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายคิวกร แสนยะมาตย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 1.2 งานธุรการ : บุคลากรในรพ.และผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาสารคาม		
ตัวชี้วัดที่	OKR 69.2 อัตราบุคลากรใน รพ.และผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการของโรงพยาบาลมหาสารคาม 58.2.1 ด้านการแพทย์ ≥ ร้อยละ 80 58.2.2 ด้านการสาธารณสุข ≥ ร้อยละ 80 58.2.3 ด้านบริหารจัดการ ≥ ร้อยละ 80		
คำนิยาม			
ค่าเป้าหมาย			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย			
แหล่งข้อมูล			
รายการข้อมูล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง						
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+						
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 1.3 งานรักษาความปลอดภัย : ไม่พบอุบัติเหตุทรัพย์สินทางราชการ ผู้ป่วยและญาติเจ้าหน้าที่สูญหายและความรุนแรงในโรงพยาบาล						
ตัวชี้วัดที่	OKR 69.3 อุบัติการณ์ทรัพย์สินทางราชการ ผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่สูญหายและความรุนแรงในโรงพยาบาล						
คำนิยาม	ทรัพย์สินทางราชการ คือ ทรัพย์สินทุกชนิดที่เป็นของทางราชการ ไม่ว่าจะได้มาโดยการจัดซื้อ จัดหา สร้างขึ้น รับบริจาค หรือได้มาโดยวิธีอื่น ๆ และใช้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ ความรุนแรง คือ การทำร้ายร่างกาย การทำลายทรัพย์สินทางราชการ						
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม และเจ้าหน้าที่						
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมรายงานความเสี่ยงของโรงพยาบาล บันทึกรายงานประจำวันของงานรักษาความปลอดภัย						
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติเหตุทรัพย์สินทางราชการ ผู้ป่วยและญาติ เจ้าหน้าที่สูญหายและความรุนแรงในโรงพยาบาล						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2570	2571	2572	0	0	0
2570	2571	2572					
0	0	0					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวณัฐกุล เจริญศิริ						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายศิวักร แสนยะมาตย์						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 1.4 ยานพาหนะ : ไม่พบอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่รถราชการเป็นฝ่ายผิด		
ตัวชี้วัดที่	OKR 69.4 อุบัติการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่รถราชการเป็นฝ่ายผิด		
คำนิยาม	อุบัติเหตุที่เกิดกับรถราชการ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่ได้ตั้งใจ ในระหว่างที่มีการนำรถยนต์หรือยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ (เช่น รถ ส่วนกลาง รถประจำตำแหน่ง หรือรถรับรอง) ออกไปปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถราชการ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต อุบัติเหตุที่รถราชการเป็นฝ่ายผิด หมายถึง เหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงานราชการ โดยผลการพิสูจน์พยานหลักฐาน การพิจารณาของพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) หรือคำพิพากษาของศาล ระบุว่า "ผู้ขับขี่รถราชการคันดังกล่าวเป็นผู้กระทำความประมาทเลินเล่อ" จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต แก่บุคคลภายนอก (คู่กรณี) หรือทรัพย์สินของทางราชการเอง		
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	พนักงานขับรถ		
แหล่งข้อมูล	แบบรายงานอุบัติเหตุ...		
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่รถราชการเป็นฝ่ายผิด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0	0	0
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวณัฐกุล เจริญศิริ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายศิวักร แสนยะมาตย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 1.5 งานจัดการขยะ : น้ำหนักของมูลฝอยติดเชื้อในหอผู้ป่วยใน เฉลี่ยไม่เกิน 0.75 กิโลกรัมต่อเตียงต่อคนต่อวัน		
ตัวชี้วัดที่	OKR 69.5 น้ำหนักของมูลฝอยติดเชื้อในหอผู้ป่วยใน เฉลี่ยไม่เกิน 0.75 กิโลกรัมต่อเตียงต่อคนต่อวัน		
คำนิยาม	มูลฝอยติดเชื้อ (Infectious Waste) หมายถึง ขยะหรือมูลฝอยที่มีสารประกอบพลอยได้ หรือปนเปื้อนด้วย เชื้อโรค (เช่น เชื้อไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา หรือปรสิต) ในปริมาณหรือความเข้มข้นที่อาจทำให้เกิดโรคแก่คนได้ หากมีการสัมผัสหรือแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม หอผู้ป่วยใน ประกอบด้วย (แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) 1.ใหญ่ 2.กลาง 3.เล็ก		
ค่าเป้าหมาย	≤ 0.75 กิโลกรัมต่อเตียงต่อคนต่อวัน		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หอผู้ป่วยใน		
แหล่งข้อมูล	หน่วยงานบำบัดน้ำเสียและขยะ		
รายการข้อมูล	A : น้ำหนักมูลฝอยติดเชื้อรวมในหอผู้ป่วยใน B : จำนวนวันนอนหอผู้ป่วยใน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0.75 กิโลกรัม	0.75 กิโลกรัม	0.75 กิโลกรัม
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายสุระศักดิ์ จันทะพิมพ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายศิวักร แสนยะมาตย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 1.6 งานนิติการ : บุคลากรในโรงพยาบาลรอบรู้กฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 69.6 อัตราบุคลากรในโรงพยาบาลรอบรู้กฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ตามเกณฑ์ที่กำหนด มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 75 58.6.1 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 58.6.2 พรบ.คอมพิวเตอร์ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 58.6.3 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80 58.6.4 อุบัติการณ์บุคลากรดำเนินการฝ่าฝืนตามกฎหมาย มากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับ 0
คำนิยาม	กฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข หมายถึง กลุ่มของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กฎกระทรวง ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่เป็นกฎหมายส่วนกลางในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายเฉพาะทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับ (ทั้งสายวิชาชีพ สายสนับสนุนบริการ และสายสนับสนุน Back Office) จำเป็นต้องรู้ ยึดถือ และปฏิบัติตามสอดคล้องตามกรอบที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถคุ้มครองความปลอดภัยของทั้งผู้รับบริการ (ประชาชน/ผู้ป่วย) และผู้ให้บริการ (เจ้าหน้าที่) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act) หรือที่เรียกกันติดปากว่า PDPA หมายถึง กฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และกลไกในการกำกับดูแลการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย "ข้อมูลส่วนบุคคล" ไม่ให้ถูกนำไปใช้ในทางที่มิชอบ หรือนำไปเผยแพร่โดยที่เจ้าของข้อมูลไม่ยินยอม เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวส่วนตัวของประชาชน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ หมายถึง พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกำหนดความผิดและบทลงโทษสำหรับผู้กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเสียหาย ทำลาย หรือส่งผลกระทบต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ รวมถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อควบคุมการใช้งานเทคโนโลยีให้มีความปลอดภัย โปร่งใส และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อรองรับสิทธิของประชาชนในการ "รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ของรัฐ" เพื่อส่งเสริมความโปร่งใส

	ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรดำเนินการฝ่าฝืนตามกฎหมาย หมายถึง การที่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานรัฐ (เช่น โรงพยาบาล หรือหน่วยงานสาธารณสุข) ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ไม่ว่าจะเป็นโดยเจตนา ประมาทเลินเล่อ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ละเมิดต่อสิทธิของบุคคลภายนอก หรือทำลายระบบธรรมาภิบาลขององค์กร		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 75		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาล (ไม่รวม Outsource)		
แหล่งข้อมูล	แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่กำหนด แบบบันทึกการรับทราบรายงานอุบัติการณ์ของงานนิติการ		
รายการข้อมูล	A : จำนวนตัวชี้วัดย่อยของ OKRs 58.6 ที่ผ่านเกณฑ์ B : จำนวนตัวชี้วัดย่อยของ OKRs 58.6 ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 75	ร้อยละ 75	ร้อยละ 75
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายฉัตรมงคล สิงห์กลาง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายคิวกร แสนยะมาตย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.กลุ่มงานบริหารทั่วไป : เพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานบริหารทั่วไป 1.7 งานประชาสัมพันธ์ : เพิ่มความพึงพอใจศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์			
ตัวชี้วัดที่	OKR 69.7 อัตราความพึงพอใจต่อการติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์			
คำนิยาม	การติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หมายถึง การติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ผ่านเพจโรงพยาบาลด้านหน้า และทางโทรศัพท์			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบประเมินความพึงพอใจด้านหน้า ทะเบียนรับโทรศัพท์ ทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนทางเพจ แบบประเมินความพึงพอใจทางเพจ			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความพึงพอใจ ระดับ 4 หรือ 5 B : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความพึงพอใจทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางธัญชนก แฝ่นพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ.นันทนพ รัตนเดชสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล : บุคลากรได้รับข้อมูลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนทันเวลา		
ตัวชี้วัดที่	KPI 70 อัตราบุคลากรได้รับข้อมูลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนทันเวลา		
คำนิยาม	ข้อมูลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทน หมายถึง การเลื่อนระดับ การปรับค่าตอบแทนทันเวลา หมายถึง มีการแจ้งข้อมูลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนก่อนครบคุณสมบัติอย่างน้อย 6 เดือน		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่ง (ก.พ.7) เอกสารประกอบการแจ้งและรับทราบข้อมูล (รายบุคคล)		
รายการข้อมูล	A : จำนวนบุคลากรได้รับข้อมูลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนทันเวลา B : จำนวนบุคลากรที่ต้องได้รับข้อมูลสิทธิประโยชน์และผลตอบแทนในปีนั้นทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสุชาดา วิกาสะโล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสุจิราพร ศรีตระการโกศล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (บูรณาการร่วมกับ R11_AHA) : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ระดับ 3 ขึ้นไป			
ตัวชี้วัดที่	KPI 71 อุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ระดับ 3 ขึ้นไป			
คำนิยาม	โครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical Infrastructure and Engineering) หมายถึง ระบบโครงสร้างทางกายภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เทคโนโลยี และระบบวิศวกรรมสนับสนุนต่าง ๆ ภายในสถานพยาบาล เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และได้มาตรฐานตามหลักสากล ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3 คือ ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 4 คือ ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 5 คือ			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด ผู้รับบริการ			
แหล่งข้อมูล	สมุดบันทึกรายงานอุบัติการณ์ของงานช่าง โปรแกรมรายงานความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ ระดับ 3 ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้งต่อปี	0 ครั้งต่อปี	0 ครั้งต่อปี	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายศศิพงษ์ พิมพะนิตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายจิระพันธ์ แสงยศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (บูรณาการร่วมกับ R11_AHA) : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3 ขึ้นไป 3.1 ไฟฟ้า : ไม่พบอุบัติการณ์ไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน ภายใน 10 วินาที			
ตัวชี้วัดที่	OKR 71.1 อับัติการณ์ไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน ภายใน 10 วินาที			
คำนิยาม	ไฟฟ้าสำรองไม่ทำงาน คือ เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายไฟได้ภายใน 10 วินาที ระยะเวลาในการเริ่มทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขัดข้อง จนถึงเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงพยาบาลมหาสารคามสามารถจ่ายไฟได้			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด ผู้รับบริการ			
แหล่งข้อมูล	สมุดบันทึกรายงานอับัติการณ์ของงานช่าง โปรแกรมรายงานความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A : จำนวนอับัติการณ์ไฟฟ้าสำรองไม่ทำงานภายใน 10 วินาที			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0 ครั้ง	เท่ากับ 0 ครั้ง	เท่ากับ 0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายศศิพงษ์ พิมพะนิตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายจิระพันธ์ แสงยศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (บูรณาการร่วมกับ R11_AHA) : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3 ขึ้นไป 3.2 ประปา : ไม่พบอุบัติการณ์น้ำประปาไม่ไหล			
ตัวชี้วัดที่	OKR 71.2 อุบัติการณ์น้ำประปาไม่ไหล			
คำนิยาม	น้ำประปาไม่ไหล หมายถึง สถานการณ์หรือสภาวะที่ไม่มีน้ำประปาส่งผ่านมาตามระบบท่อจ่ายน้ำจนถึงหัวก๊อกหรือสุขภัณฑ์ภายในบ้าน อาคาร หรือสถานพยาบาล ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ หรือในบางกรณีอาจรวมถึงการที่น้ำไหลกะปริดกะปรอย แรงดันน้ำต่ำมากจนไม่สามารถใช้งานกับเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ต้องใช้แรงดันดันน้ำได้ (เช่น เครื่องกรองน้ำ หรือเครื่องทำน้ำอุ่น)			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด ผู้รับบริการ			
แหล่งข้อมูล	สมุดบันทึกรายงานอุบัติการณ์ของงานช่าง โปรแกรมรายงานความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์น้ำประปาไม่ไหล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายศศิพงษ์ พิมพะนิตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายจิระพันธ์ แสงยศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (บูรณาการร่วมกับ R11_AHA) : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3 ขึ้นไป 3.3 อักคีภัย : ไม่พบอุบัติการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล			
ตัวชี้วัดที่	OKR 71.3 อับัติการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล			
คำนิยาม	การเกิดเพลิงไหม้ (Fire / Conflagration) หรือที่เรียกว่า "อักคีภัย" หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกซิเจนในอากาศกับสารเชื้อเพลิง โดยมีความร้อนเป็นตัวเร่ง ทำให้เกิดการลุกไหม้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเปลวไฟ ควันไฟ และ ก๊าซพิษ ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ไม่สามารถควบคุมได้ และสร้างความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อม			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด ผู้รับบริการ			
แหล่งข้อมูล	สมุดบันทึกรายงานอุบัติการณ์ของงานช่าง โปรแกรมรายงานความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์การเกิดเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายศศิพงษ์ พิมพะนิตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายจีระพันธ์ แสงยศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (บูรณาการร่วมกับ R11_AHA) : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3 ขึ้นไป 3.4 ลิฟท์ : ไม่พบอุบัติการณ์ลิฟท์ไม่พร้อมใช้			
ตัวชี้วัดที่	OKR 71.4 อุตบัติการณ์ลิฟท์ไม่พร้อมใช้			
คำนิยาม	ลิฟต์ไม่พร้อมใช้งาน (Elevator Out of Service / Elevator Inoperable) หมายถึง สถานการณ์หรือสภาวะที่ลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ขนส่งภายในอาคาร ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ เนื่องจากระบบกลไก ระบบไฟฟ้า หรือระบบซอฟต์แวร์ควบคุมเกิดความขัดข้องชำรุด หรืออยู่ระหว่างการปิดระบบเพื่อดำเนินการบำรุงรักษา ตรวจสอบความปลอดภัย หรือซ่อมแซมใหญ่โดยช่างผู้เชี่ยวชาญ ยกเว้นกรณีปิดเพื่อซ่อมบำรุง			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรและผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	สมุดบันทึกรายงานอุบัติการณ์ของงานช่าง โปรแกรมรายงานความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์ลิฟท์ไม่พร้อมใช้			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายศศิพงษ์ พิมพะนิตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายจิระพันธ์ แสงยศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (บูรณาการร่วมกับ R11_AHA) : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงทั่วไป ระดับ 3 ขึ้นไป 3.5 เครื่องมือแพทย์ : ไม่พบอุบัติการณ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงไม่เพียงพอ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 71.5 อับัติการณ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงไม่เพียงพอ			
คำนิยาม	เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง (9 รายการ) ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงไม่เพียงพอ คือ จำนวนเครื่องมือแพทย์ที่จัดหาเข้ามาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ รวมถึงชำรุดและดำเนินการซ่อมล่าช้า			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0 ครั้งต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานภายในโรงพยาบาลมหาสารคามที่ให้การดูแลผู้ป่วย			
แหล่งข้อมูล	สมุดบันทึกรายงานอุบัติการณ์องงานช่าง โปรแกรมรายงานความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A : จำนวนอับัติการณ์เครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูงไม่เพียงพอ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายศศิพงษ์ พิมพะนิตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายจิระพันธ์ แสงยศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล			
ตัวชี้วัดที่	KPI 72 ร้อยละความพึงพอใจภาพรวม ระดับ 4 หรือ 5 ของผู้รับบริการต่อโครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล			
คำนิยาม	โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล ประกอบด้วย (1) ห้องน้ำ (2) พื้นที่รอตรวจ (3) พื้นที่สีเขียวและนั่งพักผ่อนในโรงพยาบาล (4) ร้านค้า ร้านอาหารในโรงพยาบาล ความพึงพอใจภาพรวม หมายถึง			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความพึงพอใจ ระดับ 4 หรือ 5 B : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้คะแนนความพึงพอใจทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B *100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายคิวกร แสนยะมาตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.มารุต ดำหนักโพธิ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. กลุ่มงานพัสดุ : ประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุให้ทันเวลาตามกำหนด			
ตัวชี้วัดที่	KPI 73 อัตราประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุให้ทันเวลาตามกำหนด			
คำนิยาม	พัสดุ คือ วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และจ้างเหมาบริการ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ทันตามเวลากำหนด คือ มีการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนดใน แผนปฏิบัติการประจำปี			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	พัสดุที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท			
แหล่งข้อมูล	รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ			
รายการข้อมูล	A : จำนวนโครงการในการจัดหาพัสดุทันเวลาตามกำหนด B : จำนวนโครงการในการจัดหาพัสดุทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A*B/100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้อง รายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิตติวรดา ดาวันนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง						
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+						
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. กลุ่มงานการเงิน : ไม่พบอุบัติการณ์เบิกจ่ายเงินผิดพลาดและไม่ทันเวลา						
ตัวชี้วัดที่	KPI 74 อุบัติการณ์เบิกจ่ายเงินผิดพลาดและไม่ทันเวลา						
คำนิยาม	จำนวนครั้งที่มีการผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน หรือการเบิกจ่ายเงินที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้รับเงิน คือ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงินภายนอก คำจำกัดความของข้อผิดพลาดและความล่าช้า ได้แก่: - การจ่ายเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวน - การจ่ายเงินซ้ำ - การเบิกจ่ายเกินเวลาที่กำหนดในระเบียบหรือข้อตกลง (เช่น เกิน 30 วันหลังรับเอกสารครบถ้วน) - การเบิกจ่ายที่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับเงินว่าล่าช้า						
ค่าเป้าหมาย	0 ครั้งต่อปี						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเบิกจ่าย - ผู้รับเงิน คือ เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน						
แหล่งข้อมูล	- ระบบสารสนเทศรายงานทางการเงิน (โปรแกรม IACC) - แบบฟอร์มแจ้งการเบิกจ่าย - หนังสือร้องเรียนหรือบันทึกข้อความภายใน - บันทึกเหตุการณ์ หรือรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน						
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์เบิกจ่ายเงินผิดพลาดและไม่ทันเวลา						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **						
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>0 ครั้ง</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2570	2571	2572	0 ครั้ง	0	0
2570	2571	2572					
0 ครั้ง	0	0					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวอารีรัตน์ แสนทองทิพย์/นางสาวสุวลี ไชยโอชะ						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง								
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+								
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. กลุ่มงานการเงิน : ไม่พบอุบัติการณ์เบิกจ่ายเงินผิดพลาดและไม่ทันเวลา								
ตัวชี้วัดที่	OKR 74.1 อุบัติการณ์การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผิดพลาดและไม่ทันเวลา								
คำนิยาม	จำนวนครั้งที่มีย่อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน หรือการเบิกจ่ายเงินที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ คำจำกัดความของข้อผิดพลาดและความล่าช้า ได้แก่: - การจ่ายเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวน - การจ่ายเงินช้า - การเบิกจ่ายที่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับเงินว่าล่าช้า								
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลทั้งหมด								
แหล่งข้อมูล	- ระบบสารสนเทศรายงานทางการเงิน (โปรแกรม IACC) - แบบฟอร์มแจ้งการเบิกจ่าย - หนังสือร้องเรียนหรือบันทึกข้อความภายใน - บันทึกเหตุการณ์ หรือรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน								
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์การเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผิดพลาดและไม่ทันเวลา								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A								
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>เท่ากับ 0</td><td>เท่ากับ 0</td><td>เท่ากับ 0</td></tr></table>	2570	2571	2572	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0		
2570	2571	2572							
เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	1. นางสาวอารีรัตน์ แสนทองทิพย์ 2. นางสาวสุวลี ไชยโอชะ								
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ								

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง								
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+								
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	6. กลุ่มงานการเงิน : ไม่พบอุบัติเหตุการเบิกจ่ายเงินผิดพลาดและไม่ทันเวลา								
ตัวชี้วัดที่	OKR 74.2 อุบัติการณ์การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินภายนอกผิดพลาดและไม่ทันเวลา								
คำนิยาม	จำนวนครั้งที่มีย่อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน หรือการเบิกจ่ายเงินที่ดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีสิทธิรับเงินภายนอก คำจำกัดความของข้อผิดพลาดและความล่าช้า ได้แก่: - การจ่ายเงินผิดบัญชี/ผิดจำนวน - การจ่ายเงินซ้ำ - การเบิกจ่ายเกินเวลาที่กำหนดในระเบียบหรือข้อตกลง (เช่น เกิน 30 วันหลังรับเอกสารครบถ้วน) - การเบิกจ่ายที่มีการร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้รับเงินว่าล่าช้า								
ค่าเป้าหมาย	0 ครั้งต่อปี								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้มีสิทธิรับเงินภายนอก								
แหล่งข้อมูล	- ระบบสารสนเทศรายงานทางการเงิน (โปรแกรม IACC) - แบบฟอร์มแจ้งการเบิกจ่าย - หนังสือร้องเรียนหรือบันทึกข้อความภายใน - บันทึกเหตุการณ์ หรือรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน								
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงินภายนอกผิดพลาดและไม่ทันเวลา								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A								
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	2570	2571	2572	0	0	0		
2570	2571	2572							
0	0	0							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	1. นางสาวอารีรัตน์ แสนทองทิพย์ 2. นางสาวสุลลี ไชยโอชะ								
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริณญาพร คงแสนคำ								

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. กลุ่มงานบัญชี : 1. การบริหารจัดการลูกหนี้ผ่านเกณฑ์			
ตัวชี้วัดที่	KPI 75 การบริหารจัดการลูกหนี้ ผ่านเกณฑ์			
คำนิยาม	การบริหารจัดการลูกหนี้ (Accounts Receivable Management หรือ Debtors Management) หมายถึง กระบวนการวางแผน การจัดระเบียบ การกำกับดูแล และการควบคุมดูแล "ลูกหนี้" ขององค์กร (เงินที่บุคคลภายนอก หรือผู้มารับบริการยังค้างชำระอยู่) ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการให้สินเชื่อ การออกไปแจ้งหนี้ การติดตามทวงถาม ไปจนถึงการเรียกเก็บเงินให้ได้ครบถ้วนและตรงเวลา			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล	A : คะแนนที่ได้จากการประเมิน B : คะแนนเต็ม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B)*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พันทนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริณญาพร คงแสนคำ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. กลุ่มงานบัญชี : 2. การรับรู้สินทรัพย์ทางบัญชีถูกต้อง ตรงกับทะเบียนคุมพัสดุในแต่ละปีงบประมาณ
ตัวชี้วัดที่	KPI 76 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนของการรับรู้สินทรัพย์ทางบัญชี
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนในการกระทบยอดลูกหนี้ ครัวเรือน อาคารและสิ่งก่อสร้างระหว่างกลุ่มงานประกัน กลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานบัญชี หมายถึง การตรวจพบความไม่ตรงกันหรือข้อผิดพลาดระหว่างยอดลูกหนี้ที่บันทึก/รายการ โดยกลุ่มงานประกัน ยอดครัวเรือน อาคารและสิ่งก่อสร้าง ของผู้รับบริการที่บันทึก/รายงานโดย กลุ่มงานพัสดุ กับ กลุ่มงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น: - การกระทบยอดไม่ตรงกันของรายชื่อบุคคล, จำนวนเงิน, หรือสถานะลูกหนี้ - การบันทึกข้อมูลล่าช้า ส่งผลให้ข้อมูลไม่ตรงกัน - การคีย์ข้อมูลผิดประเภท เช่น บันทึกรายได้ประกันผิดกองทุน/สิทธิ - ความคลาดเคลื่อนที่นำไปสู่การทวงถามผิดคน ผิดยอด หรือการรายงานงบการเงินผิดพลาด - ครัวเรือน - อาคารและสิ่งก่อสร้าง การกระทบยอด (Reconciliation) หมายถึง การตรวจสอบและเปรียบเทียบยอดลูกหนี้ ครัวเรือน อาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้ตรงกันในเดือนถัดไป
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 เป็นต้นไป
แหล่งข้อมูล	- ทะเบียนคุมสินทรัพย์ (ทะเบียนครัวเรือน) - รายงานตรวจนับสินทรัพย์ประจำปี/ประจำไตรมาส - รายงานการโยกย้าย/จำหน่าย/ซ่อมแซมสินทรัพย์ - ระบบสารสนเทศครัวเรือน (ถ้ามี เช่น e-Asset หรือระบบ ERP) - แบบฟอร์มแจ้งโอนย้ายหรือเปลี่ยนสถานะสินทรัพย์ - รายงานผลการตรวจสอบภายในหรือจากหน่วยงานภายนอก - รายงานงบทดลองบัญชี GFMS
รายการข้อมูล	A : จำนวนความคลาดเคลื่อนของการรับรู้สินทรัพย์ทางบัญชี
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พันทนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริยุญาพร คงแสนคำ			

นียมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. กลุ่มงานประกันสุขภาพ : 7.1 ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ภายในกลุ่มงานประกัน
ตัวชี้วัดที่	OKR 76.1 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ภายในกลุ่มงานประกัน
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ในกลุ่มงานประกัน หมายถึง การตรวจพบความไม่ตรงกันหรือข้อผิดพลาดระหว่างยอดลูกหนี้ของผู้รับบริการที่บันทึก/รายงานโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น: - การกระทบยอดไม่ตรงกันของรายชื่อลูกหนี้, จำนวนเงิน, หรือสถานะลูกหนี้ - การบันทึกข้อมูลล่าช้า ส่งผลให้ข้อมูลไม่ตรงกัน - การคีย์ข้อมูลผิดพลาดประเภท เช่น บันทึกรายได้ประกันผิดกองทุน/สิทธิ - ความคลาดเคลื่อนที่นำไปสู่การทวงถามผิดคน ผิดยอด หรือการรายงานงบการเงินผิดพลาด การกระทบยอด (Reconciliation) หมายถึง การตรวจสอบและเปรียบเทียบยอดลูกหนี้จาก 2 ฝ่าย เพื่อให้ตรงกันในเดือนถัดไป รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ - รายงานลูกหนี้จากงานลูกหนี้กลุ่มงานประกันสุขภาพและงานเรียกเก็บ - รายการเปรียบเทียบลูกหนี้ (Reconciliation Sheet) - รายการความคลาดเคลื่อน (ถ้ามี) - วันที่ตรวจพบความคลาดเคลื่อน - รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง - สาเหตุของข้อผิดพลาด - วิธีการแก้ไขและป้องกัน - เอกสารหลักฐานประกอบ (ใบเสร็จ, สำเนาใบแจ้งหนี้, ฯลฯ)
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนลูกหนี้คำรักษาพยาบาลทั้งหมด ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 เป็นต้นไป
แหล่งข้อมูล	- รายงานลูกหนี้ประกันสุขภาพจากระบบ HIS / หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้งาน - รายงานบัญชีลูกหนี้จากงานลูกหนี้กลุ่มงานประกันสุขภาพและงานเรียกเก็บ (ERP หรือระบบที่เกี่ยวข้อง) - รายงานการกระทบยอดประจำเดือน/ไตรมาส - บันทึกความแตกต่างหรือความคลาดเคลื่อนในการกระทบยอด - รายงานผลการตรวจสอบจากภายในหรือภายนอก

รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ภายในกลุ่มงานประกัน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พันนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. กลุ่มงานบัญชี : 7.2 ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ระหว่างกลุ่มงานประกันและบัญชี
ตัวชี้วัดที่	OKR 76.2 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ระหว่างกลุ่มงานประกันและบัญชี
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนในการกระทบลูกหนี้ระหว่างกลุ่มงานประกันและบัญชี หมายถึง การตรวจพบความไม่ตรงกันหรือข้อผิดพลาดระหว่างยอดลูกหนี้ของผู้รับบริการที่บันทึก/รายงานโดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ กับ กลุ่มงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น: - การกระทบยอดไม่ตรงกันของรายชื่อลูกหนี้, จำนวนเงิน, หรือสถานะลูกหนี้ - การบันทึกข้อมูลล่าช้า ส่งผลให้ข้อมูลไม่ตรงกัน - การคีย์ข้อมูลผิดพลาด เช่น บันทึกรายได้ประกันผิดกองทุน/สิทธิ - ความคลาดเคลื่อนที่นำไปสู่การทวงถามผิดคน ผิดยอด หรือการรายงานงบการเงินผิดพลาด การกระทบยอด (Reconciliation) หมายถึง การตรวจสอบและเปรียบเทียบยอดลูกหนี้จาก 2 ฝ่าย เพื่อให้ตรงกันในเดือนถัดไป รายการข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ - รายงานลูกหนี้จากทั้งฝ่ายประกันสุขภาพและงานบัญชี - รายการเปรียบเทียบลูกหนี้ (Reconciliation Sheet) - รายการความคลาดเคลื่อน (ถ้ามี) - วันที่ตรวจพบความคลาดเคลื่อน - รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง - สาเหตุของข้อผิดพลาด - วิธีการแก้ไขและป้องกัน - เอกสารหลักฐานประกอบ (ใบเสร็จ, สำเนาใบแจ้งหนี้, ฯลฯ)
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	- เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ - เจ้าหน้าที่บัญชีที่ดูแลบัญชีลูกหนี้ - หัวหน้างานด้านบัญชีและประกันสุขภาพ - หน่วยงานตรวจสอบภายใน
แหล่งข้อมูล	- รายงานลูกหนี้ประกันสุขภาพจากระบบ HIS / หรือโปรแกรมอื่นที่ใช้งาน

	- รายงานบัญชีลูกหนี้จากระบบบัญชี/การเงิน (ERP หรือระบบที่เกี่ยวข้อง) - รายงานการกระทบยอดประจำเดือน/ไตรมาส - บันทึกความแตกต่างหรือความคลาดเคลื่อนในการกระทบยอด - รายงานผลการตรวจสอบจากภายในหรือภายนอก			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งที่พบความไม่ตรงกันของข้อมูลลูกหนี้ระหว่างกลุ่มงานประกันกับกลุ่มงานบัญชี			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พันนา / จนท.กลุ่มงานประกัน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ/นางจรรวรณ์ อัครวิสุทธิเจริญ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R6 : ระบบสนับสนุนทรัพยากรที่เป็นเลิศ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูง...ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	7. กลุ่มงานบัญชี : 7.3 ไม่พบอุบัติการณ์สินทรัพย์ไม่ตรงกับทะเบียนคุม
ตัวชี้วัดที่	OKR 76.3 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการกระทียอดครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้าง ระหว่างกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานบัญชี
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนในการกระทียอดครุภัณฑ์ อาคารและสิ่งก่อสร้างระหว่างกลุ่มงานพัสดุและกลุ่มงานบัญชี หมายถึง การตรวจพบความไม่ตรงกันหรือข้อผิดพลาดระหว่างยอดครุภัณฑ์ อาคารของผู้รับบริการที่บันทึก/รายงานโดย กลุ่มงานพัสดุ กับ กลุ่มงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น: - ครุภัณฑ์ - อาคารและสิ่งก่อสร้าง การกระทียอด (Reconciliation) หมายถึง การตรวจสอบและเปรียบเทียบยอดครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้างจาก 2 ฝ่าย เพื่อให้ตรงกันในเดือนถัดไป การรับรู้สินทรัพย์ทางบัญชี คือ ทะเบียนคุมพัสดุ คือ การรับรู้สินทรัพย์ทางบัญชีถูกต้อง ตรงกับทะเบียนคุมพัสดุ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2568 เป็นต้นไป สินทรัพย์ทางบัญชีตรงกับทะเบียนคุมพัสดุ หมายถึง จำนวนครั้งที่ตรวจพบว่ารายการสินทรัพย์ของหน่วยงานตรงกับทะเบียนคุมสินทรัพย์ ทั้งในด้าน จำนวน, สถานที่ตั้ง, ผู้รับผิดชอบ, หรือ มูลค่า ไม่ว่าจะเป็น : - สินทรัพย์มีอยู่จริงและปรากฏในทะเบียนคุม - ข้อมูลในทะเบียนคุมตรงกับข้อเท็จจริง (เช่น หมายเลขครุภัณฑ์, หน่วยงานรับผิดชอบ, สถานที่จัดเก็บ, มูลค่าตามบัญชี ฯลฯ) - การโยกย้าย/โอนสินทรัพย์โดยมีการปรับปรุงทะเบียนคุม - สินทรัพย์ในทะเบียนคุมตรงกับรายงานงบทดลองบัญชี GFMS
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพและกลุ่มงานบัญชี
แหล่งข้อมูล	
รายการข้อมูล	A : B :
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้อง รายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พินนา+ จนท.พัสดุ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริยุญาพร คงแสนคำ+หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R7 : รพ.มหาสารคามอัจฉริยะ (Smart Hospital)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. HAIT : ได้รับการรับรองคุณภาพ HAIT Level 4 ภายในปี 2572
ตัวชี้วัดที่	KPI 77 ผ่านการรับรอง Hospital Accreditation of Information Technology (HAIT)
คำนิยาม	Hospital Accreditation of Information Technology (HAIT) หมายถึง "มาตรฐานการประเมินและรับรองคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล" ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย สมาคมเวชสารสนเทศไทย (Thai Medical Informatics Association: TMI) มาตรฐานนี้เป็นเครื่องมือและกรอบแนวทาง (Framework) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้โรงพยาบาล (ทั้งภาครัฐและเอกชน) สามารถยกระดับระบบ IT, โครงสร้างพื้นฐาน, ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ, รวมถึงการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลทางการแพทย์ (เช่น รหัส ICD) ให้มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ภาพรวมในมิติทางคลินิกและข้อมูลด้วย 7 หมวดสำคัญที่ HAIT ใช้ในการตรวจประเมิน 1. HAIT 1-2: การจัดทำแผนแม่บทและการจัดโครงสร้างระบบสารสนเทศ 2. HAIT 3: การจัดการความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (Security Management / IT Security) 3. HAIT 4: การจัดการระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอุบัติการณ์ (IT Service and Incident Management) 4. HAIT 5: ระบบควบคุมคุณภาพข้อมูลการวินิจฉัยและการรักษาผู้ป่วยและคุณภาพรหัส ICD (Data Quality) 5. HAIT 6: การควบคุมคุณภาพการพัฒนาโปรแกรม (Software Development Quality Control) 6. HAIT 7: การจัดการศักยภาพและสมรรถนะของทรัพยากรไอที (IT Capacity & Competency) HAIT ระดับ 4 คือ การจัดการระบบบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและอุบัติการณ์ (IT Service and Incident Management) ซึ่งว่าด้วยการวางระบบ "หลังบ้าน" ของทีม IT เพื่อสนับสนุนผู้ใช้งาน (แพทย์ พยาบาล และสายสนับสนุนอื่น ๆ) ให้สามารถใช้ระบบโรงพยาบาลได้อย่างไม่มีสะดุด
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	Level 4
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม

แหล่งข้อมูล	หนังสือรับรองจากสมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI)		
รายการข้อมูล	A : การรับรอง Hospital Accreditation of Information Technology (HAIT)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	Level 2	Level 3	Level 4
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายปิยะวุฒิ คลังระหัด		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายพัทยะ ธรรมบุตร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R7 : รพ.มหาสารคามอัจฉริยะ (Smart Hospital)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. HAIT : ได้รับการรับรองคุณภาพ HAIT Level 4 ภายในปี 2572 1.1 IT Master Plan : แผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงพยาบาล สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลระยะ 10 ปี		
ตัวชี้วัดที่	OKR 77.1 7 หมวดมาตรฐาน HAIT ผ่านระดับ Level 4		
คำนิยาม	7 หมวดมาตรฐาน HAIT มีดังนี้ 1. IT Master Plan Level 4 คือ... 2. IT Risk Management System Level 4 คือ... 3. Information Security Management Level 4 คือ... 4. Service Desk, Service Level Agreement, Incident and Problem Management Level 4 คือ.... 5. Clinical Data Quality Control Level 4 คือ... 6. Software Development Quality Control (if available) Level 4 คือ... 7. Capacity Management and Change Management Level 4 คือ... การประเมินตนเอง ด้วยวิธี Self Assessment		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสาร 7 หมวดของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ		
รายการข้อมูล	A : หมวดมาตรฐาน HAIT ที่ผ่านระดับ Level 4 B : หมวดมาตรฐาน HAIT ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 70	2571 ≥ ร้อยละ 80	2572 ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายปิยะวุฒิ คลังระหัด		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายพัทยะ ธรรมบุตร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R7 : รพ.มหาสารคามอัจฉริยะ (Smart Hospital)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Smart Hospital : ได้รับการรับรองระดับเพชรของกระทรวงสาธารณสุข		
ตัวชี้วัดที่	KPI 78 ผ่านการรับรองโรงพยาบาล Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข		
คำนิยาม	โรงพยาบาล Smart Hospital (โรงพยาบาลอัจฉริยะ) หมายถึง โรงพยาบาลที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมระดับสูง และระบบสารสนเทศ เข้ามาบูรณาการและเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ยกย่องคุณภาพการรักษาพยาบาล คำนึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และช่วยให้บุคลากรทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นระดับเงิน คะแนนการประเมิน ≥ 600-699 คะแนน ระดับทอง คะแนนการประเมิน ≥ 700-799 คะแนน ระดับเพชร คะแนนการประเมิน ≥ 800 คะแนน		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ระดับเพชร		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	สำนักสุขภาพดิจิทัล กระทรวงสาธารณสุข		
รายการข้อมูล	A : การรับรองโรงพยาบาล Smart Hospital ของกระทรวงสาธารณสุข ระดับเพชร		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ระดับเพชร	ระดับเพชร	ระดับเพชร
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสุจิตรา นาสิงห์ขันธุ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายธวัชไชย วรรณไชย		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M3_ยกระดับระบบบริหารจัดการโรงพยาบาลดิจิทัลสู่องค์กรสมรรถนะสูง			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R7 : รพ.มหาสารคามอัจฉริยะ (Smart Hospital)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับ P+ และเป็นองค์กรสมรรถนะสูงของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Smart Hospital : ได้รับการรับรองระดับเพชรของกระทรวงสาธารณสุข 2.1 4 ด้านโรงพยาบาล Smart Hospital ผ่านคะแนนระดับเพชร			
ตัวชี้วัดที่	OKR 78.1 ร้อยละ 100 ของ 4 หมวดโรงพยาบาล Smart Hospital มีคะแนน > ร้อยละ 90			
คำนิยาม	4 หมวดโรงพยาบาล Smart Hospital ได้แก่ 1. Smart การบริหารจัดการ (Smart Management / Back Office) 2. Smart การบริการผู้ป่วย (Smart Service / Front Office) 3. Smart การรักษาพยาบาล (Smart Clinical Support) 4. Smart โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม (Smart Infrastructure / Service Support)			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	เอกสารประกอบการประเมิน 4 ด้าน Smart Hospital ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหมวดโรงพยาบาล Smart Hospital มีคะแนน $\geq$ ร้อยละ 90 B : จำนวนหมวดโรงพยาบาล Smart Hospital ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B)*100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้อง รายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ร้อยละ 100	2571 ร้อยละ 100	2572 ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสุจิตรา นาสิงห์ขันธุ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายธวัชไชย วรรณไชย			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap 8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการการแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ)
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	จิตเวชวัยรุ่น : ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
ตัวชี้วัดที่	KPI 79 อัตรากลุ่มอายุ15-25ปี เข้าถึงบริการซึมเศร้า
คำนิยาม	วัยรุ่นในสถานศึกษา หมายถึง ผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2.อาชีวศึกษา 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4.มหาวิทยาลัยการกีฬามหาสารคาม ภาวะซึมเศร้า หมายถึง กลุ่มเป้าหมายที่เจ็บป่วยด้วยโรคจิตเวชที่มีอาการสอดคล้องตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Depressive Disorder ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ฉบับที่ 5 (DSM-5: Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders 5) และตามมาตรฐานการจำแนกโรคระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกฉบับที่ 10 (ICD – 10 : International Classification of Diseases and Health Related Problems - 10) โดยบันทึกตามรหัสโรคของ ICD10 หมวด F32.x, F33.x, F34.1, F38.x และ F39.x การเข้าถึงบริการ หมายถึง การที่กลุ่มเป้าหมายผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่า เป็นโรคซึมเศร้า ได้รับการบริการตามแนวทางการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด และแนวทางการจัดการโรคซึมเศร้าสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) หรือได้รับการช่วยเหลือตามแนวทางมาตรฐานอย่างเหมาะสม จากหน่วยบริการทุกสถานบริการของประเทศไทย
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ100
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนมัธยมศึกษา 2.อาชีวศึกษา 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4.มหาวิทยาลัยการกีฬามหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล HDC กระทรวงสาธารณสุข ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน/นักศึกษา

รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มารับบริการในหน่วยบริการสุขภาพ B = จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ที่มาจากการคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจในเขตจังหวัดมหาสารคาม (ความชุกที่ประมาณการฯ คำนวณจาก: ร้อยละ 2.7 จากจำนวนประชากร 15 ปี ขึ้นไป)			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	90	95	100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย								
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)								
Roadmap	Roadmap R8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ การแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/รอุบัติเหตุ)								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	จิตเวชวัยรุ่น : ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 1 เพิ่มความครอบคลุมการค้นหา คัดกรองภาวะซึมเศร้า								
ตัวชี้วัดที่	OKR 79.1 ร้อยละของการเพิ่มความครอบคลุมการค้นหา คัดกรองภาวะซึมเศร้า <table><tr><td>1. โรงเรียนมัธยมศึกษา</td></tr><tr><td>2. อาชีวศึกษา</td></tr><tr><td>3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</td></tr><tr><td>4. มหาวิทยาลัยการกีฬามหาสารคาม</td></tr></table>			1. โรงเรียนมัธยมศึกษา	2. อาชีวศึกษา	3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	4. มหาวิทยาลัยการกีฬามหาสารคาม		
1. โรงเรียนมัธยมศึกษา									
2. อาชีวศึกษา									
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม									
4. มหาวิทยาลัยการกีฬามหาสารคาม									
คำนิยาม	การคัดกรองภาวะซึมเศร้า หมายถึง การใช้ชุดเครื่องมือหรือการทดสอบแบบย่อ (2Q+) และเฉพาะเจาะจง (8Q,9Q) คัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1) ภาวะซึมเศร้า 2) การฆ่าตัวตาย								
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เป้าหมายหลัก : นักเรียน นักศึกษา ในสถานการศึกษา ดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 2.อาชีวศึกษา 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4.มหาวิทยาลัยการกีฬามหาสารคาม								
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล MENTAL HEALTH CHECK IN กระทรวงสาธารณสุข								
รายการข้อมูล	A = จำนวนนักเรียน นักศึกษา ในสถานการศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการคัดกรองภาวะซึมเศร้า B = จำนวนนักเรียน นักศึกษา ในสถานการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100								
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>ร้อยละ 80</td><td>ร้อยละ 90</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table>	2570	2571	2572	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100		
2570	2571	2572							
ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด									
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด									

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)		
Roadmap	Roadmap R8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ การแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/รอุบัติเหตุ)		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	จิตเวชวัยรุ่น : ซึมเศร้าเข้าถึงบริการ 2 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ขาดยา ได้รับการติดตามเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่องทุกราย		
ตัวชี้วัดที่	OKR 79.2 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นที่ขาดยาได้รับการติดตามเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง		
คำนิยาม	วัยรุ่นที่ขาดยา หมายถึง กลุ่มประชากรที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยรุ่น (โดยทั่วไปคืออายุ 10–19 ปี หรืออาจรวมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นอายุไม่เกิน 24 ปี) ที่มีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพทั้งทางกายหรือทางจิตเวช แล้วไม่สามารถเข้ารับการรักษ ได้รับยา หรือรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาที่แพทย์กำหนดไว้ได้ ในบริบททางการแพทย์และการสาธารณสุข คำว่า "ขาดยา" (Non-compliance / Non-adherence) ในกลุ่มวัยรุ่น เป็นประเด็นที่มีความซับซ้อนและท้าทายสูงมาก เนื่องจากวัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา จิตใจ สังคม และพฤติกรรมเฉพาะตัว ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ยาโดยตรง		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายโรคซึมเศร้าที่ขาดนัดไม่ได้รับยาต่อเนื่อง		
แหล่งข้อมูล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขาดยาได้รับการติดตามเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง B : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับยาทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap R8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ การแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ)			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ : สัดส่วนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล			
ตัวชี้วัดที่	KPI 80 สัดส่วนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล			
คำนิยาม	การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ หมายถึง การเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ในกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจรักษา การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องในหน่วยบริการปฐมภูมิ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	80 : 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในเขต อ.เมืองมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC , แบบคัดกรอง/เวชระเบียน ,โปรแกรม EMR			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในหน่วยบริการปฐมภูมิ B : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในโรงพยาบาลมหาสารคาม ยกเว้นผู้ป่วยส่งตรวจพิเศษ Lab X-Ray จากหน่วยปฐมภูมิ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A : B			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	70 : 30	70 : 30	80 : 20	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางรัตนา เสนาหนอก			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางรัตนา เสนาหนอก			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap R8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ การแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/โรคอุบัติเหตุ)			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ : สัดส่วนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล 3.1 DM			
ตัวชี้วัดที่	OKR 80.1 DM			
คำนิยาม	การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ หมายถึง การเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกโรค DM ในกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจรักษา การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องในหน่วยบริการปฐมภูมิ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	80 : 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในเขต อ.เมืองมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC , แบบคัดกรอง/เวชระเบียน ,โปรแกรม EMR			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรค DM ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในหน่วยบริการปฐมภูมิ B : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรค DM ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A : B			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	70 : 30	70 : 30	80 : 20	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.บรรจง จาตบุญนาค/นวก.พรวดี เทพบุตร			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พว.รัตนา เสนาหนอก			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap R8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ การแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/โรคอุบัติเหตุ)			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ : สัดส่วนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล 3.2 HT			
ตัวชี้วัดที่	OKR 80.2 HT			
คำนิยาม	การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ หมายถึง การเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกโรค HT ในกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจรักษา การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องในหน่วยบริการปฐมภูมิ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	80 : 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในเขต อ.เมืองมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC , แบบคัดกรอง/เวชระเบียน ,โปรแกรม EMR			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรค HT ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในหน่วยบริการปฐมภูมิ B : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรค HT ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A : B			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	70 : 30	70 : 30	80 : 20	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.บรรจง จาตบุญนาค/นวก.พรวิทย์ เทพบุตร			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พว.รัตนา เสนาหนอก			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap R8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ การแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/โรคอุบัติเหตุ)			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ : สัดส่วนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล 3.3 CKD			
ตัวชี้วัดที่	OKR 80.3 CKD			
คำนิยาม	การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ หมายถึง การเข้ารับบริการผู้ป่วยนอกโรค CKD ในกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจรักษา การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องในหน่วยบริการปฐมภูมิ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	80 : 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในเขต อ.เมืองมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC , แบบคัดกรอง/เวชระเบียน ,โปรแกรม EMR			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรค CKD ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในหน่วยบริการปฐมภูมิ B : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกโรค CKD ของประชาชนในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A : B			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	70 : 30	70 : 30	80 : 20	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.บรรจง จาตบุญนาค/นวก.พรวิทย์ เทพบุตร			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พว.รัตนา เสนาหนอก			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap R8 : ประชาชน 5 กลุ่มวัยเข้าถึงบริการ การแพทย์ปฐมภูมิอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครยุทธศาสตร์คุณภาพสูง ร่วมกับภาคีเครือข่าย (NCD/จิตเวชและยาเสพติด/TB/โรคอุบัติเหตุ)			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ : สัดส่วนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิต่อการเข้าถึงบริการในโรงพยาบาล 3.4 ผู้สูงอายุ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 80.4 ผู้สูงอายุ			
คำนิยาม	การเข้าถึงบริการปฐมภูมิ หมายถึง การเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก ในกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้คำปรึกษา การส่งเสริมสุขภาพ การตรวจรักษา การฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ การดูแลต่อเนื่องในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชาชนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	80 : 20			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในเขต อ.เมืองมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC , แบบคัดกรอง/เวชระเบียน ,โปรแกรม EMR			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในหน่วยบริการปฐมภูมิ B : จำนวนครั้งการใช้บริการผู้ป่วยนอกผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A : B			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	70 : 30	70 : 30	80 : 20	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.บรรจง จาตบุญนาค/นวก.พรวิทย์ เทพบุตร			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พว.รัตนา เสนาหนอก			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.1. DM/HT/Stroke/STEMI : อัตราความสำเร็จของการลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มโรค 4 โรค (DM/HT/Stroke/STEMI) ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่	KPI 81 อัตราความสำเร็จของการลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ ในกลุ่มโรค 4 โรค (DM/HT/Stroke/STEMI)
คำนิยาม	ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคเบาหวาน ในปีงบประมาณปัจจุบัน และไม่เคยไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยเบาหวานมาก่อน ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ลดลง หมายถึง จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ หมายถึง ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง และมีระดับความดันโลหิตสูงมากกว่าหรือเท่ากับ 140/90 มม.ปรอท และไม่เคยไม่ได้รับการวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมาก่อน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง หมายถึง จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในปีงบประมาณปัจจุบัน ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	อัตราป่วยรายใหม่เบาหวาน ลดลง $\geq$ ร้อยละ 5 อัตราป่วยรายใหม่เบาหวาน ลดลงร้อยละ 2.5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่อาศัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยจากโรคเบาหวาน (E10-E14) และได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าป่วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
แหล่งข้อมูล	1) โปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) 2) ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข
รายการข้อมูล 1	A1: จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณปัจจุบัน A2: จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปีงบประมาณปัจจุบัน
รายการข้อมูล 2	B1: จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าด้วยโรคเบาหวาน (E10-E14) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา B2: จำนวนผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกจากแพทย์ว่าด้วยโรคความดันโลหิตสูง (I10-I15) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$[(B1-A1)/B1] \times 100$

	[(B2-A2)/B2]×100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	Baseline data	2570	2571	2572
	อัตราป่วยรายใหม่ โรคเบาหวานลดลง	ร้อยละ 4	≥ ร้อยละ 4	≥ ร้อยละ 5
	อัตราป่วยรายใหม่ โรคความดันโลหิต สูงลดลง	ร้อยละ 2	ร้อยละ 2.5	ร้อยละ 2.5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ดร.เจษฎาภรณ์ แสนวัง /นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หัวหน้างานระบาด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนิเทศและทศวิทยานิเทศ) (Strengthening Nodes)		
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.1. DM/HT/Stroke/STEMI : อัตราความสำเร็จของการลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มโรค 4 โรค (DM/HT/Stroke/STEMI) ตามค่าเป้าหมาย 1.1.1 เพิ่มความครอบคลุมการค้นหา คัดกรอง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย		
ตัวชี้วัดที่	OKR 81.1 อัตราความครอบคลุมการค้นหา คัดกรอง ประชากรกลุ่มเป้าหมาย		
คำนิยาม	ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโรค มีดังนี้ DM/HT Stroke/STEMI วิธีการค้นหาคัดกรองในแต่ละโรค DM = HT = Stroke/STEMI =		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโรค มีดังนี้ DM/HT Stroke/STEMI		
แหล่งข้อมูล	1) โปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) 2) ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข		
รายการข้อมูล 1	A = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรอง		
รายการข้อมูล 2	B = จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ดร.เจษฎาภรณ์ แสนวัง/นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หัวหน้างานระบาด		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนิเทศและทศวรรษ) (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.1. DM/HT/Stroke/STEMI : อัตราความสำเร็จของการลดการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ในกลุ่มโรค 4 โรค (DM/HT/Stroke/STEMI) ตามค่าเป้าหมาย1.1.2 กลุ่มเสี่ยง (DM/HT/Stroke/STEMI) ได้รับการติดตามเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล (Individual Lifestyle modification)
ตัวชี้วัดที่	OKR 81.2 อัตรากลุ่มเสี่ยง (DM/HT/Stroke/STEMI) เข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล (Individual Lifestyle modification)
คำนิยาม	ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน หมายถึง ประชากรอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่มีระดับน้ำตาล ในเลือดหลังอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง $\geq 100-125$ mg/dl หรือค่าระดับน้ำตาลโดยไม่อดอาหาร $\geq 140 - 199$ mg/dl ในปีงบประมาณ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชากรอายุ 30 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูงและมีค่าความดันโลหิตตัวบนเฉลี่ย (SBP) ในช่วง 130-139 mmHg และ/หรือค่าความดันโลหิตตัวล่างเฉลี่ย (DBP) ในช่วง 85-89 mmHg ในเขตรับผิดชอบและยังไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูง ในปีงบประมาณ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรค Stroke/STEMI หมายถึง ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการคัดกรอง แล้วมี CVD Risk มากกว่า ร้อยละ 20 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior Modification) ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคหลอดเลือดเฉียบพลัน ซึ่งประกอบด้วย โรคเบาหวาน (DM), โรคความดันโลหิตสูง (HT), โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (STEMI) หมายถึง "กระบวนการปรับปรุง วางเงื่อนไข และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง" โดยเน้นการจัดการ 4 ด้านหลัก คือ อาหาร การออกกำลังกาย การจัดการความเครียด และการงดสิ่งเสพติด เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิต และไขมัน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการหยุดยั้งการดำเนินโรค ไม่ให้ผู้ป่วย DM/HT พัฒนาความรุนแรงไปเป็นโรคเฉียบพลันที่อันตรายถึงชีวิตอย่าง Stroke หรือ STEMI
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโรค มีดังนี้ DM/HT Stroke/STEMI
แหล่งข้อมูล	1) โปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC)

	2) ระบบรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข		
รายการข้อมูล 1	A : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพรายบุคคล (Individual Lifestyle modification) B : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ร้อยละ 70	2571 ≥ร้อยละ 75	2572 ≥ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ดร.เจษฎาภรณ์ แสนวัง /นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หัวหน้างานระบาด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลมหาสารคาม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐภูมิและทุติยภูมิ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.2 ERSD : ลดอัตราป่วย ESRD รายใหม่ลดลง			
ตัวชี้วัดที่	KPI 82 อัตราป่วย ESRD รายใหม่ลดลง			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะที่ 5 หมายถึง ผู้ที่มีอัตราการกรองของไต หรือ eGFR (estimated glomerular filtration rate) น้อยกว่า 15 มล./ นาทีต่อ 1.73 คำนวณ จากค่า serum creatinine ตามสมการ CKD-EPI โดยที่ยังไม่ได้รับการฟอกเลือดด้วย เครื่องไตเทียม (Hemodialysis) หรือการล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal Dialysis) หรือวินิจฉัยเป็น ผู้ป่วยภาวะ ไตวายเฉียบพลัน (Acute Kidney Injury) หรือ อยู่ ระหว่างการนอนโรงพยาบาล			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	ลดลง ≥ 2% จากค่าฐานปี 2569 ลดลง ≥ 2% จากค่าฐานปี 2570 ลดลง ≥ 2% จากค่าฐานปี 2571			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	- ประชาชนอายุ ≥ 35 ปี ในเขตรับผิดชอบ - กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DM) - กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (HT) - กลุ่มผู้ป่วย CKD ระยะ 1–4 - กลุ่ม Acute on CKD และ HT Crisis			
แหล่งข้อมูล	HDC			
รายการข้อมูล 1	B: จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 รายใหม่ ของปีงบประมาณก่อนหน้า			
รายการข้อมูล 2	A: จำนวนผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 รายใหม่ ของปีงบประมาณปัจจุบัน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(B-A)/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลง ≥ 2% จาก ค่าฐานปี 2569	ลดลง ≥ 2% จาก ค่าฐานปี 2570	ลดลง ≥ 2% จากค่า ฐานปี 2571	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	หน่วยไตเทียม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	หน่วยไตเทียม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนุญและทุติยญ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.2 ESRD : ลดอัตราป่วย ESRD รายใหม่ลดลง 1.2.1. กลุ่มผู้ป่วย DM ชะลอการเสื่อมของไต			
ตัวชี้วัดที่	OKR 82.1 อัตรากลุ่มผู้ป่วย DM ชะลอการเสื่อมของไต			
คำนิยาม	ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีการวินิจฉัยหลักหรือรอง และมีผล eGFR ติดตามอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีรหัสโรคเป็น E11 และมี E10.2, E11.2, E14.2 ร่วมกับ N18.1 – N18.5 หรือ N18.9			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	พ.ศ. 2570 ≥ 65% พ.ศ. 2571≥ 70% พ.ศ. 2572≥ 75%			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Type 1 และ Type 2) ที่ขึ้นทะเบียนรักษาในคลินิก NCD / DM Clinic มีผลตรวจ eGFR อย่างน้อย 2 ครั้ง ห่างกัน ≥ 6–12 เดือน ในผู้ป่วย CKD ระดับ 3 ขึ้น ไป เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 (เพิ่ม wording)			
แหล่งข้อมูล	HDC ทะเบียนผู้ป่วย, 43 แฟ้ม (Diagnosis E10–E14 + N18.x)			
รายการข้อมูล 1	จำนวนผู้ป่วย DM ที่มีค่า eGFR ลดลงไม่เกิน 5 ml/min/1.73m ² ต่อปี			
รายการข้อมูล 2	จำนวนผู้ป่วย DM ทั้งหมดที่มีผล eGFR อย่างน้อย 2 ครั้งในปีงบประมาณนั้น			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	ร้อยละผู้ป่วยDMชะลอการเสื่อมของไต=(จำนวนผู้ป่วยDMที่ชะลอการเสื่อมได้/จำนวน ผู้ป่วยDMทั้งหมดที่มีการติดตามeGFR)×100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ 60%	≥ 65%	≥ 70%	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	OPD-DM			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	OPD-DM			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.2 ERSD : ลดอัตราป่วย ESRD รายใหม่ลดลง 1.2.2. กลุ่มผู้ป่วย HT ชะลอการเสื่อมของไต			
ตัวชี้วัดที่	OKR 82.2 อัตรากลุ่มผู้ป่วย HT ชะลอการเสื่อมของไต			
คำนิยาม	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุม BP <130/80 mmHg และ eGFR ลดลงไม่เกิน 5 mL/min/ปี			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	พ.ศ. 2570 ≥ 65% พ.ศ. 2571 ≥ 70% พ.ศ. 2572 ≥ 75%			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย HT ใน NCD Clinic (I10, I12+N18.x)			
แหล่งข้อมูล	43 แฟ้ม / OPD MED follow-up			
รายการข้อมูล 1	ผู้ป่วย HT ควบคุม BP ได้และ eGFR ลดลงไม่เกิน 5 mL/min/ปี			
รายการข้อมูล 2	ผู้ป่วย HT ที่ติดตามครบตามเกณฑ์			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(HTควบคุมBPและชะลอไตได้/ผู้ป่วย HT ที่ติดตามครบตามเกณฑ์)*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ 60%	≥ 65%	≥ 70%	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	OPD-MED			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	OPD-MED			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนิเทศและทศิณิเทศ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราผู้ป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.2 ERSD : ลดอัตราป่วย ESRD รายใหม่ลดลง 1.2.3. กลุ่มผู้ป่วย HT Crisis ได้รับการติดตามเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่องทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 82.3 อัตรากลุ่มผู้ป่วย HT Crisis ได้รับการติดตามเข้ารับการรักษอย่างต่อเนื่อง			
ค่านิยาม	ร้อยละของผู้ป่วย HT Crisis ที่ได้รับการนัดติดตามภายใน 1 เดือน และติดตามต่อเนื่องครบ 6 เดือน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	พ.ศ. 2570 ≥ 80% พ.ศ. 2571≥ 90% พ.ศ. 2572= 100%			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่วินิจฉัย HT Crisis (SBP ≥180 หรือ DBP ≥120) (I16.x +N17.x หรือ I63.x)			
แหล่งข้อมูล	ER register / IPD / OPD follow-up record			
รายการข้อมูล 1	ผู้ป่วย HT Crisis ที่ได้รับการติดตามครบตามเกณฑ์			
รายการข้อมูล 2	ผู้ป่วย HT Crisis ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(HT Crisisที่ติดตามครบ/ผู้ป่วย HT Crisis ทั้งหมด)*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ 80%	≥ 90%	100%	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	OPD-MED			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	OPD-MED			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐภูมิและทุติยภูมิ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.2 ERSD : ลดอัตราป่วย ESRD รายใหม่ลดลง 1.2.4. กลุ่มผู้ป่วย Acute on top CKD ได้รับการวางแผนจำหน่ายและติดตามรักษาอย่างน้อย 1 ปี ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 82.4 กลุ่มผู้ป่วย Acute on top CKD ได้รับการวางแผนจำหน่ายและติดตามรักษาอย่างน้อย 1 ปี			
คำนิยาม	ร้อยละของผู้ป่วย Acute on CKD ที่มี discharge plan ชัดเจน และได้รับการติดตามต่อเนื่อง ≥ 12 เดือน (ทุก N17.x + N18.x จึงจัดเป็น Acute on CKD โดยไม่กำหนดการรักษาด้วย RRT) โดยการจัดเป็น Acute on CKD ต้องมีการบันทึกรหัส N17.x และ N18.x ในการวินิจฉัยครั้งเดียวกัน หรือภายในช่วงการรักษาเดียวกัน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	พ.ศ. 2570 $\geq 80\%$ พ.ศ. 2571 $\geq 90\%$ พ.ศ. 2572 $\geq 95\%$			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Acute on CKD Admit ทุกสิทธิการรักษา ที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	43 แฟ้ม/ CKD clinic follow-up			
รายการข้อมูล 1	ผู้ป่วย Acute on CKD ที่มี discharge plan และติดตามครบ ≥ 1 ปี			
รายการข้อมูล 2	ผู้ป่วย Acute on CKD ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(Acute on CKDติดตามครบ /ผู้ป่วย Acute on CKD ทั้งหมด)*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	$\geq$ ร้อยละ 80	$\geq$ ร้อยละ 85	$\geq$ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	IPD-MED			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	IPD-MED			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนุฎิและทุติยภูมิจิ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. SMI-V : ลดอัตราผู้เสพติดเสพติดที่อยู่ในระบบการรักษา ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน			
ตัวชี้วัดที่	KPI 83 อัตราผู้เสพติดเสพติดที่อยู่ในระบบการรักษา ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน ลดลง			
คำนิยาม	ผู้เสพติดเสพติดที่อยู่ในระบบการรักษา หมายถึง บุคคลที่มีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และได้ผ่านกระบวนการคัดกรองเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา พันฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ในสถานพยาบาลหรือศูนย์บำบัดที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย โดยอยู่ภายใต้การดูแลติดตามของบุคลากรทางการแพทย์และทีมสหวิชาชีพอย่างเป็นระบบ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เสพติดเสพติดที่อยู่ในระบบการรักษา ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน			
แหล่งข้อมูล	1. HDC 2. ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาล			
รายการข้อมูล	A= จำนวนผู้เสพติดเสพติดที่อยู่ในระบบการรักษา ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมา B= จำนวนผู้เสพติดเสพติดที่อยู่ในระบบการรักษา ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สินในปีปัจจุบัน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/A*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี	ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี	ลดลงร้อยละ 20 ต่อปี	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.ชโลธร โกสาทอง			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	อจ.ทอง/แพทย์ปฐมนุฎิ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนิเทศและทศวรรษ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. SMI-V : ลดอัตราการทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน 2.1. ผู้เสพสารเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัดเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 83.1 อัตราผู้เสพสารเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัด			
คำนิยาม	ผู้เสพสารเสพติดสมัครใจเข้ารับการบำบัด หมายถึง ผู้เสพสารเสพติดทุกระดับความรุนแรงที่เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ของสถานพยาบาลยาเสพติดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด เฉพาะระบบสมัครใจ ในสถานพยาบาลยาเสพติด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรายงานข้อมูลการบำบัดรักษา ในฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดในประเทศไทย (บสต.)			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาล			
รายการข้อมูล	A= จำนวนผู้เสพสารเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการบำบัด B= จำนวนผู้เสพสารเสพติดที่อยู่ในระบบทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.ชลธร โกสาทอง			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	อจ.ทอง/อจ.ปฐมนิเทศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนิเทศและทศุติยภูมิ) (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. SMI-V : ลดอัตราการทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น และทำลายทรัพย์สิน 2.2 ผู้เสพสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดจนครบ ไม่กลับไปเสพซ้ำภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 83.2 อัตราผู้เสพสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดจนครบ ไม่กลับไปเสพซ้ำภายใน 1 ปี
คำนิยาม	ผู้เสพสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดจนครบ ไม่กลับไปเสพซ้ำ ภายใน 1 ปี หมายถึง ดัชนีชี้วัดความสำเร็จสูงสุด (Ultimate Outcome) ของกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยนับบุคคลที่ผ่านเงื่อนไขสำคัญ 2 ประการร่วมกัน คือ: 1. ด้านกระบวนการ (Process): ได้เข้ารับการบำบัดรักษาครบถ้วนตามเกณฑ์ และระยะเวลาที่แพทย์หรือโปรแกรมการรักษากำหนด (Complete Treatment) ไม่ว่าจะเป็นระบบสมัครใจ บังคับบำบัด หรือต้องโทษ 2. ด้านผลลัพธ์ (Outcome): เมื่อจำหน่ายออกจากระบบการรักษาแล้ว มีการติดตามดูแลในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ (เช่น ผลการตรวจปัสสาวะ หรือการประเมินทางคลินิก) ยืนยันว่า "ไม่มีการหวนกลับไปใช้สารเสพติดซ้ำอีกเลย (Continuous Abstinence)" เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 1 ปี (12 เดือน) นับจากวันที่สิ้นสุดการบำบัด *การดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือ บำบัดฟื้นฟูอย่างรอบด้านทั้งด้านกาย จิต สังคม อย่างต่อเนื่องตามสภาพปัญหาของผู้ป่วยเฉพาะราย ตั้งแต่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูจนถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือตามเกณฑ์มาตรฐาน หลังการบำบัดอย่างน้อย 1 ปี
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้เสพสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดในระบบ
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลการบำบัดรักษายาเสพติดของประเทศ (บสต.) ซึ่งรายงานข้อมูลการบำบัดรักษาจากสถานพยาบาล
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้เสพสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดจนครบ ไม่กลับไปเสพซ้ำ ภายใน 1 ปี B = จำนวนผู้เสพสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดในระบบทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พว.ชลธร โกสาทอง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	อจ.ทอง/อจ.ปฐมภูมิ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนุภูมิและทุติยภูมิ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. TB : อุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรค ไม่เกิน 75 ต่อแสนประชากร ในปี 2572			
ตัวชี้วัดที่	KPI 84 อุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรค			
คำนิยาม	อุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรคต่อแสนประชากร หมายถึง จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนใหม่ในปีงบประมาณนั้น หารด้วยจำนวนประชากรกลางปี คูณด้วย100,000			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ไม่เกิน 75 ต่อแสนประชากร			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยวัณโรคอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1. โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลวัณโรคแห่งชาติ หรือโปรแกรม National Tuberculosis Information Program (NTIP) 2. ฐานข้อมูลประชากร			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนใหม่ในปีงบประมาณนั้น B : จำนวนประชากรกลางปี			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100,000			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ไม่เกิน 125 ต่อแสนประชากร	ไม่เกิน 100 ต่อแสนประชากร	ไม่เกิน 75 ต่อแสนประชากร	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรุ่งลาวัลย์ ไลออน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ศิโรตม์ จันทรักษา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐภูมิและทุติยภูมิ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครุยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. TB : ลดอัตราอุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรคปอด 3.1. เพิ่มอัตราความครอบคลุมการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค			
ตัวชี้วัดที่	OKR 84.1 อัตราความครอบคลุมการคัดกรอง 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค			
คำนิยาม	คัดกรองวัณโรค หมายถึง การตรวจคัดกรองวัณโรคด้วยเอกซเรย์ทรวงอกในประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง ดังนี้ ร้อยละ 90 1.1 ผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรค 1.2 ผู้ติดเชื้อ HIV 1.3 ผู้ป่วยเบาหวานที่มี HbA1c ≥ 7 , ผู้ป่วยโรค CKD Stage 3 ขึ้นไป 1.4 ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปี ที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) หรือมีโรคเบาหวานร่วมด้วย 1.5 ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 1.6 บุคลากรสาธารณสุข 1.7 ผู้ต้องขังเรือนจำ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรค อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1.โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลวัณโรคแห่งชาติ หรือโปรแกรม National Tuberculosis Information Program (NTIP) 2. HIS			
รายการข้อมูล	A : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 7 กลุ่มที่ได้รับการคัดกรองวัณโรคด้วยเอกซเรย์ทรวงอก B : จำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายทั้งหมด 7 กลุ่ม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนิเทศและทศวรรษ) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. TB : อุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรคปอด ไม่เกิน 75 ต่อแสนประชากร ในปี 2572 3.2. กลุ่มสงสัยผู้ป่วยวัณโรคปอด (CXR ผิดปกติ) ได้รับการตรวจเสมหะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค			
ตัวชี้วัดที่	OKR 84.2 อัตรากลุ่มสงสัยผู้ป่วยวัณโรคปอด (CXR ผิดปกติ) ที่ได้รับการตรวจเสมหะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค			
คำนิยาม	กลุ่มสงสัยผู้ป่วยวัณโรคปอด (CXR ผิดปกติ) หมายถึง กลุ่มที่เข้ารับการคัดกรองด้วยเอกซเรย์ทรวงอกในประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง ที่มีผลการตรวจด้วยเอกซเรย์ทรวงอกผิดปกติที่เข้าได้กับโรควัณโรคปอด การตรวจเสมหะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค หมายถึง การตรวจเสมหะด้วยวิธี AFB หรือการตรวจทางอณูชีววิทยา (Molecular test)			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มที่เข้ารับการคัดกรองด้วยเอกซเรย์ทรวงอกในประชากร 7 กลุ่มเสี่ยง ที่มีผลการตรวจด้วยเอกซเรย์ทรวงอกผิดปกติที่เข้าได้กับโรควัณโรคปอด			
แหล่งข้อมูล	1.โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลวัณโรคแห่งชาติ หรือโปรแกรม National Tuberculosis Information Program (NTIP) 2. HIS			
รายการข้อมูล	A : จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยผู้ป่วยวัณโรคปอด (CXR ผิดปกติ) ที่ได้รับการตรวจเสมหะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค B : จำนวนประชากรกลุ่มสงสัยผู้ป่วยวัณโรคปอด (CXR ผิดปกติ) ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรุ่งลาวัลย์ ไลออน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ศิริโรจน์ จันทรักษา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนุญและทุติยญ) (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. TB : ลดอัตราอุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรคปอด 3.3 กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อวัณโรค (LTBI) ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง (TB Preventive Treatment, TPT)
ตัวชี้วัดที่	OKR 84.3 กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อวัณโรค (LTBI) ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง (TB Preventive Treatment, TPT)
คำนิยาม	กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อวัณโรค (LTBI) หมายถึง 1. ผู้ป่วย HIV ทุกรายที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยวัณโรคและไม่เคยรักษาวัณโรคระยะแฝงมาก่อน ที่ได้รับการคัดกรองแล้วว่าไม่เป็นวัณโรคปอดและมีผลการตรวจ TST หรือ IGRAs ให้ผลลบ 2. ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคทุกราย ที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยวัณโรคและไม่เคยรักษาวัณโรคระยะแฝงมาก่อน ที่ได้รับการคัดกรองแล้วว่าไม่เป็นวัณโรคปอดและมีผลการตรวจ TST หรือ IGRAs ให้ผลลบ 3. ผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค ทุกราย ที่มีอายุ < 5 ปี ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยวัณโรคและไม่เคยรักษาวัณโรคระยะแฝงมาก่อน ที่ได้รับการคัดกรองแล้วว่าไม่เป็นวัณโรคปอด การรักษาวัณโรคระยะแฝง (TB Preventive Treatment, TPT) หมายถึง การใช้ยาปฏิชีวนะตามสูตรยารักษาวัณโรคระยะแฝง เพื่อกำจัดเชื้อในร่างกาย ป้องกันไม่ให้ก่อโรคในอนาคต
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชากรที่ติดเชื้อวัณโรค (LTBI)
แหล่งข้อมูล	1.โปรแกรมการบริหารจัดการข้อมูลวัณโรคแห่งชาติ หรือโปรแกรม National Tuberculosis Information Program (NTIP) 2. HIS
รายการข้อมูล	A : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อวัณโรค (LTBI) ได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝง (TB Preventive Treatment, TPT) B :จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อวัณโรค (LTBI) ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวรุ่งลาวัลย์ ไลออน / पीत่าย			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ศิริโรตม์ จันทรักษา / อจ.ชมพู่			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (ปฐมนุฎิและทฤษฎี) (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap 9 : ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครยุทธศาสตร์ที่สำคัญ			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. ลดอัตราป่วยรายใหม่ในโรครยุทธศาสตร์ที่สำคัญ 2.1. NCDs 2.2. จิตเวชและยาเสพติด 2.3. TB 2.4. อุบัติเหตุ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. TB : อุบัติการณ์การเกิดผู้ป่วยวัณโรค ไม่เกิน 75 ต่อแสนประชากร ในปี 2572 3.4 ไม่พบอุบัติการณ์การการเป็นโรควัณโรคระบบทางเดินหายใจ จากการทำงานของบุคลากร			
ตัวชี้วัดที่	OKR 84.4 อุบัติการณ์การเป็นโรควัณโรคระบบทางเดินหายใจ จากการทำงานของบุคลากร			
คำนิยาม	อุบัติการณ์การเป็นโรควัณโรคระบบทางเดินหายใจจากการทำงานของบุคลากร คือ การวัดความถี่ของการเป็นโรควัณโรคระบบทางเดินหายใจในบุคลากรที่มีการสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคระบบทางเดินหายใจระยะแพร่กระจายเชื้อ บุคลากรโรงพยาบาล คือ บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม ทุกประเภทการจ้างงานที่มีการติดเชื้อวัณโรคในระหว่างการปฏิบัติงาน โดยมีการสอบสวนโรคโดยคณะกรรมการ และลงความเห็นว่าเป็นการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน วัณโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การได้รับการวินิจฉัยเป็นโรควัณโรคที่กล่อกเสี่ยงหลอดลม ปอด			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1. การสอบสวนโรค (งาน IC ระบาด อาชีวเวชกรรม) 2. การตรวจรักษาในคลินิก (อายุรกรรม วัณโรค) 3. คณะกรรมการดำเนินงานวัณโรคในบุคลากร			
รายการข้อมูล	A : จำนวนบุคลากรที่เป็นโรควัณโรคระบบทางเดินหายใจ จากการทำงาน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 2	เท่ากับ 1	เท่ากับ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางประนอมพร ตุ่มอูญ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.มารุต ตำหนักโพธิ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)		
Roadmap	Roadmap 10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พชอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. อสม.สามารถจัดการปัญหาสุขภาพในครัวเรือนในคุ่มสุขภาพที่รับผิดชอบได้เพิ่มขึ้น (DM/HT/Stroke/STEMI/CKD/TB/ อุบัติเหตุ/จิตเวชและยาเสพติด)		
ตัวชี้วัดที่	KPI 85 อสม. สามารถจัดการปัญหาสุขภาพในครัวเรือนในคุ่มสุขภาพที่รับผิดชอบ		
คำนิยาม	อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) จัดการปัญหาสุขภาพในครัวเรือนโดยการเป็น "หมอคนที่ 1" ซึ่งเป็นผู้คัดกรอง ประเมินความเสี่ยง และส่งเสริมสุขภาพะชั้นพื้นฐานในชุมชน ผ่านการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ติดตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชัน "สมาร์ท อสม." เป็นเครื่องมือหลักในการทำงานและบันทึกข้อมูล การจัดการปัญหาสุขภาพในครัวเรือน ประกอบด้วย 4 ข้อดังต่อไปนี้ 1. คัดกรองและประเมินสุขภาพ 2. ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4. ติดตามเยี่ยมบ้าน ปัญหาสุขภาพ ได้แก่ DM/HT/Stroke/STEMI/CKD/TB/จิตเวชและยาเสพติด		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รับผิดชอบในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	1. Dashboard Smart อสม. 2. ระบบรายงาน Health Station		
รายการข้อมูล	A= จำนวนอสม.ที่สามารถจัดการปัญหาสุขภาพในครัวเรือนในคุ่มสุขภาพที่รับผิดชอบได้ตามเกณฑ์ B= จำนวนอสม.ทั้งหมดในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ80	ร้อยละ90	ร้อยละ100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริธร พลไชย		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พชอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. อสม.สามารถจัดการปัญหาสุขภาพในครัวเรือนในคุ้มสุขภาพที่รับผิดชอบได้เพิ่มขึ้น (DM/HT/Stroke/STEMI/CKD/TB/ อุบัติเหตุ/จิตเวชและยาเสพติด) 1.1 อสม.ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการ 8 โรคเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 85.1 อสม. ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการ 8 โรค			
คำนิยาม	อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ได้รับการพัฒนาสมรรถนะพัฒนาสมรรถนะในการจัดการ 8 โรค DM/HT/Stroke/STEMI/CKD/TB/ อุบัติเหตุ/จิตเวช และยาเสพติดผ่าน หลักสูตรและการอบรม เพื่อยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นพัฒนา ความรู้ ทักษะ ทศนคติ และพฤติกรรม ให้ครอบคลุมการดูแลปัญหาสุขภาพประกอบด้วย 4 ข้อดังต่อไปนี้ 1. คัดกรองและประเมินสุขภาพ 2. ให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ 3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 4. ติดตามเยี่ยมบ้าน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายสุขภาพในชุมชน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ในอำเภอเมืองมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1.รายงาน Health Station 2. ทะเบียนการพัฒนาศักยภาพ อสม. 8 โรค			
รายการข้อมูล	A= จำนวนอสม. ที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการ 8 โรค B= จำนวน อสม. อำเภอเมืองมหาสารคาม ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 80	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริธร พลไชย			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พชอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Care giver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)/พระคิลานุปัฏฐาก/ผู้ช่วยพยาบาล : สามารถดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) และมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ดีขึ้น
ตัวชี้วัดที่	KPI 86 Care giver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)/พระคิลานุปัฏฐาก/ผู้ช่วยพยาบาล : สามารถดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) และมีความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ดีขึ้น
คำนิยาม	1.Care giver หมายถึง ผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมอนามัย หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานรัฐ จำนวน 70 ชั่วโมง เพื่อให้มีทักษะความรู้ในการดูแลช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน 2.อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.) หมายถึง บุคคลที่ทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงระยะยาว ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด 3.พระคิลานุปัฏฐาก หมายถึง พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำวัด (อสว.) เป็นพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพของชุมชนและสังคม มีหน้าที่ปฏิบัติดูแลพระสงฆ์อาพาธ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรคและการจัดการปัจจัยที่คุกคามสุขภาพพระสงฆ์ พระสงฆ์ที่จะเป็นพระคิลานุปัฏฐาก ต้องผ่านการอบรม โดยกระทรวงสาธารณสุข 4.ผู้ช่วยพยาบาล หมายถึง.... 5.กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) หมายถึง ประชาชนที่มีค่าคะแนนการประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 11 คะแนน โดยแบ่งเป็นกลุ่มติดบ้าน มี ADL 5 - 11 คะแนน และกลุ่มติดเตียง มี ADL 0 - 4 คะแนน (คะแนนเต็ม ADL = 20 คะแนน) 6. ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) ดีขึ้น หมายถึง มีค่าคะแนน/ประเมินความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (ADL) เพิ่มขึ้น ≥ 1 คะแนนหลังได้รับการดูแลเป็นเวลา 10 เดือน
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 30
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคาม

แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล HDC จังหวัดมหาสารคาม รายงานการเปลี่ยนแปลงคะแนน ADL จากกองทุน Long term care		
รายการข้อมูล	A = จำนวนกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ที่มีค่า ADL เพิ่มขึ้น B = จำนวนกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B* 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 20	ร้อยละ 25	ร้อยละ 30
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางวิศรดา ตีเมืองชัย/นายปรเมศร์ ปุริยะ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวิศรดา ตีเมืองชัย		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย			
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)			
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พชอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Care giver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)/พระคิลานุปัฏฐาก/1 ตำบลต่อ 1 ผู้ช่วยพยาบาล : สามารถดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้เพิ่มขึ้น 2.1 ความครอบคลุมของ Care giver ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนด			
ตัวชี้วัดที่	OKR 86.1 ความครอบคลุมของ Care giver ได้สัดส่วนตามเกณฑ์ที่กำหนด			
คำนิยาม	ความครอบคลุมของ Care giver หมายถึง Care giver 1 คน ต่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL < 12) 6 คน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	Care giver ในเขตอำเภอเมือง มหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนรายชื่อ/จำนวนกลุ่มผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ผ่านการอบรม			
รายการข้อมูล	A = จำนวน Care giver ทั้งหมด B = จำนวน Care giver ตามเกณฑ์ที่กำหนด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 70	ร้อยละ 75	ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางวิศรดา ตีเมืองชัย			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวิศรดา ตีเมืองชัย			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพโรครุยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)		
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พชอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. Care giver/อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (อสบ.)/พระคิลาณุปัฏฐาก/1 ตำบลต่อ 1 ผู้ช่วยพยาบาล : สามารถดูแลกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นได้เพิ่มขึ้น 2.2 กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคลเพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 86.2 กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล		
คำนิยาม	แผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) หมายถึง แบบการวางแผนการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจาก Care Manager ทีมผู้เชี่ยวชาญ ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามโปรแกรม 3 C ของกรมอนามัย โดยผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถรับรู้ถึงความช่วยเหลือจากทีมผู้ให้การดูแลที่เกี่ยวข้อง		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ของอำเภอเมืองมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูล LTC ของกรมอนามัย		
รายการข้อมูล	A = กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ได้รับการดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล B = กลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง (ADL <12) ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางวิศรดา ดีเมืองชัย		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวิศรดา ดีเมืองชัย		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_ พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายคู่มือความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พชอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. พชจ./อบจ./สสจ./พชอ./ศปถ./สถาบันการศึกษามีการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสุขภาพ 8 โรคใน 3 ชุมชนโยบาย (อายุยืน/เมืองน่าอยู่)
ตัวชี้วัดที่	KPI 87 ระดับความสำเร็จของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพระดับอำเภอประกาศนโยบาย พชอ. 8 โรคในชุมชนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่
คำนิยาม	ภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ หมายถึง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน นโยบาย พชอ. 8 โรค หมายถึง นโยบาย 8 โรคสำคัญ (DM/HT/Stroke/STEMI/CKD/TB/ อุบัติเหตุทางถนน/จิตเวชและยาเสพติด) สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแต่ละระดับมีการดำเนินงานดังนี้ ระดับ 1 มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ/ตำบล ระดับ 2 มีการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้มีการวิเคราะห์ปัญหา จัดทำแผนแก้ไข ปัญหา 8 โรคสำคัญ กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ทุกปี ระดับ 3 ดำเนินการตามแผนแก้ไขปัญหา 8 โรคสำคัญ มีการบูรณาการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ เช่น กองทุนสุขภาพตำบล งบประมาณจากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ระดับ 4 มีการสรุป ถอดบทเรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน 8 โรคสำคัญใน และประกาศเป็นนโยบายพชอ. ระดับ 5 มีผลลัพธ์ตัวชี้วัด 8 โรคสำคัญ ผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (**ผลลัพธ์ 8 โรค) ชุมชนโยบายอายุยืน หมายถึง ประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 โดยในประเด็นที่ ๑ คนมหาสารคามทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตดีมีอายุยืนยาว (4 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด) 1) เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and Rehabilitation: CBTx)/เพื่อลดความเสี่ยงจากผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V) และเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี ด้วย TO BE NUMBER ONE จำนวน 3 ตัวชี้วัด

	2) เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่สำคัญของพื้นที่คุ้มครองให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรและกองทุนท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย จำนวน 13 ตัวชี้วัด 2.1) เพื่อกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน 4 ตัวชี้วัด 2.2) เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ตัวชี้วัด 2.3) เพื่อการป้องกันควบคุมโรควัณโรคจำนวน 3 ตัวชี้วัด 2.4) เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำนวน 1 ตัวชี้วัด 2.5) เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีจำนวน 1 ตัวชี้วัด 2.6) เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรจำนวน 2 ตัวชี้วัด 2.7) เพื่อให้กองทุนท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ตัวชี้วัด 3) เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและการดูแลกลุ่มเปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุจำนวน 3 ตัวชี้วัด 4) เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ชุดนโยบายเมืองน่าอยู่ หมายถึง ประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 โดยประเด็นที่ 2มหาสารคามเมืองน่าอยู่สู่จังหวัดสุขภาพดี (Healthy Province) (เมืองปลอดภัย เมืองสะอาด เมืองสีเขียว และเมืองสุขภาพดี)(จำนวน 5 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด) 1) เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และใช้หมวกกันน็อก 100%จำนวน 6 ตัวชี้วัด 2) เป้าประสงค์ที่ 2เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองสะอาดและบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี จำนวน 2 ตัวชี้วัด 3) เป้าประสงค์ที่ 3เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองสีเขียว โดยการเพิ่มป่าชุมชน การเพิ่มต้นไม้แห่งแผ่นดินสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี(ปอดชุมชน)และสร้างสวนครัวรั้วกินได้จำนวน 4 ตัวชี้วัด 4) เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองสุขภาพดี จำนวน 3 ตัวชี้วัด 5) เป้าประสงค์ที่ 5เพื่อให้พระสงฆ์เมืองมหาสารคามสุขภาพดีจำนวน 3 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	8 โรคสำคัญผ่าน ระดับ 5

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ รพ.เป็นผช.เลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ (ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. รพ.สต. โรงเรียน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย สถานีตำรวจ เกษตร ปศุสัตว์ พัฒนาชุมชน รพ.) ตัวแทนจากภาคประชาชน (อสม. วัด กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ) โดยมีนายกอบต./กำนัน เป็นประธาน ผู้แทนจากสาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ			
แหล่งข้อมูล	1.แบบรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 8 โรคสำคัญ 2.แบบสรุปการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ			
รายการข้อมูล	A : ระดับความสำเร็จของภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพระดับอำเภอประกาศนโยบายพขอ. 8 โรคในชุดนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	4 โรคสำคัญ ผ่าน ระดับ 5	6 โรคสำคัญ ผ่าน ระดับ 5	8 โรคสำคัญ ผ่าน ระดับ 5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	เลขาฯ อนุคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 8 โรคสำคัญ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์ นักสาธารณสุขชำนาญการ รพ.มหาสารคาม นายยุทธพงษ์ เชาวน์สันเทียะ นักสาธารณสุขชำนาญการ สสอ.เมือง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พขอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. พขจ./อบจ./สสจ./พขอ./ศปถ./สถาบันการศึกษามีการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสุขภาพ 8 โรคใน 3 ชุตนโยบาย (อายุยืน/เมืองน่าอยู่/เด็กอัจฉริยะ) 3.1 ชุตอายุยืนยาว : 8 โรคสำคัญ
ตัวชี้วัดที่	OKR 87.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนปัญหาสุขภาพ 8 โรคที่สำคัญในชุนนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่
คำนิยาม	การจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนปัญหาสุขภาพ 8 โรคสำคัญในชุนนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่ หมายถึง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการดำเนินงานแก้ปัญหาสุขภาพ 8 โรคสำคัญ (DM/HT/Stroke/STEMI/CKD/TB/ อุบัติเหตุทางถนน/จิตเวชและยาเสพติด) แต่ละปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และบรรลุตัวชี้วัด โดยแต่ละระดับมีการดำเนินงานดังนี้ ระดับ 1 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา 8 โรคสำคัญระดับอำเภอ ระดับ 2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาผลการดำเนินงาน 8 โรคสำคัญ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ทุก 3 เดือน ระดับ 3 มีการบูรณาการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณ เช่น กองทุนสุขภาพตำบล งบประมาณจากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ระดับ 4 นำข้อเสนอแนะ ไปปรับใช้ในพื้นที่ และหา Best Practice ในพื้นที่ ระดับ 5 มีการสรุป ถอดบทเรียน และนำเข้า พขอ. เพื่อกำหนดเป็นชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนปัญหาสุขภาพ 8 โรคสำคัญในชุนนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่ ชุนนโยบายอายุยืน หมายถึง ประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 โดยในประเด็นที่ ๑ คนมหาสารคามทุกช่วงวัยคุณภาพชีวิตดีมีอายุยืนยาว (4 เป้าประสงค์ 21 ตัวชี้วัด) 1) เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Based Treatment and Rehabilitation: CBTx)/เพื่อลดความเสี่ยงจากผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (Serious Mental Illness with High Risk to Violence: SMI-V) และเพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี ด้วย TO BE NUMBER ONE จำนวน 3 ตัวชี้วัด 2) เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคที่สำคัญของพื้นที่คุ้มครองให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรและกองทุนท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย จำนวน 13 ตัวชี้วัด

	2.1) เพื่อกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน 4 ตัวชี้วัด 2.2) เพื่อการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจำนวน 1 ตัวชี้วัด 2.3) เพื่อการป้องกันควบคุมโรควัณโรคจำนวน 3 ตัวชี้วัด 2.4) เพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จำนวน 1 ตัวชี้วัด 2.5) เพื่อให้สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารีจำนวน 1 ตัวชี้วัด 2.6) เพื่อคุ้มครองให้ประชาชนปลอดภัยจากการใช้ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรจำนวน 2 ตัวชี้วัด 2.7) เพื่อให้กองทุนท้องถิ่น (กปท.) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัยในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับตำบลอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 1 ตัวชี้วัด 3) เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวและการดูแลกลุ่มเปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้สูงอายุจำนวน 3 ตัวชี้วัด 4) เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง จำนวน 2 ตัวชี้วัด ชุดนโยบายเมืองน่าอยู่ หมายถึง ประเด็นหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดมหาสารคาม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 โดยประเด็นที่ 2 มหาสารคามเมืองน่าอยู่สู่จังหวัดสุขภาพดี (Healthy Province) (เมืองปลอดภัย เมืองสะอาด เมืองสีเขียว และเมืองสุขภาพดี)(จำนวน 5 เป้าประสงค์ 18 ตัวชี้วัด) 1) เป้าประสงค์ที่ 1 เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และใช้หมวกกันน็อก 100%จำนวน 6 ตัวชี้วัด 2) เป้าประสงค์ที่ 2 เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองสะอาดและบริหารจัดการขยะเปียกลดโลกร้อนได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี จำนวน 2 ตัวชี้วัด 3) เป้าประสงค์ที่ 3 เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองสีเขียว โดยการเพิ่มป่าชุมชน การเพิ่มต้นไม้แห่งแผ่นดินสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี(ปอดชุมชน)และสร้างสวนครัวรั้วกินได้จำนวน 4 ตัวชี้วัด 4) เป้าประสงค์ที่ 4 เพื่อให้มหาสารคามเป็นเมืองสุขภาพดี จำนวน 3 ตัวชี้วัด 5) เป้าประสงค์ที่ 5 เพื่อให้พระสงฆ์เมืองมหาสารคามสุขภาพดีจำนวน 3 ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	8 โรคสำคัญผ่าน ระดับ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา 8 โรคสำคัญระดับอำเภอ ประกอบด้วยภาครัฐ (ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เทศบาล รพ.สต. โรงเรียน สถานีดารวจ รพ.) ตัวแทนจากภาคประชาชน (อสม. วัด กลุ่มสตรี ชมรมผู้สูงอายุ) โดยมีผู้บริหารจาก รพ./สสอ. เป็นประธาน ผู้แทนจาก รพ./สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ
แหล่งข้อมูล	1.แบบสรุปรายการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 8 โรคสำคัญ

รายการข้อมูล	A: ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนปัญหาสุขภาพ 8 โรคที่สำคัญในชุดนโยบายอายุยืน/เมืองน่าอยู่			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	4 โรคสำคัญ ผ่าน ระดับ 5 ภายใน Q2	6 โรคสำคัญ ผ่าน ระดับ 5 ภายใน Q2	8 โรคสำคัญ ผ่าน ระดับ 5 ภายใน Q2	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	เลขาฯ อนุคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสุขภาพ 8 โรคสำคัญ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์ /นายยุทธพงษ์ เชาวสันเทียะ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พขอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. พขจ./อบจ./สสจ./พขอ./ศปถ./สถาบันการศึกษามีการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสุขภาพ 8 โรครใน 3 ชุตนโยบาย (อายุยืน/เมืองน่าอยู่/เด็กอัจฉริยะ) 3.2 ชุตเมืองน่าอยู่ : จุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
ตัวชี้วัดที่	OKR 87.2 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่
คำนิยาม	การจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่ หมายถึง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่ แต่ละปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และบรรลุตัวชี้วัด โดยแต่ละระดับมีการดำเนินงานดังนี้ ระดับ 1 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่ระดับอำเภอ ระดับ 2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ผลการดำเนินงานจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ทุก 3 เดือน ระดับ 3 นำข้อเสนอแนะ ไปขยายผลในพื้นที่ ระดับ 4 มีการบูรณาการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ เช่น กองทุนสุขภาพตำบล งบประมาณจากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เป็นต้น ระดับ 5 มีการสรุป ถอดบทเรียน และนำเข้า พขอ. เพื่อกำหนดเป็นชุดข้อเสนอเชิงนโยบายจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ระดับ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย ภาครัฐ (ปลัดฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล รพ.สต. สถานศึกษา สถานีตำรวจ แขวงทางหลวง รพ.) ตัวแทนจากภาคประชาชน (อสม. ชมรมนิสิตนักศึกษา) ตัวแทนจากภาคเอกชน บริษัทกลาง) โดยมีผู้บริหารจาก รพ./สสอ. เป็นประธาน ผู้แทนจาก รพ./สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ
แหล่งข้อมูล	1.แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุของ ER

	2.แบบสรุปการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็น เมืองน่าอยู่		
รายการข้อมูล	A : ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิด อุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	เลขาฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซ้ำในประเด็นเมืองน่าอยู่		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M4_พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพโรคยุทธศาสตร์คุณภาพสูงร่วมกับภาคีเครือข่าย
ประเด็นยุทธศาสตร์	ST : ยกระดับคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (Strengthening Nodes)
Roadmap	Roadmap R10 : ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพเข้มแข็งและเป็นหุ้นส่วนในการจัดการสุขภาพระดับพื้นที่ (NCDs/จิตเวชและยาเสพติด/TB/อุบัติเหตุ) 3.1. อสม./ผู้ดูแล/นักบริบาล 3.2. พขอ./ศปถ. 3.3. แกนนำสุขภาพชุมชนอื่นๆ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. พขจ./อบจ./สสจ./พขอ./ศปถ./สถาบันการศึกษามีการขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสุขภาพ 8 โรคใน 3 ชุตนโยบาย (อายุยืน/เมืองน่าอยู่/เด็กอัจฉริยะ) 3.3 ชุตเด็กอัจฉริยะ : มหัทศจรย์ 2,500 วัน
ตัวชี้วัดที่	OKR 87.3 ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ
คำนิยาม	การจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ หมายถึง ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการดำเนินงานขับเคลื่อนมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ แต่ละปี เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง และบรรลุตัวชี้วัด โดยแต่ละระดับมีการดำเนินงานดังนี้ ระดับ 1 มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ ระดับอำเภอ ระดับ 2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ผลการดำเนินงานนโยบายมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ทุก 3 เดือน ระดับ 3 นำข้อเสนอแนะ ไปขยายผลในพื้นที่ ระดับ 4 มีการบูรณาการงบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่างๆ เช่น กองทุนสุขภาพตำบล งบประมาณจากโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท เป็นต้น ระดับ 5 มีการสรุป ถอดบทเรียน และนำเข้า พขอ. เพื่อกำหนดเป็นชุดข้อเสนอเชิงนโยบายนโยบายมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ระดับ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ ระดับอำเภอประกอบด้วย ภาคีรัฐ (ปลัดฝ่ายทะเบียน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เทศบาล รพ.สต. สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) ตัวแทนจากภาคประชาชน (อสม. ตัวแทนผู้ประกอบการ ตัวแทนผู้สูงอายุ) โดยมีผู้บริหารจาก รพ./สสอ. เป็นประธาน ผู้แทนจาก รพ./สาธารณสุขอำเภอเป็นเลขานุการ
แหล่งข้อมูล	แบบสรุปการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายมหัทศจรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ

รายการข้อมูล	A : ระดับความสำเร็จในการจัดทำชุดข้อเสนอเชิงนโยบายมหัศจรรย์ 2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะระดับที่ 5			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	เลขาฯ คณะกรรมการขับเคลื่อนมหัศจรรย์2,500 วันในประเด็นเด็กอัจฉริยะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์ นักสาธารณสุขชำนาญการ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.1. RSQ : อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 3 ขึ้นไปลดลง
ตัวชี้วัดที่	KPI 88 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 3 ขึ้นไป
คำนิยาม	อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี้) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น F: (เยียวยาวนาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวรหรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการปัม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ ความเสี่ยงระดับ 1-5 คือ 1 : เกิดความผิดพลาดขึ้นแต่ไม่มีผลกระทบต่อผลสำเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการทำงาน (ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า 90%) หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ ไม่เกิน 1.5 เดือน หรือ ผลกระทบด้านการเงินมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 บาท

	2 : เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว โดยมีผลกระทบ (ที่ควบคุมได้) ต่อผลสำเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน (ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 81 - 90%) หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 1.5 - 3 เดือน หรือ ผลกระทบด้านการเงินมีมูลค่า 10,001 – 100,000 บาท 3 : เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลกระทบ (ที่ต้องทำการแก้ไข) ต่อผลสำเร็จหรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน (ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 71 - 80%) หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 3 – 4.5 เดือน หรือ ผลกระทบด้านการเงินมีมูลค่า 100,001 – 500,000 บาท 4 : เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ 60 - 70%) หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 4.5 - 6 เดือน หรือ ผลกระทบด้านการเงินมีมูลค่า 500,001 – 10,000,000 บาท 5 : เกิดความผิดพลาดขึ้นแล้ว และมีผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย (ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า 60%) ทำให้ภารกิจขององค์กรเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ ทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการ มากกว่า 6 เดือน หรือ ผลกระทบด้านการเงินมีมูลค่ามากกว่า 10,000,000 บาท			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 10			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน บุคลากร และผู้มาเยือน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A : จำนวนครั้งการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 3 ขึ้นไปของปีก่อนหน้า B : จำนวนครั้งการเกิดอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 3 ขึ้นไปของปีปัจจุบัน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 10	≥ ร้อยละ 10	≥ ร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิราวรรณ พิศพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.1. RSQ : อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปและระดับ 3 ขึ้นไปลดลง 2.1.1. Risk Registerของความเสี่ยงสำคัญระดับโรงพยาบาลที่ Risk Level ลดลง
ตัวชี้วัดที่	OKR 88.1 ร้อยละ Risk Register ของความเสี่ยงสำคัญระดับโรงพยาบาลที่ Risk Level ลดลง
คำนิยาม	Risk Register ของความเสี่ยงสำคัญของโรงพยาบาล ประกอบด้วย Septic shock in sepsis, Acute Respiratory failure in TB Lung, Hypovolemic shock in Trauma, Hypovolemic shock in UGIB, Increased Intracranial Pressure (ICP) in Hemorrhagic stroke, Prolong hypoxia in PPHN, hypovolemic shock in PPH, Increased Intracranial Pressure (ICP) in Traumatic brain injury, Cardiac arrest in intra hemodialysis, Cardiogenic shock in STEMI, pulmonary embolism (PE) in Fracture around Hip, Hypovolemic shock in Fracture pelvis (unstable type), Upper airway Obstruction (UAO) in Deep neck infection (DNI), VAP, การติดเชื้อดื้อยา, CLABSI, ให้เลือดผิดคนผิดหมู่ผิดชนิด, Medication Error ระดับ E ขึ้นไป, Diagnostic Error ระดับ E up, อักเสบ, โจรกรรมทางไซเบอร์, ฆ่าตัวตายสำเร็จ, อุบัติภัย/อุบัติเหตุหมู่, แพ้ยาซ้ำ/แพ้ยากลุ่มเดียวกันจากระบบของโรงพยาบาล, Under triage, ระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ระดับ E, ผ่าตัดผิดข้าง ผิดคนผิดตำแหน่ง, รายงานผล Lab คลาดเคลื่อน, รายงานผลพยาธิคลาดเคลื่อน, CAUTI และ SSI People Safety ... Risk Level ลดลงหมายถึง Risk Level จากการวิเคราะห์อุบัติการณ์เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณต่ำกว่า Risk Level จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงต้นปีงบประมาณ Risk Level ต้นปีงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์คาดการณ์ระดับความรุนแรงและความถี่จากความเสี่ยง Risk Level เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ หมายถึง การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและความถี่จากอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน บุคลากร และผู้มาเยือน ที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	1. โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS) 2. 12 กิจกรรมทบทวน		
รายการข้อมูล	A :จำนวน Risk Registerของความเสี่ยงสำคัญระดับโรงพยาบาลที่ Risk Level ลดลง B :จำนวน Risk Registerของความเสี่ยงสำคัญระดับโรงพยาบาลทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิราวรรณ พิศพล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงวิภาวดี แสนโคตร / นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.1. RSQ : ปฏิบัติการความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปและระดับ 3 ขึ้นไปลดลง 2.1.2 จำนวนหน่วยงานที่จัดทำ Risk Profile ของความเสี่ยงสำคัญระดับหน่วยงานเพิ่มขึ้น (Proactive Risk Management)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 88.2 อัตราหน่วยงานที่จัดทำRisk Profile ของความเสี่ยงสำคัญระดับหน่วยงาน			
คำนิยาม	หน่วยงานที่จัดทำ Risk Profile คือ หน่วยงานทางคลินิก จำนวน 79 หน่วยงาน หน่วยงานทางคลินิก คือ หน่วยงานหอผู้ป่วย (57) และหน่วยงานห้องตรวจผู้ป่วยนอก เฉพาะสาขา (สูตินรีเวชกรรม, ศัลยกรรม , อายุรกรรม, ออร์โธ, กุมารเวชกรรม, จักษุ, หูคอจมูก, จิตเวช) งานผู้ป่วยนอกคัดกรอง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทันตกรรม กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีวิทยา ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจพยาธิวิทยากายวิภาค เกสซกรรม ห้องผ่าตัด วิสัญญีวิทยา โภชนาการ และไตเทียม ภายในโรงพยาบาล			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานหน่วยงานทางคลินิก ภายในโรงพยาบาล			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A :จำนวนหน่วยงานทางคลินิกที่จัดทำ Risk profile B :จำนวนหน่วยงานทางคลินิกทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิราวรรณ พิศพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงจันทร์จิรา วรรณติกุล / นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.1. RSQ : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสียหายระดับ E ขึ้นไป และระดับ 3 ขึ้นไปลดลง 2.1.3หน่วยงานในโรงพยาบาลที่ผลลัพธ์มาตรฐานสำคัญจำเป็นบรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่	OKR 88.3 ร้อยละหน่วยงานในโรงพยาบาลที่ผลลัพธ์มาตรฐานสำคัญจำเป็นบรรลุเป้าหมาย
คำนิยาม	มาตรฐานสำคัญจำเป็นของโรงพยาบาล ได้แก่ อุบัติการณ์ฆ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดหัตถการ, อัตราการติดเชื้อดื้อยา, อัตราการติดเชื้อ VAP, อัตราการติดเชื้อ CAUTI, อัตราการติดเชื้อในแผลผ่าตัดสะอาด (SSI), อัตราการติดเชื้อ CLABSI, บุคลากรติดเชื้อวัณโรคปอด, Medication error with harms (Level E up), แพ้ยาซ้ำ/แพ้ยากลุ่มเดียวกันจากระบบของรพ., อุบัติการณ์ให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด, อุบัติการณ์การระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ระดับ E ขึ้นไป, Diagnostic error ระดับ E ขึ้นไป, ร้อยละการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตรวจวิเคราะห์ Lab คลาดเคลื่อน, จำนวนอุบัติการณ์การรายงานผลการตรวจพยาธิกายภาพคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป และ ร้อยละการคัดกรองที่ห้องฉุกเฉินถูกต้อง หน่วยงานที่ผลลัพธ์มาตรฐานสำคัญจำเป็นบรรลุเป้าหมาย หมายถึง หน่วยงานทางคลินิกที่มีจำนวนตัวชี้วัดมาตรฐานสำคัญจำเป็นบรรลุเป้าหมาย $\geq$ ร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในหน่วยงาน หน่วยงานทางคลินิก คือ หน่วยงานหอผู้ป่วยและหน่วยงานห้องตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะสาขา (สูตินรีเวชกรรม, ศัลยกรรม , อายุรกรรม, ออร์โธ, กุมารเวชกรรม, จักษุ, หูคอ จมูก, จิตเวช) งานผู้ป่วยนอกคัดกรอง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทันตกรรม กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีวิทยา ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจพยาธิวิทยากายวิภาค เภสัชกรรม ห้องผ่าตัด วิสัญญีวิทยา โภชนาการ ไตเทียม ภายในโรงพยาบาล
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานทางคลินิก คือ หน่วยงานหอผู้ป่วยและหน่วยงานห้องตรวจผู้ป่วยนอกเฉพาะสาขา (สูตินรีเวชกรรม, ศัลยกรรม , อายุรกรรม, ออร์โธ, กุมารเวชกรรม, จักษุ, หูคอ จมูก, จิตเวช) งานผู้ป่วยนอกคัดกรอง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทันตกรรม กายภาพบำบัด

	กิจกรรมบำบัด รังสีวิทยา ห้องตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องตรวจพยาธิวิทยากายวิภาคเภสัชกรรม ห้องผ่าตัด วิทยาลัยวิชา โภชนาการ ไตเทียม ภายในโรงพยาบาล			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A :จำนวนหน่วยงานทางคลินิกในโรงพยาบาลที่ผลลัพธ์มาตรฐานสำคัญจำเป็นบรรลุเป้าหมาย B :จำนวนหน่วยงานทางคลินิกทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิราวรรณ พิศพล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงวิภาวดี แสนโคตร/ นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.1. RSQ : อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 3 ขึ้นไปลดลง 2.1.4 อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปได้รับการจัดทำ RCA/CQI เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 88.4 อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป และระดับ 4 ขึ้นไปได้รับการจัดทำ RCA/CQI
คำนิยาม	อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ประกอบด้วย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น F: (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิจารณา) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวรหรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการบีม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ RCA (Root Cause Analysis) คือ กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาหรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีก ปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานให้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดเกณฑ์การทำ RCA ดังนี้ 1.RCA รายการ โดยการประชุมทบทวน 1.1 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E และระดับ 3 ขึ้นไป 1.2 อุบัติการณ์ความเสี่ยงกลุ่ม near miss ที่ถ้า miss จะเป็นระดับ GHI / 4-5 2.RCA รายการ ที่มีความถี่สูง เช่น Prescribing error โดยการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติการณ์ 3.RCA รายการโรค : Specific clinical risk ที่ risk level สูงของแต่ละ CLT โดยการทบทวนเวชระเบียน

	CQI (Continuous Quality Improvement) คือ กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และดำเนินการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และผลลัพธ์สุดท้ายตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
รายการข้อมูล	A :จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับE ขึ้นไป และระดับ 4 ขึ้นไป ได้รับการจัดทำ RCA/CQI B :จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับE ขึ้นไปและระดับ 4 ขึ้นไปทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิราวรรณ พิศพล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงจันทร์จิรา ควรรตีกุล/ นางสาวช่อทิพย์ ภาคมฤค		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.2 NSO : ลดอัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล ระดับ E ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่	KPI 89 อัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล ระดับ E ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
คำนิยาม	อุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล ได้แก่ 1. อุบัติการณ์ให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด ระดับ E ขึ้นไป 2. อุบัติการณ์ให้ administration error ระดับ E ขึ้นไป 3. อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ระดับ E ขึ้นไป 4. อุบัติการณ์ทรุดลงโดยไม่ได้วางแผน ระดับ E ขึ้นไป 5. อัตราท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้นไป ต่อ 1,000 Vent.day ระดับ E หมายถึง เหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วและส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย โดยผู้ป่วยได้รับอันตรายชั่วคราว และจำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือการแทรกแซงเพิ่มเติมจากทีมสุขภาพเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ตั้งแต่ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยทุกรายที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายใต้การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์พยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมความเสี่ยง

รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญทางการแพทย์ผ่านเกณฑ์ B : จำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญทางการแพทย์ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 60 (3 ข้อ)	≥ ร้อยละ 80 (4 ข้อ)	≥ ร้อยละ 80 (4 ข้อ)	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวพูนทรัพย์ สมกล้า			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสมทรง บตรตะ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.2 NSO : ลดอัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงสำคัญทางการแพทย์พยาบาลระดับE ขึ้นไป 2.2.1 หน่วยงานทางการแพทย์พยาบาลที่มีผลิตภาพ (Productivity) ทางทางการแพทย์ ได้รับการจัดการแก้ไขให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน			
ตัวชี้วัดที่	OKR 89.1 อัตราหน่วยงานทางการแพทย์พยาบาลที่มีผลิตภาพ (Productivity) ทางทางการแพทย์ เป็นตามมาตรฐาน			
คำนิยาม	Productivity ทางทางการแพทย์ หมายถึง ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง "ภาระงานที่ต้องการจริง" กับ "ทรัพยากรหรือเวลาที่ใช้ไปจริง" Productivity ทางทางการแพทย์ เป็นตามมาตรฐาน หมายถึง Productivity ตั้งแต่ 90-110 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานทางการแพทย์พยาบาลภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หน่วยงานทางการแพทย์พยาบาล			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหน่วยงานทางการแพทย์พยาบาลที่มีผลิตภาพ (Productivity) ทางทางการแพทย์ เป็นตามมาตรฐาน B : จำนวนหน่วยงานทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65	ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางเพลินตา กุลทรัพย์ธนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวเพชรินทร์ ภูมิภักดิ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.2 NSO : ลดอัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางการพยาบาลระดับ E ขึ้นไป 2.2.2 บุคลากรทางการพยาบาลผ่านการประเมินสมรรถนะความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง เพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 89.2 อัตราบุคลากรทางการพยาบาลผ่านการประเมินสมรรถนะความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล			
คำนิยาม	ความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล ได้แก่ 1. อุบัติการณ์ให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด ระดับ E ขึ้นไป 2. อุบัติการณ์ให้ administration error ระดับ E ขึ้นไป 3. อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ระดับ E ขึ้นไป 4. อุบัติการณ์ทรุดลงโดยไม่ได้วางแผน ระดับ E ขึ้นไป 5. อัตราท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้นไป ต่อ 1,000 Vent.day			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	พยาบาลวิชาชีพ			
แหล่งข้อมูล	รายงานผลการประเมินสมรรถนะของกลุ่มการพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลผ่านการประเมินสมรรถนะความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล B : จำนวนบุคลากรทางการพยาบาลทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางดรุณี สมบูรณ์กิจ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวเพชรินทร์ ภูมิภักดิ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.2 NSO : ลดอัตราอุบัติการณ์ความเสี่ยงทางการพยาบาลระดับE ขึ้นไป 2.2.3 หน่วยงานทางการพยาบาลรับการนิเทศตามความเสี่ยงโรคสำคัญทางการพยาบาลระดับE ขึ้นไป			
ตัวชี้วัดที่	OKR 89.3 หน่วยงานทางการพยาบาลมีการนิเทศตามความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาลระดับ E ขึ้นไป			
คำนิยาม	การนิเทศความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการติดตาม กำกับ แนะนำ สนับสนุน การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยให้บุคลากรวิเคราะห์ รายงานและจัดการความเสี่ยงได้เหมาะสม เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียต่อผู้ป่วย บุคลากร และองค์กร ความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาล ได้แก่ 1. อุบัติการณ์ให้เลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด ระดับ E ขึ้นไป 2. อุบัติการณ์ให้ administration error ระดับ E ขึ้นไป 3. อุบัติการณ์ระบุตัวผู้ป่วยผิดพลาด ระดับ E ขึ้นไป 4. อุบัติการณ์ทรุดลงโดยไม่ได้วางแผน ระดับ E ขึ้นไป 5. อัตราท่อช่วยหายใจเลื่อนหลุดระดับ E ขึ้นไป ต่อ 1,000 Vent.day			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	หัวหน้าหอ/ หัวหน้างาน หรือผู้ได้รับมอบหมายการนิเทศ			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมความเสี่ยง รายงานเวรตรวจการ บันทึกการนิเทศ			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหน่วยงานทางการพยาบาลที่ได้รับการนิเทศความเสี่ยงสำคัญทางการพยาบาลระดับ E ขึ้นไป B : จำนวนหน่วยงานทางการพยาบาลทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางเพลินตา กุลทรัพย์ธนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวเพชรินทร์ ภูมิภักดิ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO : ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ
ตัวชี้วัดที่	KPI 90 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป
คำนิยาม	Diagnostic Error หรือ การวินิจฉัยโรคผิดพลาด หมายถึง ความล้มเหลวในการอธิบายปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน และทันเวลา รวมถึงความล้มเหลวในการสื่อสารคำอธิบายนั้นให้ผู้ป่วยเข้าใจด้วย ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี่) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น F: (เยียวยาวนาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิจารณา) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวรหรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการปัดป้อง) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ

ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS) รายงานการทบทวนอุบัติการณ์ของ CLT			
รายการข้อมูล	A : อับัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พญ.กนกพร บุตรमारศรี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.วิภาวดี แสนโคตร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO : ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ 2.3.1 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปของ Subglottic stenosis (ENT)
ตัวชี้วัดที่	OKR 90.1 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ของ subglottic stenosis
คำนิยาม	Diagnostic Error : โรค subglottic stenosis เป็นภาวะตีบได้กล่องเสียง/ช่องเสียงทางเดินหายใจส่วนบนแคบลง ทำให้อากาศผ่านได้ยาก อาการหลักคือหายใจมีเสียงดัง (Stridor) ลักษณะเสียงหวีดแหลม (High-pitched sound) หายใจลำบาก (Dyspnea/Respiratory distress) หายใจถี่ โดยเฉพาะเวลาออกแรง ออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรม เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยน (Hoarseness) ไอเรื้อรัง ไออย่างต่อเนื่อง มีเสมหะเยอะขึ้น อาการหอบในเด็ก อาจมีอาการเหมือนเป็นกลุ่มโรคหัด (Croup) บ่อยครั้ง หรือเสียงหายใจดัง หายใจลำบากขณะนอนหลับในกรณีรุนแรงอาจทำให้ตื่นมาหอบกลางดึก ความรู้สึกรู้สึกมีเสมหะติดคอและอาจหอบเหนื่อยจนตัวเขียวในรายที่รุนแรง แต่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและทันเวลาอาจเนื่องจากอาการคล้ายโรคหืด (Asthma) หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เนื่องจากเสียงหวีดที่คล้ายกัน แต่ภาวะนี้จะไม่ตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลมหรือเนื่องจากข้อจำกัดของบุคลากร กระบวนการหรือระบบบริการส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Diagnostic errorแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. Missed Diagnosis หมายถึงกรณีที่อาการของผู้ป่วยชัดเจน เช่น หายใจมีเสียงดัง (Stridor) ลักษณะเสียงหวีดแหลม (High-pitched sound) หายใจลำบาก (Dyspnea/Respiratory distress) หายใจถี่ โดยเฉพาะเวลาออกแรง เสียงแหบหรือเสียงเปลี่ยน (Hoarseness) ไอเรื้อรัง ไออย่างต่อเนื่อง ไม่ตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลม แต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค 2. Wrong Diagnosis หมายถึงกรณีที่ให้นิยามโรคที่ไม่ถูกต้องและทันเวลาอาจเนื่องจากอาการคล้ายโรคหืด (Asthma) หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) เนื่องจากเสียงหวีดที่คล้ายกัน แต่ภาวะนี้จะไม่ตอบสนองต่อยาพ่นขยายหลอดลม 3. Delayed Diagnosis หมายถึงกรณีที่ควรได้รับการวินิจฉัยโรคเร็วกว่าที่เป็นเช่น

	อาการคล้ายโรคหืด (Asthma) หรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี่) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น F: (เยียวยาวนาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิจารณา) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวรหรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการปัม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้ป่วยด้านโสต ศอ นาสิกที่ OPD ER หอผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS) รายงานการทบทวนอุบัติการณ์ของ CLT			
รายการข้อมูล	A :อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางกิงแก้ว บัวละคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ปิยะนารถ ด่านพรประเสริฐ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO : ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ 2.3.2 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ของ Ectopic Pregnancy
ตัวชี้วัดที่	OKR 90.2 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ของ Ectopic Pregnancy
คำนิยาม	Diagnostic Error คือ เหตุการณ์ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและทันเวลา อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของบุคลากรกระบวนการหรือระบบบริการส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Diagnostic error แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. Missed Diagnosis หมายถึง กรณีที่อาการของผู้ป่วยไม่ได้รับคำอธิบายเช่น อาการอ่อนเพลียหรือเจ็บปวดเรื้อรังหรือผู้ป่วยมีอาการชัดเจนแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค 2. Wrong Diagnosis หมายถึง กรณีที่ให้การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้องและมาพบสาเหตุที่แท้จริงภายหลัง 3. Delayed Diagnosis หมายถึง กรณีที่ควรได้รับการวินิจฉัยโรคเร็วกว่าที่เป็นเช่น การวินิจฉัยโรคมะเร็ง ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี่) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น

	F: (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติ หรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการปั้ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Ectopic pregnancy ที่มารับบริการ ในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมระบบสารสนเทศ รายงานอุบัติการณ์ของ CLT สุนิรีเวชกรรม			
รายการข้อมูล	A: อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางองค์ออน ภาณุตานนท์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.เบญจรัตน์ ตรีวิริยานุภาพ			

นียมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO : ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ 2.3.3 blunt abdomen/blunt chest (ศัลยกรรม)
ตัวชี้วัดที่	OKR 90.3 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน blunt abdomen/blunt chest
คำนิยาม	Diagnostic Error คือเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและทันเวลา อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของบุคลากร กระบวนการ หรือระบบบริการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Diagnostic error แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. Missed Diagnosis หมายถึงกรณีที่อาการของผู้ป่วยไม่ได้รับคำอธิบาย เช่น อาการปวดท้องหรือปวดหน้าอกจากการกระแทก หรือผู้ป่วยมีอาการชัดเจนแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค 2. Wrong Diagnosis หมายถึงกรณีที่ให้การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง และมาพบสาเหตุที่แท้จริงภายหลัง 3. Delayed Diagnosis หมายถึงกรณีที่ควรได้รับการวินิจฉัยโรคเร็ว แต่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า เช่น Intra abundance injury ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี้) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย

	E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น F: (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิจารณา) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวรหรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการป้มน) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย blunt abdomen/blunt chest ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS) รายงานการทบทวนอุบัติการณ์ของ CLT			
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน blunt abdomen/blunt chest			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสิรินารถ ประพาศพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ไชยวัฒน์ พาณิษฐ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO : ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ 2.3.4 STEMI
ตัวชี้วัดที่	OKR 90.4 อับัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปของ STEMI
คำนิยาม	Diagnostic Error คือเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและทันเวลา อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของบุคลากร กระบวนการ หรือระบบบริการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Diagnostic error แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. Missed Diagnosis หมายถึงกรณีที่อาการของผู้ป่วยไม่ได้รับคำอธิบาย เช่น อาการเจ็บหน้าอก หรือผู้ป่วยมีอาการชัดเจนแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค 2. Wrong Diagnosis หมายถึงกรณีที่ให้การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง และมาพบสาเหตุที่แท้จริงภายหลัง 3. Delayed Diagnosis หมายถึงกรณีที่ควรได้รับการวินิจฉัยโรคเร็วกว่าที่เป็น แต่วินิจฉัยล่าช้า เช่น วินิจฉัยเป็นโรคกระเพาะอาหารก่อน ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี่) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น

	F: (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติ หรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการปั๊ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ			
ค่าเป้าหมาย	เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย STEMI			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย STEMI ที่เกิด Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปาริชาติ ศรีหนู			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงศศิธร ดวงพรหม			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO : ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ 2.3.5 Pediatric DHF
ตัวชี้วัดที่	OKR 90.5 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Pediatric DHF
คำนิยาม	Diagnostic Error คือเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและทันเวลา อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของบุคลากร กระบวนการ หรือระบบบริการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Diagnostic error แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. Missed Diagnosis หมายถึงกรณีที่อาการของผู้ป่วยไม่ได้รับคำอธิบาย เช่น อาการไข้สูงลอยหลายวัน หรือผู้ป่วยมีอาการชัดเจนแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค 2. Wrong Diagnosis หมายถึงกรณีที่ให้การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง และมาพบสาเหตุที่แท้จริงภายหลัง 3. Delayed Diagnosis หมายถึงกรณีที่ควรได้รับการวินิจฉัยโรคเร็วกว่าที่เป็นแต่วินิจฉัยล่าช้า เช่น วินิจฉัยเป็นไขหวัดก่อน ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี้) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น

	F: (เยียวานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติ หรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการปั๊ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยเด็กที่มารับบริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมรายงานความเสี่ยง HRMS รายงานการทบทวนอุบัติการณ์ของ CLT กุมภาพันธ์ 2572			
รายการข้อมูล	A : อับัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Pediatric DHF			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO : ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ 2.3.6 Traumatic Eye injury
ตัวชี้วัดที่	OKR 90.6 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Traumatic Eye injury
คำนิยาม	Diagnostic Error คือเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและทันเวลา อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของบุคลากร กระบวนการ หรือระบบบริการ ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Diagnostic error แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. Missed Diagnosis หมายถึงกรณีที่อาการของผู้ป่วยไม่ได้รับคำอธิบาย เช่น อาการอ่อนเพลียหรือเจ็บปวดเรื้อรัง หรือผู้ป่วยมีอาการชัดเจนแต่ไม่ได้รับการวินิจฉัยโรค 2. Wrong Diagnosis หมายถึงกรณีที่ให้การวินิจฉัยที่ไม่ถูกต้อง และมาพบสาเหตุที่แท้จริงภายหลัง 3. Delayed Diagnosis หมายถึงกรณีที่ควรได้รับการวินิจฉัยโรคเร็วกว่าที่เป็น เช่น การวินิจฉัยโรคมะเร็ง ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี่) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น

	F: (เยียวยานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติ หรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวร หรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน H: (ต้องการปั้ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มผู้รับบริการ Traumatic Eye injury ในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS) รายงานการทบทวนอุบัติการณ์ของ CLT Eye			
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Traumatic Eye injury			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอังคณา สุวรรณดิษฐ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.วิรัตน์ สุทธิสา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.3 MSO :ป้องกันและเฝ้าระวัง Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไป ในกลุ่มโรคสำคัญ 2.3.7 Neck shaft femoral fracture
ตัวชี้วัดที่	OKR 90.7 อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Neck shaft femoral fracture
คำนิยาม	Diagnostic Error คือ เหตุการณ์ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและทันเวลา อันเนื่องมาจากข้อจำกัดของบุคลากรกระบวนการหรือระบบบริการส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย Diagnostic errorแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1. Missed Diagnosis หมายถึง การวินิจฉัยไม่พบโรคทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษา 2. Wrong Diagnosis หมายถึง กรณีที่ให้การวินิจฉัยที่ผิดโรค ไม่ตรงกับโรคที่เป็น 3. Delayed Diagnosis หมายถึง กรณีที่ได้รับการวินิจฉัยโรคที่ล่าช้าทำให้ผู้ป่วยบริการได้รับการรักษาที่ล่าช้า ความเสี่ยงระดับ A-I คือ A: (เกิดที่นี่) มีโอกาสเกิดเหตุการณ์และค้นพบได้ด้วยตัวเอง สามารถปรับแก้ไขได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่นและผู้ป่วยหรือบุคลากร B: (เกิดที่ไกล) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นแล้วโดยส่งต่อเหตุการณ์/ความผิดพลาดนั้นไปที่ผู้อื่นแต่สามารถตรวจพบและแก้ไขได้ โดยยังไม่มีผลกระทบใดๆ ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร C: (เกิดกับใคร) เกิดเหตุการณ์/ความผิดพลาดขึ้นและมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร แต่ไม่เกิดอันตรายหรือเสียหาย D: (ให้ระวัง) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องให้การดูแลเฝ้าระวังเป็นพิเศษว่าจะไม่เป็นอันตราย E: (ต้องรักษา) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือบุคลากร เกิดอันตรายชั่วคราวที่ต้องแก้ไข/รักษาเพิ่มมากขึ้น F: (เสียเวลานาน) เกิดความผิดพลาดขึ้น มีผลกระทบที่ต้องใช้เวลาแก้ไขนานกว่าปกติหรือเกินกำหนด ผู้ป่วยหรือบุคลากร ต้องรักษา/นอนโรงพยาบาลนานขึ้น G: (ต้องพิการ) เกิดความผิดพลาดถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร ทำให้เกิดความพิการถาวรหรือมีผลกระทบทำให้เสียชื่อเสียง/ความเชื่อถือและ/หรือมีการร้องเรียน

	H: (ต้องการปั๊ม) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร มีผลทำให้ต้องทำการช่วยชีวิต ต้องดูแลต่อเนื่องตลอดชีวิต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ หรือกรณีทำให้เสียชื่อเสียงและ/หรือมีการเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงพยาบาล I: (จำใจลา) เกิดความผิดพลาด ถึงผู้ป่วยหรือบุคลากร เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิต เสียชื่อเสียงโดยมีการฟ้องร้องทางศาล/สื่อ ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกคอสะโพกหักจาก ทุกราย		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Neck shaft femoral fracture ทั้งเพศชายและหญิง		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS) รายงานการทบทวนอุบัติการณ์ของ CLT		
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์ Diagnostic Error ระดับ E ขึ้นไปใน Neck shaft femoral fracture		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเดิม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 0 ครั้ง	2571 0 ครั้ง	2572 0 ครั้ง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางรัชมี เกตุธานี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.5 IC : ลดการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ			
ตัวชี้วัดที่	KPI 91 อัตราการติดเชื้อ HAI < 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน			
คำนิยาม	การติดเชื้อในโรงพยาบาลหากการติดเชื้อที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยเข้ารับการรักษานานตั้งแต่ 48 ชั่วโมงขึ้นไป หรือไม่อยู่ในระยะฟักตัวของเชื้อโรค			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	< 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษานานในหอผู้ป่วยใน			
แหล่งข้อมูล	การซักประวัติ ตรวจร่างกาย, เวชระเบียน, ผล Lab, ผลCXR			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในโรงพยาบาลตามเกณฑ์การวินิจฉัย IC B : จำนวนวันนอนผู้ป่วยทั้งหมดในช่วง 1 เดือน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A / B) \times 1,000$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 < 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน	2571 < 1.0 ต่อ 1,000 วันนอน	2572 < 0.5 ต่อ 1,000 วันนอน	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนุชจรี พันธุ์โยศรี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางเพิ่มพูน ศิริกิจ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.5 IC : ลดการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ 2.5.1 VAP			
ตัวชี้วัดที่	OKR 91.1 อัตราการติดเชื้อตำแหน่ง VAP ≤ 6 ต่อ 1,000 vent.Day			
คำนิยาม	ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator–Associated Pneumonia : VAP) หมายถึง ภาวะปอดอักเสบที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจมากกว่า 2 วัน ปฏิทินเป็นต้นไป (วันแรกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนับเป็นวันที่ 1 ปฏิทิน) หรือหลังถอดเครื่องช่วยหายใจไม่เกิน 2 วันปฏิทิน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≤ 6.0 ต่อ 1,000 vent.Day			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ			
แหล่งข้อมูล	การซักประวัติ ตรวจร่างกาย, เวชระเบียน, ผล Lab, ผลCXR			
รายการข้อมูล	A: จำนวนครั้งของการติดเชื้อตำแหน่ง VAP B: จำนวนวันใช้เครื่องช่วยหายใจทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 1,000			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤5.5 ต่อ 1,000 vent.Day	≤4.5 ต่อ 1,000 vent.Day	≤ 3.5 ต่อ 1,000 vent.Day	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนุชจรี พันธุ์โยศรี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางเพิ่มพูน ศิริกิจ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.5 IC : ลดการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ 2.5.2 CLABSI		
ตัวชี้วัดที่	OKR 91.2 อัตราการติดเชื้อตำแหน่ง CLABSI < 1.5 ต่อ 1,000 line.Day		
คำนิยาม	การติดเชื้อในกระแสโลหิตที่สัมพันธ์กับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Central line-associated bloodstream infection : CLABSI) หมายถึง การติดเชื้อในกระแสเลือดที่ได้รับการยืนยันด้วยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยผู้ป่วยได้รับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางมาแล้วอย่างน้อย 2 วัน ปฏิทิน หรือถอดสายสวนหลอดเลือดดำออกมาเกิน 1 วัน		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≤ 1.5 ต่อ 1,000 line.Day		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในที่ได้รับการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง		
แหล่งข้อมูล	การซักประวัติ ตรวจร่างกาย, เวชระเบียน, ผล Lab		
รายการข้อมูล	A: จำนวนครั้งติดเชื้อจากการใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง B: จำนวนวันที่ใส่สายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 1,000$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 ≤ 1.5 ต่อ 1,000 line.Day	2571 ≤ 1.0 ต่อ 1,000 line.Day	2572 ≤ 0.5 ต่อ 1,000 line.Day
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนุชรี พันธุ์โยศรี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางเพิ่มพูน ศิริกิจ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.5 IC : ลดการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ 2.5.3 CAUTI			
ตัวชี้วัดที่	OKR 91.3 อัตราการติดเชื้อตำแหน่ง CAUTI ≤ 1.5 ต่อ 1,000 cath.Day			
คำนิยาม	การติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะจากการใส่สายสวนปัสสาวะ หมายถึง การพบเชื้อจุลชีพในน้ำปัสสาวะและทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ หลังได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะและเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล เกิน 2 วันปฏิทิน หรือหลังจากถอดสายสวนปัสสาวะออก ภายใน 2 วันปฏิทิน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≤ 1.5 ต่อ 1,000 cath.Day			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในที่ได้รับการใส่สายสวนปัสสาวะ			
แหล่งข้อมูล	การซักประวัติ ตรวจร่างกาย, เวชระเบียน, ผล Lab			
รายการข้อมูล	A: จำนวนครั้งติดเชื้อจากการใส่สายสวนปัสสาวะ B: จำนวนวันที่ใส่สายปัสสาวะทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 1,000			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤ 1.5 ต่อ 1,000 cath.Day	≤ 1.0 ต่อ 1,000 cath.Day	≤ 0.5 ต่อ 1,000 cath.Day	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนุชจรี พันธุ์ยศศรี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางเพิ่มพูน ศิริกิจ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.5 IC : ลดการติดเชื้อจากบริการสุขภาพ 2.5.4 อัตราการติดเชื้อดื้อยา			
ตัวชี้วัดที่	OKR 91.4 อัตราการติดเชื้อดื้อยา ≤ 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน			
คำนิยาม	การที่เชื้อจุลชีพมีความทนทานต่อฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพ ที่เคยใช้ทำลายเชื้อชนิดนั้นได้ผล			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≤ 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	การซักประวัติ ตรวจร่างกาย, เวชระเบียน, ผล Lab			
รายการข้อมูล	A: จำนวนครั้งติดเชื้อดื้อยา B: จำนวนวันนอน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) X 1,000			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≤ 1.5 ต่อ 1,000 วันนอน	≤ 1.0 ต่อ 1,000 วันนอน	≤ 0.5 ต่อ 1,000 วันนอน	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนุชจรี พันธุ์โยศรี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางเพ็ญพน ศิริกิจ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่	KPI 92 อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป
คำนิยาม	อุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา (medication error) ระดับ E ขึ้นไป หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่สามารถป้องกันได้ที่อาจจะเป็นสาเหตุหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยในขณะที่ยาอยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุขผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในขั้นตอนของการใช้ยา ได้แก่ การสั่งใช้ยา การเตรียมและจัดจ่ายยา ซึ่งจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยา (prescribing error) ความคลาดเคลื่อนการจัดเตรียมและจ่ายยา (dispensing error) และความคลาดเคลื่อนการบริหารยา (administration error) ทั้งในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยมีระดับความรุนแรงของความคลาดเคลื่อนทางยาส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย (Harm) ตั้งแต่ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้ Intervention เพื่อช่วยชีวิต เช่น แพ้ยาแบบ anaphylaxis และหัวใจหยุดเต้น ระดับ I: มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในที่เกิดความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม
รายการข้อมูล	A : จำนวนเหตุการณ์การเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาที่มีระดับความรุนแรงตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป ในผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป 2.7.1 ลด Prescribing error ผู้ป่วยนอก		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.1 อัตรา Prescribing error ผู้ป่วยนอก		
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสั่งใช้ยาของแพทย์ ได้แก่ การเลือกใช้ยาผิด (โดยใช้หลักการเลือกยาตามข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย ยาอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยใช้อยู่ การสั่งใช้ยาซ้ำซ้อน การสั่งใช้ยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันและปัจจัยอื่น ๆ) การเลือกขนาดยาผิด การเลือกรูปแบบยาผิด การสั่งยาในจำนวนที่ผิด การเลือกวิถีทางให้ยาผิด การเลือกความเข้มข้นของยาผิด การเลือกอัตราเร็วการให้ยาผิดหรือการให้คำแนะนำในการใช้ยาผิด การสั่งใช้ยาผิดตัวผู้ป่วย หรือการไม่ระบุชื่อยา ความแรง ความเข้มข้น ความถี่ของการให้ยา ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70%		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยนอก		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : อัตราความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยา ในผู้ป่วยนอกของปีก่อนหน้า B: อัตราความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยา ในผู้ป่วยนอกของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 50%	≥ ร้อยละ 60%	≥ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป 2.7.1 ลด Prescribing error ผู้ป่วยใน		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.2 อัตรา Prescribing error ผู้ป่วยใน		
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนในการสั่งใช้ยา (Prescribing error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในกระบวนการสั่งใช้ยาของแพทย์ ได้แก่ การเลือกใช้ยาผิด (โดยใช้หลักการเลือกยาตามข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วย ยาอื่น ๆ ที่ผู้ป่วยใช้อยู่ การสั่งใช้ยาซ้ำซ้อน การสั่งใช้ยาที่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกันและปัจจัยอื่น ๆ) การเลือกขนาดยาผิด การเลือกรูปแบบยาผิด การสั่งยาในจำนวนที่ผิด การเลือกวิถีทางให้ยาผิด การเลือกความเข้มข้นของยาผิด การเลือกอัตราเร็วการให้ยาผิดหรือการให้คำแนะนำในการใช้ยาผิด การสั่งใช้ยาผิดตัวผู้ป่วย หรือการไม่ระบุชื่อยา ความแรง ความเข้มข้น ความถี่ของการให้ยา ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ลดลง $\geq$ ร้อยละ 70%		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยใน		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : อัตราความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยา ในผู้ป่วยนอกของปีก่อนหน้า B: อัตราความคลาดเคลื่อนการสั่งใช้ยา ในผู้ป่วยนอกของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	$\geq$ ร้อยละ 50%	$\geq$ ร้อยละ 60%	$\geq$ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยากระดับ E ขึ้นไป 2.7.3 ลด Dispensing error ผู้ป่วยนอก		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.3 อัตรา Dispensing error ผู้ป่วยนอก		
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนการจ่ายยา (Dispensing Error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจ่ายยาของหน่วยงานเภสัชกรรม ที่จ่ายยาไม่ถูกต้องตามที่ระบุในคำสั่งใช้ยา ได้แก่ ผิดชนิดยา รูปแบบ ความแรง ขนาดยา วิธีใช้ยา จำนวนยาที่สั่งจ่าย จ่ายผิดตัวผู้ป่วย จ่ายยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ จ่ายยาที่ไม่มีคำสั่งใช้ยา (unauthorized drug) เตรียมยาผิด เช่น เจือจาง ผสมผิด ใช้ภาชนะบรรจุยาไม่เหมาะสม ฉลากยาผิด		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70%		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยนอก		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : อัตราความคลาดเคลื่อนการจ่ายยา ในผู้ป่วยนอกของปีก่อนหน้า B: อัตราความคลาดเคลื่อนการจ่ายยา ในผู้ป่วยนอกของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 50%	≥ ร้อยละ 60%	≥ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยากระดับ E ขึ้นไป 2.7.3 ลด Dispensing error ผู้ป่วยใน		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.4 อัตรา Dispensing error ผู้ป่วยใน		
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนการจ่ายยา (Dispensing Error) หมายถึง ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการจ่ายยาของหน่วยงานเภสัชกรรม ที่จ่ายยาไม่ถูกต้องตามที่ระบุในคำสั่งใช้ยา ได้แก่ ผิดชนิดยา รูปแบบ ความแรง ขนาดยา วิธีใช้ยา จำนวนยาที่สั่งจ่าย จ่ายผิดตัวผู้ป่วย จ่ายยาที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ จ่ายยาที่ไม่มีคำสั่งใช้ยา (unauthorized drug) เตรียมยาผิด เช่น เจือจาง ผสมผิด ใช้ภาชนะบรรจุยาไม่เหมาะสม ฉลากยาผิด		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70%		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยใน		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : อัตราความคลาดเคลื่อนการจ่ายยา ในผู้ป่วยนอกของปีก่อนหน้า B: อัตราความคลาดเคลื่อนการจ่ายยา ในผู้ป่วยนอกของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 50%	≥ ร้อยละ 60%	≥ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป 2.7.4 ลด Administration error ผู้ป่วยนอก		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.5 อัตรา Administration error ผู้ป่วยนอก		
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนการบริหารยา (Administration Error) หมายถึงความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการให้ยาแก่ผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาล โดยเป็นผลให้ไม่เป็นตามหลักการให้ยาในด้านถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิธีทาง ถูกเทคนิค และไม่ปฏิบัติตามเป้าประสงค์ของการรักษา รวมถึงการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการให้ยาตามที่แพทย์สั่ง		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70%		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยนอก		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : อัตราความคลาดเคลื่อนการบริหารยา ในผู้ป่วยนอกของปีก่อนหน้า B: อัตราความคลาดเคลื่อนการบริหารยา ในผู้ป่วยนอกของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 50%	2571 ≥ ร้อยละ 60%	2572 ≥ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มภารกิจพยาบาล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป 2.7.5 ลด Administration error ผู้ป่วยใน		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.6 อัตรา Administration error ผู้ป่วยใน		
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนการบริหารยา (Administration Error) หมายถึงความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการให้ยาแก่ผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาล โดยเป็นผลให้ไม่เป็นตามหลักการให้ยาในด้านถูกคน ถูกยา ถูกขนาด ถูกเวลา ถูกวิธีทาง ถูกเทคนิค และไม่ปฏิบัติตามเป้าประสงค์ของการรักษา รวมถึงการที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการให้ยาตามที่แพทย์สั่ง		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70%		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยใน		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : อัตราความคลาดเคลื่อนการบริหารยา ในผู้ป่วยนอกของปีก่อนหน้า B: อัตราความคลาดเคลื่อนการบริหารยา ในผู้ป่วยนอกของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 50%	2571 ≥ ร้อยละ 60%	2572 ≥ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พี่อ้อม พงนิย์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป 2.7.4 ลด Medication error ยา High Alert Drug		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.7 จำนวน Medication error ยา High Alert Drug		
คำนิยาม	ยาความเสี่ยงสูง (High Alert Drug) หมายถึง ยาที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงต่อการใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์ มีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนทางยา หรือเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาสูง อาจรวมถึงยาที่อยู่ระหว่างการศึกษาทดลอง ยาที่ต้องควบคุม ยาที่ไม่อยู่ในบัญชียาโรงพยาบาล ยาที่มีพิษการบำบัดแคบ ยาทางจิตเวช ยาทางวิสัญญี ยาที่มีชื่อคล้ายกัน หรือออกเสียงคล้ายกัน เป็นไปตามประกาศรายการยาความเสี่ยงสูง โรงพยาบาลมหาสารคาม		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการของโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโปรแกรมรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนความคลาดเคลื่อนทางยาความเสี่ยงสูงของปีก่อนหน้า B: จำนวนความคลาดเคลื่อนทางยาความเสี่ยงสูงของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 50%	2571 ≥ ร้อยละ 60%	2572 ≥ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยา ระดับ E ขึ้นไป 2.7.6 ลด Medication error ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.8 จำนวน Medication error ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์		
คำนิยาม	ความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ หมายถึง เหตุการณ์ใด ๆ ที่สามารถป้องกันได้ที่จะเป็นสาเหตุหรือหรือนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมหรือเป็นอันตรายแก่ผู้ป่วยในขณะที่ยาอยู่ในความควบคุมของบุคลากรสาธารณสุขผู้ป่วยหรือผู้รับบริการในขั้นตอนของการใช้ยา ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ได้แก่ การสั่งใช้ยา การจ่ายยา การบริหารยา ที่ผู้ป่วยมีประวัติแพ้ยา ทั้งชนิดเดียวกันและกลุ่มเดียวกัน		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ลดลง $\geq$ ร้อยละ 70		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยใน		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลรายงาน ADR รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของปีก่อนหน้า B: จำนวนความคลาดเคลื่อนทางยา ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้องรายงาน)	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 $\geq$ ร้อยละ 50%	2571 $\geq$ ร้อยละ 60%	2572 $\geq$ ร้อยละ 70%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.7 PTC : ไม่พบอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนทางยาในระดับ E ขึ้นไป 2.7.5 ลด Medication error ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ Medication reconciliation		
ตัวชี้วัดที่	OKR 92.9 ร้อยละผู้ป่วยที่ได้รับการประสานรายการยาถูกต้อง		
คำนิยาม	การประสานรายการยา (medication reconciliation) หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันของทีมบุคลากรทางการแพทย์ (สหสาขาวิชาชีพ) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลรายการยาที่ผู้ป่วยใช้อยู่อย่างครบถ้วนและถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล ยาที่ซื้อมาเอง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบกับรายการยาที่แพทย์สั่งใหม่ในแต่ละช่วงรอยต่อของการรักษา เช่น เมื่อแรกรับเข้าโรงพยาบาล ระหว่างย้ายหอผู้ป่วย หรือในวันกลับบ้าน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาที่อาจเกิดขึ้น		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยใน		
แหล่งข้อมูล	แบบประเมิน medication reconciliation		
รายการข้อมูล	A : ผู้จำนวนป่วยที่ได้รับการประสานรายการยาถูกต้อง B : ผู้จำนวนป่วยที่สำรวจ		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	กลุ่มงานเภสัชกรรม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	เลขา PTC		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.1 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (OPD/IPD) เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	KPI 94 อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียน (OPD/IPD) OPD $\geq$ ร้อยละ 99 IPD $\geq$ ร้อยละ 99
คำนิยาม	เวชระเบียน (Medical Records Department) หมายถึง เอกสารทางการแพทย์ทุกประเภท ที่ใช้บันทึกและเก็บรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพ ประวัติของผู้ป่วย ทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติครอบครัว ประวัติการแพ้ยา เอกสารการยินยอมให้ทำการรักษาพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยในอดีตและปัจจุบัน ข้อมูลบ่งชี้เฉพาะของบุคคล การรักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาล ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลการชันสูตรบาดแผลหรือพลิกศพ ผลการบันทึกค่าทั้งที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพหรือเครื่องหมายอื่นใด จากอุปกรณ์เครื่องมือในสถานบริการสาธารณสุขหรือเครื่องมือทางการแพทย์ทุกประเภท หรือเอกสารการบันทึก การกระทำใด ๆ ที่เป็นการสั่งการรักษา การปรึกษาเพื่อการรักษาพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วยไปทำการรักษาที่อื่น การรับผู้ป่วยรักษาต่อ การกระทำตามคำสั่งของผู้มีอำนาจในการรักษาพยาบาลตามที่สถานบริการกำหนดไว้ เอกสารอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบเพื่อการตัดสินใจทางการแพทย์ เพื่อการประสานงานในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และเอกสารอื่นใดที่ทางองค์กรอนามัยโลก หรือสถานบริการสาธารณสุขกำหนดไว้ว่าเป็นเอกสารทางเวชระเบียน หมายถึงรวมถึงชื่อของหน่วยงาน ที่ทำหน้าที่ในการจัดทำเอกสารดังกล่าว การเก็บรวบรวม การค้นหา การบันทึก การแก้ไข การให้รหัสโรค รหัสหัตถการ การจัดทำรายงานทางการแพทย์ การนำมาจัดทำสถิติผู้ป่วย การนำมาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อการอื่นใดตามที่สถานบริการสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ยังรวมถึงเอกสารทางการแพทย์ที่อยู่ในรูปแบบสื่อดิจิทัล หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record -EMR) ซึ่งเป็นรูปแบบของเวชระเบียนที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยนอก คือ เวชระเบียนที่มีการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยครบถ้วน ได้แก่ข้อมูลการวินิจฉัยรหัสโรค (ICD-10, ICD-9) ตามเกณฑ์ของ TMI อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วยใน (Inpatient Medical Record Completeness Rate) หมายถึง ดัชนีชี้วัดเปอร์เซ็นต์หรือสัดส่วนของเวชระเบียน

	(Chart) ผู้ป่วยใน (IPD) ที่ได้รับการบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาลจากแพทย์ พยาบาล และทีมสหวิชาชีพ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมาย และองค์กรรับรองคุณภาพกำหนด ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้หลังจากผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาล (Discharge)ตามเกณฑ์ของ TMI		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 99		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	1. เวชระเบียนผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการ 2. เวชระเบียนผู้ป่วยในของหน่วยบริการ โดยการสุ่มเวชระเบียน จำนวนร้อยละ 3 ของเวชระเบียนทั้งหมด		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลเวชระเบียน OP/IP จากระบบ HIS รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพเวชระเบียน		
รายการข้อมูล	A : ผลรวมคะแนนความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน B : ผลรวมคะแนนเต็มความสมบูรณ์ของเวชระเบียน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 95	2571 ≥ ร้อยละ 98	2572 ≥ ร้อยละ 99
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นส.อริญตา ศรีอาจ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางวิรัตน์ วงภาพ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ								
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+								
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.8 รังสี : ไม่พบการแพ้สารทึบรังสีซ้ำ								
ตัวชี้วัดที่	KPI 95 อุบัติการณ์การแพ้สารทึบรังสีซ้ำ								
คำนิยาม	สารทึบรังสี หมายถึง สารที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา เพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพ การแพ้สารทึบรังสี หมายถึง ผู้ป่วยมีอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับสารทึบรังสี เช่น ผื่นลมพิษ หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ผิวหนังบวมแดง หน้าบวม ลิ้นบวม ตาบวม หัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตต่ำ หายใจหอบ หายใจมีเสียงหวีด การแพ้สารทึบรังสีซ้ำ หมายถึง อาการแพ้สารทึบรังสีที่เกิดจากการให้สารทึบรังสีชนิดเดิม								
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางรังสีวิทยา ที่ต้องมีการฉีดสารทึบรังสี (contrast media)								
แหล่งข้อมูล	รายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสารทึบรังสี								
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์การแพ้สารทึบรังสีซ้ำ								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A								
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>0 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td></tr></table>			2570	2571	2572	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
2570	2571	2572							
0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายวิสันต์ ไชยมาตย์								
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.วิภาวดี แสนโคตร								

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.8 รังสี : ไม่พบการแพ้สารทึบรังสีระดับ E ขึ้นไป 2.8.1 มีการคัดกรองผู้ป่วยก่อนใช้สารทึบรังสี		
ตัวชี้วัดที่	OKR 95.1 อัตราผู้ป่วยได้รับการคัดกรองก่อนใช้สารทึบรังสี		
คำนิยาม	การคัดกรองผู้ป่วยก่อนใช้สารทึบรังสี หมายถึง การคัดกรองผู้ป่วยก่อนการนัดตรวจ/ก่อนการตรวจพิเศษทางรังสี เพื่อให้ทราบถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้าม และข้อควรระวังต่างๆ เช่น LMP/UPT, ประวัติการแพ้ยา/ประวัติการแพ้สารทึบรังสี/โรคประจำตัว เช่น โรคหืด โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์เป็นพิษ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น ได้แก่ BUN, Cr, eGFR และ น้ำหนักและส่วนสูง เป็นต้น เพื่อใช้ในการเตรียมตัวผู้ป่วยและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างบริการทางรังสี		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางรังสีวิทยา ที่ต้องมีการฉีดสารทึบรังสี (contrast media)		
แหล่งข้อมูล	การบันทึกการคัดกรองในเอกสาร ได้แก่ ใบส่งตรวจ ใบยินยอมในการตรวจ		
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองก่อนใช้สารทึบรังสี B = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับสารทึบรังสีทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายวิสันต์ ไชยมาตย์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.วิภาวดี แสนโคตร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.8 รังสี : ไม่พบการแพ้สารทึบรังสีซ้ำ 2.8.2 มีการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างการฉีดสารทึบรังสี (ก่อนและหลังทำ) ทุกราย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 95.2 อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างการฉีดสารทึบรังสี (ก่อนและหลังทำ)			
คำนิยาม	การเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างการฉีดสารทึบรังสี คือ การวัด vital sign และสังเกตอาการผู้ป่วยหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ร่วมกับการซักถามเป็นระยะ ตลอดการให้บริการ พร้อมทั้งทำการบันทึกในเอกสาร ทั้ง ก่อน, หว่าง และหลังฉีดสารทึบรังสี ดังภาคผนวกที่...			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางรังสีวิทยา ที่ต้องมีการฉีดสารทึบรังสี (contrast media)			
แหล่งข้อมูล	รายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสารทึบรังสี			
รายการข้อมูล	A = ผู้ป่วยที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยระหว่างการฉีดสารทึบรังสี (ก่อนและหลังทำ) B = ผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสารทึบรังสีทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 ร้อยละ 100	2571 ร้อยละ 100	2572 ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายวิสันต์ ไชยมาตย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.วิภาวดี แสนโคตร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.8 รังสี : ไม่พบการแพ้สารทึบรังสีซ้ำ 2.8.3 มีการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังฉีดสารทึบรังสี 30 นาที		
ตัวชี้วัดที่	OKR 95.3 อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังฉีดสารทึบรังสี 30 นาที ทุกราย		
คำนิยาม	การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยภายหลังฉีดสารทึบรังสี คือ การวัด vital sign และสังเกตอาการผู้ป่วยหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ร่วมกับการซักถามอาการภายหลังการฉีดสารทึบรังสีไม่น้อยกว่า 30 นาที พร้อมทั้งทำการบันทึกในเอกสาร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยปลอดภัยจากอาการไม่พึงประสงค์ พร้อมให้คำแนะนำผู้ป่วยในการปฏิบัติตนหลังฉีดสารทึบรังสี ดังภาคผนวกที่....		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการทางรังสีวิทยา ที่ต้องมีการฉีดสารทึบรังสี (contrast media)		
แหล่งข้อมูล	จากการบันทึกข้อมูลการเฝ้าระวัง		
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการเฝ้าระวังผู้ป่วยหลังฉีดสารทึบรังสี 30 นาที B= จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการฉีดสารทึบรังสีทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายวิสันต์ ไชยมาตย์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.วิภาวดี แสนโคตร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9.1 ไม่พบอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป			
ตัวชี้วัดที่	KPI 96 อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป			
คำนิยาม	การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การรับส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ การบันทึกผล ไปจนถึงการรายงานผล ที่ส่งผลให้ผลการตรวจที่รายงานต่อผู้ส่งตรวจ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ อุบัติการณ์ระดับ E ขึ้นไป หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event) ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ป่วยแล้ว และมีผลกระทบต่อผู้ป่วยในระดับใดระดับหนึ่ง ตั้งแต่ ต้องได้รับการดูแลเพิ่มเติม (ระดับ E) ไปจนถึง เกิดอันตรายร้ายแรงหรือเสียชีวิต (ระดับ I)			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = จำนวนอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ.อุมาพร ศรีมันตะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ.สุภาพ บุญสา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9. Lab และคลังเลือด : 2.9.1 ไม่พบอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป 2.9.1.1 Lab เคมีคลินิก			
ตัวชี้วัดที่	OKR 96.1 อุตบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไปที่ Lab เคมีคลินิก			
คำนิยาม	อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการตรวจหรือรายงานผล คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และจัดอยู่ในระดับความรุนแรง ตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มาได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = จำนวนอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทนพญ.อุมาพร ศรีมันตะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทนพญ.สุภาพ บุญสา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9. Lab และคลังเลือด : 2.9.1 ไม่พบอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป 2.9.1.2 Lab จุลชีววิทยา			
ตัวชี้วัดที่	OKR 96.2 อุตบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไปที่ Lab จุลชีววิทยา			
คำนิยาม	อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการตรวจหรือรายงานผล คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และจัดอยู่ในระดับความรุนแรง ตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = จำนวนอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทนพญ.อุมาพร ศรีมันตะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทนพ.รัก พลจำ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9. Lab และคลังเลือด : 2.9.1 ไม่พบอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป 2.9.1.3 Lab โลหิตวิทยา			
ตัวชี้วัดที่	OKR 96.3 อุตการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไปที่ Lab โลหิตวิทยา			
คำนิยาม	อุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา ครอบคลุมการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ผลการตรวจหรือรายงานผล คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และจัดอยู่ในระดับความรุนแรง ตั้งแต่ระดับ E ขึ้นไป			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = จำนวนอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาคลาดเคลื่อนระดับ E ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ.อุมาพร ศรีมันตะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพ.รัก พลจำ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9.2 ไม่พบการรายงานค่าวิกฤติไม่ทันเวลา			
ตัวชี้วัดที่	KPI 97 อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤติไม่ทันเวลา			
คำนิยาม	ค่าวิกฤติ หมายถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีค่าอยู่นอกช่วงอ้างอิง (Reference Interval) ในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อผู้ป่วย หากไม่ได้รับการรักษาหรือดำเนินการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน (ค่าวิกฤติ มีดังภาคผนวกที่.....) การรายงานค่าวิกฤติ หมายถึง กระบวนการที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อยู่ในบัญชีค่าวิกฤติ โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย หลังจากตรวจพบผลค่าวิกฤติ ภายใน 15 นาที ผ่านทางโทรศัพท์และบันทึกหลักฐานการรายงานผลทุกครั้ง ระยะเวลาในการรายงานค่าวิกฤติ นับตั้งแต่ มีการรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจนถึงเวลาที่หอผู้ป่วยกดยืนยันการรับทราบผล			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤติไม่ทันเวลา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ.อุมาพร ศรีมันตะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ.สุภาพ บุญสา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ									
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+									
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)									
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร									
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9.2 ไม่พบการรายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลา 2.9.2.1 Lab เคมี									
ตัวชี้วัดที่	OKR 97.1 อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลาที่ Lab เคมีคลินิก									
คำนิยาม	ค่าวิกฤต Lab เคมีคลินิก หมายถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของงานเคมีคลินิกที่มีค่าอยู่นอกช่วงอ้างอิง ในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อผู้ป่วย หากไม่ได้รับการรักษาหรือดำเนินการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน รายการตามบัญชีค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้แก่ Glucose, Sodium, Potassium, CO ₂ , Calcium, Magnesium และ Trop-T การรายงานค่าวิกฤต หมายถึง กระบวนการที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อยู่ในบัญชีค่าวิกฤต โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย หลังจากตรวจพบผลค่าวิกฤต ภายใน 15 นาที ผ่านทางโทรศัพท์และบันทึกหลักฐานการรายงานผลทุกครั้ง ระยะเวลาในการรายงานค่าวิกฤต นับตั้งแต่ มีการรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจนถึงเวลาที่หอผู้ป่วยกดยืนยันการรับทราบผล									
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง									
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม									
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)									
รายการข้อมูล	A = อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤต Lab เคมีคลินิกไม่ทันเวลา									
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A									
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **									
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>0 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td></tr></table>	2570	2571	2572	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง			
2570	2571	2572								
0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง								
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ.อุมาพร ศรีมันตะ									
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ.สุภาพ บุญสา									

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9.2 ไม่พบการรายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลา 2.9.2.2 Lab จุลชีววิทยา		
ตัวชี้วัดที่	OKR 97.2 อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤต ไม่ทันเวลาที่ Lab จุลชีววิทยา		
คำนิยาม	ค่าวิกฤติ Lab จุลชีววิทยา หมายถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของงานจุลชีววิทยาที่มีค่าอยู่นอกช่วงอ้างอิง ในระดับที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต หรือก่อให้เกิดภาวะคุกคามต่อผู้ป่วย หากไม่ได้รับการรักษาหรือดำเนินการทางการแพทย์อย่างเร่งด่วน รายการตามบัญชีค่าวิกฤติทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้แก่ Hemoculture พบเชื้อ การรายงานค่าวิกฤติ หมายถึง กระบวนการที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อยู่ในบัญชีค่าวิกฤติ โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย หลังจากตรวจพบผลค่าวิกฤติ ภายใน 15 นาที ผ่านทางโทรศัพท์และบันทึกหลักฐานการรายงานผลทุกครั้ง ระยะเวลาในการรายงานค่าวิกฤติ นับตั้งแต่ มีการรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจนถึงเวลาที่หอผู้ป่วยกดยืนยันการรับทราบผล		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)		
รายการข้อมูล	A = อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤติ Lab จุลชีววิทยาไม่ทันเวลา		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ.อุมาพร ศรีมันตะ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพ.รัก พลจำ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9.2 ไม่พบการรายงานค่าวิกฤตไม่ทันเวลา 2.9.2.3 Lab โลหิตวิทยา			
ตัวชี้วัดที่	OKR 97.3 อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤต ไม่ทันเวลาที่ Lab โลหิตวิทยา			
คำนิยาม	ค่าวิกฤต Lab โลหิตวิทยา (Critical Value / Panic Value in Hematology) หมายถึง ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Lab) ในหมวดโลหิตวิทยา (เช่น การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด หรือ CBC และการแข็งตัวของเลือด) ที่มีค่าสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอย่างรุนแรง จนเป็นสัญญาณเตือนว่าผู้ป่วยกำลังอยู่ในภาวะอันตรายขั้นวิกฤต มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิต หรือเกิดความพิการถาวรอย่างเฉียบพลัน หากไม่ได้รับการรายงานผลให้แพทย์ทราบและทำการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน การรายงานค่าวิกฤต หมายถึง กระบวนการที่ห้องปฏิบัติการดำเนินการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่อยู่ในบัญชีค่าวิกฤต โรงพยาบาลมหาสารคาม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์หรือผู้รับผิดชอบการดูแลผู้ป่วย หลังจากตรวจพบผลค่าวิกฤต ภายใน 15 นาที ผ่านทางโทรศัพท์และบันทึกหลักฐานการรายงานผลทุกครั้ง ระยะเวลาในการรายงานค่าวิกฤต นับตั้งแต่ มีการรับรองผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จนถึงเวลาที่หอผู้ป่วยกดยืนยันการรับทราบผล			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = อุบัติการณ์การรายงานค่าวิกฤต Lab โลหิตวิทยาไม่ทันเวลา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพญ.วิชุดา ภารวงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพ.สุรมนตรี อุปจันโท			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9.3 .ไม่พบจ่ายเลือดผิดคนผิดหมู่ผิดชนิด			
ตัวชี้วัดที่	KPI 98 อุบัติการณ์จ่ายเลือดผิดคนผิดหมู่ผิดชนิด			
คำนิยาม	การจ่ายเลือดและส่วนประกอบของเลือด หมายถึง การจ่ายเลือดทั้งส่วนพลาสมาและเม็ดเลือดแดง หรือ ส่วนประกอบของเลือด โดยผ่านทางหลอดเลือดดำ อุบัติการณ์จ่ายเลือดผิดคน ผิดหมู่ ผิดชนิด หมายถึง เหตุการณ์ที่มีการจ่ายเลือดหรือผลิตภัณฑ์เลือดแก่ผู้ป่วย ที่ไม่ตรงกับที่ควรได้รับ ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการระบุตัวตน การตรวจสอบความเข้ากันได้ หรือการจัดเตรียมเลือด			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มารับการรักษาให้เลือดที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = อุบัติการณ์การการจ่ายเลือดผิดคนผิดหมู่ผิดชนิด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพ.อาทิตย์ พิมพักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายวิฑูรย์ กองบุตร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.9.3 ไม่พบให้เลือดผิดคนผิดหมู่ผิดชนิด 2.9.3.1 การติดสติ๊กเกอร์จากระบบ AI ที่จะรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อรับเลือดถูกคน (ขั้นตอนก่อนเข้าเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Automate มีการPrint สติ๊กเกอร์ผู้ป่วยจากระบบ AI เพื่อมาติดหลอดตัวอย่าง) เพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 98.1 ร้อยละการติดสติ๊กเกอร์จากระบบ AI ที่จะรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อรับเลือดถูกต้อง			
คำนิยาม	ระบบ AI หมายถึง โปรแกรม AI ของงานธนาคารเลือด (Ai version professional) ซึ่งประกอบด้วยชื่อ-สกุล, HN., Ward, อายุของคนไข้และ แถบ barcode lab number ที่เชื่อมโยงกับระบบ LIS เพื่อให้เครื่อง Automate ทำงานตามคำสั่งจาก barcode นั้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มารับการรักษาและให้เลือดที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล (HRMS)			
รายการข้อมูล	A = จำนวนผู้ป่วยที่ติดสติ๊กเกอร์จากระบบ AI เพื่อรับเลือดที่มีการสุ่มตรวจสอบถูกต้อง B = จำนวนสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยที่มีการให้เลือดทั้งหมดที่สุ่มตรวจสอบ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) x 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ทพ.อาทิตย์ พิมพ์ภักดี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายวิฑูรย์ กองบุตร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.10. พยาธิวิทยากายวิภาค : ผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลา
ตัวชี้วัดที่	KPI 99 อัตราผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลา
คำนิยาม	Precision Medicine (เวชศาสตร์แม่นยำ) ในบริบทของ Pathology คือการวินิจฉัยโรคที่ก้าวข้ามการดูเพียงสัณฐานวิทยา (Morphology) ของเซลล์และเนื้อเยื่อไปสู่การวิเคราะห์ในระดับ โมเลกุลและพันธุกรรม (Molecular Pathology) เพื่อระบุความผิดปกติจำเพาะ, การกลายพันธุ์ (Mutations), หรือ Biomarkers ที่ซ่อนอยู่ในรอยโรคนั้นๆ ทันเวลา หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่ส่งส่งตรวจจนถึงออกผล ไม่เกิน 4 สัปดาห์
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	1.โรคมะเร็งเต้านม 2. โรคมะเร็งปอด 3.โรคมะเร็งทางนรีเวช
แหล่งข้อมูล	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค
รายการข้อมูล	A=จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการตรวจ ER, PR , HER-2 และ Ki-67 ที่มีผลถูกต้อง ทันเวลา B=จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการตรวจ ER, PR , HER-2 และ Ki-67ทั้งหมด C= จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการตรวจ EGFR mutation ที่มีผลถูกต้อง ทันเวลา D= จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการตรวจ EGFR mutation ทั้งหมด E=จำนวนผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชที่ได้รับการตรวจ MMR and P53 ที่มีผลถูกต้อง ทันเวลา F= จำนวนผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชที่ได้รับการตรวจ MMR and P53 ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A+C+E) / (B+D+F) * 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 80	≥ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นส.สุพรรณี หารคำ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิน จิตีพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.10. พยาธิวิทยากายวิภาค : ผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลา 2.10.1 โรคมะเร็งเต้านม			
ตัวชี้วัดที่	OKR 99.1 อัตราผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลาในโรคมะเร็งเต้านม			
คำนิยาม	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจ ER, PR , HER-2 และ Ki-67			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้รับการตรวจ ER, PR , HER-2 และ Ki-67			
แหล่งข้อมูล	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค			
รายการข้อมูล	A=จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการตรวจ ER, PR , HER-2 และ Ki-67 ที่มีผลถูกต้อง ทันเวลา B=จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการตรวจ ER, PR , HER-2 และ Ki-67ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นส.สุพรรณิ หารคำ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิฐ ฐิติพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.10. พยาธิวิทยากายวิภาค : ผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลา 2.10.2 โรคมะเร็งปอด			
ตัวชี้วัดที่	OKR 99.2 อัตราผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลาในโรคมะเร็งปอด			
คำนิยาม	ผู้ป่วยมะเร็งปอดได้รับการตรวจ EGFR mutation			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งปอด			
แหล่งข้อมูล	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค			
รายการข้อมูล	A= จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการตรวจ EGFR mutation ที่มีผลถูกต้อง ทันเวลา B= จำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับการตรวจ EGFR mutation ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ร้อยละ50	≥ ร้อยละ 60	ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายสนธิ รัตนเมือง			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิญ จิติพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.10. พยาธิวิทยากายวิภาค : ผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลา 2.10.3 โรคมะเร็งทางนรีเวช			
ตัวชี้วัดที่	OKRs 99.3 อัตราผลการตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยการแพทย์แม่นยำ มีความถูกต้องและทันเวลาในโรคมะเร็งทางนรีเวช			
คำนิยาม	ผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชได้รับการตรวจ MMR and P53			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวช			
แหล่งข้อมูล	กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค			
รายการข้อมูล	A=จำนวนผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชที่ได้รับการตรวจ MMR and P53 ที่มีผลถูกต้องทันเวลา B= จำนวนผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชที่ได้รับการตรวจ MMR and P53 ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวชุลีพร สืบสาน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ธนิส จิตีพรรณกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.11 นิติเวชวิทยา : ไม่พบการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตรวจ วิเคราะห์ทางนิติเวช วิทยาคลาดเคลื่อน (เช่น ลำไส้/ ผิดสิ่งส่งตรวจ/ ผิดวิธีการ/ผลคลาดเคลื่อน) ระดับ E ขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่	KPI 100 จำนวนปฏิบัติการการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ ทางนิติเวช วิทยาคลาดเคลื่อน ระดับ 3 ขึ้น
คำนิยาม	การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ ทางนิติเวชวิทยาคลาดเคลื่อน หมายถึง การตรวจลำไส้/ ผิดสิ่งส่งตรวจ/ ผิดวิธีการ/ผลคลาดเคลื่อน การตรวจลำไส้ หมายถึง การตรวจชั้นสูตรบาดแผล ≥ 3 วัน , รายงานผลชั้นสูตรศพ > 45 วัน ผิดสิ่งส่งตรวจ หมายถึง ความผิดพลาดในขั้นตอนก่อนการตรวจวิเคราะห์ เช่น ติดป้าย ชื้อสลับกัน สิ่งส่งตรวจไม่ตรงกับชนิดที่ต้องการตรวจ ผิดวิธีการ หมายถึง การเก็บรักษาหรือนำส่งวัตถุพยานทางคดีหรือร่างกายมนุษย์ไป ตรวจวิเคราะห์ไม่ตรงตามกระบวนการที่กำหนด เช่น เก็บสารกันเสียผิดประเภท การปนเปื้อน ผลคลาดเคลื่อน หมายถึง ข้อผิดพลาดในกระบวนการชั้นสูตร เช่น ระบุสาเหตุการตาย ผิดพลาด ประเมินระยะเวลาการเสียชีวิตคลาดเคลื่อน ดีความบาดแผลผิดพลาดหรือ การปนเปื้อนของหลักฐาน ระดับความรุนแรง ระดับ 3 ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ 3 : ต้องแก้ไข มีผลกระทบชั่วคราว ระดับ 4 : ไม่บรรลุผลสำเร็จ ความเสียหายรุนแรงชั่วคราว ระดับ 5 : เสียหายอย่างรุนแรง เช่น ระบุอัตลักษณ์บุคคลผิดพลาด หรือความผิดพลาด ในการรายงานผลชั้นสูตรจนนำไปสู่การดำเนินคดีผิดพลาด
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ศพคดี และผู้ป่วยคดีที่ได้รับการตรวจชั้นสูตร
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนการรับส่งสิ่งส่งตรวจ

รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์การตรวจวิเคราะห์และรายงานผลการตรวจ ทางนิติเวชวิทยา คลาดเคลื่อน ระดับ 3 ขึ้นไป			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นพ.ยศวริศ จรรย์ยานนท์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ยศวริศ จรรย์ยานนท์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.11 นิติเวชวิทยา : ไม่พบการตรวจวิเคราะห์และรายงานผลตรวจ วิเคราะห์ทางนิติเวช วิทยาคลาดเคลื่อน (เช่น ลำไส้/ ผิดสิ่งส่งตรวจ/ ผิดวิธีการ/ผลคลาดเคลื่อน) ระดับ E ขึ้นไป 2.11.1 ไม่พบการระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดพลาด เกณฑ์ 0 ครั้ง			
ตัวชี้วัดที่	OKR 100.1 อุบัติการณ์ระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดพลาด			
คำนิยาม	ระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดพลาด หมายถึง การระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดจากความเป็นจริง ได้แก่ การระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดพลาดจากความคลาดเคลื่อนในการชันสูตร และการระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดพลาดจากการสวมสิทธิ์ การสวมสิทธิ์ หมายถึง การใช้ตัวตนผู้อื่นมาระบุเป็นตัวตนของตนเอง			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ศพคดี และผู้ป่วยคดีที่ได้รับการตรวจชันสูตร			
แหล่งข้อมูล	ทะเบียนการชันสูตรศพและผู้ป่วยคดีโดยแพทย์นิติเวช ทะเบียนการตรวจชันสูตรของงานเวชระเบียน			
รายการข้อมูล	A : การระบุตัวผู้เสียชีวิตผิดพลาด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นพ.ยศวริศ จรรย์ยานนท์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.ยศวริศ จรรย์ยานนท์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.12. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) : ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกระยะที่2			
ตัวชี้วัดที่	KPI 101 อัตราหมู่บ้านที่เกิดโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2			
คำนิยาม	พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกระยะที่2 หมายถึง พื้นที่ที่ไม่สามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกให้สงบได้ภายใน 28 วันนับจากวันเริ่มป่วยของผู้ป่วยรายแรกในชุมชน(Index case) และพบผู้ป่วยใหม่ในสัปดาห์ที่ 5 หรือสัปดาห์อื่นๆ เป็นต้นไปในหมู่บ้านเดียวกัน สอบสวนโรคแล้วมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายแรก			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2 เท่ากับ 0			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่			
แหล่งข้อมูล	1.ฐานข้อมูลโปรแกรม DDS 2.ทะเบียนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 3.แบบบันทึกการสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้าน / ชุมชน (House Index ; Container Index)			
รายการข้อมูล	1.จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกวันเริ่มป่วยเกิน28 วันหลังจากผู้ป่วยรายแรก 2.จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A=จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกวันเริ่มป่วยเกิน28 วันหลังจากผู้ป่วยรายแรก B=จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกทั้งหมด สูตร = $\frac{A}{B} \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเดิม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 0	ร้อยละ 0	ร้อยละ 0	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.12. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) : ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2 2.12.1 การรายงาน DDS โรคไข้เลือดออกทันเวลา			
ตัวชี้วัดที่	OKR 101.1 อัตราการรายงาน DDS โรคไข้เลือดออกทันเวลา			
คำนิยาม	การรายงาน DDS หมายถึง จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ที่แพทย์วินิจฉัยโรค ไข้เลือดออก / สงสัยไข้เลือดออก ถูกบันทึกในระบบเฝ้าระวังโรค DDS ภายใน 24 ชั่วโมง			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	อัตราการรายงาน DDS โรคไข้เลือดออกทันเวลาร้อยละ100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ที่วินิจฉัยโดยแพทย์			
แหล่งข้อมูล	1.ฐานข้อมูลโปรแกรม DDS 2.ฐานข้อมูลผู้ป่วย OPD / IPD ในโรงพยาบาล 3.แบบบันทึกทะเบียนผู้ป่วยในหอผู้ป่วย			
รายการข้อมูล	1.จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในระบบรายงาน DDS 2.จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกในระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A=จำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในระบบรายงาน DDS B=จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกในระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล สูตร = $\frac{A}{B} \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 95	100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2.12. การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ (DHS) : ป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกระยะที่ 2 2.12.2 อัตราหมู่บ้านที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI/CI)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 101.2 อัตราหมู่บ้านที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI/CI) ผ่านเกณฑ์			
คำนิยาม	หมู่บ้านที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI/CI) คือ ตัวชี้วัดความหนาแน่นของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	อัตราการรายงาน DDS โรคไข้เลือดออกทันเวลาร้อยละ100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนหมู่บ้านที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลาย			
แหล่งข้อมูล	1.ฐานข้อมูลโปรแกรม DDS 2.ฐานข้อมูลผู้ป่วย OPD / IPD ในโรงพยาบาล 3.แบบบันทึกทะเบียนผู้ป่วยในหอผู้ป่วย			
รายการข้อมูล	A : จำนวนหมู่บ้านที่มีดัชนีลูกน้ำยุงลาย B : จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยโรคไข้เลือดออกในระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 95	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวณัฐจิรา อัมปะมะโน			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.1 การระงับความรู้สึก : ไม่พบอุบัติการณ์ Cardiac arrest ขณะให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน		
ตัวชี้วัดที่	KPI 102 อุบัติการณ์ Cardiac arrest ขณะให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน		
คำนิยาม	อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง จำนวนอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เท่ากับ 0		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึก		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HRMS On cloud ของโรงพยาบาล เอกสารการทบทวน 12 กิจกรรม สรุปสถิติข้อมูลทางวิสัยทัศน์		
รายการข้อมูล	A : จำนวนอุบัติการณ์ Cardiac arrest ขณะให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0 ครั้ง		
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวดวงแก้ว พรณพราว		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.พัชรมัย ศรีพรม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.1 การระงับความรู้สึก : ไม่พบอุบัติการณ์ Cardiac arrest ขณะให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน 3.1.1 ความพร้อมในการเตรียมให้ยาระงับความรู้สึกเพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 102.1 ความพร้อมในการเตรียมให้ยาระงับความรู้สึก		
คำนิยาม	อุบัติการณ์ (Incident) หมายถึง จำนวนอุบัติการณ์ความไม่พร้อมในการเตรียมให้ยาผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึกที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด ความไม่พร้อมในการเตรียมให้ยาระงับความรู้สึก หมายถึง ความไม่พร้อมของการเตรียมยา เครื่องมือ อุปกรณ์ตามแนวทาง 1. One lung ventilation Anesthesia 2. Neurasthenia 3. Spine surgery		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึก		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HRMS On cloud ของโรงพยาบาล เอกสารการทบทวน 12 กิจกรรม สรุปสถิติข้อมูลทางวิสัญญี สถิติการงดและเลื่อนผ่าตัดจากการเตรียมไม่พร้อมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก สถิติการทบทวนข้อมูลการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนให้ยาระงับความรู้สึกร่วมกับ CLT		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยใน 3 กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่ทบทวนมีความพร้อมในการเตรียมให้ยาระงับความรู้สึก B : จำนวนผู้ป่วยใน 3 กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่สุ่มทบทวนทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/*100		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 85	2572 ≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภัชณีน พรหมอัน		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวดวงแก้ว พรหมพราว พญ.พัชรมัย ศรีพรม		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ						
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+						
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.1 การระงับความรู้สึก : ไม่พบอุบัติการณ์ Cardiac arrest ขณะให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดไม่เร่งด่วน 3.1.2 การประเมินและแก้ไขตาม EWS เหมาะสมก่อน ขณะและหลังให้ยาระงับความรู้สึก ขณะที่ผู้ป่วยอยู่ที่ห้องผ่าตัดเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดที่	OKR 102.2 อับัติการณ์การประเมินและแก้ไขตาม Early Warning Sign (EWS) ไม่เหมาะสมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก						
คำนิยาม	การประเมินและแก้ไขตาม EWS หมายถึง อับัติการณ์ประเมินและประเมินซ้ำและแก้ไขตาม EWS ทั้งหมด ขณะและหลังให้ยาระงับความรู้สึกในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ที่ห้องผ่าตัดตามแนวทางปฏิบัติ 1. Hypoxia in one lung ventilation anesthesia 2. Increase Intracranial Pressure (IICP) in neuroanesthesia 3. Hypovolemic shock in spine surgery						
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้มารับบริการให้ยาระงับความรู้สึก						
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HRMS On cloud ของโรงพยาบาล เอกสารการทบทวน 12 กิจกรรม สรุปสถิติข้อมูลทางวิสัญญี สถิติการงดและเลื่อนผ่าตัดจากการเตรียมไม่พร้อมก่อนให้ยาระงับความรู้สึก สถิติการทบทวนข้อมูลการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมก่อนให้ยาระงับความรู้สึกร่วมกับ CLT						
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยใน 3 กลุ่มผู้ป่วยสำคัญที่มีการทบทวน ที่ได้รับการประเมินและแก้ไขตาม Early Warning Sign (EWS) เหมาะสมก่อน ขณะและหลัง B : จำนวนผู้ป่วยใน 3 กลุ่มผู้ป่วยสำคัญทั้งหมดที่สุ่มทบทวน						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100						
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>≥ ร้อยละ 90</td><td>≥ ร้อยละ 90</td><td>≥ ร้อยละ 90</td></tr></table>	2570	2571	2572	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90
2570	2571	2572					
≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90	≥ ร้อยละ 90					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภัชณีน พรหมอัน						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวดวงแก้ว พรรณพราว พญ.พัชรมัย ศรีพรม						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาคุณภาพร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.2 การผ่าตัด : ไม่พบอุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดชนิด
ตัวชี้วัดที่	KPI 103 อุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดชนิด
คำนิยาม	การผ่าตัด หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องมือผ่าตัดเพื่อเปิด แก๊ซ ตัดต่อ หรือนำอวัยวะหรือเนื้อเยื่อบางส่วนออกจากร่างกาย โดยนับรวมทั้งการผ่าตัดที่ให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน และให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ หัตถการรุกราน (Invasive Procedure) คือ การทำหัตถการทางการแพทย์ที่มีการสอดใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือเข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ การตัด หรือการเปิดโพรง/ช่องของร่างกาย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา โดยนับรวมทั้งการทำหัตถการที่ให้ยาระงับความรู้สึกและไม่ได้ให้ยาระงับความรู้สึก ผ่าตัดผิดคน (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong patient)* (CPS102) หมายถึง การผ่าตัด หรือการทำหัตถการรุกราน (Invasive Procedure) ผิดตัวผู้ป่วย โดยที่เหตุการณ์นี้ถูกตรวจพบเมื่อใดก็ได้หลังจากที่ได้เริ่มทำหัตถการไปแล้ว ผ่าตัดผิดตำแหน่ง ผิดข้าง (Surgery or other invasive procedure performed on the wrong body part (CPS101) หมายถึง การผ่าตัด หรือการทำหัตถการรุกราน (Invasive Procedure) ผิดตำแหน่งหรือผิดอวัยวะ โดยตรวจพบหลังเริ่มทำไปแล้ว ผ่าตัดผิดชนิด (Wrong surgical or other invasive procedure performed on a patient)* (CPS103) หมายถึง การผ่าตัด หรือการทำหัตถการรุกราน (Invasive Procedure) การผ่าตัดกับผู้ป่วย ซึ่งไม่ตรงกับที่ได้รับ การยินยอมโดยมีข้อมูล (Informed Consent) ที่ได้บันทึกไว้สำหรับผู้ป่วยรายนั้น โดยทุกความเสี่ยงนี้ - เป็นอุบัติการณ์ความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการรักษาพยาบาล โดยผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาด้วยการผ่าตัด - การนับจำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง นับตามจำนวนรายครั้งของการผ่าตัด อ้างอิงจาก NHS, Revised Never Events Policy and Framework
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน	เท่ากับ 0

ระยะ 3 ปี							
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยผ่าตัดและทำหัตถการรูก้อนในห้องผ่าตัดทุกราย						
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมความเสี่ยง โปรแกรม HRMS On cloud ของโรงพยาบาล เอกสารการทบทวน 12 กิจกรรม สรุปสถิติข้อมูลทางห้องผ่าตัด สถิติการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงของห้องผ่าตัดร่วมกับ CLT						
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์ความเสี่ยงการผ่าตัดผิดคน ผิดตำแหน่ง ผิดข้าง ผิดชนิด						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>0 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td><td>0 ครั้ง</td></tr></table>	2570	2571	2572	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
2570	2571	2572					
0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสุพัตรา มุราชัย						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางประยูร จำปาปี / นพ.ชวลิต สงครามยศ						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.2 การผ่าตัด : ไม่พบอุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดชนิด 3.1.1 ไม่พบอุบัติการณ์ Mark site ที่ผิวหนังผิดพลาด
ตัวชี้วัดที่	OKR 103.1 อุบัติการณ์ Mark site ที่ผิวหนังผิดพลาด
คำนิยาม	อุบัติการณ์ Mark Site ที่ผิวหนังผิดพลาด หมายถึง ความผิดพลาดในการทำเครื่องหมาย (Marking) บริเวณผิวหนังที่จะทำการผ่าตัดหรือทำหัตถการรูก้ำ ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง หรือผิดตำแหน่ง (Wrong Site Surgery) อุบัติการณ์ Mark Site ที่ผิวหนังผิดพลาด จึงหมายถึงเหตุการณ์ที่: 1) ไม่ทำเครื่องหมาย (No Mark): ลืมทำเครื่องหมายบริเวณที่จะผ่าตัดหรือทำหัตถการ ซึ่งเป็นความผิดพลาดที่พบบ่อยและมีความเสี่ยงสูง 2) ทำเครื่องหมายผิดตำแหน่ง/ผิดข้าง (Wrong Location): ทำเครื่องหมายผิดข้าง (เช่น ทำที่เข้าซ้าย ทั้งที่ต้องผ่าขวา) หรือทำเครื่องหมายผิดระดับ (เช่น ผิดระดับกระดูกสันหลัง) 3) เครื่องหมายไม่ชัดเจน/ถูกลบ (Unclear/Wiped off): ใช้ปากกาที่ไม่เหมาะสม ทำให้เครื่องหมายเลือนหายไปหลังการเตรียมผิวหนัง หรือเครื่องหมายไม่ชัดเจนจนตีความผิดพลาด 4) ทำเครื่องหมายแบบไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน (Incorrect Protocol) คือ การทำเครื่องหมายที่ผิวหนังไม่ตรงกับเอกสารการยินยอม (Informed Consent) 5) ทำเครื่องหมายบนบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นได้หลังการเตรียมผ่าตัด (Not Visible): เช่น ทำเครื่องหมายบนส่วนที่ถูกผ้าปิดไว้ ทำให้ทีมผ่าตัดไม่สามารถตรวจสอบซ้ำได้ในขั้นตอน "Time-Out" อ้างอิง เอกสาร/แนวทาง: WHO Surgical Safety Checklist และ Patient Safety Solutions
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เท่ากับ 0
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยผ่าตัดที่ทำหัตถการเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกที่มีสองข้างที่จำเป็นต้องระบุข้างหรือการผ่าตัดที่จำเป็นต้องทำ Mark Site ที่ผิวหนังทั้งหมด
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมความเสี่ยง

	โปรแกรม HRMS On cloud ของโรงพยาบาล เอกสารการทบทวน 12 กิจกรรม สรุปสถิติข้อมูลทางห้องผ่าตัด สถิติการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงของห้องผ่าตัดร่วมกับ CLT			
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์ Mark site ที่ผิวหนังผิดพลาด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนิรมล ภูหวล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกัญญา รังสี / นพ.ชวลิต สงครามยศ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.2 การผ่าตัด : ไม่พบอุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดชนิด 3.1.2 การบันทึก Surgical safety checklist ถูกต้องและครบถ้วนเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 103.2 ร้อยละการบันทึก Surgical safety checklist ถูกต้องและครบถ้วน
คำนิยาม	อุบัติการณ์ Surgical Safety Checklist ผิดพลาด หมายถึง ความล้มเหลวในการนำแบบตรวจสอบความปลอดภัยในการผ่าตัด (Surgical Safety Checklist: SSC) มาใช้ปฏิบัติอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่องค์การอนามัยโลก (WHO) พัฒนาขึ้นเพื่อลดความผิดพลาดและภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ความผิดพลาดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การกรอกข้อมูลผิดพลาด แต่รวมถึง: 1) ไม่ใช่ Checklist เลย (Non-Utilization): ไม่มีการนำแบบตรวจสอบมาใช้ในการผ่าตัดเลยแม้แต่น้อย โดยเฉพาะในกรณีที่เร่งด่วน หรือการผ่าตัดเล็ก ๆ 2) ความไม่สมบูรณ์ (Incompleteness): การใช้ Checklist แต่กรอกไม่ครบถ้วน ตกหล่นบางรายการ หรือไม่ได้ตรวจสอบร่วมกันทั้งทีม 3) การยืนยันข้อมูลผิดพลาด: การยืนยันข้อมูลสำคัญผิดพลาด เช่น ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลผู้ป่วย ตำแหน่งผ่าตัด หรือความพร้อมของอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง อ้างอิงเอกสาร/แนวทาง: WHO Surgical Safety Checklist
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมด
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมความเสี่ยง โปรแกรม HRMS On cloud ของโรงพยาบาล สุ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของ Surgical Safety Checklist สรุปสถิติข้อมูลทางห้องผ่าตัด สถิติการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงของห้องผ่าตัดร่วมกับ CLT
รายการข้อมูล	A : จำนวนเวชระเบียนที่ Surgical safety checklist ที่สุ่มตรวจพบถูกต้องและครบถ้วน B : จำนวนเวชระเบียนที่สุ่มตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของ Surgical safety checklist ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 95	≥ ร้อยละ 98	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจันทร์เพ็ญ เสียงไพรวัลย์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางปานนาถ สุวรรณพงษ์ / นพ.ชวลิต สงครามยศ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.2 การผ่าตัด : ไม่พบอุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดชนิด 3.1.3 ไม่พบอุบัติการณ์การทำ Timeout ไม่เหมาะสม		
ตัวชี้วัดที่	OKR 103.3 อุบัติการณ์การทำ Timeout ไม่เหมาะสม		
คำนิยาม	อุบัติการณ์การทำ Timeout ไม่เหมาะสม หมายถึง การไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางการ Time-Out ซึ่งแนวทางปฏิบัติ คือ 1.ทีม Scrub time-out ร่วมกับทีมวิสัญญี และ ทีม Scrub time-out ร่วมกับแพทย์ผ่าตัด 2. ทีม Scrub time-out ร่วมกับทีมวิสัญญี และแพทย์ผ่าตัด 3. ถ้ามีการเปลี่ยนแพทย์ผู้ผ่าตัดให้มีการ Time-out ซ้ำก่อนลงมีด		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เท่ากับ 0		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยผ่าตัดทั้งหมด		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมความเสี่ยง		
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์การทำ Timeout ไม่เหมาะสม		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายขจรศักดิ์ หาดทะเล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางภคนันท์ ปะวรรณจะ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.2 การผ่าตัด : ไม่พบอุบัติการณ์การผ่าตัดผิดคน ผิดข้าง ผิดตำแหน่ง ผิดชนิด 3.1.4 ไม่พบอุบัติการณ์เครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ค้างในร่างกาย
ตัวชี้วัดที่	KPI 104 อุบัติการณ์เครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ค้างในร่างกาย
คำนิยาม	การผ่าตัด หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องมือผ่าตัดเพื่อเปิด แก๊ซ ตัดต่อ หรือนำอวัยวะหรือเนื้อเยื่อบางส่วนออกจากร่างกาย โดยนับรวมทั้งการผ่าตัดที่ให้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วไป ให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน และให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ หัตถการรุกราน (Invasive Procedure) คือ การทำหัตถการทางการแพทย์ที่มีการสอดใส่อุปกรณ์หรือเครื่องมือเข้าไปในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเจาะ การตัด หรือการเปิดโพรง/ช่องของร่างกาย เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษา โดยนับรวมทั้งการทำหัตถการที่ให้ยาระงับความรู้สึกและไม่ได้ให้ยาระงับความรู้สึก อุบัติการณ์เครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ค้างในร่างกาย (CPS307) หมายถึง การผ่าตัด การทำหัตถการทุกหัตถการ (รายครั้ง) การมีอุปกรณ์หรือสิ่งตกค้างในร่างกายผู้ป่วย หมายถึง การวางหรือทิ้งวัสดุ-อุปกรณ์ทุกชนิดไว้ในร่างกายผู้ป่วยภายหลังการผ่าตัด/ การทำหัตถการทุกหัตถการโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น การคงค้างของผ้าซับโลหิตหรือเครื่องมือไว้ในร่างกายผู้ป่วย เป็นต้น การนับจำนวนอุบัติการณ์ความเสี่ยง นับตามจำนวนรายครั้งของการผ่าตัด อ้างอิงจาก NHS, Provisional publication of Never Events reported
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เท่ากับ 0
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยผ่าตัดและทำหัตถการรุกรานในห้องผ่าตัดทั้งหมด
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมความเสี่ยง โปรแกรม HRMS On cloud ของโรงพยาบาล เอกสารการทบทวน 12 กิจกรรม สรุปลิติข้อมูลทางห้องผ่าตัด สถิติการทบทวนอุบัติการณ์ความเสี่ยงของห้องผ่าตัด
รายการข้อมูล	A : อุบัติการณ์เครื่องมือ/วัสดุ อุปกรณ์ค้างในร่างกาย

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวพนัสดา ชาวพงษ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายสุรพงษ์ ไทยมิตร / นพ.ชวลิต สงครามยศ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.3 อาหารและโภชนาบำบัด : เพิ่มผู้ป่วย Stroke และ Sepsis ใน SICU และ TICU ที่มีค่า Nutrition Alert Form (NAF) ลดลง
ตัวชี้วัดที่	KPI 105 อัตราผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU ที่มีค่า Nutrition Alert Form Score (NAF score) ลดลง
คำนิยาม	NAF Score ย่อมาจาก Nutrition Alert Form Score เป็นแบบประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ คัดกรองภาวะโภชนาการเบื้องต้น ในผู้ป่วย เพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) NAF Score จะมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว อาหารที่ได้รับ อาการทางระบบทางเดินอาหาร ภาวะวิกฤติ หรือโรคประจำตัว การแปลผลคะแนน (โดยทั่วไป): 0 – 5 คะแนน (NAF = A) : ไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรือมีภาวะทุพโภชนาการระดับน้อย 6 – 10 คะแนน (NAF = B) : พบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลาง (Moderate Malnutrition) มักจะมีการส่งต่อให้ทีมโภชนาการประเมินต่อ ≥ 11 คะแนน (NAF = C) : มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง (Severe Malnutrition) มักจะต้องส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลโภชนาบำบัดโดยเร็ว NAF Score ลดลง หมายถึง คะแนน NAF Score ลดลง เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ ผู้ป่วย Stroke ที่อยู่ใน SICU และ TICU ที่มีคะแนน NAF = B/C
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 60
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU
แหล่งข้อมูล	SICU และ TICU แบบประเมิน NAF
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่เข้าเกณฑ์การประเมิน NAF Score ใน SICU และ TICU ที่มีคะแนน NAF Score ลดลง

	B : จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่เข้าเกณฑ์การประเมิน NAF Score ใน SICU และ TICU ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 50	≥ ร้อยละ 55	≥ ร้อยละ 60	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสิริลักษณ์ คำมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางรติรัตน์ กสิกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.3 อาหารและโภชนบำบัด : เพิ่มผู้ป่วย Stroke และ Sepsis ใน SICU และ TICU ที่มีค่า NAF ลดลง 3.3.1 เพิ่มการคัดกรองภาวะโภชนาการผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU			
ตัวชี้วัดที่	OKR 105.1 อัตราการคัดกรองภาวะโภชนาการผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU			
คำนิยาม	การคัดกรองภาวะโภชนาการ หมายถึง วิธีส่วนต้นแรกที่ใช้ค้นหาและส่วนต่างๆ ของแต่ละบุคคลหรืออาจส่งผลต่อภาวะภาวะทุพโภชนาการ (ภาวะทุพโภชนาการ) คุณภาพโภชนาการขาดสารอาหารหรือโภชนาการเกินความสามารถในการคัดแยกความต้องการทางโภชนาการในขั้นละเอียด (การประเมินโภชนาการ) และโปรแกรมการรักษาทางโภชนบำบัด การคัดกรอง หมายถึง การคัดกรองถูกต้องและครบถ้วน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยใน SICU และ TICU ที่ ICD-10 คือ I60-I62, I69			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Stroke ใน SICU/TICU ที่ได้รับการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนแล้วพบว่าการคัดกรองภาวะโภชนาการถูกต้องและครบถ้วน B : จำนวนผู้ป่วย Stroke ใน SICU/TICU ที่ได้รับการสุ่มตรวจสอบเวชระเบียนทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B × 100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ100	ร้อยละ100	ร้อยละ100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสิริลักษณ์ คำมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางรติรัตน์ กลีกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.3 อาหารและโภชนาบำบัด : เพิ่มผู้ป่วย Stroke และ Sepsis ใน SICU และ TICU ที่มีค่า NAF ลดลง 3.3.2 เพิ่มการปฏิบัติตาม Suggestion ของนักโภชนาการ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 105.2 อัตราการตอบสนองต่อ Suggestion การให้โภชนาบำบัดของนักโภชนาการในผู้ป่วย Stroke			
คำนิยาม	การตอบสนองต่อ Suggestion ของนักโภชนาการ หมายถึง การตอบสนองในการทำ Intervention ตามคำแนะนำของนักโภชนาการ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU			
แหล่งข้อมูล	Doctor order sheet ใน SICU และ TICU			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU ที่ได้รับการตอบสนองต่อ Suggestion การใช้โภชนาบำบัดของนักโภชนาการ B : จำนวนผู้ป่วย Stroke ใน SICU และ TICU ที่นักโภชนาการ Suggestion การใช้โภชนาบำบัดทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสิริลักษณ์ คำมุงคุณ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางรติรัตน์ กสิกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.4 Sepsis ใน SICU และ TICU
ตัวชี้วัดที่	KPI 106 อัตราผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICU ที่มีค่า NAF score ลดลง
คำนิยาม	NAF Score ย่อมาจาก Nutrition Alert Form Score เป็นแบบประเมินหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ คัดกรองภาวะโภชนาการเบื้องต้น ในผู้ป่วย เพื่อค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) NAF Score จะมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว อาหารที่ได้รับ อาการทางระบบทางเดินอาหาร ภาวะวิกฤติ หรือโรคประจำตัว การแปลผลคะแนน (โดยทั่วไป): 0 – 5 คะแนน (NAF = A) : ไม่พบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ หรือมีภาวะทุพโภชนาการระดับน้อย 6 – 10 คะแนน (NAF = B) : พบความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการระดับปานกลาง (Moderate Malnutrition) มักจะมีการส่งต่อให้ทีมโภชนาการประเมินต่อ ≥ 11 คะแนน (NAF = C) : มีภาวะทุพโภชนาการรุนแรง (Severe Malnutrition) มักจะต้องส่งต่อแพทย์เพื่อดูแลโภชนาบำบัดโดยเร็ว NAF Score ลดลง หมายถึง คะแนน NAF Score ลดลง เกณฑ์การคัดเข้า ได้แก่ ผู้ป่วย Stroke ที่อยู่ใน SICU และ TICU ที่มีคะแนน NAF = B/C
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	อัตราผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICU ที่มีค่า NAF score ลดลง มากกว่า ร้อยละ 70
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICU
แหล่งข้อมูล	SICU/TICU. แบบประเมิน NAF
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICU ที่มีค่า NAF score ลดลง B : จำนวนผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICU ที่ประเมินค่า NAF ทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ60	≥ ร้อยละ65	≥ ร้อยละ70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนิธิยา นามวงศ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางรติรัตน์ กสิกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.4 Sepsis ใน SICU และ TICU 3.4.1 เพิ่มการคัดกรองภาวะโชนาการ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 106.1 อัตราการคัดกรองภาวะโชนาการผู้ป่วย Sepsis ใน SICU และ TICU			
คำนิยาม	การคัดกรองภาวะโชนาการ หมายถึง วิธีส่วนด้านแรกที่ใช้ค้นหาและส่วนต่างๆ ของแต่ละบุคคลหรืออาจส่งผลต่อภาวะภาวะทุพโชนาการ (ภาวะทุพโชนาการ) คุณภาพโชนาการขาดสารอาหารหรือโชนาการเกินความสามารถในการคัดแยกความต้องการทางโชนาการในชั้นละเอียด (การประเมินโชนาการ) และโปรแกรมการรักษาทางโชนบำบัด การคัดกรอง หมายถึง การคัดกรองถูกต้องและครบถ้วน			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Sepsis ใน SICU และ TICU			
แหล่งข้อมูล	SICU และ TICU แบบคัดกรองภาวะโชนาการ			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICUที่ได้รับการคัดกรองภาวะโชนาการ B : จำนวนผู้ป่วย Sepsis ใน SICU/TICU ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ100	ร้อยละ100	ร้อยละ100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนิธิยา นามวงศ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางรติรัตน์ กลีกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.4 Sepsis ใน SICU และ TICU 3.4.2 เพิ่มการปฏิบัติตาม Suggestion ของนักโภชนาการ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 106.2 อัตราการปฏิบัติตาม Suggestion การใช้โภชนบำบัดของนักโภชนาการ ในผู้ป่วย Sepsis			
คำนิยาม	การตอบสนองต่อ Suggestion ของนักโภชนาการ หมายถึง การตอบสนองในการทำ Intervention ตามคำแนะนำของนักโภชนาการ			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วย Sepsis ใน SICU และ TICU			
แหล่งข้อมูล	SICU และ TICU Doctor order sheet			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วย Sepsis ใน SICU และ TICU ที่ได้รับการปฏิบัติตาม Suggestion การใช้โภชนบำบัดของนักโภชนาการ B : จำนวนผู้ป่วย Sepsis ใน SICU และ TICU ที่นักโภชนาการ Suggestion การใช้โภชนบำบัดทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนิธิยา นามวงศ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางรติรัตน์ กลีกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.4 ผู้ป่วยระยะท้ายมีภาวะ Good Death
ตัวชี้วัดที่	KPI 107 ร้อยละผู้ป่วยระยะท้ายมีภาวะ Good Death
คำนิยาม	ผู้ป่วยระยะท้าย ได้แก่ CA - Advanced CA Non CA - ESRD no RRT /Neurological Disease/COPD/Congestive Heart Failure/Hepatic failure/AIDS/ผู้สูงอายุ(อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บป่วยใน 7 กลุ่มโรค/ผู้ป่วยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย ***ผู้ให้บริการทุกระดับ เป็นผู้ระบุผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะท้ายของชีวิต โดยใช้ Surprise question "คุณจะมีอาการใจหรือไม่ว่าผู้ป่วยคนนี้จะเสียชีวิตภายใน 12 เดือน ข้างหน้า?" รหัส ICD-10 คือ Z515, Z718 Good death หมายถึง ผู้ป่วยระยะท้ายที่มีครบทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ได้รับทำตาม Advance Care Planning (ACP) 2. สามารถ control symptom ได้ไม่ทุกข์ทรมานและจากไปอย่างสงบโดย Pain score $\leq$ 4 คะแนน และ Dyspnea score $\leq$ 4 คะแนน 3. เสียชีวิตตามสถานที่ที่ได้อำนาจไว้
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะท้ายที่เสียชีวิตทั้งหมด
แหล่งข้อมูล	MSKH PC Program สมุดทะเบียนผู้ป่วยประคับประคอง (Palliativecare) ทะเบียนราษฎร์
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายมีภาวะ Good death B : จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายที่เสียชีวิตทั้งหมด
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ร้อยละ 80	≥ร้อยละ 85	≥ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางมะลิ เนื่องวงษา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.มนัญญา ภิรมย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.4 ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care) : ผู้ป่วยระยะท้ายมีภาวะGood Death 3.4.1 ผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliativecare)
ตัวชี้วัดที่	OKR 107.1 ร้อยละผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliativecare)
คำนิยาม	ผู้ป่วยระยะท้าย ได้แก่ CA - Advanced CA Non CA - ESRD no RRT /Neurological Disease/COPD/Congestive Heart Failure/Hepatic failure/AIDS/ผู้สูงอายุ(อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บป่วยใน 7 กลุ่มโรค/ผู้ป่วยเด็ก(อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย ***ผู้ให้บริการทุกระดับ เป็นผู้ระบุผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะท้ายของชีวิต โดยใช้ Surprise question "คุณจะมีอาการหรือไม่ว่าผู้ป่วยคนนี้จะเสียชีวิตภายใน 12 เดือน ข้างหน้า?" กระบวนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่มีแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยที่มีประวัติของอยู่ในกลุ่มโรคสำคัญมาก ที่มีการทำแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Planning (ACP) ในการให้บริการรหัส ICD-10 คือ Z515, Z718
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประมาณการผู้ป่วยระยะท้ายที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
แหล่งข้อมูล	MSKH PC Program สมุดทะเบียนผู้ป่วยประคับประคอง (Palliativecare)
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าถึงการดูแลแบบประคับประคอง (Palliativecare) B : จำนวนประมาณการผู้ป่วยระยะท้ายที่ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ร้อยละ 70	≥ร้อยละ 75	≥ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางมะลิ เนืองวงษา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.มนัญญา ภิรมย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.4 ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative care) : ผู้ป่วยระยะท้ายมีภาวะ Good Death 3.4.2 ผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าถึงกระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) มีภาวะ Good death
ตัวชี้วัดที่	OKR 107.2 ร้อยละผู้ป่วยระยะท้ายที่เข้าถึงกระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) มีภาวะ Good death
คำนิยาม	ผู้ป่วยระยะท้าย ได้แก่ CA - Advanced CA Non CA - ESRD no RRT /Neurological Disease/COPD/Congestive Heart Failure/Hepatic failure/AIDS/ผู้สูงอายุ(อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บป่วยใน 7 กลุ่มโรค/ผู้ป่วยเด็ก (อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย ***ผู้ให้บริการทุกระดับ เป็นผู้ระบุผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะท้ายของชีวิต โดยใช้ Surprise question "คุณจะมีอาการหรือไม่ว่าผู้ป่วยคนนี้จะเสียชีวิตภายใน 12 เดือน ข้างหน้า?" กระบวนการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) หมายถึง การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตที่มีแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ในผู้ป่วยที่มีประวัติของอยู่ในกลุ่มโรคสำคัญมาก ที่มีการทำแผนการดูแลล่วงหน้า Advance Care Planning (ACP) ในการให้บริการ รหัส ICD-10 คือ Z515, Z718 Good death หมายถึง ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีครบทั้ง 3 ข้อดังต่อไปนี้ 1. ได้รับทำตาม Advance Care Planning (ACP) 2. สามารถ control symptom ได้ไม่ทุกข์ทรมานและจากไปอย่างสงบ โดย Pain score ≤ 4 คะแนน และ Dyspnea score ≤ 4 คะแนน 3. เสียชีวิตตามสถานที่ที่ได้วางแผนไว้
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	$\geq$ ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เข้าสู่กระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
แหล่งข้อมูล	MSKH PC Program

	สมุดทะเบียนผู้ป่วยประคับประคอง (Palliativecare)		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เข้าสู่กระบวนการการดูแลแบบประคับประคอง (Palliativecare) มีภาวะ Gooddeath B : จำนวนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เสียชีวิตทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B*100$		
ระยะเวลาที่ต้อง รายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการ ดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ร้อยละ 80	2571 ≥ร้อยละ 85	2572 ≥ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางมะลิ เนื่องวงษา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.มนัญญา ภิรมย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.4 ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliativecare) : ผู้ป่วยระยะท้ายมีภาวะ Good Death 3.4.3 ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการติดตามเยี่ยมบ้านเพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 107.3 ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน		
คำนิยาม	ผู้ป่วยระยะท้าย ได้แก่ CA - Advanced CA Non CA - ESRD no RRT /Neurological Disease/COPD/Congestive Heart Failure/Hepatic failure/AIDS/ผู้สูงอายุ(อายุ > 60 ปี) ที่เจ็บป่วยใน 7 กลุ่มโรค/ผู้ป่วยเด็ก(อายุ 0-14 ปี) ประคับประคองระยะท้าย ***ผู้ให้บริการทุกระดับ เป็นผู้ระบุผู้ป่วยที่เข้าสู่ภาวะท้ายของชีวิต โดยใช้ Surprise question "คุณจะมีอาการใจหรือไม่ที่ผู้ป่วยคนนี้จะเสียชีวิตภายใน 12 เดือน ข้างหน้า?" การติดตามเยี่ยมบ้านหมายถึง การติดตามเยี่ยมโดยเครือข่ายการดูแลประคับประคองในชุมชน (เยี่ยมบ้านโดยตรง/โทรศัพท์/Line /Telemedicine) : PPS 10-20 % ติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห์ PPS 30-40 % ติดตามเยี่ยม 2 สัปดาห์ PPS 50-70 % ติดตามเยี่ยม 1-2 เดือน PPS 70-100 % ติดตามเยี่ยม 3 เดือน		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 50		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะท้าย (Palliativecare)		
แหล่งข้อมูล	หน่วยบริหารบรรเทา รพ.มหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายที่ได้รับการติดตามเยี่ยมบ้าน B : จำนวนผู้ป่วยระยะท้ายทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเดิม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ร้อยละ 40	≥ร้อยละ 45	≥ร้อยละ 50
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายปรเมษฐ์ ปุริมายะตา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.มนัญญา ภิรมย์		

นียมตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ									
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+									
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)									
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร									
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.5 การระงับความปวด (Pain control) : เพิ่มอัตราการจัดการความปวดอย่างเป็นระบบในผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันจนบรรเทาความปวด									
ตัวชี้วัดที่	KPI 108 อัตราผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันได้รับการจัดการความปวดอย่างเป็นระบบจนบรรเทาความปวด									
คำนิยาม	อาการปวดแบบเฉียบพลัน หมายถึง ความปวดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่สั้น มีปัญหาไม่นานขึ้นกับสภาพของการบาดเจ็บและพยาธิสภาพ โดยมากเกิดจากการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้เฉียบพลันที่รู้สาเหตุ สามารถอธิบายและบอกถึงระยะเวลาของการเกิดความปวดได้ โดยมากมีความวิตกกังวลและอาการแสดงทางคลินิกที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาท sympathetic มากเกินปกติ เช่น หัวใจเต้นเร็ว อัตรา การหายใจถี่กว่าปกติ ความดันโลหิตสูงขึ้น เหงื่อออก ม่านตาขยายและผิวหนังซีด เป็นต้น และเมื่อพยาธิสภาพหายไป ความปวดจะหายไปด้วย เช่น ความปวดแผลผ่าตัด แผลอุบัติเหตุ เป็นต้น การจัดการความปวดอย่างเป็นระบบ หมายถึง มีการประเมินระดับความปวด ให้การ รักษาพยาบาลตามระดับความปวดที่ประเมินได้ทั้งรูปแบบใช้ยาและไม่ใช้ยา มีการประเมินซ้ำสอดคล้องตามกิจกรรมการรักษาพยาบาล จนระดับความปวดลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับที่ต้องการการรักษา ร่วมกับการบันทึกการรักษาพยาบาลครบถ้วน ตามวิธีปฏิบัติการจัดการความปวด (MKH-WI-QCC-007) ของโรงพยาบาลที่กำหนดไว้ ระดับความปวดที่ต้องได้รับการจัดการความปวดอย่างเป็นระบบ 1.ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี (Fully conscious) <table><tr><td>กลุ่มอายุ</td><td>เครื่องมือ</td><td>คะแนนที่ต้องการการจัดการความปวด</td></tr><tr><td>อายุ 0 – 6 สัปดาห์ (Preterm และ term)</td><td>NIPS</td><td>> 4 ต้องการการรักษา</td></tr><tr><td>อายุ 6 สัปดาห์ – 6 ปี</td><td>FLACCS</td><td>> 3 ต้องการการรักษา</td></tr></table>	กลุ่มอายุ	เครื่องมือ	คะแนนที่ต้องการการจัดการความปวด	อายุ 0 – 6 สัปดาห์ (Preterm และ term)	NIPS	> 4 ต้องการการรักษา	อายุ 6 สัปดาห์ – 6 ปี	FLACCS	> 3 ต้องการการรักษา
กลุ่มอายุ	เครื่องมือ	คะแนนที่ต้องการการจัดการความปวด								
อายุ 0 – 6 สัปดาห์ (Preterm และ term)	NIPS	> 4 ต้องการการรักษา								
อายุ 6 สัปดาห์ – 6 ปี	FLACCS	> 3 ต้องการการรักษา								

	อายุ 6 – 10 ปี	-Numeric Rating Scale (NRS) - Face Pain Scale – Revised (FPS - R)	> 4 ต้องการการรักษา > 4 ต้องการการรักษา
	อายุ > 10 ปี	Numeric Rating Scale (NRS- Verbal Rating Scale (VRS)	> 4 ต้องการการรักษา ปวดปานกลางขึ้นไป ต้องการการรักษา
	2. ผู้ป่วยความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง (Alteration of conscious)		
	กลุ่มอายุ	เครื่องมือ	คะแนนที่ต้องการการจัดการความปวด
	อายุ 0-3 ปี	Comfort behavior scale (CBS)	> 17 ต้องการการรักษา
	อายุ > 3 ปี	Behavior Pain Scale (BPS)	> 6 ต้องการการรักษา
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยทุกรายที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล		
แหล่งข้อมูล	เวชระเบียนผู้ป่วย โดย 1.กรรมการ pain ประจำหน่วยงานสุ่มตรวจสอบเวชระเบียน อย่างน้อย เดือนละ 5 chart /เดือน 2. กรรมการ QA สุ่มตรวจสอบเวชระเบียน ทุก 3 เดือน โดยสุ่มอย่างน้อย 5% ของผู้ป่วยในที่มาใช้บริการในช่วงเวลานั้น		
รายการข้อมูล	A = จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มีระดับความปวดเฉียบพลันได้รับการจัดการความปวด และมีระดับความปวดลดลงต่ำกว่าระดับที่ต้องการการรักษา B = จำนวนครั้งผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลันที่ต้องการการรักษาทั้งหมดในช่วงเวลาเดียวกัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 80	2572 ≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์ /นางนงเล็ก แก้วมะไฟ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวพณีย์ ขูลีลัง /พญ.จันทร์จิรา วรรณติกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.5 การระงับความปวด (Pain control) : เพิ่มอัตราการจัดการความปวดอย่างเป็นระบบในผู้ป่วยที่มีอาการปวดแบบเฉียบพลันจนบรรเทาความปวด 3.5.1 เพิ่มอัตราการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน
ตัวชี้วัดที่	OKR 108.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน
คำนิยาม	แนวทางการจัดการความปวดในผู้ป่วยที่มีความปวดเฉียบพลัน หมายถึง วิธีปฏิบัติการจัดการความปวด (MKH-WI-QCC-007) ซึ่งกำหนดแนวทางการจัดการความปวด ดังนี้ 1. การประเมินความปวดแรกรับ 2. การประเมินความปวดต่อเนื่องและความปวดตามอาการ หรือการทำหัตถการ 3. การใช้เครื่องมือการประเมินความปวดเหมาะสมตามช่วงอายุและอาการ 4. แนวทางการจัดการความปวดที่ใช้ยาและไม่ใช้ยา 4.1 แนวทางการระงับปวดเฉียบพลันในการผ่าตัด 4.2 แนวทางการดูแลระงับปวดในห้องพักรักษา 4.3 แนวทางการดูแลระงับปวดที่หอผู้ป่วย 5. แนวทางการประเมินซ้ำหลังจัดการความปวด 6. แนวทางการบันทึกทางการพยาบาล
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยทุกรายที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีความปวดเฉียบพลัน
แหล่งข้อมูล	ผลการนิเทศทางการพยาบาล โดย หัวหน้าหอผู้ป่วย ให้การนิเทศทางการพยาบาล โดยการสุ่มสังเกตพฤติกรรมพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยในการปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความปวด และบันทึกรายงานส่งทุกเดือน
รายการข้อมูล	A = จำนวนพยาบาลที่ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการความปวดอย่างถูกต้องทุกขั้นตอน B = จำนวนพยาบาลที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งหมดในช่วงเวลานั้นๆ
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B * 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ80	≥ ร้อยละ85	≥ ร้อยละ90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์ /นางนงเล็ก แก้วมะไฟ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวพจณีย์ ขูลีลัง /พญ.จันทร์จิรา ควรรตีกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.6 การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) : 3.6.1 ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC) และมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index, BI) เพิ่มขึ้น ภายใน 6 เดือน		
ตัวชี้วัดที่	KPI 109 ร้อยละของผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC) และมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index, BI) เพิ่มขึ้น 1 คะแนน ภายใน 6 เดือน		
คำนิยาม	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (Intermediate Care Patient หรือ Transitional Care Patient) หมายถึง ผู้ป่วยที่พ้นจากระยะวิกฤตหรือระยะเจ็บป่วยเฉียบพลันแล้ว สัญญาณชีพและอาการทางคลินิกเริ่มคงที่ แต่ร่างกายยังฟื้นฟูไม่เต็มที่หรือมีความบกพร่องอยู่ ทำให้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ จึงยังไม่พร้อมที่จะกลับไปพักฟื้นที่บ้านทันที		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านเข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (IMC)		
แหล่งข้อมูล	ระบบการติดตามของ IMC โปรแกรม COC		
รายการข้อมูล	A : ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermediate care, IMC) และมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index, BI) เพิ่มขึ้น 1 คะแนน ภายใน 6 เดือน B : ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง(Intermediate care, IMC) ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุทธิรัตน์ บุชดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคคตวิวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.6 การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) : 3.6.1 ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC) และมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index, BI) เพิ่มขึ้น ภายใน 6 เดือน 3.6.1.1 เพิ่มมีการติดตาม 6 ครั้งภายใน 6 เดือน		
ตัวชี้วัดที่	OKR 109.1 ร้อยละการติดตามผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) 6 ครั้งภายใน 6 เดือน		
คำนิยาม	การติดตามผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC Follow-up) หมายถึง กระบวนการดูแล ฟื้นฟู ประเมินผล และให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านได้รับการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลหรือศูนย์พักฟื้น (IMC Ward) เพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านหรือในชุมชน เป้าหมายหลักคือการทำให้อย่างมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องในช่วง "นาทีทอง" (Golden Period มักอยู่ภายใน 6 เดือนแรก) ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และลดโอกาสการกลับมาป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลซ้ำ (Readmission)		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านเข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (IMC)		
แหล่งข้อมูล	ระบบการติดตามของ IMC โปรแกรม COC		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) ที่ได้รับการติดตาม 6 ครั้งภายใน 6 เดือน B : จำนวนผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC) ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B * 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 65	≥ ร้อยละ 70
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุพธิรัตน์ บุษดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคคติวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับP+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.6 การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) : 3.6.1 ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC) และมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index, BI) เพิ่มขึ้น ภายใน 6 เดือน 3.6.1.2 เพิ่มการปฏิบัติการดูแลได้ของผู้ดูแล
ตัวชี้วัดที่	OKR 109.2 ร้อยละผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) สามารถปฏิบัติการดูแลได้ (ในการเยี่ยมบ้าน 1 ครั้ง)
คำนิยาม	ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC Caregiver) หมายถึง บุคคลที่รับหน้าที่หลักในการดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนการฟื้นฟูผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตแล้ว (แต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เต็มที่) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันและใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดในช่วง "นาทีทอง" (Golden Period) ของการฟื้นฟู ผู้ดูแลกลุ่มนี้อาจเป็น สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วยอาชีพ (Caregiver) ที่ผ่านการอบรม ซึ่งถือเป็น "หัวใจสำคัญ" ในการเชื่อมต่อการรักษาจากโรงพยาบาลกลับบ้านครับ ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) สามารถปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวันได้ครอบคลุมหลายมิติ เพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูร่างกายและป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยมีแนวทางปฏิบัติหลักๆ ดังนี้ 1. การดูแลกิจวัตรประจำวันพื้นฐาน (Basic ADL Care) • การรักษาความสะอาด: ช่วยเช็ดตัวหรืออาบน้ำ สระผม แปรงฟัน และดูแลความสะอาดหลังการขับถ่าย • การสวมใส่เสื้อผ้า: ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า โดยเลือกเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ระบายอากาศได้ดี •  ทริคสำคัญ: ต้องยึดหลัก "ช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น" เพื่อกระตุ้นให้ผู้ป่วยพยายามทำด้วยตัวเองให้มากที่สุด (เช่น ให้ผู้ป่วยใช้มือข้างที่ปกติช่วยติดกระดุม หรือตักอาหารเข้าปากเอง) เพื่อเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อและสมองไปในตัว 2. การช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Support)

	• การท่ายากภาพบำบัด: ช่วยขยับยืดเหยียดข้อต่อ (Range of Motion) เพื่อป้องกันภาวะข้อติดแข็ง ตามท่าทางที่นักกายภาพบำบัดสอนไว้ • การฝึกเคลื่อนไหว: ช่วยพยุงผู้ป่วยลุกนั่ง ฝึกยืน ฝึกเดิน หรือใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน (เช่น Walker, ไม้เท้า) อย่างถูกวิธี • การเคลื่อนย้ายตัว (Transfer): ปฏิบัติการย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปยังรถเข็น (Wheelchair) หรือเก้าอี้นั่งถ่าย ด้วยท่าทางที่ปลอดภัยและป้องกันการปวดหลังของผู้ดูแล 3. การพยาบาลพื้นฐานและการให้ยา (Basic Nursing & Medication) • การจัดการยา: จัดเตรียมและดูแลให้ผู้ป่วยรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด ห้ามปรับลดหรือเพิ่มยาเอง • การประเมินเบื้องต้น: วัดและบันทึกสัญญาณชีพ (ความดันโลหิต อุณหภูมิ ชีพจร) หรือเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว (ในผู้ป่วยเบาหวาน) • การดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์: ดูแลความสะอาดของสายสวนปัสสาวะ (Foley catheter) หรือสายให้อาหารทางจมูก (NG Tube) ระวังไม่ให้สายพับงอ หรือเลื่อนหลุด (หากผู้ป่วยมีอุปกรณ์เหล่านี้กลับบ้าน) 4. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน (Complication Prevention) • ป้องกันแผลกดทับ: พลิกตะแคงตัวผู้ป่วยทุกๆ 2 ชั่วโมง จัดท่าทางให้ถูกต้อง และอาจใช้ที่นอนลมช่วยลดแรงกดทับ (กรณีผู้ป่วยยังพลิกตัวเองไม่ได้) • ป้องกันการสำลักอาหาร (Aspiration): จัดให้ผู้ป่วยนั่งศีรษะสูง 45 - 90 องศาขณะรับประทานอาหาร และให้นั่งพักในท่าเดิมอย่างน้อย 30-45 นาทีหลังทานเสร็จ • ป้องกันปอดอักเสบ: กระตุ้นให้ผู้ป่วยสูดหายใจเข้าลึกๆ หรือช่วยเคาะปอดเพื่อระบายเสมหะ • ป้องกันการพลัดตกหกล้ม: ล็อกล้อเตียงและรถเข็นทุกครั้งที่ไม่ได้เคลื่อนที่ เช็ดพื้นให้แห้งเสมอ และจัดบ้านให้ไม่มีสิ่งกีดขวาง 5. การดูแลด้านจิตใจ (Psychological Support) • ชวนพูดคุย ให้กำลังใจ รับฟังความอัดอั้นใจของผู้ป่วยอย่างเข้าใจ • หากิจกรรมผ่อนคลายให้ทำร่วมกัน เช่น ฟังเพลง ดูทีวี หรืองานอดิเรกง่ายๆ เพื่อลดภาวะซึมเศร้าจากการเจ็บป่วย
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่านเข้าถึงระบบการบริบาลขั้นสาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC)
แหล่งข้อมูล	ระบบการติดตามของ IMC โปรแกรม COC
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) สามารถปฏิบัติการดูแลได้ตามเกณฑ์ B : จำนวนผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) ทั้งหมด

สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุทธิรัตน์ บุษดี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคคติวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาคู่ความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.6 การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) : 3.6.2 ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) เข้าถึงระบบการดูแลต่อเนื่องและมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (BI) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน ในหอผู้ป่วยบริบาลบรรเทา ระยะกลาง (IMC Ward)
ตัวชี้วัดที่	KPI 111 อัตราผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) เข้าถึงระบบการดูแลต่อเนื่องและมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (BI) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน ในผู้ป่วย IMC Ward
คำนิยาม	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน หมายถึง ผู้ป่วยกลุ่มโรค Stroke, Traumatic brain Injury, Spinal cord Injury และ Fracture hip (Fragility fracture) ที่รอดชีวิตและมีคะแนนความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (BI) < 15 รวมทั้งคะแนน BI < 15 with multiple impairments ตามเกณฑ์การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง การบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC) หมายถึง การบริบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางที่มีอาการทางคลินิกผ่านพ้นภาวะวิกฤติและมีอาการคงที่แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกายบางส่วนอยู่และมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์โดยทีมสหวิชาชีพ (multidisciplinary approach) อย่างต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนตั้งแต่ในโรงพยาบาลจนถึงชุมชน เพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกาย จิตใจ ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และลดความพิการหรือภาวะทุพพลภาพ รวมทั้งกลับสู่สังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางใน รพ.ทุกระดับ ความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (Barthel Index, BI) หมายถึง แบบประเมินสมรรถนะความสามารถทำกิจวัตรประจำวันบาร์เทล ที่มีคะแนนเต็มเท่ากับ 20 ระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ขึ้นทะเบียน IMC หอผู้ป่วยบริบาลบรรเทาระยะกลาง (IMC Ward) หมายถึง หอผู้ป่วยบริบาลบรรเทา ระยะกลาง
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน เข้าถึงระบบการบริบาลฟื้นฟูสภาพระยะกลาง (Intermediate care, IMC)

แหล่งข้อมูล	โปรแกรม Disability (ผู้ป่วยสิทธิ์ UC) สอน.บัดดี โปรแกรม COC R9		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) เข้าถึงระบบการดูแลต่อเนื่องและมี ความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (BI) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน ในผู้ป่วย IMC Ward B : จำนวนผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน ที่ได้รับการฝึกในหอผู้ป่วย IMC Ward ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 85	2572 ≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนงเล็ก แก้วมะไฟ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคคติวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.6 การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) : 3.6.2 ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) เข้าถึงระบบการดูแลต่อเนื่องและมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (BI) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน ใน IMC Ward		
ตัวชี้วัดที่	OKR 111.1 อัตราการปฏิบัติตามแนวทางการฟื้นฟูอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/วัน โดยสหวิชาชีพ		
คำนิยาม	การปฏิบัติตามแนวทางการฟื้นฟูโดยสหวิชาชีพ หมายถึง การปฏิบัติตามการฟื้นฟูระยะกลางของกระทรวงสาธารณสุข โดยสหวิชาชีพ		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) ใน IMC Ward		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม Disability (ผู้ป่วยสิทธิ์ UC) สอน.บัดดี้ โปรแกรม COC R9		
รายการข้อมูล	A : ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) ใน IMC Ward ที่ได้รับการปฏิบัติตามแนวทางการฟื้นฟูอย่างน้อย 3 ชั่วโมง/วัน โดยสหวิชาชีพ B : ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) ใน IMC Ward ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 80	2571 ≥ ร้อยละ 85	2572 ≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนงเล็ก แก้วมะไฟ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคดีวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.6 การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) : 3.6.2 ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) เข้าถึงระบบการดูแลต่อเนื่องและมีความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน (BI) เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 2 คะแนน ใน IMC Ward			
ตัวชี้วัดที่	OKR 111.2 อัตราผู้ดูแลสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้ก่อนจำหน่าย			
คำนิยาม	ผู้ดูแล หมายถึง ผู้ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยระยะกลางเมื่อกลับบ้าน การปฏิบัติตามแนวทางการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้ หมายถึง การปฏิบัติตามการฟื้นฟูระยะกลางโดยผู้ดูแลของกระทรวงสาธารณสุข			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) ใน IMC Ward			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม Disability (ผู้ป่วยสิทธิ์ UC) สอน.บัดดี้ โปรแกรม COC R9			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ป่วยที่ผู้ดูแลสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยได้ ก่อนจำหน่าย B : จำนวนผู้ป่วยระยะเปลี่ยนผ่าน (IMC) ใน IMC Ward ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนงเล็ก แก้วมะไฟ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคคตวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.8 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน : 3.8.1 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัดที่	KPI 112 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์แผนไทย
คำนิยาม	การแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์ การผดุงครรภ์การนวดไทยและให้ หมายถึงความรวมถึง การเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู้หรือตำราที่ได้ถ่ายทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา ประกอบด้วย - เวชกรรมไทย คือ การตรวจการวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงการผดุงครรภ์ไทย เกสัชกรรมไทย และการนวดไทย - เกสัชกรรมไทย คือ การกระทำในการเตรียมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ยา การเลือกสรรยา การควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุงยาและการจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์และการจัดจำหน่ายยาตามกฎหมายว่าด้วยยา - การผดุงครรภ์ไทย คือ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การส่งเสริมสุขภาพหญิงมีครรภ์ การป้องกันความผิดปกติในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด การทำคลอด การดูแลการส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพมารดาและทารกในระยะหลังคลอด - การนวดไทย คือ การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการรักษาหรือบำบัดเพื่อแก้ไขอันตรายนั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการมารับบริการงานการแพทย์แผนไทย 1. การรับบัตร / ทำบัตรใหม่ - ความผิดพลาดในการตรวจสอบ สิทธิการรักษา

	2. การซักประวัติและตรวจ ร่างกาย - บันทึกข้อมูลการซักประวัติ ตรวจร่างกายไม่ครบถ้วน 3. การวินิจฉัยและวางแผนการ รักษา - ความผิดพลาดในการบันทึก ข้อมูลรหัสการวินิจฉัย 4. การจ่ายยาสมุนไพร - แพ้ยาสมุนไพร - ไม่ได้รับยา / ลืมยา - จ่ายยาผิดคน 5. การทำหัตถการ – นวด/ประคบ/อบไอน้ำสมุนไพร/ฟื้นฟูหลังคลอด - เกิดการพลัดตกหกล้ม - เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการ - เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด ขณะอบไอน้ำสมุนไพร - รอนาน - ทำหัตถการผิดคน / ผิดข้าง / ผิดตำแหน่ง 6. การให้คำแนะนำ - ไม่ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติ ให้เหมาะสมตามอาการ/โรค 7. การนัดหมาย - ผู้รับบริการไม่ได้รับการนัดหมาย / ไม่ได้บัตรนัด			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่เข้ารับบริการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1. โปรแกรมบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. สมุดลงทะเบียนบันทึกความเสี่ยงกลุ่มงานการแพทย์แผนไทย			
รายการข้อมูล	A = อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์แผนไทย			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ทุกไตรมาส			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริพร ราชมรรค์แก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอดทา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.8 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน : 3.8.1 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์แผนไทย 3.8.1.1 การนวดแผนไทย			
ตัวชี้วัดที่	OKR 112.1 อับัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการการนวดแผนไทย			
คำนิยาม	การนวดแผนไทย หมายถึง การตรวจ การวินิจฉัย การบำบัด การรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทย อับัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการรักษาหรือบำบัดเพื่อแก้ไขอันตรายนั้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่ได้รับการบริการการนวดแผนไทยในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน			
แหล่งข้อมูล	1.โปรแกรมบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. สมุดลงทะเบียนบันทึกความเสี่ยงกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน			
รายการข้อมูล	A = อับัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการการนวดแผนไทย			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ทุกไตรมาส			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริพร ราชรามแก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอดทา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.8 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน : 3.8.1 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์แผนไทย 3.8.1.2 ทับหม้อเกลือ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 112.2 อุตบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการทับหม้อเกลือ			
คำนิยาม	การทับหม้อเกลือ คือ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นการใช้หม้อดินเผาบรรจุเกลือที่ตั้งไฟจนร้อน วางบนสมุนไพร เช่น ไพล ว่านชักมดลูก ใบพลับพลึง แล้วห่อด้วยผ้า เพื่อนำมาประคบบริเวณหน้าท้อง หลัง และขา วิธีนี้ช่วยฟื้นฟูร่างกายมารดาหลังคลอด โดยช่วยให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น ขับน้ำคาวปลา ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ทำให้กล้ามเนื้อคลายตัว ลดอาการปวดเมื่อย และช่วยให้หน้าท้องกระชับขึ้น อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการรักษาหรือบำบัดเพื่อแก้ไขอันตรายนั้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่ได้รับบริการทับหม้อเกลือในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน			
แหล่งข้อมูล	1.โปรแกรมบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. สมุดลงทะเบียนบันทึกความเสี่ยงกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน			
รายการข้อมูล	A = อุตบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการทับหม้อเกลือ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ทุกไตรมาส			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริพร ราชรามแก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอดุทา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.8 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน : 3.8.1 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์แผนไทย 3.8.1.3 อุตการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของการใช้ยาสมุนไพร			
ตัวชี้วัดที่	OKR 112.3 อุตการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของการใช้ยาสมุนไพร			
คำนิยาม	ยาสมุนไพร หมายถึง ยาที่ได้จากสมุนไพรโดยตรง หรือที่ได้จากการผสม ประ หรือแปรสภาพสมุนไพร ที่มุ่งหมายสำหรับใช้ตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทยหรือยาที่รัฐมนตรีประกาศ กำหนดให้เป็นยาแผนไทย รวมถึง ยาที่บรรจุในตำรายาที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และตำรับยาที่ตั้งตามศาสตร์องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการรักษาหรือบำบัดเพื่อแก้ไขอันตรายนั้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่ได้รับยาสมุนไพร ในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1.โปรแกรมบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. สมุดลงทะเบียนบันทึกความเสี่ยงกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน			
รายการข้อมูล	A = อุตการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของการใช้ยาสมุนไพร			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ทุกไตรมาส			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริพร ราชรามแก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอดทา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.8 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน : 3.8.2 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์ผสมผสาน
ตัวชี้วัดที่	KPI 113 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์ผสมผสาน
คำนิยาม	การแพทย์ผสมผสาน หมายถึง การดูแลสุขภาพที่ผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบันร่วมกับ การแพทย์ทางเลือกหรือการแพทย์เสริมเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพแบบองค์รวมให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีที่สุด ครอบคลุมทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยมักใช้วิธีการรักษาหลายศาสตร์ร่วมกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย - การฝังเข็ม คือ การใช้เข็มขนาดเล็กมาก ฝังตามจุดฝังเข็มบนร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่นๆ เพื่อให้พลังงาน และอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล - การบ่งต่อด้วยหนามหวาย หมายถึง เป็นวิธีการรักษาอาการหรือความผิดปกติของดวงตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม อาการแสบตา จอประสาทตาเสื่อม และอาการอื่นๆ โดยการใช้หนาม หวายขม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดึงเส้นใยที่เกิดขึ้นในจุดรอยโรคที่อยู่ บริเวณแผ่นหลังของผู้ป่วยโดยมิได้กระทำใดๆ ต่อดวงตาโดยตรง อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการรักษาหรือบำบัดเพื่อแก้ไขอันตรายนั้น
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เกณฑ์ 0 ครั้ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่ได้เข้ารับบริการการแพทย์ผสมผสาน ในโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	2. โปรแกรมบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. สมุดลงทะเบียนบันทึกความเสี่ยงกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
รายการข้อมูล	A = อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์ผสมผสาน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ทุกไตรมาส

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริพร ราชรามแก้ว		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.8 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน : 3.8.2 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์ผสมผสาน 3.8.2.1 ผังเข็ม			
ตัวชี้วัดที่	OKR 113.1 ผังเข็ม			
คำนิยาม	การผังเข็ม หมายถึง การใช้เข็มขนาดเล็กมาก ผังตามจุดผังเข็มบนร่างกาย ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังงานมากกว่าจุดอื่นๆ เพื่อให้พลังงาน และอวัยวะต่างๆของร่างกายที่เสียสมดุลไป กลับมาอยู่ในภาวะสมดุล อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการรักษาหรือบำบัดเพื่อแก้ไขอันตรายนั้น			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่ได้รับบริการผังเข็ม ในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1.โปรแกรมบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. สมุดลงทะเบียนบันทึกความเสี่ยงกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน			
รายการข้อมูล	A = อุตการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการผังเข็ม			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ทุกไตรมาส			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริพร ราชรามแก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ฌมอดุทา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+		
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.8 การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน : 3.8.2 ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการแพทย์ผสมผสาน 3.8.2.2 บ่งต่อ		
ตัวชี้วัดที่	OKR 113.2 อุตบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปบริการบ่งต่อด้วยนามหวาย		
คำนิยาม	การบ่งต่อด้วยหนามหวาย หมายถึง เป็นวิธีการรักษาอาการหรือความผิดปกติของดวงตา เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม อาการแสบตา จอประสาทตาเสื่อม และอาการอื่นๆ โดยการใช้หนาม หวายขม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ดึงเส้นใยที่เกิดขึ้นในจุดรอยโรคที่อยู่ บริเวณแผ่นหลังของผู้ป่วยโดยมิได้กระทำใดๆ ต่อดวงตาโดยตรง อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป หมายถึง ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ส่งผลให้เกิดอันตรายชั่วคราวและต้องมีการรักษาหรือบำบัดเพื่อแก้ไขอันตรายนั้น		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่ได้รับบริการบ่งต่อด้วยหนามหวาย ในกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	1. โปรแกรมบันทึกความเสี่ยงโรงพยาบาลมหาสารคาม 2. สมุดลงทะเบียนบันทึกความเสี่ยงกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน		
รายการข้อมูล	A = อุตบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปของบริการบ่งต่อด้วยหนามหวาย		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ทุกไตรมาส		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิริพร ราชรามแก้ว		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอุดทา		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+			
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.9 Home- base care : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปในบริการ Home base care			
ตัวชี้วัดที่	KPI 114 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ในบริการ Home base care			
คำนิยาม	Home base care หมายถึง การดูแลสุขภาพที่บ้าน การให้บริการด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยและครอบครัว และผู้ดูแล ณ ที่อยู่อาศัยของผู้ป่วยเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ครอบคลุมทุกมิติ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ประกอบด้วย ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วย เพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	เท่ากับ 0 ครั้ง			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ Home base care			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC, โปรแกรมSmart COC, โปรแกรม HIS			
รายการข้อมูล	A : จำนวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ในบริการ Home base care			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เท่ากับ 0 ครั้ง	เท่ากับ 0 ครั้ง	เท่ากับ 0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปานแก้ว สีดาเยี่ยม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางบรรจง จาตบุญนาค			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.9 Home- base care : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปในบริการ Home base care 3.8.1 DM : ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการ Home base care
ตัวชี้วัดที่	OKR 114.1 DM อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการ Home base care
คำนิยาม	เกณฑ์ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับบริการ Home base care ได้แก่ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hyperglycemia Hypoglycemia 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ค่า HbA1C > 11% หรือ FBS > 300 mg/dl Hemoglobin A1C (HbA1C) หมายถึง การตรวจเลือดที่ใช้ วัดระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดย้อนหลังประมาณ 2-3 เดือน โดยดูจากปริมาณน้ำตาลที่จับกับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง Fasting Blood Sugar (FBS) หมายถึง การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต
ค่าเป้าหมายการดำเนินงาน	0 ครั้ง

ระยะ 3 ปี				
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับบริการ Home base care			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC, โปรแกรมSmart COC			
รายการข้อมูล	A : จำนวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการ Home base care			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปานแก้ว สีดาเจียม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางบรรจง จาดบุญนาค			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.9 Home- base care : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปในบริการ Home base care 3.8.2 HT : อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ใช้บริการ Home base care
ตัวชี้วัดที่	OKR 114.2 HT อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ใช้บริการ Home base care
คำนิยาม	เกณฑ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับบริการ Home base care ได้แก่ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลด้วยภาวะ Hypertensive Urgency หรือ Hypertensive Emergency 2. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีค่า BP > 140/90 mmHg case ที่รับยาแล้วยังควบคุมไม่ได้ ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่เข้ารับบริการ Home base care
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม HDC, โปรแกรม Smart COC

รายการข้อมูล	A : จำนวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการ Home base care			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางปานแก้ว สีดาเยี่ยม			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางบรรจง จาดบุญนาค			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M5_ยกระดับการพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการสู่มาตรฐานระดับประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์	WO : พัฒนายุทธศาสตร์บริหารจัดการดิจิทัลมุ่งสู่โรงพยาบาลมาตรฐานระดับ P+
Roadmap	Roadmap R11 : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA)
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	2. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพขั้นก้าวหน้า (AHA) 2.1. AHA Part 1 ภาพรวมของการบริหารองค์กร 2.2. AHA Part 2 ระบบงานสำคัญของโรงพยาบาล 2.3. AHA Part 3 กระบวนการดูแลผู้ป่วย 2.4. AHA Part 4 ผลการดำเนินการขององค์กร
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3.9 Home- base care : ไม่พบอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไปในบริการ Home base care 3.8.3 อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยแผลกดทับที่ใช้บริการ Home base care
ตัวชี้วัดที่	OKR 114.3 Pressure sore อุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยแผลกดทับที่ใช้บริการ Home base care
คำนิยาม	เกณฑ์ผู้ป่วยแผลกดทับที่เข้ารับบริการ Home base care ได้แก่ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยแผลกดทับที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาลด้วยแผลกดทับขนาดไม่เกิน 5x5 cm. และไม่เกิน gr. 3 2. ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับขนาดไม่เกิน 5x5 cm. และไม่เกิน gr. 3 3. ยกเว้นผู้ป่วย Palliative care ระดับความรุนแรง ระดับ E ขึ้นไป ดังนี้ ระดับ E : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราวรวมถึงจำเป็นต้องได้รับ intervention การรักษาหรือแก้ไขเพิ่มเติม ระดับ F : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ที่นำไปสู่หรือทำให้มีผลเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเพียงชั่วคราวและจำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลหรือยืดระยะเวลาในการรักษาตัวในโรงพยาบาลออกไปอันเนื่องจาก error ที่เกิดขึ้น ระดับ G : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยถาวรพิการ ระดับ H : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องให้เพื่อช่วยชีวิต ระดับ I : มีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น และเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยจนถึงแก่ชีวิต
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	0 ครั้ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยแผลกดทับที่เข้ารับบริการ Home base care
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม Smart COC

รายการข้อมูล	A : จำนวนความเสี่ยงระดับ E ขึ้นไป ของผู้ป่วยเบาหวานที่ใช้บริการ Home base care			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางขวัญเรือน แก้วเห่า			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางบรรจง จาดบุญนาค			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. การเงินการคลัง : โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ตัวชี้วัดที่	KPI 115 ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score (TPS) ระดับ A
คำนิยาม	ผลการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score หมายถึง คะแนนรวมที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลมหาสารคาม การประเมินมักจะประเมินผลลัพธ์ใน 6 ด้านหลัก การบริหารแผน: การจัดการรายได้และรายจ่ายให้สอดคล้องกับแผน การบริหารต้นทุน: การควบคุมต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) การบริหารค่าใช้จ่าย: การควบคุมการใช้จ่าย แล็บ และเวชภัณฑ์ ผลิตภาพ (Productivity): ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร เช่น อัตราการครองเตียง การบริหารจัดการสภาพคล่องและหนี้สิน: ความสามารถในการชำระหนี้ คะแนนงบทดลอง: ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี เกณฑ์การตัดสินระดับคะแนน A (ดีมาก): ≥ 12 คะแนน B (ดี): 10.5 - 11.9 คะแนน (เกณฑ์ผ่านที่โรงพยาบาลต้องทำให้ถึง) C (พอใช้): 9.0 - 10.4 คะแนน D (ปรับปรุง): 7.5 - 8.9 คะแนน F (ไม่ผ่านเกณฑ์): < 7.5 คะแนน
ค่าเป้าหมาย	ระดับ A
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
รายการข้อมูล	A : คะแนนการประเมินประสิทธิภาพ Total Performance Score (TPS)
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ระดับ B	ระดับ A	ระดับ A	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พันนา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. การเงินการคลัง : โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ตัวชี้วัดที่	OKR 115.1 โรงพยาบาลมีภาวะวิกฤตทางการเงิน ระดับ 0
คำนิยาม	ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน หมายถึง โรงพยาบาลมีวิกฤตทางการเงิน ตามหลักเกณฑ์การคิดวิกฤตทางการเงิน ระดับ 7 (Risk Scoring) ของกองเศรษฐกิจสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการ วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน 5 รายการ ประกอบด้วย 1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio :CR) = สินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 2. อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio : QR) =(สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย สินค้าคงเหลือ หักด้วย สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 3. อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio : Cash Ratio) (เงินสด บวกกับ รายการเทียบเท่าเงินสด บวกกับ เงินฝากประจำ) หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน 4. ทุนสำรองสุทธิ (Net Working Capital : NWC) = สินทรัพย์หมุนเวียน หักด้วย หนี้สินหมุนเวียน 5. (Net Income : NI) = รวมรายได้ หักด้วย รวมค่าใช้จ่าย อัตราส่วนทางการเงินทั้ง 5 รายการข้างต้นถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของโรงพยาบาล โดยกำหนดเกณฑ์สำหรับการประเมินโดยมีค่ากลางของโรงพยาบาลมาเปรียบเทียบกับค่ากลางของอุตสาหกรรม ดังนี้ 1. กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์ 1. CR < 1.5 2. QR < 1.0 3. Cash < 0.8 2. กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน 2.1 แสดงฐานะทางการเงิน ทุนหมุนเวียน (NWC) <0

	2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (กำไรสุทธิ) (กำไรสุทธิรวมค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดหน่วย Net Income NI) $NI < 0$ 3. กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง 3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน* 3.1 NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 6 เดือน โดยให้น้ำหนักของ NWC/ANI ระยะเวลาทุนหมุนเวียนหมด < 3 เดือน มากกว่าตัวแปรอื่น ไม่เกิดปัญหาการเงินรุนแรง ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้นำเงื่อนไขมาใช้ในการจัดกลุ่มโรงพยาบาลที่ประสบวิกฤตทางการเงินเป็น 7 ระดับ ดังนี้ ระดับ 0-1 ปกติ ระดับ 2 คาดว่าจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน ระดับ 3 คาดว่าจะดีขึ้นภายใน 3 เดือน ระดับ 4 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน ระดับ 5 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน ระดับ 6 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน ระดับ 7 มีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง การประเมินโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจะประเมินทุกสิ้นไตรมาส โดยกำหนดให้โรงพยาบาลที่ได้ระดับ 7 ซึ่งมีภาวะวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง และระดับ 6 ที่คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน ทั้งนี้ ระบบข้อมูลบัญชีของโรงพยาบาลที่ดีมีคุณภาพมีส่วนสำคัญที่ทำให้ผลการประเมินสถานะทางการเงินที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาวะวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นได้	
ค่าเป้าหมาย	ระดับ 0	
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลมหาสารคาม	
แหล่งข้อมูล	กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ	
รายการข้อมูล	ประเภทดัชนีชี้วัด	น้ำหนักความรุนแรงของความเสี่ยง (Risk Score)
	1.กลุ่มแสดงความคล่องตามสภาพสินทรัพย์	
	1.1 CR น้อยกว่า 1.5	1
	1.2 QR น้อยกว่า 1	1
	1.3 Cash น้อยกว่า 0.8	1
	2.กลุ่มแสดงความมั่นคงทางการเงิน	
	2.1 แสดงฐานะทางการเงิน (ทุนหมุนเวียน) NWC น้อยกว่า 0	1
	2.2 แสดงฐานะจากผลประกอบการ (รายได้สูง/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ) NI น้อยกว่า 0	1

	3.กลุ่มแสดงระยะเวลาเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง มี 2 มิติ				
	3.1 มิติ NWC หรือทุนหมุนเวียน ที่เพียงพอ รับภาระการขาดทุนเฉลี่ยต่อเดือน (กรณี NWC เป็นบวก&มี NI ติดลบ)				
	a) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอาจหมด มากกว่า 6 เดือน				0
	b) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน				1
	c) ระยะเวลาทุนหมุนเวียนอยู่ได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน				2
	3.2 มิติ ผลกำไรจากการดำเนินการ เพียงพอ รับภาระหนี้สินหมุนเวียน (กรณีNWC ติดลบ & มีNI เป็นบวก) *กรณีมีกำไรจากการดำเนินงาน แต่ขาดเงินทุนหมุนเวียน*				
	a) ผลกำไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก มากกว่า 6 เดือน				2
	b) ผลกำไร สามารถปรับ NWC เป็นบวก มากกว่า 3 เดือน ไม่เกิน 6 เดือน				1
	c) ผลกำไร สามารถปรับ NWC เป็นบวกน้อยกว่า หรือเท่ากับ 3 เดือน				0
	3.3 กรณี NWC ติดลบ & มีNI เป็นบวก				0
	3.4 กรณีNWC ติดลบ & มีNI เป็นลบ				2
สูตรคำนวณตัวชี้วัด					
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **				
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572		
	ระดับ 0	ระดับ 0	ระดับ 0		
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พันทนา				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริยุญาพร คงแสนคำ				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. การเงินการคลัง : โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน
ตัวชี้วัดที่	OKR 115.2 อัตราลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่มีระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการเก็บรักษาลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน - UC ร้อยละ 90 - พรบ. ร้อยละ 60 (ปัจจุบันร้อยละ 45-50)
คำนิยาม	ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการเก็บรักษาลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล OPD คือ ระยะเวลาจำนวนวันเฉลี่ยนับตั้งแต่ผู้ป่วยปิดสิทธิ์แต่ละ Visit จนถึงการออก Statement ระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการเก็บรักษาลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล IPD คือ ระยะเวลาจำนวนวันเฉลี่ยนับตั้งแต่ผู้ป่วย Discharge จนถึงการออก Statement ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ป่วยมารับบริการ เกณฑ์มาตรฐานของระยะเวลาถ่วงเฉลี่ยในการเก็บรักษาลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล หมายถึง "กรอบเวลามาตรฐานหรือเป้าหมาย (เป็นจำนวนวัน)" ที่องค์กรกำหนดไว้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ชี้วัดประสิทธิภาพในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล โดยนับตั้งแต่วันที่โรงพยาบาลได้ให้บริการรักษาและจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Discharge) ไปจนถึงวันที่โรงพยาบาลได้รับเงินสดโอนเข้าบัญชีเงินบำรุง เกณฑ์มาตรฐานของสิทธิ UC หมายถึง "กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางมาตรฐานในการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ" หรือที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคยในชื่อ "สิทธิบัตรทอง" หรือ "สิทธิ 30 บาท" (UC ย่อมาจาก Universal Coverage หรือ Universal Health Coverage) เกณฑ์มาตรฐานของสิทธิ พรบ. หมายถึง "กฎเกณฑ์ เงื่อนไข และวงเงินความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535" (และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับที่กำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำประกันภัย เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนทุกคนที่ประสบอุบัติเหตุจากรถ ไม่ว่าจะเป็นคนขับ คนโดยสาร หรือคนเดินถนน ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงที โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85 - สิทธิ UC_90 วัน - สิทธิ พรบ. ≥ 60 วัน - ข้าราชการ ≥ 80 วัน

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทุกสิทธิที่โรงพยาบาลต้องติดตามและเรียกเก็บ เช่น UC, พรบ., ประกันสังคม, สิทธิข้าราชการ, สิทธิต่างด้าว		
แหล่งข้อมูล	- ข้อมูลจากระบบการเงินและบัญชีโรงพยาบาล (HIS/AR System) - รายงานลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน/ประจำปี - ฐานข้อมูลการเบิก-จ่ายจากกองทุน UC, พรบ., และกองทุนอื่น ๆ		
รายการข้อมูล	A : จำนวนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลที่มีระยะเวลาแล้วเฉลี่ยในการเก็บรักษาลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลตามเกณฑ์มาตรฐาน B : จำนวนลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 85	2571 ≥ ร้อยละ 85	2572 ≥ ร้อยละ 85
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายปรีชา มาตรา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. การเงินการคลัง : โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
ตัวชี้วัดที่	KPI 116 ประสิทธิภาพในการทำกำไรของโรคที่สำคัญทั้ง 3 กองทุน (กองทุน UC เบิกได้จ่ายตรง ประกันสังคม) เพิ่มขึ้น		
คำนิยาม	ประสิทธิภาพในการทำกำไร หมายถึง ความสามารถของโรงพยาบาลในการบริหารต้นทุนและรายได้จากโรคที่สำคัญ เพื่อให้มีผลต่างรายรับสุทธิสูงกว่าต้นทุนที่ใช้ไป รายได้สุทธิ (Net Income หรือ Net Profit) หมายถึง รายได้ทั้งหมดที่เหลืออยู่จริงหลังจากหักรายจ่าย ต้นทุนรวม (Total Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่ต้องจ่ายไปเพื่อใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาล โรคที่สำคัญด้านการเงิน คือ โรคที่มีความสามารถในการทำกำไรได้ ได้แก่ กองทุน UC คือ โรค Cataract , สลายนิ่ว กองทุนประกันสังคม คือ Cataract กองทุนเบิกได้จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง คือ Cataract		
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยโรคที่สำคัญทั้ง 3 กองทุน		
แหล่งข้อมูล	1. ข้อมูลรายได้จากระบบการเงินการคลังโรงพยาบาล 2. ข้อมูลต้นทุนรายโรคจากระบบ Cost/DRG 3. ฐานข้อมูลผู้ป่วย OPD/IPD ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคที่สำคัญ		
รายการข้อมูล	A : รายได้สุทธิตotalของโรคสำคัญ B : ต้นทุนรวมของโรคสำคัญ		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/B \times 100$ ประสิทธิภาพการทำกำไร (%) = (รายได้สุทธิ - ต้นทุนรวม) ÷ รายได้สุทธิ × 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวกนกพรณ วัฒนินทร		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจารุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	KPI 117 อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้ เพิ่มพิเศษ (Premium)		
คำนิยาม	กำไรสุทธิ = รายได้จากบริการ Premium หักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงและค่าใช้จ่ายทางอ้อม (ต้นทุน) - รายได้รวมจากบริการ Premium - ค่าใช้จ่ายรวมที่เกี่ยวข้องกับบริการ Premium - ผลกำไรสุทธิ (รายได้ – ค่าใช้จ่าย)		
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 10 ของรายได้สุทธิจากบริการ Premium		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการที่เลือกใช้บริการ Premium และหน่วยงาน/กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการและบริหารจัดการรายได้		
แหล่งข้อมูล	1. รายงานบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย (งบทดลอง/งบกำไรขาดทุน) 2. ระบบบัญชีโรงพยาบาล 3. รายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยงาน		
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากบริการ Premium B : รายได้รวมจากบริการ Premium		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B/*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10	ร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวกนกพรพรณ วัฒนินทร		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน			
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.1 ห้องพิเศษ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.1 ห้องพิเศษ อัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น			
คำนิยาม	ห้องพิเศษ (Special Ward / Private Room) หมายถึง ห้องพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยใน (IPD) ของโรงพยาบาล ที่จัดสัดส่วนไว้เป็นเอกเทศส่วนบุคคล (ห้องเดี่ยว) หรือเป็นกลุ่มขนาดเล็ก (ห้องพิเศษรวม 2-4 เตียง) เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวกสบาย ความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยเพิ่มขึ้นในระหว่างการนอนพักรักษาตัว โดยผู้รับบริการจะต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มเติมในส่วนของ "ค่าห้องและค่าอาหาร" นอกเหนือจากสิทธิการรักษาขั้นพื้นฐาน อัตรากำไรสุทธิ = กำไรสุทธิ/รายได้รวม * 100			
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้มารับบริการที่เลือกใช้บริการห้องพิเศษในโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	1. รายงานบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย (งบทดลอง/งบกำไรขาดทุน) 2. ระบบบัญชีโรงพยาบาล 3. รายงานการเงินประจำเดือนของหน่วยงาน			
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากบริการห้องพิเศษ B : รายได้รวมจากบริการห้องพิเศษ			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B/*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวกนกพรณ วัฒนินทร			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.2 SMC ผู้ป่วยนอกมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.2 SMC ผู้ป่วยนอก มีอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น - จักขุวิทยา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 - ศัลยกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 - สูติ-นรีเวชกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 - ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 10 - อายุรกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 - กุมารเวชกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10 - โสต ศอ นาสิก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 10
คำนิยาม	SMC ผู้ป่วยนอก ย่อมาจาก Special Medical Clinic (ผู้ป่วยนอก) หมายถึง "คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ" สำหรับผู้มารับบริการประเภทผู้ป่วยนอก (OPD) หรือผู้ป่วยที่ตรวจรักษาแล้วสามารถรับยากลับบ้านได้ทันทีโดยไม่ต้องนอนพักค้างคืน) กำไรสุทธิจากการให้บริการการบริการ SMC ผู้ป่วยนอก คือ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการการ SMC ผู้ป่วยนอก ลบด้วยต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการ SMC ผู้ป่วยนอก
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการ ประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ ข้าราชการ สิทธิประกันสังคม รัฐวิสาหกิจและสิทธิอื่นๆ
แหล่งข้อมูล	คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (OPD) ศูนย์บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC center)
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากบริการ SMC OPD B : รายได้รวมจากบริการ SMC OPD
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A/B) \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 10	เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 10	เพิ่มขึ้น ร้อย ละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางวาสนา บำรุงบุญ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางอุไรวรรณ ประเสริฐสังข์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษเพิ่มขึ้น 2.3 SMC การผ่าตัดมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.3 อัตรากำไรสุทธิจากบริการ SMC การผ่าตัดเพิ่มขึ้น
	- จักษุวิทยา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
	- ศัลยกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
	- สูติ-นรีเวชกรรม เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
	- ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
	- โสต ศอ นาสิก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
คำนิยาม	การบริการผ่าตัดเฉพาะทางนอกเวลา (specific medical clinic) ประกอบด้วย การผ่าตัดของแผนกจักษุ, ศัลยกรรม, สูตินรีเวชกรรม, ศัลยกรรมกระดูกและข้อและโสตศอ นาสิก ที่อยู่ในรายการประกาศ SMC รายได้ที่เกิดจากการให้บริการการผ่าตัด SMC คือ ค่าบริการผ่าตัดเฉพาะทางนอกเวลาราชการที่อยู่ในรายการประกาศ SMC ต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการการผ่าตัด SMC คือ ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมบริการผ่าตัดสหวิชาชีพ กำไรสุทธิจากการให้บริการการผ่าตัด SMC คือ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการการผ่าตัด SMC ลบด้วยต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการการผ่าตัด SMC
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัดเฉพาะทางนอกเวลาราชการ
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมทางการเงิน โปรแกรมรายจ่ายค่าตอบแทน
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากการให้บริการการผ่าตัด SMC ของปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิจากการให้บริการการผ่าตัด SMC ของปีก่อนหน้า
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/B*100
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายกิจมงคล ทาดทา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางประยูร จำปาปี			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.4 การบริการทันตกรรมมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.4 การบริการทันตกรรมมีอัตรากำไรสุทธิ เพิ่มขึ้น
คำนิยาม	การบริการทันตกรรม ประกอบด้วย การบริการทางทันตกรรมกับผู้ป่วยกองทุนข้าราชการ ประกันสังคม และการบริการทางทันตกรรมในหมวด อวัยวะเทียม , งาน PP เบิกจากกองทุนได้เพิ่มเติมในผู้ป่วยกองทุน UC งานทันตกรรมรากเทียม รายได้จากการให้บริการทันตกรรม คือ รายได้จากการให้บริการทันตกรรมจากกองทุนข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุน UC คลินิก Premium และรายได้จากการชำระเงินเอง ต้นทุนจากการให้บริการทันตกรรม คือ ค่าใช้จ่ายวัสดุทันตกรรมที่ใช้ในโรงพยาบาล ไม่รวม PCU ค่าใช้จ่ายแลปทันตกรรม และค่าตอบแทนบุคลากรนอกเวลาราชการ กำไรสุทธิ คือ รายได้จากการให้บริการทันตกรรม ลบด้วยต้นทุนจากการให้บริการทันตกรรม คือ
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่รับบริการทันตกรรม กลุ่ม ข้าราชการ, ประกันสังคม , UC ที่มารับบริการที่เกิดรายได้ เช่น รักษาฟัน , ใส่ฟันเทียม, ANC ขูดหินปูน , UC ต่างจังหวัด หรืออื่นๆ
แหล่งข้อมูล	รายได้เพิ่มพิเศษ จาก รายได้ที่ได้รับจริงทุกกองทุนแยกประเภทโดยละเอียด จากงานประกัน ต้นทุนรวม จาก การเงินหมวดเงินเดือน และ พัสดุ หมวด วัสดุทันตกรรม, ค่าแลปทันตกรรม
รายการข้อมูล 1	A : กำไรสุทธิของการบริการทันตกรรมปีปัจจุบัน
รายการข้อมูล 2	B : กำไรสุทธิของการบริการทันตกรรมปีที่ผ่านมา
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B) / B * 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 5	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นส.วินัฐติยา เสรีชัยกุล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกรรองกาญจน์ ศรีวัฒนา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.5 ตรวจสอบคุณภาพมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.5 ตรวจสอบคุณภาพมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น		
คำนิยาม	การตรวจสอบสุขภาพ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบประเมินสถานะทางร่างกายของบุคคลที่ "ยังไม่มีอาการเจ็บป่วยแสดงออกมา" เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ความผิดปกติ หรือร่องรอยของโรคตั้งแต่ในระยะเริ่มต้น รายได้ที่เกิดจากการให้บริการตรวจสอบสุขภาพ คือ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการตรวจสอบสุขภาพตามแพคเกจ ตามช่วงอายุ ตามกิจกรรม เช่น ตรวจสอบสุขภาพต่างดาว ตรวจสอบสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการตรวจสอบสุขภาพ คือ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่สถานพยาบาลต้องจ่ายไปในกระบวนการให้บริการตรวจสอบค้นหาความเสี่ยงทางสุขภาพแก่ผู้รับบริการ ตั้งแต่จุดลงทะเบียน เจาะเลือด เอกซเรย์ ไปจนถึงขั้นตอนการรับฟังผลตรวจจากแพทย์ เช่น ค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง ค่าตอบแทนบุคลากร ฯลฯ กำไรสุทธิจากการให้บริการตรวจสอบสุขภาพ คือ รายได้ที่เกิดจากการให้บริการตรวจสอบสุขภาพ ลบด้วยต้นทุนที่เกิดจากการให้บริการตรวจสอบสุขภาพ		
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่มารับบริการที่หน่วยตรวจสอบสุขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมตรวจสอบสุขภาพโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิของการบริการตรวจสอบสุขภาพปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิของการบริการตรวจสอบสุขภาพปีที่ผ่านมา		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางศิริพร ศรีชะตา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสุธิดา เอี่ยมเกื้อกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.6 การให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนอก มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.6 การให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนอก มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น		
คำนิยาม	การบริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนอก หมายถึง การให้บริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนอกกองทุนข้าราชการ การให้บริการทางกายภาพบำบัดตามสิทธิประโยชน์ในผู้ป่วยนอกกองทุนประกันสังคมและกองทุน UC รายได้จากการให้บริการทางกายภาพบำบัด คือ รายได้จากการบริการทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยนอก รวมกับรายได้จากกายอุปกรณ์ ต้นทุนจากการให้บริการทางกายภาพบำบัด คือ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการดำเนินงาน รวมกับต้นทุนกายอุปกรณ์ กำไรจากการให้บริการ คือ รายได้จากการให้บริการทางกายภาพบำบัด ลบด้วยต้นทุนจากการให้บริการทางกายภาพบำบัด รหัสทางกายภาพบำบัด = รหัสทางกายอุปกรณ์ =		
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มารับบริการทางกายภาพบำบัด		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรม Disability (เฉพาะสิทธิ UC) โปรแกรม RCM		
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิของการให้บริการทางกายภาพบำบัดปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิของการให้บริการทางกายภาพบำบัดปีที่ผ่านมา		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางศุภรินทร์ ยิ้มศิริ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคคติวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.7 แพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น (บูรณาการ R11)
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.7 แพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
คำนิยาม	การบริการด้านการแพทย์แผนไทย หมายถึง บริการการตรวจ วินิจฉัย ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค รักษาโรค และฟื้นฟูสุขภาพ สิทธิจ่ายตรง เบิกต้นสังกัด ประกันสังคม ชำระเงินเอง รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนไทย 1. โรคสตรี: U50 ถึง U52 2. โรคเด็ก: U54 ถึง U55 3. โรคที่เกิดอาการหลายระบบ: U56 ถึง U60 4. โรคที่เกิดเฉพาะตำแหน่ง: U61 ถึง U72 5. โรคและอาการอื่น: U74 ถึง U75 หัตถการแผนไทย (100-77-00 ถึง 999-78-88) หัตถการส่งเสริมสุขภาพ (100-79-00 ถึง 999-79-99) ยาสมุนไพรเดี่ยว หรือ ยาสมุนไพรตำรับ มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 รหัสบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1100 ถึง 11081) รหัสบริการการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน (11100 ถึง 11183) การบริการด้านแพทย์ผสมผสาน หมายถึง การบริการรักษาพยาบาลนอกเหนือจากการแพทย์ปัจจุบัน และการแพทย์แผนไทย เช่น ฝังเข็ม การแพทย์ทางเลือกอื่น ๆ หรือการบริการอื่น ๆ ที่มีการเพิ่มเติมรหัสภายหลัง รหัสกลุ่มโรคและอาการด้านการแพทย์แผนจีน 1. โรคทางการแพทย์แผนจีน (Diseases in Chinese Medicine): U78 2. รหัสวินิจฉัยรูปแบบ/กลุ่มอาการด้านการแพทย์แผนจีน (Pattern identification / Syndrome differentiation in Chinese Medicine): U79 รหัสหัตถการแพทย์แผนจีน (ICD-10-TM) ได้แก่ - 9991801 electro acupuncture therapy - 9991810 single-handed needle insertion

	- 9021801 subcutaneous electro-needling - 9991811 double-handed needle insertion - 9031801 muscle electro-needling รายได้ของการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คือ รายได้จากการให้บริการ ในสิทธิจ่ายตรง เบิกต้นสังกัด ประกันสังคม ชำระเงินเอง โดยมีการวินิจฉัยรหัสกลุ่มโรคและอาการที่มีรหัส 3 หลักขึ้นต้นด้วย U50 ถึง U76 หรือ U78 ถึง U79 หรือ ส่งจ่ายยาสมุนไพรเดี่ยว หรือยาสมุนไพรตำรับ ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย 41 หรือ 42 หรือให้หัตถการแผนไทย (100-77-00 ถึง 999-78-88) หรือหัตถการส่งเสริมสุขภาพ (100-79-00 ถึง 999-79-99)หรือกิจกรรมบริการการแพทย์แผนไทยที่บ้าน (1100 ถึง 11081) หรือบริการการแพทย์ทางเลือกที่บ้าน (11100 ถึง 11183) อย่างใดอย่างหนึ่ง ต้นทุน ของการบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน คือ กำไรสุทธิจากการให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน คือ รายได้ของการให้บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน ลบด้วย ต้นทุนของการบริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน			
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่เข้ารับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน			
แหล่งข้อมูล	ข้อมูล 43 แพ้ม (PERSON/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/PROCEDURE_OPD/COMMUNITY_SERVICE) โปรแกรม HDC โปรแกรม HIS			
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากการให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิจากการให้บริการการแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสานของปีก่อนหน้า			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/B*100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี	2571 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี	2572 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	คุณศิริพร ราชรามแก้ว			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ดร.ภก.อดิศักดิ์ ถมอดธา			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.8 ODS & MIS มีอัตราการจ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.8 ODS & MIS มีอัตราการจ่ายค่าชดเชยเพิ่มขึ้น		
	- การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) ร้อยละ 10		
	- การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (MIS) ร้อยละ 10		
คำนิยาม	การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (ODS) ประกอบด้วยการทำหัตถการหรือการผ่าตัดตั้งแต่ 2 - 24 ชั่วโมงนับจากเวลาลงมีดผ่าตัด ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณา จำนวน 70 กลุ่มโรค การผ่าตัดผ่านกล้องแบบแผลเล็ก (MIS) ประกอบด้วยการทำหัตถการหรือการผ่าตัดที่ใช้เทคนิคและเครื่องมือพิเศษช่วยผ่าตัดด้วยวิธีผ่านกล้อง (Laparoscopic) ทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก อัตราการจ่ายค่าชดเชย คือ การจ่ายค่าชดเชยรายโรค คูณด้วยจำนวนผู้ป่วยเข้ารับบริการผ่าตัด ODS & MIS		
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้นร้อยละ 10		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการผ่าตัด ODS & MIS		
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมงานประกัน		
รายการข้อมูล	A : อัตราการจ่ายค่าชดเชย ODS & MIS ของปีปัจจุบัน B : อัตราการจ่ายค่าชดเชย ODS & MIS ของปีก่อนหน้า		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	10	15	15
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายกิจมงคล ทาดทา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางประยูร จำปาปี		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.9 Skin Clinic มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.9 Skin Clinic มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น
คำนิยาม	Skin Clinic หรือ คลินิกผิวหนัง คือ ที่เน้นการดูแล รักษา และฟื้นฟูผิวหนังโดยเฉพาะ ซึ่งในปัจจุบันมักจะครอบคลุมทั้งการรักษาโรคผิวหนังทั่วไปและการเสริมความงามเข้าไว้ด้วยกันครับ โดยทั่วไปบริการของ Skin Clinic จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้: 1. การรักษาโรคผิวหนัง (Medical Dermatology) เน้นการรักษาความผิดปกติทางพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง ผผ และเล็บ เช่น: • โรคผิวหนังทั่วไป: ผื่นคัน, ภูมิแพ้ผิวหนัง, เชื้อรา, กลากเกลื้อน • ปัญหาผิวและฝ้า: การรักษาสิวเรื้อรัง, ฝ้า, กระ และจุดด่างดำที่เกิดจากเม็ดสี • โรคเฉพาะทาง: สะเก็ดเงิน, ผผร่วน, ด่างขาว หรือการตรวจคัดกรองมะเร็งผิวหนัง 2. การดูแลด้านความงาม (Aesthetic & Laser) เน้นการปรับปรุงรูปลักษณ์ให้ดูดีขึ้น ชะลอวัย หรือแก้ไขจุดบกพร่อง เช่น: • หัตถการฉีดยา: การใช้ฟิลเลอร์ (Filler) เพื่อเติมเต็ม หรือสารลดเลือนริ้วรอย (Botulinum Toxin) • เทคโนโลยีเลเซอร์: การยกกระชับหน้า (เช่น Ulthera, Thermage), การกำจัดขน หรือการลบรอยสัก • การทำทรีตเมนต์: การผลัดวิตามินเข้าสู่ผิว, การผลัดเซลล์ผิว (Peeling) และ การทำหน้าใส รายได้จากการทำ Skin clinic คือ รายได้จากการชดเชยกองทุนสิทธิผู้ป่วย ต้นทุนจากการทำ Skin clinic คือ รายจ่ายจากการให้บริการ Skin clinic ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากร ค่ายา ค่าเสื่อมของอุปกรณ์และสถานที่ กำไรสุทธิ คือ รายได้จากการทำ Skin clinic ลบด้วยต้นทุนจากการทำ Skin clinic
ค่าเป้าหมาย	มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มาตรวจ Skin Clinic ที่คลินิกตรวจการนอนหลับ
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจ Skin Clinic ประจำเดือน

	โปรแกรม RCM		
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากการให้บริการ Skin Clinic ของปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิจากการให้บริการ Skin Clinic ของปีก่อนหน้า		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น ≥ ร้อยละ 10
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจันทราพร ลุนลุด		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.อารยา กীরติมหาตม์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน			
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. อัตรากำไรสุทธิจากการหารายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) เพิ่มขึ้น 2.10 Sleep test มีอัตรากำไรสุทธิ			
ตัวชี้วัดที่	OKR 117.10 Sleep test มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น			
คำนิยาม	Sleep test คือ กระบวนการตรวจการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับโดยใช้อุปกรณ์เพื่อบันทึกสัญญาณต่างๆเช่น การทำงานของสมอง การหายใจ รหัส ICD 10= G473 รหัส ICD 9 =8917 รายได้จากการทำ Sleep test คือ รายได้จากการชดเชยกองทุนสิทธิผู้ป่วย ต้นทุนจากการทำ Sleep test คือ รายจ่ายจากการให้บริการ Sleep test ประกอบด้วย ค่าตอบแทนบุคลากร ค่ายา ค่าเสื่อมของอุปกรณ์และสถานที่ กำไรสุทธิ คือ รายได้จากการทำ Sleep test ลบด้วยต้นทุนจากการทำ Sleep test			
ค่าเป้าหมาย	มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ10			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มาตรวจ Sleep test ที่คลินิกตรวจการนอนหลับ			
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจ Sleep test ประจำเดือน โปรแกรม RCM			
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากการให้บริการ Sleep test ของปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิจากการให้บริการ Sleep test ของปีก่อนหน้า			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/B*100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ 10	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสมาลัย คงเอี่ยม/นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.นันทกานต์ เอี่ยมอุดมกาล/พญ.ปิยนารถ ด้านพรประเสริฐ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง
ตัวชี้วัดที่	KPI 118 ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง 6 มิติ
คำนิยาม	ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง คือ การประเมินความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการเงิน การป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดการเงินและงบประมาณ รวมถึงการดำเนินการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการทุจริต การละเมิด และความผิดพลาดในด้านการเงิน ซึ่งมุ่งเน้นในการรักษาความถูกต้อง โปร่งใส และประสิทธิผลในการใช้จ่ายงบประมาณ กรอบการประเมินและบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานได้อย่างโปร่งใส ลดความผิดพลาด ป้องกันการทุจริต และบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 6 มิติหลัก ได้แก่: 1. มิติด้านการเงิน คือ การควบคุมและตรวจสอบการบริหารจัดการเงิน การรับ-จ่ายเงินสด เงินตราพระราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 2. มิติด้านการจัดเก็บรายได้ คือ การดูแลระบบการจัดเก็บเงิน ค่าบริการ หรือรายได้ต่างๆ ให้ครบถ้วน รวดเร็ว และไม่มีช่องว่างให้เกิดการรั่วไหล 3. มิติด้านงบการเงิน คือ การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินให้โปร่งใส เป็นปัจจุบัน 4. มิติด้านพัสดุและสินทรัพย์ คือ การควบคุมตั้งแต่การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย ไปจนถึงการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพอย่างถูกต้อง 5. มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คือ การประเมินสภาพแวดล้อมการควบคุม กำหนดกิจกรรมการควบคุม และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 6. มิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (IT) คือ การควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือข้อมูลรั่วไหล
ค่าเป้าหมาย	คะแนนที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย $\geq$ ร้อยละ 90

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินความเสี่ยง		
รายการข้อมูล	A = จำนวนข้อบกพร่องหรือความเสี่ยงที่ถูกค้นพบในการตรวจสอบ B = จำนวนมติการประเมินทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ปีละ 1 ครั้ง		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 90	2571 ≥ ร้อยละ 90	2572 ≥ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน			
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง			
ตัวชี้วัดที่	OKR 118.1 มิติด้านการเงิน			
คำนิยาม	มิติด้านการเงิน คือ การควบคุมและตรวจสอบการบริหารจัดการเงิน การรับ-จ่ายเงินสด เงินตราของราชการ ให้ถูกต้องตามระเบียบ			
ค่าเป้าหมาย	คะแนนที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย $\geq$ ร้อยละ 90			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินความเสี่ยง			
รายการข้อมูล	A = จำนวนข้อที่ผ่านการประเมินในมิติด้านการเงิน B = จำนวนข้อทั้งหมดที่ประเมินของมิติด้านการเงิน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ปีละ 1 ครั้ง			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนิภาพร โพธิกะ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริยุญาพร คงแสนคำ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์						
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน						
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง						
ตัวชี้วัดที่	OKR 118.2 มิติด้านการจัดเก็บรายได้						
คำนิยาม	มิติด้านการจัดเก็บรายได้ คือ การดูแลระบบการจัดเก็บเงิน ค่าบริการ หรือรายได้ต่างๆ ให้ครบถ้วน รวดเร็ว และไม่มีช่องว่างให้เกิดการรั่วไหล						
ค่าเป้าหมาย	คะแนนที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย $\geq$ ร้อยละ 90						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม						
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินความเสี่ยง						
รายการข้อมูล	A = จำนวนข้อที่ผ่านการประเมินในมิติด้านจัดเก็บรายได้ B = จำนวนข้อทั้งหมดที่ประเมินของมิติด้านจัดเก็บรายได้						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ปีละ 1 ครั้ง						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>$\geq$ ร้อยละ 90</td><td>$\geq$ ร้อยละ 90</td><td>$\geq$ ร้อยละ 90</td></tr></table>	2570	2571	2572	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90
2570	2571	2572					
$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางนิภาภรณ์ โคสม						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรวรณ อัครวิสุทธิเจริญ						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง		
ตัวชี้วัดที่	OKR 118.3 มิติด้านงบการเงิน		
คำนิยาม	มิติด้านงบการเงิน คือ การตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี จัดทำงบการเงิน และรายงานทางการเงินให้โปร่งใส เป็นปัจจุบัน		
ค่าเป้าหมาย	คะแนนที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย $\geq$ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินความเสี่ยง		
รายการข้อมูล	A = จำนวนข้อที่ผ่านการประเมินในมิติด้านงบการเงิน B = จำนวนข้อทั้งหมดที่ประเมินของมิติด้านงบการเงิน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ปีละ 1 ครั้ง		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภาวิณี พงษ์พันนา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวสิริญาพร คงแสนคำ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์						
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน						
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง						
ตัวชี้วัดที่	OKR 118.4 มิติด้านพัสดุและสินทรัพย์						
คำนิยาม	มิติด้านพัสดุและสินทรัพย์ คือ การควบคุมตั้งแต่การวางแผนจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจรับ การเก็บรักษา การเบิกจ่าย ไปจนถึงการจำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพอย่างถูกต้อง						
ค่าเป้าหมาย	คะแนนที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย $\geq$ ร้อยละ 90						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม						
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินความเสี่ยง						
รายการข้อมูล	A = จำนวนข้อที่ผ่านการประเมินในมิติด้านพัสดุและสินทรัพย์ B = จำนวนข้อทั้งหมดที่ประเมินของมิติด้านพัสดุและสินทรัพย์						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ปีละ 1 ครั้ง						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>$\geq$ ร้อยละ 90</td><td>$\geq$ ร้อยละ 90</td><td>$\geq$ ร้อยละ 90</td></tr></table>	2570	2571	2572	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90
2570	2571	2572					
$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางพรรณี ภูมิขิต						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกัญตา คำพอ						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง		
ตัวชี้วัดที่	OKR 118.5 มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง		
คำนิยาม	มิติด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง คือ การประเมินสภาพแวดล้อม การควบคุม กำหนดกิจกรรมการควบคุม และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร		
ค่าเป้าหมาย	คะแนนที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย $\geq$ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินความเสี่ยง		
รายการข้อมูล	A = จำนวนข้อที่ผ่านการประเมินในมิติด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง B = จำนวนข้อทั้งหมดที่ประเมินของมิติด้านควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ปีละ 1 ครั้ง		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นิติกร		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายศิวักร แสนยามาตย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. ประสิทธิภาพในการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการเงินการคลัง		
ตัวชี้วัดที่	OKR 118.6 มิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (IT)		
คำนิยาม	มิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (IT) คือ การควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ การเข้าถึงข้อมูล และป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์หรือข้อมูลรั่วไหล		
ค่าเป้าหมาย	คะแนนที่ผ่านการประเมินอย่างน้อย $\geq$ ร้อยละ 90		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	รายงานการตรวจสอบภายใน รายงานการประเมินความเสี่ยง		
รายการข้อมูล	A = จำนวนข้อที่ผ่านการประเมินในมิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ B = จำนวนข้อทั้งหมดที่ประเมินของมิติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	ปีละ 1 ครั้ง		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90	$\geq$ ร้อยละ 90
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสุจิตรา นาสิงห์ขัน		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายพัทยะ ธรรมบุตร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์								
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน								
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. อัตราการเข้าถึงบริการและความสมบูรณ์การบันทึกค่าบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS) เพิ่มขึ้น (จำนวน 28 รายการ)								
ตัวชี้วัดที่	KPI 119 อัตราการเข้าถึงบริการและความสมบูรณ์การบันทึกค่าบริการ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS)								
คำนิยาม	อัตราการเข้าถึงบริการและความสมบูรณ์ของการบันทึกค่าบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPFS) หมายถึง สัดส่วนของประชากรที่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนในระบบเวชระเบียน								
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลทุกกลุ่มอายุและสิทธิการรักษา								
แหล่งข้อมูล	ระบบเวชระเบียน HIS รายงานบริการ PPFS ของหน่วยบริการ ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนราษฎร								
รายการข้อมูล	A : จำนวนประชากรที่ได้รับบริการ PPFS (Promotion, Prevention, and Health Services) และมีข้อมูลครบถ้วน B : จำนวนประชากรที่มีข้อมูลการบันทึกครบถ้วนในระบบเวชระเบียน จำนวนรายการบริการ PPFS ตามเกณฑ์ 28 รายการ								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100								
ระยะเวลาที่ต้อง	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>ร้อยละ 80</td><td>ร้อยละ 80</td><td>ร้อยละ 80</td></tr></table>	2570	2571	2572	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80		
2570	2571	2572							
ร้อยละ 80	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภา พุทธิวงศ์								
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ								

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management)		
ตัวชี้วัดที่	KPI 120 ประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังรวม (Inventory Management)		
คำนิยาม	สินค้าคงคลังรวม ประกอบด้วย วัสดุการแพทย์ วัสดุมิใช่การแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทันตกรรม ยาและเวชภัณฑ์มีชีเยา ระยะเวลาในการคงคลังพัสดุ โดยเน้นรักษาระดับพัสดุดังกล่าวให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา และลดต้นทุนจมและป้องกันพัสดุเสื่อมสภาพ		
ค่าเป้าหมาย	≤ 60 วัน		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	สินค้าคงคลังรวมทั้งหมด		
แหล่งข้อมูล	รายงานมูลค่าคงคลังประจำเดือน		
รายการข้อมูล	A : มูลค่าสินค้าคงคลัง ณ สิ้นเดือน B : วงเงินงบประมาณสินค้าคงคลังรวมทั้งปี		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/(B/365)$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวพรณี ภูมิขิต		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกัญตา คำพอ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินคงคลัง (Inventory Management) - คลังวัสดุการแพทย์		
ตัวชี้วัดที่	OKR 120.1 คลังวัสดุการแพทย์		
คำนิยาม	วัสดุการแพทย์ หมายถึง ระยะเวลาในการคงคลังพัสดุ โดยเน้นรักษาระดับพัสดุดังกล่าวให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา และลดต้นทุนจมและป้องกันพัสดุเสื่อมสภาพ		
ค่าเป้าหมาย	≤ 60 วัน		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	วัสดุการแพทย์		
แหล่งข้อมูล	รายงานมูลค่าคงคลังประจำเดือน		
รายการข้อมูล	A : มูลค่าวัสดุการแพทย์คงคลัง ณ สิ้นเดือน B : วงเงินงบประมาณวัสดุการแพทย์รวมทั้งปี		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/(B/365)		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวพรณี ภูมิขิต		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกัญดา คำพอ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินคลัง (Inventory Management) - คลังวัสดุสำนักงาน		
ตัวชี้วัดที่	OKR 120.2 คลังวัสดุมีการแพทย์		
คำนิยาม	วัสดุทางการแพทย์ หมายถึง สิ่งของ ครุภัณฑ์ขนาดเล็ก หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้สิ้นเปลืองภายในหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการหัตถการ การตรวจวินิจฉัย หรือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโดยตรง แต่เป็นสิ่งของจำเป็นที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงานประจำวัน (Back Office และสายสนับสนุนบริการ) เพื่อให้อาคาร สถานที่ และระบบงานบริหารจัดการของโรงพยาบาลหรือองค์กรสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่น ระยะเวลาในการคงคลังพัสดุ โดยเน้นรักษาระดับพัสดुकคลังให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา และลดต้นทุนจมและป้องกันพัสดุเสื่อมสภาพ		
ค่าเป้าหมาย	≤ 60 วัน		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	วัสดุทางการแพทย์		
แหล่งข้อมูล	รายงานมูลค่าคงคลังประจำเดือน		
รายการข้อมูล	A : มูลค่าวัสดุทางการแพทย์คงคลัง ณ สิ้นเดือน B : วงเงินงบประมาณวัสดุทางการแพทย์รวมทั้งปี		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/(B/365)		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวพรณี ภูมิขิต		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกัญญา คำพอ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) - คลังยาเวชภัณฑ์		
ตัวชี้วัดที่	OKR 120.3 คลังยาเวชภัณฑ์		
คำนิยาม	ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา หมายถึง กลุ่มของสินค้า พืช สัตว์ หรือสิ่งสิ้นเปลืองทางการแพทย์ที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ป่วยโดยตรง ซึ่งถือเป็น "ทรัพยากรหลักและค่าใช้จ่ายหมวดใหญ่ที่สุด" ของสถานพยาบาลในการขับเคลื่อนสายงานหลัก (Clinical Front Office) ระยะเวลาในการคงคลังพืช โดยเน้นรักษาระดับพืชคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา และลดต้นทุนจมและป้องกันพืชเสื่อมสภาพ		
ค่าเป้าหมาย	≤ 60 วัน		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา		
แหล่งข้อมูล	รายงานมูลค่าคงคลังประจำเดือน		
รายการข้อมูล	A : มูลค่ายาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา คงคลัง ณ สิ้นเดือน B : วงเงินงบประมาณยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยา รวมทั้งปี		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/(B/365)		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน	≤ 60 วัน
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายวุฒิพงษ์ อักกะมานัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสาวชมพูนุช พัฒนจักร		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน			
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 2. หน่วยเบิกบริหารคลังวัสดุการแพทย์ของหน่วยเบิก (Sub stock) ไม่เกิน 3 วัน			
ตัวชี้วัดที่	KPI 121 ร้อยละหน่วยเบิกบริหารคลังวัสดุการแพทย์ของหน่วยเบิก (Sub stock) ไม่เกิน 3 วัน			
คำนิยาม	หน่วยเบิก (Sub stock) หมายถึง หอผู้ป่วยทั้งหมดภายในโรงพยาบาลมหาสารคาม วัสดุการแพทย์ ประกอบไปด้วย หมวด 29 วัสดุการแพทย์ , หมวด 31 หมวด 40 วัสดุการแพทย์ – ไตเทียม ,หมวด 49 เวชภัณฑ์มีไชยา, หมวด 50 เวชภัณฑ์มีไชยา – ไหมเย็บ, , หมวด 54 วัสดุวิทยาศาสตร์แล็บ – จุลชีววิทยาคลินิก **จำนวน 257 รายการ ตามโปรแกรมระบบบริหารเวชภัณฑ์ฯ (คลัง)			
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	สินค้าและหน่วยเบิก			
แหล่งข้อมูล	โปรแกรมบริหารคลังเวชภัณฑ์			
รายการข้อมูล	A :จำนวนหน่วยเบิกที่บริหารคลังวัสดุการแพทย์ ไม่เกิน 3 วัน B :จำนวนหน่วยเบิกทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวพรณี ภูมิขิต			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางกัญดา คำพอ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 3. ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า		
ตัวชี้วัดที่	KPIs 122 หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า		
คำนิยาม	หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า หมายถึง หน่วยพลังงานไฟฟ้าในหน่วยของ kwh ที่บันทึกได้จากมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละเดือน		
ค่าเป้าหมาย	เพิ่มขึ้น ≤ ร้อยละ 3		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	มิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดในโรงพยาบาล		
แหล่งข้อมูล	แบบฟอร์มรายงานค่าสาธารณูปโภค		
รายการข้อมูล	A : หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีปัจจุบัน B : หน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีก่อนหน้า		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 เพิ่มขึ้น ≤ ร้อยละ 3	2571 เพิ่มขึ้น ≤ ร้อยละ 3	2572 เพิ่มขึ้น ≤ ร้อยละ 3
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นายณพดล พัวคู่ขาม		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายศิวักร แสนยามาตย์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค		
ตัวชี้วัดที่	KPI 123 ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรคลดลง		
คำนิยาม	ประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรคยุทธศาสตร์ หมายถึง ความสามารถของโรงพยาบาลในการจัดทำ วิเคราะห์ และควบคุมต้นทุนต่อโรคยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อให้ค่าใช้จ่ายต่อโรคมียมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า โดยไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด		
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 5		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกที่เข้ารับการรักษาตามโรคยุทธศาสตร์ (เช่น DM, HT, Stroke, STEMI, CKD, CA) ในทุกกองทุน (UC, สปส., พรบ., ชำระเงินสด ฯลฯ)		
แหล่งข้อมูล	- ข้อมูลต้นทุนรายโรคจากฝ่ายการเงินและบัญชี - ฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย (HIS) - ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายต่อโรคจากฝ่ายแผนงาน/กลุ่มงานประกันสุขภาพ		
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากการบริหารต้นทุนรายโรค ยุทธศาสตร์ B : รายได้รวมที่เกี่ยวข้องกับโรคยุทธศาสตร์)		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5	ร้อยละ 5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวภา พุทธิวงศ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรุวรรณ วิสุทธิเจริญ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (Sepsis)
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.1 ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Pneumonia (CAP) ในผู้ป่วยในลดลง
คำนิยาม	ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (In-patient) ที่ได้รับการวินิจฉัยหลักเป็นโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต (Community Acquired Sepsis) ต่อการนอนโรงพยาบาลหนึ่งครั้ง (Admission) ต้นทุนสำคัญต่อ Admission ประกอบด้วย: - ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ - เครื่องช่วยหายใจ , Patient monitor - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา - ค่าตรวจทางรังสีวิทยา - ค่าหัตถการและค่าบริการทางการแพทย์ - ค่าห้องและค่าอาหาร (ไม่รวมค่าห้องพิเศษที่จ่ายเพิ่ม) ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง ผู้ป่วยในทุกคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal Diagnosis) หรือโรคร่วมเป็น (Comorbidity) Community Acquired Sepsis ตามรหัส ICD-10: A40.0 - A41.9, R65.1 และ R57.2
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี (เทียบกับค่าฐานปีงบประมาณ 2569)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในทุกคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal Diagnosis) หรือโรคร่วมเป็น (Comorbidity) Community Acquired Sepsis
แหล่งข้อมูล	1. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System - HIS) 2. ระบบบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาล (Cost Accounting System) 3.เวชระเบียนผู้ป่วยใน
รายการข้อมูล	A : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Sepsis ของปีก่อนหน้า B : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Sepsis ของปีปัจจุบัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/A*100

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ
	5	5	5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสุนทียะ ปัตติทานัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ศุภธิดา เทินสระเกษ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน			
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (Sepsis)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.2 ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค ESRD ในผู้ป่วยในลดลง			
คำนิยาม	ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย (ESRD) คือ ค่าใช้จ่ายในการบำบัดทดแทนไต (Renal Replacement Therapy) โดยเฉพาะการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis) ซึ่งมีต้นทุนสูงที่สุด จาก ต้นทุนค่าวัสดุทางการแพทย์ (เช่น ตัวกรองเลือด น้ำยาฟอกเลือด) และ ต้นทุนค่าบุคลากรทางการแพทย์ ต้นทุนสำคัญต่อ Admission ประกอบด้วย: ต้นทุนค่าวัสดุและอุปกรณ์ (Medical Supply Cost) ได้แก่ ตัวกรองเลือด (Dialyzer) สายฟอกเลือด น้ำยาฟอกเลือด และยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดแดง ต้นทุนค่าบุคลากร (Labor Cost): ค่าแรงของแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยไตเทียม ต้นทุนค่าลงทุนและค่าเสื่อมราคา (Capital Cost): ค่าเครื่องฟอกเลือด ค่าระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ (RO) สำหรับใช้ฟอกเลือด และค่าอาคารสถานที่			
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี (เทียบกับค่าฐานปีงบประมาณ 2569)			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในทุกคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับการวินิจฉัยโรค ESRD			
แหล่งข้อมูล	1. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System - HIS) 2. ระบบบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาล (Cost Accounting System) 3. เวชระเบียนผู้ป่วยใน			
รายการข้อมูล	A : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค ESRD ของปีก่อนหน้า B : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค ESRD ของปีปัจจุบัน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/A*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	
	5	5	5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางกชฌาภาณุ ดวงมาตย์พล			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมโภชน์ อินทรักษ์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (Sepsis)		
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.3 ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Traumatic Brain injury ในผู้ป่วยในลดลง		
คำนิยาม	ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน Traumatic Brain injury ต้นทุนสำคัญต่อ Admission ประกอบด้วย: - ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ - เครื่องช่วยหายใจ , Patient monitor - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา - ค่าตรวจทางรังสีวิทยา - ค่าหัตถการและค่าบริการทางการแพทย์ - ค่าห้องและค่าอาหาร (ไม่รวมค่าห้องพิเศษที่จ่ายเพิ่ม)		
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี (เทียบกับค่าฐานปีงบประมาณ 2569)		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในทุกคนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับการวินิจฉัยโรค Traumatic Brain injury		
แหล่งข้อมูล	1. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System - HIS) 2. ระบบบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาล (Cost Accounting System) 3. เวชระเบียนผู้ป่วยใน		
รายการข้อมูล	A : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Traumatic Brain injury ของปีก่อนหน้า B : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Traumatic Brain injury ของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ 5	ลดลงร้อยละ 5	ลดลงร้อยละ 5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพร อินนอก		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สมคริต ศรีพลแทน		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (Sepsis)
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.4 ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Sepsis ในผู้ป่วยใน ลดลง
คำนิยาม	ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (In-patient) ที่ได้รับการวินิจฉัยหลักเป็นโรคติดเชื้อในกระแสโลหิต (Community Acquired Sepsis) ต่อการนอนโรงพยาบาลหนึ่งครั้ง (Admission) ต้นทุนสำคัญต่อ Admission ประกอบด้วย: - ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ - เครื่องช่วยหายใจ , Patient monitor - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา - ค่าตรวจทางรังสีวิทยา - ค่าหัตถการและค่าบริการทางการแพทย์ - ค่าห้องและค่าอาหาร (ไม่รวมค่าห้องพิเศษที่จ่ายเพิ่ม) ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด หมายถึง ผู้ป่วยในทุกคนที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal Diagnosis) หรือโรคร่วมเป็น (Comorbidity) Community Acquired Sepsis ตามรหัส ICD-10: A40.0 - A41.9, R65.1 และ R57.2
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี (เทียบกับค่าฐานปีงบประมาณ 2569)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยในทุกคนที่เข้ารับการรักษานในโรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal Diagnosis) หรือโรคร่วมเป็น (Comorbidity) Community Acquired Sepsis
แหล่งข้อมูล	1. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System - HIS) 2. ระบบบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาล (Cost Accounting System) 3.เวชระเบียนผู้ป่วยใน
รายการข้อมูล	A : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Sepsis ของปีก่อนหน้า B : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Community Acquired Sepsis ของปีปัจจุบัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/A*100

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ
	5	5	5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวสุคนทิพย์ ปัตติทานัง		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.ศุภธิดา เทินสระเกษ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (UGIB)
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.5 ต้นทุนเฉลี่ยโรค UGIB ในผู้ป่วยในลดลง
คำนิยาม	1.UGIB หมายถึง การที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบน (upper gastrointestinal bleeding) หมายถึง ภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) เหนือต่อ ligament of Treitz โดยแบ่งประเภทของเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนตามสาเหตุ ได้แก่ 1) เลือดออกจากหลอดเลือดขดในทางเดินอาหารส่วนบน 2) เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนจากสาเหตุที่ไม่ใช่หลอดเลือดขด 2. ผู้ป่วยในโรค Upper Gastrointestinal Bleeding หมายถึง ผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาลมหาสารคามและได้รับการวินิจฉัยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น ด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร 3. ต้นทุนเฉลี่ยโรค UGIB ในผู้ป่วยใน หมายถึง ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการรักษาผู้ป่วยในด้วยโรค UGIB หารด้วยจำนวนผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยโรคนี้ในช่วงเวลาที่กำหนด ICD10 = (Upper gastrointestinal bleeding: K25.0-K256, K26.0-K26.6, K27.0-k27.2, k27.4-k27.6, K28.0-k28.2, k28.4-k28.6, k29.0, k92.0-k92.2 ICD 9 = 4516,4233, 4513
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ลดลงจากเดิม $\geq$ ร้อยละ 5
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคามโดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น (UGIB) และได้รับการรักษาโดยการส่องกล้องทางเดินอาหาร
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม
รายการข้อมูล	A : ต้นทุนเฉลี่ยโรค UGIB ของปีก่อนหน้า B ต้นทุนเฉลี่ยโรค UGIB ของปีปัจจุบัน
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/A \times 100$
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **

เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ลดลง 5%	ลดลง 5%	ลดลง 5%
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวจิรพรรณ แสงฉายา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นายปกรณ์ เศรษฐวิวัฒน์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน			
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (Cataract)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.6 ต้นทุนเฉลี่ยโรค Cataract ในผู้ป่วยใน ลดลง			
คำนิยาม	1.โรค Cataract หมายถึง ภาวะที่เลนส์ตาขุ่นทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจน ซึ่งการรักษาหลักคือการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา 2.ต้นทุนเฉลี่ยโรค Cataract หมายถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยประมาณที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคต่อกระจกต้อผู้ป่วยหนึ่งราย หรือต่อการผ่าตัดหนึ่งครั้ง 3.ต้นทุนเฉลี่ยโรค Cataract ในผู้ป่วยในลดลงร้อยละ 5 หมายถึง โรงพยาบาลได้ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อกระจกต้อลดลง 5% โดยอาจเกิดจากกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเลือกใช้วัสดุที่คุ้มค่า การปรับปรุงกระบวนการผ่าตัดให้เร็วขึ้นหรือการบริหารจัดการคิวผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนผู้ป่วยลดลง			
ค่าเป้าหมาย	ต้นทุนเฉลี่ยโรค Cataract ในผู้ป่วยในลดลงร้อยละ 5			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม			
รายการข้อมูล	A : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Cataract ของปีก่อนหน้า B : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Cataract ของปีปัจจุบัน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/A*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	
	5	5	5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางอังคณา สุวรรณดิษฐ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสุภาวดี ปักสังคะเนย์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน		
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค Postpartum hemorrhage		
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.7 ต้นทุนเฉลี่ยโรค Postpartum hemorrhage ในผู้ป่วยใน ลดลง		
คำนิยาม	Postpartum Hemorrhage (PPH) หรือ ภาวะตกเลือดหลังคลอด คือภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรมที่ผู้ป่วยสูญเสียเลือดปริมาณมากหลังคลอดบุตร (มากกว่า 500 มิลลิลิตร สำหรับการคลอดปกติ หรือมากกว่า 1,000 มิลลิลิตรสำหรับการผ่าตัดคลอด) ซึ่งส่งผลให้เกิดอาการหน้ามืด ซีพจรเต้นเร็ว กระสับกระส่าย และอาจเกิดภาวะช็อกที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที		
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 5		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	ฐานข้อมูลโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Postpartum hemorrhage ของปีก่อนหน้า B : ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Postpartum hemorrhage ของปีปัจจุบัน		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/A*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≤ ร้อยละ 5	≤ ร้อยละ 5	≤ ร้อยละ 5
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางรัศมี เกตุธานี		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (Fracture around hip)
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.8 ต้นทุนเฉลี่ยโรค Fracture around hip ในผู้ป่วยใน ลดลง
คำนิยาม	ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยในการดูแลรักษาผู้ป่วยใน (In-patient) ที่ได้รับการวินิจฉัยหลักเป็น Fracture around hip หรือภาวะ กระดูกสะโพกหัก หมายถึง การที่กระดูกบริเวณ สะโพก โดยเฉพาะกระดูกต้นขา (Femur) ส่วนบน เกิดการร้าวหรือแตกหัก มักเกิดจากการล้มในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุน • ผู้ป่วย FLS คือ ผู้ป่วยทั้งเพศชายและหญิง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการ รักษาในโรงพยาบาลด้วยภาวะกระดูกสะโพกหักจากภัยอันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture)ทุกราย • ภัยอันตรายชนิดไม่รุนแรง (Fragility fracture)หมายถึง แรงกระทำจากการล้ม ในระดับที่น้อยกว่าหรือเทียบเท่าความสูงขณะยืนของผู้ป่วย (Equivalent to fall from height) ต้นทุนสำคัญต่อ Admissionประกอบด้วย: - ค่ายาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ - Patient monitor - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา - ค่าตรวจทางรังสีวิทยา - ค่าหัตถการและค่าบริการทางการแพทย์ - ค่าห้องและค่าอาหาร (ไม่รวมค่าห้องพิเศษที่จ่ายเพิ่ม) ผู้ป่วย Fracture around hip หมายถึง ผู้ป่วยในทุกคนที่เข้ารับการรักษานใน โรงพยาบาลมหาสารคาม และได้รับการวินิจฉัยโรคหลัก (Principal Diagnosis) ตามรหัส ICD-10: 1. Close Femoral neck fracture S7200 2. Close intertrochanteric or lesser or greater trochantericS7210 3. Close fracture subtrochanteric S7220 การผ่าตัดด้วยรหัสหัตถการ ICD9 1. Total hip replacement 81.51

	2. Partial hip replacement (bipolar hemiarthroplasty,hemiarthroplasty) 81.52 3. Close reduction of fracture with internal Fixation 79.15 4. Open reduction of fracture with internal Fixation 79.35 5. Close reduction of fracture without internal Fixation 79.05 6. Open reduction of fracture without internal Fixation 79.25 Internal fixation of bone without fracture reduction 78.55 1.การผ่าตัดเร็วภายใน 72 ชั่วโมงหลังรับไว้รักษา 2. ระยะวันนอน ≤ 7 วัน 3. ลด Mortarityrate 4.ลด Morbidity ลดการรักษาที่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้			
ค่าเป้าหมาย	ลดลงร้อยละ 5 ภายในระยะเวลา 3 ปี (เทียบกับค่าฐานปีงบประมาณ 2569)			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล	1. ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System - HIS) 2. ระบบบัญชีต้นทุนของโรงพยาบาล (Cost Accounting System) 3. เวชระเบียนผู้ป่วยใน			
รายการข้อมูล	A :ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Fracture around hip ของปีก่อนหน้า B :ต้นทุนสำคัญเฉลี่ยโรค Fracture around hip ของปีปัจจุบัน			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/A*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลง ≤ ร้อยละ 5	ลดลง ≤ ร้อยละ 5	ลดลง ≤ ร้อยละ 5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางรัศมี เกตุธานี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นพ.สุรศักดิ์ จิตบรรจง			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (DM)
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.9 ต้นทุนเฉลี่ยโรค DM ลดลง (โรค DM มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
คำนิยาม	ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน (รหัส ICD-10 : E10-14) และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการ/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่มารับบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม ต้นทุนการบริการ โรค DM : - ตามสิทธิการรักษา : จ่ายตรง, UC , ประกันสังคม) - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา - ค่ายาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ - สถานที่ (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) รายได้ : กองทุนโรคเรื้อรัง (UC) , OP /PP ค่ายา (กำไรสุทธิ) , ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กำไรสุทธิ) หน่วยงานจักษุ : ตรวจตา (OP) , หน่วยงานทันตกรรม : ตรวจฟัน (OP) หน่วยงานกายภาพ : ตรวจเท้า (OP)
คำเป้าหมาย	ต้นทุนเฉลี่ยโรค DM ลดลงร้อยละ 5 (โรค DM มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคเบาหวาน (รหัส ICD-10 : E10-14) และได้รับการ ขึ้นทะเบียนมารับบริการโรคเบาหวาน/ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่มารับบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud ข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/PROCEDURE_OPD/COMMUNITY_SERVICE) โปรแกรม HDC
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากการให้บริการการโรคเบาหวานของปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิจากการให้บริการการโรคเบาหวานปีก่อนหน้า
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$(A-B)/B \times 100$

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10ต่อปี	ลดลงร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10ต่อปี	ลดลงร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10ต่อปี	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พจนทรัพย์ / สร้อยสุดา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงจิราพร / แพทย์หญิงยุคนธร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลังด้านการจัดเก็บรายได้ด้านรายได้เพิ่มพิเศษ (Premium) ด้านรายจ่ายด้านต้นทุน
Roadmap	Roadmap_ R12: การเงินการคลังมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	1. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน 1.1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 1.2. เพิ่มประสิทธิภาพในการหารายได้เพิ่มพิเศษ 1.3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 1.4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารรายจ่าย 4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนรายโรค (HT)
ตัวชี้วัดที่	OKR 123.10 ต้นทุนเฉลี่ยโรค HT ลดลง (โรค HT มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
คำนิยาม	ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงด้วยรหัส = I10-I15 และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการ/ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่มารับบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม ต้นทุนการบริการ โรค HT: - ตามสิทธิการรักษา : จ่ายตรง, UC , ประกันสังคม) - ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการและพยาธิวิทยา - ค่ายาเวชภัณฑ์ และวัสดุทางการแพทย์ - สถานที่ (ค่าน้ำ-ค่าไฟ) รายได้ : กองทุนโรคเรื้อรัง (UC) , OP /PP ค่ายา (กำไรสุทธิ) , ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ (กำไรสุทธิ)
ค่าเป้าหมาย	ต้นทุนเฉลี่ยโรค HT ลดลงร้อยละ 5 (โรค HT มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10)
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงด้วยรหัส = I10-I15 และได้รับการขึ้นทะเบียนมารับบริการ/ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง อาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดที่มารับบริการโรงพยาบาลมหาสารคาม
แหล่งข้อมูล	บันทึกผ่านโปรแกรมพื้นฐานของหน่วยบริการ และส่งออกข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้ม เข้าสู่ระบบ Health Data Center (HDC) On Cloud ข้อมูล 43 แฟ้ม (PERSON/ SERVICE/ DIAGNOSIS_OPD/ DRUG_OPD/PROCEDURE_OPD/COMMUNITY_SERVICE) โปรแกรม HDC
รายการข้อมูล	A : กำไรสุทธิจากการให้บริการโรคความดันโลหิตสูงของปีปัจจุบัน B : กำไรสุทธิจากการให้บริการโรคความดันโลหิตสูงปีก่อนหน้า
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A-B)/B*100

ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10ต่อปี	ลดลงร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10ต่อปี	ลดลงร้อยละ 5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 10ต่อปี	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	พจนทรัพย์ / สร้อยสุดา			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	แพทย์หญิงจิราพร / แพทย์หญิงยุคนธร			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1. ผู้รับบริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	KPI 124 อัตราผู้รับบริการมีความผูกพัน		
คำนิยาม	ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.สามัคคี, ศสม.ราชภัฏฯ, ศสม.บ้านส่องนางใย) เช่น ผู้ป่วย ญาติ ผู้มารับบริการตรวจสุขภาพ ความผูกพัน หมายถึง การตอบแบบสอบถามว่าจะกลับมาใช้บริการซ้ำ และจะแนะนำให้ผู้อื่นมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสำรวจความพึงพอใจ ความผูกพันของผู้รับบริการโรงพยาบาลและเครือข่าย		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้รับบริการที่มีความผูกพัน B : จำนวนผู้รับบริการที่สำรวจทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 70	2571 ≥ ร้อยละ 75	2572 ≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางธัญชนก แฝ่นพงษ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางนันทน์ รัตนเดชสกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.1 ผู้ป่วยนอกมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.1 อัตราผู้รับบริการ OPD มีความผูกพัน		
คำนิยาม	ผู้รับบริการ OPD หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ความผูกพัน หมายถึง การตอบแบบสอบถามว่าจะกลับมาใช้บริการซ้ำ และจะแนะนำให้ผู้อื่นมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกที่มีความผูกพัน B : จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดที่สำรวจทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางนิตยา อามาตย์บัณฑิต		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.2 ผู้ป่วยในมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น		
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.2 อัตราผู้รับบริการ IPD มีความผูกพัน		
คำนิยาม	ผู้รับบริการ IPD หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม ความผูกพัน หมายถึง การตอบแบบสอบถามว่าจะกลับมาใช้บริการซ้ำ และจะแนะนำให้ผู้อื่นมาใช้บริการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยในที่มีความผูกพัน B : จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดที่สำรวจทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570 ≥ ร้อยละ 70	2571 ≥ ร้อยละ 75	2572 ≥ ร้อยละ 80
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนันท์ ทกานต์ นักผูก		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางเพลินตา กุลทรัพย์ธนา		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์						
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง						
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.3 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยนอก						
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.3 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยนอก						
คำนิยาม	ผู้รับบริการ OPD หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความสุข ความชอบ หรือทัศนคติในทางบวกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานการณ์ หรือการกระทำใดๆ ซึ่งความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการ (Needs) หรือความคาดหวัง (Expectations) ของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและตรงใจ						
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก ในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง						
แหล่งข้อมูล	เอกสารสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย						
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอกที่มีความพึงพอใจ B : จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดที่สำรวจทั้งหมด						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>≥ ร้อยละ 75</td><td>≥ ร้อยละ 80</td><td>≥ ร้อยละ 85</td></tr></table>	2570	2571	2572	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85
2570	2571	2572					
≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสุรัตน์ ทิพย์วัฒน์						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางนิตยา อามาตย์บัณฑิต						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์						
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง						
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล						
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน						
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.4 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยใน						
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.4 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยใน รายแผนก						
คำนิยาม	ผู้รับบริการ IPD หมายถึง ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาสารคาม ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความสุข ความชอบ หรือทัศนคติในทางบวกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานการณ์ หรือการกระทำใดๆ ซึ่งความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการ (Needs) หรือความคาดหวัง (Expectations) ของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและตรงใจ						
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85						
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่ายศูนย์บริการสุขภาพชุมชนเมือง						
แหล่งข้อมูล	เอกสารสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในโรงพยาบาลมหาสารคามและเครือข่าย						
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้มารับบริการในแผนกผู้ป่วยในที่มีความพึงพอใจ B : จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดที่สำรวจทั้งหมด						
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100						
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **						
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>≥ ร้อยละ 75</td><td>≥ ร้อยละ 80</td><td>≥ ร้อยละ 85</td></tr></table>	2570	2571	2572	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85
2570	2571	2572					
≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85					
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนันทกานต์ นักผูก						
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางเพลินตา กุลทรัพย์ธนา						

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.5 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)		
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.5 อัตราความพึงพอใจผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER)		
คำนิยาม	ผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีลักษณะเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาฉุกเฉินอย่างทันท่วงที เพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนั้น ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความรู้สึกที่ดี ความสุข ความชอบ หรือทัศนคติในทางบวกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง สถานการณ์ หรือการกระทำใดๆ ซึ่งความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความต้องการ (Needs) หรือความคาดหวัง (Expectations) ของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมและตรงใจ		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่มารับบริการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลมหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	เอกสารสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้มารับบริการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มีความพึงพอใจ B : จำนวนผู้มารับบริการทั้งหมดที่สำรวจทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	≥ ร้อยละ 75	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 85
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิไลพร แก้วอรุณ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางปรมาภรณ์ คลังพระศรี		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.6 เพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วยในชุมชนกลุ่มดูแลต่อเนื่อง		
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.6 อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยในชุมชนกลุ่มดูแลต่อเนื่อง		
คำนิยาม	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึงการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อความถาม "ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล.....โดยรวมในระดับใด" สุ่มสอบถามจากผู้รับบริการในกระบวนการบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ระดับความพึงพอใจ หมายถึงระดับความรู้สึพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับที่ระบุไว้ในแต่ละข้อความของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด การวัดระดับความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความรู้สึกต่อบริการที่ได้รับของผู้ป่วย โดยวัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4-5 เท่านั้น ผู้ป่วยในชุมชนกลุ่มดูแลต่อเนื่อง หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยหรือผู้ดูแลที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 80		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ		
แหล่งข้อมูล	ผู้รับบริการผู้ป่วยนอก		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 B : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2568	2569	2570
	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางธัญชนก แผ่นพงษ์		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางนันทน์ รัตนเดชสกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.7 เพิ่มความพึงพอใจของกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค		
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.7 อัตราความพึงพอใจของกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค		
คำนิยาม	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึงการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อความ "ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล.....โดยรวมในระดับใด" สุ่มสอบถามจากผู้รับบริการในกระบวนการบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ระดับความพึงพอใจ หมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับที่ระบุไว้ในแต่ละข้อความของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด การวัดระดับความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความรู้สึกต่อบริการที่ได้รับของผู้ป่วย โดยวัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4–5 เท่านั้น กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรคตามกลุ่มวัย		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนในเขตตำบลตลาด อำเภอเมือง มหาสารคาม		
แหล่งข้อมูล	แบบประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 B : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2568	2569	2570
	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางวิศรดา ดีเมืองซ้าย		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.8 เพิ่มความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสุขภาพ		
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.8 อัตราความพึงพอใจของกลุ่มตรวจสุขภาพ		
คำนิยาม	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึงการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อความ "ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล.....โดยรวมในระดับใด" สุ่มสอบถามจากผู้รับบริการในกระบวนการบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ระดับความพึงพอใจ หมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับที่ระบุไว้ในแต่ละข้อความของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด การวัดระดับความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความรู้สึกต่อบริการที่ได้รับของผู้ป่วย โดยวัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4-5 เท่านั้น กลุ่มตรวจสุขภาพ หมายถึง ประชาชนที่ได้รับการบริการตรวจสุขภาพ โดยงานตรวจสุขภาพโรงพยาบาลมหาสารคาม		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ		
แหล่งข้อมูล	แบบประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 B : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2568	2569	2570
	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางศิริพร ศรีชะตา		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางสุธิดา เอี่ยมเกื้อกุล		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	1.ผู้ใช้บริการมีความผูกพันเพิ่มมากขึ้น 1.9 เพิ่มความพึงพอใจของกลุ่มผู้ป่วยที่มีความต้องการเฉพาะ		
ตัวชี้วัดที่	OKR 124.9 อัตราความพึงพอใจกลุ่มผู้ป่วยที่มีเข้ารับบริการ PMC หรือ SMC		
คำนิยาม	การประเมินความพึงพอใจในภาพรวม หมายถึงการประเมินโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีข้อความ "ท่านมีความพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับจากโรงพยาบาล.....โดยรวมในระดับใด" สุ่มสอบถามจากผู้รับบริการในกระบวนการงานบริการผู้ป่วยนอกทั้งหมด ระดับความพึงพอใจ หมายถึงระดับความรู้สึกพึงพอใจต่อบริการที่ได้รับที่ระบุไว้ในแต่ละข้อความของแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับจากน้อยที่สุดไปถึงมากที่สุด การวัดระดับความพึงพอใจ หมายถึง การประเมินความรู้สึกต่อบริการที่ได้รับของผู้ป่วย โดยวัดเฉพาะผู้ป่วยที่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 4-5 เท่านั้น กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ PMC หรือ SMC หมายถึง กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้ป่วยที่เลือกเข้ามารับการตรวจรักษาใน "ช่องทางบริการรูปแบบพิเศษ" (Premium / Special Services) ของโรงพยาบาลรัฐบาล ซึ่งเป็นบริการทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว มีความยืดหยุ่น และพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมส่วนต่างเพิ่มเติม		
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 85		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ		
แหล่งข้อมูล	แบบประเมินความพึงพอใจแยกตามกลุ่มผู้รับบริการ		
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับความพึงพอใจระดับ 4 และ 5 B : จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(A/B) * 100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2568	2569	2570
	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85	≥ ร้อยละ 85
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางวาสนา บำรุงบุญ		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางนิตยา อามาทย์บัณฑิต		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ประชาชนมีความผูกพันเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPI 125 อัตราประชาชนมีความผูกพัน			
คำนิยาม	ประชาชนมีความผูกพัน หมายถึง ภาวะที่ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม มีความเชื่อมั่น และกระตือรือร้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม นโยบาย หรือการพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศของตนเอง ไม่ได้เป็นเพียง "ผู้รับบริการ" ที่ตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 60			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถาม/แบบสำรวจ			
รายการข้อมูล	A : ประชาชนที่มีความผูกพันต่อโรงพยาบาลมหาสารคาม B : ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	$A/B*100$			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 60	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางธัญชนก แผ่นพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ.นันทพ รัตนเดชสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ประชาชนมีความผูกพันเพิ่มขึ้น 2.1 ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชนมีความผูกพันเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 125.1 อัตราภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน มีความผูกพัน			
คำนิยาม	ภาคีเครือข่ายสุขภาพชุมชน (Community Health Network / Partnership) หมายถึง การกลุ่มหรือการรวมตัวกันของบุคคล กลุ่มคน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงกลุ่มออกกำลังกายที่เข้ามามีบทบาทและมีเป้าหมายร่วมกันในการดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 60			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป			
แหล่งข้อมูล	แบบสอบถาม/แบบสำรวจ			
รายการข้อมูล	A : ประชาชนที่มีความผูกพันต่อโรงพยาบาลมหาสารคาม B : ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 60	≥ ร้อยละ 60	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางธิญชนก แผ่นพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	ทพญ.นันทพ รัตนเดชสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	2. ประชาชนมีความผูกพันเพิ่มขึ้น 2.2 ประชาชนทั่วไปมีความผูกพันเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	OKR 125.2 จำนวนคำชมเชย $\geq 1,000$ ครั้ง/ปี			
คำนิยาม	คำชมเชย คือ ถ้อยคำที่แสดงออกถึงการยกย่อง ชื่นชม ความพึงพอใจและความรู้สึกเชิงบวกต่อบุคลากรและโรงพยาบาลมหาสารคาม ช่องทางการรับคำชมเชย ได้แก่ กล่องรับความคิดเห็น ช่องทางออนไลน์ เช่น เพจโรงพยาบาล, เพจมหาสารคามช่วยกัน, QR Code			
ค่าเป้าหมาย	$\geq 1,000$ ครั้ง/ปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ประชาชนทั่วไป			
แหล่งข้อมูล	เอกสารการรับคำชมเชย กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ			
รายการข้อมูล	A : จำนวนคำชมเชยจากทุกช่องทาง			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	$\geq 1,000$ ครั้ง/ปี	$\geq 1,000$ ครั้ง/ปี	$\geq 1,000$ ครั้ง/ปี	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวศิรินุช ศรีบุญเศษ			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางนันทพ รัตนเดชสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. เครือข่ายบริการสุขภาพ มีความผูกพันเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPI 126 อัตราเครือข่ายบริการสุขภาพ มีความผูกพัน			
คำนิยาม	เครือข่ายบริการสุขภาพ หมายถึง การรวมตัวกันของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทติยภูมิ ไปจนถึงตติยภูมิ ภายในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและการดูแลสุขภาพได้อย่างทั่วถึง ไร้รอยต่อ และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าที่สุด การมีความผูกพัน หมายถึง สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่บุคคลหนึ่งมีความเชื่อมโยง ยึดเหนี่ยว และมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (อาจเป็นบุคคล องค์กร ชุมชน หรือเป้าหมาย) จนเกิดเป็นความพึงพอใจ ความซื่อสัตย์ และความต้องการที่จะดำรงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ในระยะยาว			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	≥ ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรในเครือข่ายสุขภาพ			
แหล่งข้อมูล	แบบสำรวจ/แบบสอบถาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนเครือข่ายบริการสุขภาพที่มีความผูกพันตามเกณฑ์ที่กำหนด B : จำนวนเครือข่ายบริการสุขภาพทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนรินทร์พร สงศรี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคดีวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ให้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. เครือข่ายบริการสุขภาพ มีความผูกพันเพิ่มขึ้น 3.1 รพช.			
ตัวชี้วัดที่	OKR 126.1 รพช. มีความผูกพัน			
คำนิยาม	โรงพยาบาลชุมชนมีความผูกพัน หมายถึง ภาวะที่ชาวบ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ รู้สึกเป็นเจ้าของร่วม (Sense of Ownership) และมีความเชื่อมั่นในโรงพยาบาลชุมชนของตนเอง โรงพยาบาลชุมชน มีจำนวน 12 โรงพยาบาล ได้แก่ 1. โรงพยาบาลกันทรวิชัย (อำเภอกันทรวิชัย) 2. โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (อำเภอโกสุมพิสัย) 3. โรงพยาบาลบรบือ (อำเภอบรบือ) 4. โรงพยาบาลวาปีปทุม (อำเภอวาปีปทุม) 5. โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย (อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย) 6. โรงพยาบาลเขียงยืน (อำเภอเขียงยืน) 7. โรงพยาบาลนาเชือก (อำเภอนาเชือก) 8. โรงพยาบาลนาइन (อำเภอนาइन) 9. โรงพยาบาลแกดำ (อำเภอแกดำ) 10. โรงพยาบาลยางสีสุราช (อำเภอยางสีสุราช) 11. โรงพยาบาลกุดรัง (อำเภอกุดรัง) 12. โรงพยาบาลชื่นชม (อำเภอชื่นชม)			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	แบบสำรวจ/แบบสอบถาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวนโรงพยาบาลชุมชนที่มีความผูกพันตามเกณฑ์ที่กำหนด B :จำนวนโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวนรินทร์พร สงศรี			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.กนกพร โชคคติวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ให้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	3. เครือข่ายบริการสุขภาพ มีความผูกพันเพิ่มขึ้น 3.2 รพ.สต.			
ตัวชี้วัดที่	OKR 126.2 รพ.สต. มีความผูกพัน (รพ.สต.) ร้อยละ 70			
คำนิยาม	สถานบริการสาธารณสุขด่านแรกที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนมากที่สุด ทำหน้าที่เป็นประตูแรกของระบบสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม (Holistic Care) ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยเน้นการดูแลที่ต่อเนื่องและผสมผสาน ไม่ใช่แค่รักษาเมื่อเจ็บป่วยแล้วจบไป การมีความผูกพัน หมายถึง สภาวะทางอารมณ์และความรู้สึกที่บุคคลหนึ่งมีความเชื่อมโยง ยึดเหนี่ยว และมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (อาจเป็นบุคคล องค์กร ชุมชน หรือเป้าหมาย) จนเกิดเป็นความพึงพอใจ ความซื่อสัตย์ และความต้องการที่จะดำรงรักษาความสัมพันธ์นั้นไว้ในระยะยาว			
ค่าเป้าหมาย	≥ ร้อยละ 70			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนทั้งหมด			
แหล่งข้อมูล	แบบสำรวจ/แบบสอบถาม			
รายการข้อมูล	A : จำนวน รพ.สต.ที่มีความผูกพันตามเกณฑ์ที่กำหนด B : จำนวน รพ.สต.ทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	≥ ร้อยละ 70	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางพัชรา พรหมอารักษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	พญ.เบญจวรรณ ธรรมปัญญาวัฒน์			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนรุนแรง (ม.41/ชดเชยเยียวยา/ฯลฯ) ลดลง			
ตัวชี้วัดที่	KPI 127 อัตราอุบัติการณ์ข้อร้องเรียนรุนแรง (ม.41/ชดเชยเยียวยา/ฯลฯ) ลดลงร้อยละ5 จากปีที่ผ่านมา			
คำนิยาม	ข้อร้องเรียนรุนแรง หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา ตามมาตรา 41, กองทุนประกันสังคมและโรงพยาบาลมหาสารคาม			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลมหาสารคาม ที่เข้ารับบริการทุกสิทธิการรักษา			
แหล่งข้อมูล	1. ฐานข้อมูลคณะกรรมการ ม.41 โรงพยาบาล 2. รายงานเขตเยียวยา / งานนิติกรรม / งานประกันสุขภาพ 3. ฐานข้อมูลความเสี่ยงของโรงพยาบาล			
รายการข้อมูล	A : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในปีงบประมาณปัจจุบัน B : จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาในปีงบประมาณที่ผ่านมา			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	(B-A)/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	ลดลงร้อยละ	
	5	5	5	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวกนกพรรณ วัฒนินทร			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรวรณ์ อัครวิสุทธิเจริญ			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์								
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง								
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล								
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน								
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนรุนแรง (ม.41/ชดเชยเยียวยา/ฯลฯ) ลดลง 4.1 ข้อร้องเรียนได้รับการจัดการตามแนวทาง ทุกเรื่อง								
ตัวชี้วัดที่	OKR 127.1 อัตราข้อร้องเรียนได้รับการจัดการตามแนวทาง								
คำนิยาม	ข้อร้องเรียน หมายถึง คำว่า "ข้อร้องเรียน" (Complaint) หมายถึง การแสดงออกของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (เช่น ผู้รับบริการ ประชาชน หรือพนักงาน) ที่ระบุถึงความไม่พึงพอใจ ความเดือดร้อน หรือความเสียหาย ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน การให้บริการ พฤติกรรมของบุคลากร หรือระบบการทำงานขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรได้รับทราบและดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือชดเชยเยียวยาในสิ่งที่เกิดขึ้น แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อร้องทุกข์ หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจัดการ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามเอกสารหมายเลขที่ มค.....								
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100								
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการทุกสิทธิ์การรักษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ (ศูนย์บริการข้อมูล, กล่องรับฟังความคิดเห็น, Line รพ., โทรศัพท์, ฯลฯ)								
แหล่งข้อมูล	1. ระบบรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาล 2. แบบฟอร์มรายงานการรับข้อร้องเรียน 3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการคุณภาพ								
รายการข้อมูล	A : จำนวนข้อร้องเรียนได้รับการจัดการตามแนวทาง B : จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด								
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100								
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **								
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	<table><tr><td>2570</td><td>2571</td><td>2572</td></tr><tr><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100</td><td>ร้อยละ 100</td></tr></table>	2570	2571	2572	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100		
2570	2571	2572							
ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100							
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิราวรรณ พิศพล								
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจารุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ								

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ให้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนรุนแรง (ม.41/ชดเชยเยียวยา/ฯลฯ) ลดลง 4.2 ข้อร้องทุกข์ได้รับการจัดการตามแนวทาง เรื่อง		
ตัวชี้วัดที่	OKR 127.2 อัตราข้อร้องทุกข์ได้รับการจัดการตามแนวทาง		
คำนิยาม	ข้อร้องทุกข์ หมายถึง... แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน/ข้อร้องทุกข์ หมายถึง ข้อร้องเรียนที่ได้รับการดำเนินการจัดการ ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของโรงพยาบาลมหาสารคาม ตามเอกสารหมายเลขที่ มค.....		
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ผู้รับบริการทุกสิทธิ์การรักษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ (ศูนย์บริการข้อมูล, กล้องรับฟังความคิดเห็น, Line รพ., โทรศัพท์, ฯลฯ)		
แหล่งข้อมูล	1.ระบบรับเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาล 2.แบบฟอร์มรายงานการรับข้อร้องเรียน/ข้อร้องทุกข์ 3.รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการคุณภาพ		
รายการข้อมูล	A : จำนวนข้อร้องทุกข์ได้รับการจัดการตามแนวทาง B : จำนวนข้อร้องทุกข์ทั้งหมด		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาววิราวรรณ พิศพล		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจารุวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_ พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูงด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์		
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง		
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล		
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน		
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	4. อุบัติการณ์ข้อร้องเรียนรุนแรง (ม.41/ชดเชยเยียวยา/ฯลฯ) ลดลง 4.3 ทีมใกล้เคียงได้รับการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูง		
ตัวชี้วัดที่	OKR 127.3 อัตราทีมใกล้เคียงได้รับการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงตามแผน		
คำนิยาม	การพัฒนาสมรรถนะขั้นสูง หมายถึง การผ่านหลักสูตรการอบรมหลักสูตรใกล้เคียงขั้นสูง, การอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, การจัดการข้อร้องเรียนเชิงจิตวิทยา ตามแผน หมายถึง บุคลากรในทีมใกล้เคียงได้รับการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงตามจำนวนที่ระบุไว้ในแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีนั้น ปี 2570 จำนวน....คน ปี 2571 จำนวน....คน ปี 2572 จำนวน....คน		
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ 100		
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทีมใกล้เคียงข้อร้องเรียนของโรงพยาบาล (ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อร้องเรียน)		
แหล่งข้อมูล	1. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสมรรถนะทีมใกล้เคียงประจำปี 2. หลักฐานการอบรม / หนังสือรับรองการเข้าร่วมอบรม 3. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการใกล้เคียงข้อร้องเรียน 4. แบบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากร (HRD report)		
รายการข้อมูล	A : จำนวนบุคลากรทีมใกล้เคียงที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงในปีนั้น B : จำนวนบุคลากรทีมใกล้เคียงที่ต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะขั้นสูงในปีนั้น		
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100		
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **		
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572
	100	100	100
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางสาวกนกพรณ วัฒนินทร		
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางจรรวรรณ อัครวิสุทธิเจริญ		

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ให้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. ประชาชนและผู้ให้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามเพิ่มขึ้น			
ตัวชี้วัดที่	KPI 128 อัตราตัวชี้วัดประชาชนและผู้ให้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม ร้อยละ 100 (รวม 4 ข้อ เป็น 100%)			
คำนิยาม	ตัวชี้วัดประชาชนและผู้ให้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม ประกอบด้วย 1. มูลค่าบริจาค (ทรัพย์สิน/เงิน/ฯลฯ) มากกว่า 10 ล้านบาท 2. อัตราบริจาคอวัยวะ เพิ่มขึ้นมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 5 3. จำนวนจิตอาสาและอาสาสมัคร อย่างน้อยปีละ 6 คน 4. จำนวนครั้งในการบริจาคโลหิต เกณฑ์ ไม่ลดลงจากเดิม			
ค่าเป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	ร้อยละ 100			
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	ตัวชี้วัดประชาชนและผู้ให้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคาม			
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล	A : จำนวนตัวชี้วัดประชาชนและผู้ให้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามที่ผ่านเกณฑ์ B : จำนวนตัวชี้วัดประชาชนและผู้ให้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามทั้งหมด			
สูตรคำนวณตัวชี้วัด	A/B*100			
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงานระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
	≥ ร้อยละ 80	≥ ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	นางธัญชนก แผ่นพงษ์			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด	นางนันทน์ รัตนเดชสกุล			

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. ประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามเพิ่มขึ้น 5.1 บริจาค (ทรัพย์สิน/เงิน/ฯลฯ)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 128.1 มูลค่าบริจาค (ทรัพย์สิน/เงิน/ฯลฯ) มากกว่า 10 ล้านบาท			
คำนิยาม				
คำเป้าหมาย				
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด				
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้อง รายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด				
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. ประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามเพิ่มขึ้น 5.3 จิตอาสาและอาสาสมัคร (เช่น ผู้เกษียณจิตอาสา , นักเรียน/นศ.จิตอาสา)			
ตัวชี้วัดที่	OKR 128.2 จำนวนจิตอาสาและอาสาสมัคร อย่างน้อยปีละ 6 คน			
คำนิยาม				
ค่าเป้าหมาย				
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด				
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้อง รายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	HRD			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				

นิยามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาลมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570-2579

พันธกิจ	M6_พัฒนาระบบบริการคุณภาพสูง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์			
ประเด็นยุทธศาสตร์	WT : ปฏิรูปยุทธศาสตร์ระบบบริหารการเงินการคลัง			
Roadmap	Roadmap R13 : ประชาชนและผู้ใช้บริการผูกพัน (Engagement) และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาโรงพยาบาล			
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน			
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์	5. ประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโรงพยาบาลมหาสารคามเพิ่มขึ้น 5.4 บริจาคโลหิต ไม่ลดลงจากเดิม			
ตัวชี้วัดที่	OKR 128.3 จำนวนบริจาคโลหิต เกณฑ์ เพิ่มขึ้น $\geq$ ร้อยละ			
คำนิยาม				
ค่าเป้าหมาย				
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย				
แหล่งข้อมูล				
รายการข้อมูล				
สูตรคำนวณตัวชี้วัด				
ระยะเวลาที่ต้องรายงาน (ระบุจำนวนครั้งที่ต้อง รายงาน)	** ไม่ต้องเติม **			
เป้าหมายการดำเนินงาน ระยะ 3 ปี	2570	2571	2572	
ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด	ห้อง Lab			
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด				